

# terapia familiar

ESTRUCTURA, PATOLOGIA Y TERAPEUTICA  
DEL GRUPO FAMILIAR

## 19

ELIZABETH JELIN

Pan y afectos: la organización doméstica en la producción y la reproducción

SILVIA L. QUAGLIA

Proceso psicodiagnóstico de la familia con niños desde el enfoque trigeracional

ALEJANDRO PISCITELLI

Cambio epistemológico y cambio terapéutico. La superación de la oposición analógico-digital como precondition para la construcción de una ciencia unificada del hombre

EDUARDO MANDELBAUM

Terapia familiar y psicoanálisis individual. Integración de recursos terapéuticos

CELIA ELZUFAN Y HUGO HIRSCH

Medicina familiar

MARIA CRISTINA ROJAS Y SUSANA MATUS

Las Mil y Una Noches del terapeuta de familia. Reflexiones acerca de las familias con trastornos contextuales

CARLOS SLUZKI

Proceso de producción y pautas de mantenimiento de síntomas

GUILLERMO FERNANDEZ BERNAL

CARMENZA RODRIGUEZ DRAGIN

Terapia familiar intergeneracional. Intervención breve en una familia con problemas de alcoholismo y depresión

DIALOGO

Jorge Colapinto y Alfredo Canevaro

ATENEO CLINICO

Eloisa Barrientos, Luis Izcovich, Beatriz Videla, Edmundo Zimmerman, Carlos M. Díaz Usandivaras, Aurora Pérez y María Rosa Glasserman



# terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica  
del grupo familiar

Año VI - N° 12 - Diciembre de 1983

Director

Dr. Alfredo A. Canevaro

Comité de Redacción

Lic. Fanny Levinton de Baranchuk

Dr. Rafael Skiadaressis

Consejo de Redacción

Maurizio Andolfi (Roma)

Isidoro Berenstein (Buenos Aires)

Donald Bloch (New York)

Ivan Boszormenyi-Nagy (Filadelfia)

Ives Colas (Lyon)

Alberto Eiguer (Buenos Aires - París)

Jorge García Badaracco (Buenos Aires)

J. Howells (Ipswich - Inglaterra)

Florence Kaslow (West Palm Beach - Florida)

Raymundo Macías (México)

Juan C. Nocetti (Buenos Aires)

Reynaldo Perrone (Rosario, Argentina - St. Etienne, Francia)

David Rubinstein (Filadelfia)

Jacques Rudrauf † (París)

Richard Sauber (Massachusetts)

Alberto Serrano (Buenos Aires - San Antonio - Texas)

Maria Selvini Palazzoli (Milán)

Robin Skynner (Londres)

Carlos Sluzki (Buenos Aires - Berkshire - Massachusetts)

Helm Stierlin (Heidelberg)

Guillermo Vidal (Buenos Aires)

Gerald Zuk (Nueva Orleans)

Israel Zwerling (Filadelfia)

Director Administrativo

Alberto Cattán

Secretaria Ejecutiva

Mirta Liso

Asesor Editorial

Alfredo Carlino

Asesor Gráfico

Patricia Luppi

**TERAPIA FAMILIAR** es una publicación semestral de Editorial ACE S.R.L. (ef), Gorostiaga 1731, Bs. As., Argentina. Acogida a la protección de las Convenciones Internacional y Panamericana sobre derechos de autor. Nombre de la Revista registrado como marca. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 142516.

Coordinación gráfica: Patricia Luppi, Tel. 33-3041, int. 505  
Composición: Osmar Luis Bondoni, San Carlos 1520, Santos Lugares.

Tarifa reducida 3052 – Franqueo pagado 339 – Número del Registro Internacional de Publicaciones Científicas ISSN 0325-5905.

## INDICE

|                                                                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| EDITORIAL .....                                                                                                                                                              | 7   |
| ELIZABETH JELIN                                                                                                                                                              |     |
| Pan y afectos: la organización doméstica en la producción y la reproducción .....                                                                                            | 9   |
| SILVIA L. QUAGLIA                                                                                                                                                            |     |
| Proceso psicodiagnóstico de la familia con niños desde el enfoque trigeracional .....                                                                                        | 53  |
| ALEJANDRO PISCITELLI                                                                                                                                                         |     |
| Cambio epistemológico y cambio terapéutico. La superación de la oposición analógico-digital como precondition para la construcción de una ciencia unificada del hombre ..... | 67  |
| EDUARDO MANDELBAUM                                                                                                                                                           |     |
| Terapia familiar y psicoanálisis individual. Integración de recursos terapéuticos .....                                                                                      | 99  |
| CELIA ELZUFAN Y HUGO HIRSCH                                                                                                                                                  |     |
| Medicina familiar .....                                                                                                                                                      | 115 |
| MARIA CRISTINA ROJAS Y SUSANA MATUS                                                                                                                                          |     |
| Las Mil y Una Noches del terapeuta de familia. Reflexiones acerca de las familias con trastornos contextuales .....                                                          | 123 |
| CARLOS E. SLUZKI                                                                                                                                                             |     |
| Proceso de producción y pautas de mantenimiento de síntomas .....                                                                                                            | 139 |



GUILLERMO FERNANDEZ BERNAL Y CARMENZA  
RODRIGUEZ DRAGIN

Terapia familiar intergeneracional. Intervención breve  
en una familia con problemas de alcoholismo y  
depresión ..... 157

JORGE COLAPINTO Y ALFREDO CANEVARO

Diálogo ..... 177

ELOISA BARRIENTOS, LUIS IZCOVICH, BEATRIZ VI-  
DELA, EDMUNDO ZIMMERMAN, CARLOS M. DIAZ  
USANDIVARAS, AURORA PEREZ Y MARIA ROSA  
GLASSERMAN

Ateneo clínico ..... 193

COMENTARIO DE LIBROS ..... 231

SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA FAMILIAR

Informaciones ..... 247

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES ..... 250

EDITORIAL

*La profunda crisis de nuestro país, en todos los órdenes, sacude obviamente nuestra profesión, produciendo como todo revulsivo, la exageración de sus defectos y por ende, la emergencia neta de sus virtudes. Entre ellas está la característica de la terapia familiar como forma de socioterapia, que encuentra su forma ideal de expresión en las instituciones.*

*Ahora bien, el perfeccionamiento técnico y su adecuada implementación en planes de salud cuya destinataria sea la comunidad, no sería suficiente si no analizáramos también nuestra postura frente al mismo objeto de estudio y tratamiento que nos ocupa.*

*Una característica que nos define a todos los terapeutas de familia, más allá de nuestras discrepancias teóricas y técnicas, es nuestro amor por la familia.*

*Esta definición, poco habitual en los tratados científicos, es sin embargo necesaria, no por romanticismo, sino como consolidación de vocación. Este orillar delicado por los límites de nuestra profesión, sin caer en la prédica o en el adoctrinamiento, que no serían pertinentes, es sin embargo oportuno.*

*Hoy más que nunca distintos estudiosos e investigadores se aproximan en un enfoque multidisciplinario al análisis de un tema de candente actualidad. ¿Es la familia eficiente como institución sociocultural? ¿Sobrevivirá o se extinguirá dentro de la cultura? ¿Puede existir el hombre sin familia? Estos interrogantes, cada vez más angustiosos, frente al panorama crítico de la familia contemporánea, nos colocan como terapeutas frente a una definición existencial. El perfil del*

terapeuta familiar, lo define como vocacionalmente orientado, no sólo por su biografía, como habitualmente se entiende, sino también por su quehacer mismo, en una suerte de realimentación permanente. Así entonces el terapeuta familiar, como operador social, es representante de su propia cultura. Y esta cultura está en crisis.

Pero la crisis también es, como su etimología lo indica, "desear con impaciencia", y como operadores sociales de nuestra cultura, no podemos evitar plantearnos temas que hacen a la esencia misma de nuestra tarea.

El cuestionamiento amplio y profundo de la familia, sin mojigaterías, puede hacer brotar los mecanismos sanos y vigorosos que realcen el profundo sentido de su existencia como nido ecológico del ser humano.

Esta dimensión del problema, no sólo nos une a los terapeutas de familia entre sí, sino también con los sociólogos, antropólogos, juristas, educadores y todos aquellos interesados en entender e investigar el perfil de las distintas formas de organización familiar.

Hoy más que nunca, nuestra publicación se conforma como auténticamente multidisciplinaria, para ayudar a dar respuesta a todos estos interrogantes.

El Director

---

Pan y afectos: la organización doméstica en la producción y la reproducción

---

Dra. ELIZABETH JELIN

---

Pueyrredón 510, 7º piso, Capital Federal (CEDES)

---

*Este trabajo es parte del proyecto de investigación sobre "Unidad doméstica y nivel de vida en los estratos populares urbanos: estrategias de participación laboral y de consumo en Buenos Aires", que se desarrolla en el CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Buenos Aires). Dicho proyecto contó con el apoyo financiero de PISPAL, OIT, Fundación Ford, Fundación Interamericana y Population Council. Una versión modificada de este artículo se publica también en Estudios CEDES.*

---

## Introducción

Los procesos sociales ligados a la reproducción cotidiana y generacional de la población constituyen un complejo conjunto de mecanismos y organizaciones relativamente poco estudiadas en las ciencias sociales. La temática del **mantenimiento y reproducción** de la población en las sociedades occidentales capitalistas contemporáneas ha estado prácticamente ausente del análisis social durante décadas y ha sido redescubierta sólo recientemente. Las descripciones y análisis de estos procesos eran parte de la tradición etnográfica de la antropología, pero no se habían estudiado con el mismo rigor en las sociedades occidentales, centrales o periféricas, ni en las diversas variantes de las organizaciones sociales socialistas.

Este redescubrimiento estuvo ligado a diversos desarrollos temáticos en las ciencias sociales: por un lado los debates sobre la economía política del trabajo doméstico, estimulados por los movimientos sociales de liberación de la mujer y por nuevas

corrientes de análisis y crítica dentro de la tradición marxista (Malos, 1980). Por otro lado, la crisis de la economía del bienestar en las sociedades occidentales centrales, que ha puesto sobre el tapete, como cuestión social y políticamente significativa, el tema de los mecanismos sociales de protección y mantenimiento de los individuos y grupos sociales que no "trabajan"\*.

En el mundo académico, el descubrimiento y la politización del trabajo doméstico se dio, en la última década, como reacción a la sociología funcionalista de la familia. De manera esquemática, ésta planteaba que el proceso de modernización, en tanto involucra una creciente diferenciación y especialización institucionales, produce una especialización funcional de la familia. Las únicas funciones sociales que cumpliría la familia en el mundo moderno serían el apoyo emocional de los adultos y la socialización temprana de los niños. En esta perspectiva, la tarea doméstica —que incluye todas las actividades cotidianas de transformación final de bienes para el consumo y numerosos servicios personales— no parece existir ni requerir análisis y explicaciones. En tanto se realiza en el ámbito privado de la familia y el hogar, la importancia social de la tarea doméstica parece estar centrada en su valor como expresión del amor y la devoción de las mujeres y no como actividad material socialmente necesaria. Las situaciones de crisis en la materialización de ese trabajo "invisible", en parte producto del cuestionamiento de las mujeres de la "naturalidad" de su responsabilidad por el mismo, convirtieron al tema del mantenimiento cotidiano de la fuerza de trabajo y de los que no trabajan en una cuestión social y política relevante. En las ciencias sociales el tema se convirtió en objeto de reflexión y análisis.

Además del impacto de esta problematización proveniente de los países centrales, en el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina el origen de la preocupación puede rastrearse en el análisis de la vinculación entre procesos y estilos de

\* Entre comillas porque se refiere a la definición habitual de "trabajo", o sea, el trabajo remunerado.

desarrollo y la conformación de nuevos grupos sociales. Durante la década de los sesenta, esta vinculación se fue focalizando en la búsqueda de relaciones entre la dependencia externa, que dejaba su impronta en el estilo de desarrollo, y la marginalidad social, su consecuencia desde la perspectiva de las transformaciones en los sectores populares (Cardoso y Faletto, 1969; Nun, 1969; Kowarick, 1975). Este tipo de análisis se centró en la formación de nuevos grupos. La migración rural-urbana, desproporcionada con la absorción productiva alrededor de la industria moderna, fue vista como mecanismo de transformación de la marginalidad rural en marginalidad urbana (Quijano, 1968, Singer, 1975). Pero una mirada más en detalle a su organización económica y social dio lugar a reconsiderar el lugar de estos grupos sociales dentro de la nueva estructura urbana. Se pasó a reconocer cierto papel autónomo a los llamados "sectores informales" y a revalorizar sus rasgos creativos, a la vez que las articulaciones entre ellos y los sectores más dinámicos en dicha economía aparecían como más evidentes (Roberts, 1978; Peattie, 1979).

En el plano social, el análisis de la organización de las unidades productivas del sector informal implicó necesariamente una consideración explícita de la vinculación entre procesos de producción y de reproducción y mantenimiento, dadas las determinaciones recíprocas que existen entre ellos (Schmukler, 1981; Jelin, 1976). A su vez, en el plano macrosocial, la reconsideración de los grupos sociales subalternos en el proceso de desarrollo llevó a visualizar el medio urbano no sólo como la escena de ciertas formas productivas (la fábrica moderna o el comercio callejero) que dan lugar a actores diferenciados (la clase obrera, los marginados), sino como varios escenarios superpuestos vinculados. Entre ellos, cobró especial importancia la organización del consumo colectivo en el medio urbano (el uso de la tierra, el transporte, los servicios habitacionales, la salud, etc.), como determinante del nivel y el estilo de vida de los sectores populares. De ahí la consideración de la organización del consumo como dimensión crucial de la organización social. Además, durante los últimos años se ha dado un desarro-

llo específico de la investigación y la conceptualización de la familia y sus estrategias de sobrevivencia (Torrado, 1981).

Este trabajo se inscribe dentro de esta perspectiva que privilegia las actividades de mantenimiento y reproducción. Su objetivo es avanzar en una conceptualización que rescate la dinámica interna de la organización doméstica, basándola en las tareas y actividades concretas, materiales, "utilitarias" que en ella se realizan. Este enfoque no supone olvidar los lazos afectivos y las representaciones ideológicas y culturales que enmarcan y dan sentido a la organización doméstica, sino más bien anclar los afectos y las representaciones en los aspectos materiales de la vida cotidiana.

### El ámbito doméstico, el mundo público y la vida privada

La literatura antropológica se ha especializado en analizar y discutir la temática de la organización social de la familia y la reproducción (para una revisión reciente de toda esta área, Yanagisako, 1979). Un primer punto importante a rescatar de esta literatura es la distinción analítica entre grupo residencial, unidad reproductiva, unidad económica de producción y unidad de consumo. En base a trabajos ya clásicos sobre el tema, después de revisar las diversas conceptualizaciones y enfoques, Jack Goody propone:

"The phrase 'domestic group', is used in order to circumvent some of the definitional problems and introduce an element of flexibility. This phrase is an overall term for three main kinds of unit, namely the dwelling unit, the reproductive unit, the economic unit. The economic unit is again a generic term which covers the persons jointly engaged in the process of production and consumption. In agricultural societies (as well as in craft production) these units tend to be closely linked together; in industrial societies they are usually quite distinct" (Goody, 1972, p. 106).<sup>1</sup>

(Traducción de las citas en inglés al final del artículo)

Esta diferenciación analítica ha mostrado su utilidad comparativa, dada la enorme variabilidad intercultural en las formas de organización social. Su aceptación presenta dos problemas

básicos, uno de carácter empírico, otro analítico. Si las unidades sociales se van a diferenciar según su actividad específica, queda en manos de la investigación empírica la determinación de los grados y tipos de superposiciones, correspondencias y disyunciones en la membresía y límites de los grupos sociales corresidentes, la familia y las unidades de producción y consumo. También queda abierta la cuestión de las interrelaciones entre estas unidades\*.

En el plano analítico, el problema consiste en la formulación de jerarquías e interrelaciones explicativas entre las unidades, dimensiones y actividades, o sea, el planteo de hipótesis que señalan a ciertas dimensiones como principios organizativos sociales básicos, para permitir así la interpretación de variaciones y regularidades inter- e intra-sociales y la explicación de procesos de cambio. La cuestión clave, entonces, consiste en caracterizar la dimensión sustantiva definitoria del grupo doméstico y de los vínculos entre sus miembros. En esta dirección una fuerte corriente dentro de la antropología ha puesto el énfasis sobre los lazos de parentesco y la terminología correspondiente a los mismos, derivando de ellos los arreglos residenciales y la conformación de las unidades productivas y de consumo (Bender, 1967; Fortes, 1969). Alternativamente, otros estudios han puesto el énfasis sobre los mecanismos de transmisión de la propiedad, o sea las normas matrimoniales y hereditarias (Goody, 1976; Goody, Thirsk y Thompson, 1978). En algunos casos, hay una referencia explícita a la vinculación

\* Estas cuestiones cobran su verdadera dimensión cuando se incluyen las organizaciones domésticas de tradiciones culturales divergentes, tales como la familia china (Greenhalgh, 1980), o la organización social de diversas culturas africanas y asiáticas (Oppong, 1982; Goody, 1976). Las coincidencias y distinciones entre unidades domésticas, familias, grupos residenciales y viviendas han sido objeto de discusiones operacionales muy extensas, especialmente en los intentos de estandarizar los criterios de enumeración censal para asegurar la comparatividad intersocietal (Burch *et al.*, 1976). Este punto es también de importancia capital en los análisis sobre distribución del ingreso que toman en cuenta la composición familiar (Kuznets, 1976).

entre estos mecanismos y la organización productiva de la sociedad en cuestión (Meillassoux, 1977; Bourdieu, 1976).

Como señala Yanagisako, este enfoque puede ser útil cuando la propiedad es el elemento central que define y aglutina a las unidades domésticas. Pero,

"Where this is not the case, as among landless peasants, hunter-gatherers, or wage-laborers, we may usefully identify other significant components of family organization, including the commensal group, the production group, and the budget group in which reciprocal exchange occurs without accounting. However, ... the aggregate of people engaged in any of these activities may change throughout the production cycle, the exchange cycle, or the individual's life cycle. Consequently, it seems more analytically strategic to begin with an investigation of the *activities* that are central to the domestic relationships in each particular society" (Yanagisako, 1979, p. 186).<sup>2</sup>

Aceptar la propuesta de la autora, que privilegia las actividades domésticas, implica una delimitación inicial del foco de análisis. En nuestro caso, como ya fue señalado antes, el foco está en las actividades ligadas al mantenimiento y reproducción de la población en el marco de una organización productiva dada.

El término "reproducción" incluye analíticamente tres dimensiones o niveles: la reproducción biológica, que en el plano familiar significa el tener hijos y en el plano social se refiere a los aspectos socio-demográficos de la fecundidad; la reproducción cotidiana, o sea el mantenimiento de la población existente a través de las tareas domésticas de subsistencia; y la reproducción social, o sea todas las tareas extra-productivas dirigidas al mantenimiento del sistema social (Edholm, Harris y Young, 1977). El *ámbito doméstico* incluye básicamente las actividades de producción y consumo cotidiano de alimentos y otros bienes y servicios de subsistencia, así como las actividades ligadas a la reposición generacional, es decir, tener hijos, cuidarlos y socializarlos.

La elección del ámbito doméstico no implica concebirlo

como una unidad aislada del mundo social, ni identificar "lo doméstico" con "lo privado", en contraposición con el ámbito público del poder y la producción social. Ambos son errores corrientes en la literatura sobre el tema. En efecto, a partir de distinciones analíticas referidas a los contextos en los que se desarrollan actividades y a la normatividad que regula cada ámbito, ha habido una tendencia en las ciencias sociales a tomar la distinción entre el mundo doméstico y el público como si reflejara un corte tajante real, y a atribuirle significados y referencias que van mucho más allá de lo implicado en la conceptualización original de la distinción, hecha por Fortes (1969).

El problema no reside tanto en los referentes teóricos y empíricos del mundo público, sino en la confusión e identificación entre lo doméstico y el mundo privado, invisible desde el exterior, impenetrable y, por extensión, concebido como de relativa menor importancia social\*. Más aún, la distinción entre estos ámbitos ha sido identificada con la diferenciación sexual —los hombres a cargo de las tareas públicas, las mujeres de lo privado y doméstico— como si esto fuera una constante universal de la organización social. La indagación antropológica comparativa reciente muestra que el modelo de análisis basado en la contraposición entre el ámbito privado doméstico / las mujeres / la falta de poder y el ámbito público / los hombres / el poder, carece de base universal (Rapp, 1979a) y que la distinción es fundamentalmente de naturaleza cultural e ideológica\*\*.

El enfoque que aquí proponemos para abordar el ámbito doméstico parte de la crítica a estas concepciones dualistas y se nutre de ideas desarrolladas en los últimos años desde varias

\* Yanagisako, 1979, se refiere a la superficialidad de las descripciones del ámbito doméstico en los informes etnográficos, aún de antropólogos de primera línea, resultante de esta concepción.

\*\* Larguía y Dumoulin han extendido las implicaciones de esta distinción mostrando cómo la separación entre el trabajo visible y el socialmente invisible ha servido para enmascarar la subordinación de la mujer (Larguía y Dumoulin, 1975).

perspectivas convergentes. Desde la perspectiva de la "historia de las mentalidades" Donzelot ha presentado un convincente argumento sobre la presencia conformadora de "lo social" en el mundo de la familia,

"The method we have employed (posits) the family, not as a point of departure, as a manifest reality, but as a moving resultant, an uncertain form whose intelligibility can only come from studying the system of relations it maintains with the sociopolitical level. This requires us to detect all the political mediations that exist between the two registers, to identify the lines of transformation that are situated in that space of intersections". (Donzelot, 1979, p. XXV)<sup>3</sup>

Según el autor, la tarea del historiador, consiste en

"identifying lines of transformation fine enough to account for the singularities assigned to family roles... perceiving those roles as the strategic resultant of these diverse forms... This first object, the family, will thus be seen to fade into the background, overshadowed by another, the social, in relation to which the family is both queen and prisoner". (Donzelot, 1979, p. 7)<sup>4</sup>

El concepto clave para esta indagación histórica es el "policiamiento",

"not understood in the limiting, repressive sense we give the term today, but according to a much broader meaning that encompassed all the methods for developing the quality of the population and the strength of the nation" (Donzelot, 1979, p. 6-7).<sup>5</sup>

O sea, la familia y el mundo doméstico se ven conformados en relación al mundo público de los servicios, de la legislación, del control social, de la cambiante definición del ámbito de aplicación de la medicina, de los mecanismos de regulación de las imágenes sociales prevaletes sobre la familia y la "normalidad", de las ideologías e instituciones educativas, de las definiciones sociales del lugar y objetivo de la filantropía y la

caridad pública (Donzelot, 1979; Aries, 1962). Las transformaciones en todo este sistema de instituciones e ideas van dando forma históricamente al ámbito de la familia. En este enfoque, obviamente, lo doméstico y la familia no son vistos como parte del mundo privado, sino como parte de "lo social", aquello sobre lo cual se ejerce el policiamiento y el control.

Desde la perspectiva centrada en la revisión de las diversas teorías sociológicas y psicológicas sobre la familia, y con el objetivo de responder a las preguntas sobre el futuro de la familia, Ch. Lasch también pone al descubierto el grado de politización y desprivatización a la que esta institución es sometida (Lasch, 1977). Según este autor, el patriarcalismo tradicional ha sido erosionado por la invasión de las agencias sociales, de los profesionales y los expertos, minando las áreas de competencia de los propios miembros de la familia. Sin embargo, como muestra Donzelot, la penetración de "lo social" en el ámbito familiar no es una creación reciente debida a la creciente profesionalización de los servicios en Occidente, sino que se trata de una fuerza social que se fue transformando a lo largo de varios siglos de historia, ejercida a través de diversas instituciones sociales (la filantropía y la caridad, la legislación sobre menores y familia, las prácticas médicas, etc.).

La contribución a la discusión de este tema proveniente de los estudios de la mujer, se centra en el análisis de la identidad femenina, la división sexual del trabajo y las relaciones de poder. Dentro de esta perspectiva, una primera corriente intelectual ancla la subordinación de la mujer en la dualidad público / doméstico identificada con la diferenciación hombre / mujer. La posición subordinada de la mujer es explicada por su especialización a las actividades domésticas:

"In general terms, domestic obligations and demands appear to help us understand why women everywhere are limited in their access to prestigious male pursuits" (Rosaldo, 1980, p. 399)<sup>6</sup>

El sistema de relaciones sociales que define la identidad

femenina parece casi deducible de los hechos biológicos de la reproducción.

La crítica a esta visión dualista enfatiza el carácter público y social, real o potencial, de la actividad doméstica a cargo de las mujeres. Yanagisako, por ejemplo, concluye la revisión crítica de la bibliografía sobre la organización doméstica sosteniendo que "domestic relationships are part and parcel of the political structure of a society"<sup>7</sup>. (Yanagisako, 1979, p. 181). En un artículo reciente, Elshtain critica las posturas arquetípicas del feminismo y el anti-feminismo: el feminismo que reivindica una identidad pública para las mujeres en pie de igualdad con los hombres, rechazando su papel e identidad ligada al ámbito doméstico, y la postura tradicional, que acepta la diferenciación sexual correlacionada con la distinción público/privado. Para plantear su posición, la autora hace una analogía con la leyenda de Antígona:

The standpoint of Antigone is of a woman who dares to challenge public power by giving voice to familiar and social imperatives and duties... To recapture this voice and to reclaim that standpoint, and not just for women alone, it is necessary to locate the daughters of Antigone where, shakily and problematically, they continue to locate themselves; in the arena of the social world where human life is nurtured and protected from day to day. This is a world women have not altogether abandoned, though it is one both male-dominant society and some feminist protestors have devalued as the sphere of 'shit-work', 'diaper talk' and 'terminal social decay'. This is a world that women, aware that they have traditions and values, can bring forward to put pressure on contemporary public policies and identities... To define this world simply as the 'private sphere' in contrast to the 'public sphere' is to mislead. For contemporary Americans, 'private' conjures up images of narrow exclusivity. The world of Antigone, however, is a *social* location that speaks of, and identities that are unique to a particular family, on the one hand, but, on another and perhaps even more basic level, it taps a deeply buried human identity, for we are first and foremost not political or economic man but family men and women". (Elshtain, 1982, pp. 55-56).<sup>8</sup>

En este caso, convergente con la argumentación de Donzelot, se privilegian los aspectos políticos y sociales implicados en la esfera doméstica de la reproducción y el consumo (Jelin, 1982a). En resumen, el ámbito doméstico que nos interesa caracterizar y estudiar se delimita por el conjunto de actividades comunes o compartidas ligadas al mantenimiento cotidiano de un grupo social, que se conforman y cambian en su relación con las demás instituciones y esferas de la sociedad. En esta relación, la organización doméstica no cumple solamente un papel adaptativo o "funcionalmente necesario" para la reproducción social sino que contiene en sí un potencial de innovación y politización que se extiende más allá de sus límites.

### Familia y unidad doméstica a lo largo del ciclo de vida

La elección de la unidad doméstica como foco de análisis se justifica por ser la organización social cuyo propósito específico es la realización de las actividades ligadas al mantenimiento cotidiano y la reproducción generacional de la población. Ahora bien, ¿qué es una unidad doméstica?, ¿cuáles son los parámetros estructurales de su composición y los criterios de reclutamiento de sus miembros?, ¿cómo varía y se recompone esa unidad a lo largo del ciclo de vida de sus miembros?

Un primer punto que requiere atención es la distinción analítica entre unidad doméstica y familia. La familia como institución está anclada en procesos biológicos básicos: la sexualidad y la procreación, constituyendo el marco de la organización social de estos dos procesos. A su vez, la familia está incluida en una red más amplia de relaciones —obligaciones y derechos— de parentesco, guiadas por reglas y pautas sociales establecidas. La importancia social de la familia, sin embargo, va más allá de la normatividad de la sexualidad y la filiación. La familia también constituye un grupo social de interacción, en tanto grupo co-residente que coopera económicamente en las tareas cotidianas ligadas al mantenimiento de sus miembros (Murdock, 1949).

Las actividades comunes ligadas al mantenimiento cotidiano



definen unidades domésticas, en las cuales se combinan las capacidades de sus miembros y recursos para llevar a cabo dichas tareas de producción y distribución. En tanto tales,

"household activities are continuously part of the 'larger' processes of production, reproduction, and consumption; as such, they vary by class. Household activities cannot be analyzed as separate from the socioeconomic relations of the societies in which they are embedded" (Rapp *et al* 1979, p. 176)<sup>9</sup>

Volveremos sobre el tema de la vinculación entre las unidades domésticas y los procesos sociales más amplios de producción y reproducción en la sección siguiente. En ésta, nos interesa volver a la distinción entre unidad doméstica y familia.

La familia constituye la base de reclutamiento de las unidades domésticas, develando un aspecto significativo de la normatividad social:

"It is through their commitment to the concept of family that people are recruited to the material relations of households. Because people accept the meaningfulness of family, they enter into relations of production, reproduction, and consumption with one another—they marry, beget children, work to support dependents, transmit and inherit cultural and material resources. In all of these activities, the concept of family both reflects and masks the realities of household formation and sustenance. It also glosses over the variety of experiences that social categories of persons have within households. These experiences alter radically depending on gender, generation and class". (Rapp *et al.*, 1979).<sup>10</sup>

Empíricamente, la mayoría de las unidades domésticas está compuesta por miembros emparentados entre sí, pero el grado de coincidencia entre la unidad doméstica y la familia, y más aún, la definición social de la amplitud (en términos de lazos de parentesco) del grupo co-residente, varían notoriamente entre sociedades, a lo largo de la historia, entre grupos sociales en una misma sociedad y a lo largo del ciclo de vida de sus miembros. No es éste el lugar para tipificar las posibles variacio-

nes históricas y culturales que pueden presentar empíricamente la composición de las unidades domésticas y sus vínculos con familias y redes de parentesco, tema vasto que ha sido abordado desde diversos ángulos disciplinarios y analíticos. Así, en una perspectiva comparativa, la diferenciación de unidades domésticas ha sido abordada según su relación con los procesos de cambio en la economía mundial (Wallerstein y Martin, 1979). Desde la perspectiva de la demografía histórica y la historia de la familia, la discusión se ha centrado en los cambios en el tamaño y composición de las unidades domésticas (Laslett, 1972; Berkner, 1972 y 1975). También se han aplicado modelos de análisis basados en el ciclo de vida y el ciclo doméstico a datos históricos, resultando en contribuciones que destacan, por ejemplo, las circunstancias e importancia de la presencia de pensionistas y huéspedes en ciertos sectores sociales (Hareven, 1977), los cambios en los criterios y patrones matrimoniales (Modell *et. al.*, 1978), y las transformaciones en los patrones que rigen las transiciones en el ciclo de vida (Hareven, 1978). En otra línea de indagación, los estudios recientes en antropología urbana han puesto el énfasis en la importancia de redes de relaciones de parentesco amplias en la realización de las tareas ligadas al mantenimiento cotidiano de los miembros de las unidades domésticas (Lomnitz, 1975; Stack, 1974b; Ramos, 1981). Así, Stack ha mostrado que entre los negros pobres en áreas urbanas de los Estados Unidos, la unidad relevante para estas actividades cotidianas es la "red doméstica", más que el hogar. La red doméstica es una red extensa de parentesco, donde las relaciones recíprocas están dadas por los niños, por matrimonios y por amistades, que se alían para satisfacer las funciones domésticas. Este núcleo está disperso en varios hogares. Lo interesante es que las fluctuaciones en la composición de hogares individuales no alteran estos arreglos cooperativos más amplios (Stack, 1974a).

Circunscribiendo nuestro foco a la composición de las unidades domésticas en el mundo urbano contemporáneo, además de las consideraciones ligadas a la inserción de la unidad doméstica en los procesos sociales de producción y reproducción más

amplios, que discutiremos en la sección siguiente, interesa mencionar que la composición, de la unidad doméstica, siempre normada por los lazos familiares, es el resultado de diversos procesos a lo largo del ciclo vital de sus miembros. Por un lado, están los acontecimientos ligados a la historia de la formación de la familia, incluyendo matrimonios, separaciones, nacimientos y muertes, así como las mudanzas, migraciones y otros accidentes o decisiones en coyunturas específicas, pero que dejan sus rastros en la composición del grupo doméstico futuro. Por otro lado, desde el contexto socio-político, importan los cambios en la situación económica y política en que ocurren las transiciones a lo largo del ciclo de vida, ya que estas situaciones suelen influir en la forma de organización doméstica en ese momento específico, y éste, a su vez, en la manera como se mantiene o cambia posteriormente. Es decir, la organización doméstica tiende a mantenerse a lo largo del tiempo según un patrón de actividades y de asignación de tareas, responsabilidades y autoridad establecido. Los cambios se producen como resultado de transiciones en el ciclo de vida de los miembros o como respuesta a situaciones coyunturales especiales —internas o externas— que requieren un ajuste en las estrategias acostumbradas.

Así, podemos tomar el modelo ideal de familia que intenta establecerse como unidad doméstica independiente en el momento del matrimonio. El que lo logre o no en ese momento es el producto de los recursos con los que cuenta la pareja y a su situación en relación a condiciones externas a su control. Por ejemplo, una condición externa relevante es la política de vivienda seguida por el gobierno, ya que ésta determinará el mercado de la vivienda en ese momento dado y el rango de posibilidades de acceso que una pareja específica tendrá. En el contexto más inmediato de esa misma pareja, podrá o no establecerse como unidad autónoma según el tipo de vínculo y los compromisos que cada uno de los cónyuges tenga con su familia: madres viudas o enfermas, negocios o propiedades familiares, nuevamente condicionan las opciones con las cuales los sujetos se enfrentan.

La historia posterior es compleja y multidimensional: la llegada de hijos, los cambios en los compromisos y responsabilidades hacia las familias de orientación de ambos miembros, la ayuda que pueden recibir de las redes informales, cambios en la política estatal o en el mercado de vivienda, etc., van condicionando las opciones y elecciones abiertas según las modificaciones en los recursos monetarios de los miembros de la pareja. Estas opciones no son racionalmente evaluadas de manera constante, sino que se actualizan en los momentos de transiciones significativas en el ciclo de vida del grupo familiar —nacimiento de hijos, muertes de padres, casamientos de hermanos, separaciones, etc.— o en momentos de crisis directa o indirectamente ligados a la vivienda —desalojos, cambios en la legislación de alquileres, acceso a créditos especiales, etc.

De este modo, si bien es de esperar que en todo momento específico la mayoría de los grupos domésticos estén compuestos por personas que guardan entre sí vínculos familiares inmediatos, la inclusión o exclusión de ciertos miembros no está dictada de manera unívoca por la cercanía del vínculo de parentesco, ni puede explicarse únicamente por la situación presente de los miembros de la unidad doméstica. Padres cuyos hijos no viven con ellos, que a su vez tienen a su cargo otros hijos de parientes más o menos cercanos, patrones de residencia doble (hijos de padres separados, por ejemplo, o abuelas que viven alternativamente en casa de sus varios hijos) constituyen fenómenos comunes, que deben ser tenidos en cuenta en cualquier trabajo de investigación\*.

La falta de coincidencia entre unidad residencial y núcleo de parentesco, a su vez, trae a la superficie otro problema importante, habitualmente olvidado en los análisis centrados en la unidad de residencia: por definición, los lazos de parentesco

\* Debe mencionarse que por lo general, los estudios socio-económicos toman la composición del hogar como variable explicativa o como variable de control de otros fenómenos, sin hacer la pregunta inversa sobre los *determinantes* de la composición de las unidades residenciales. Una excepción a esta regla es el creciente interés en el estudio de unidades residenciales con jefes mujeres (Buvinic y Youssef, 1978).

hacia afuera de la unidad son diferentes para los diversos miembros de la unidad. Cada miembro de la unidad tiene una red de relaciones familiares, con el sistema de relaciones mutuas, reciprocidades, derechos y deberes, relativamente independiente de las redes del resto de los miembros. La múltiple pertenencia a diversos grupos familiares implica a su vez que el grado de participación de cada miembro de una unidad doméstica en las actividades de dicha unidad puede ser significativamente diferente, dependiendo de las obligaciones y derechos que tiene en la red de relaciones familiares fuera de su unidad. Y esto, obviamente, varía según el estadio del ciclo vital de la persona en cuestión. Más sistemáticamente, los diversos miembros de una unidad doméstica contribuyen de manera diferencial a las tareas de mantenimiento cotidiano. Tanto en términos de los recursos monetarios incorporados a la unidad, como del tiempo personal dedicado a dichas tareas, el aporte de cada uno de los miembros a la actividad común varía según el tipo de obligaciones y deberes hacia afuera que cada miembro tiene. Al mismo tiempo, las unidades domésticas no necesariamente concentran todas las actividades ligadas al mantenimiento de sus miembros. Para algunas áreas de consumo, especialmente las de mantenimiento cotidiano —comida, higiene, limpieza, etc.— el grupo doméstico parecería ser la unidad social básica. Pero otras, incluyendo la salud, la vivienda y el equipamiento doméstico, pueden llevarse a cabo en unidades más amplias (redes de parentesco, barrio o comunidad) o más pequeñas (individuos aislados) que la unidad doméstica misma. En las áreas ligadas con la reproducción generacional de la población, las relaciones familiares, coincidan o no con el grupo doméstico, constituyen las relaciones sociales fundamentales.

En otras palabras, los límites de la unidad doméstica y la familia son sumamente permeables. Pero el grado de integración a las actividades de la unidad doméstica y el compromiso con esas actividades no varían al azar. Existen patrones sociales que diferencian el compromiso esperado para diversos miembros según su ubicación dentro de la unidad en términos de edad, sexo y relación de parentesco con los demás miembros. Lo que

se espera de la hija mujer niña es diferente de la adolescente, y por supuesto, del adolescente varón. Y se espera un patrón de comportamiento diferente para la madre y el padre, para hermanos, tíos y abuelos. O sea, para volver a algo mencionado más arriba, aunque la institución social cargada de afectividad es la misma, “la familia” tiene significados y es experimentada de maneras muy diversas por individuos de distinto sexo, edad y clase social\*.

Metodológicamente este planteo implica un doble camino en el proceso de investigación: se parte de una definición provisoria, empírica, del grupo doméstico compuesto por las personas que habitualmente residen en una unidad de vivienda. A partir de la desagregación y análisis de las redes de relaciones y del patrón de actividades de cada uno de los miembros, se puede explorar la utilidad analítica del concepto de unidad doméstica. Si los resultados de la investigación justifican la reconstrucción de los patrones sociales en ese nivel de agregación, la unidad doméstica cobra entidad conceptual en tanto corresponde a la estructura en que las redes de relaciones sociales de los diversos miembros convergen, cristalizadas, en una organización social con vida propia. En esta tarea, el estudio longitudinal basado en historias de vida de los miembros constituye una herramienta fundamental para detectar el grado de estabilidad en la composición de las unidades domésticas, así como las regularidades y patrones de cambio. A su vez, estudios comparativos internacionales, entre clases sociales y grupos, podrán mostrar los cambios en el grado de convergencia y cristalización de las relaciones sociales de parentesco y de las actividades ligadas al mantenimiento de la población en unidades domésticas.

\* El uso de una única palabra, “familia”, para designar experiencias diversas apunta a una universalización ideológica de un concepto que, aunque con referentes específicos en la experiencia de diferentes categorías sociales, es utilizado *como si* describiera una experiencia uniforme. Rapp, 1979b, p. 178.

## La unidad doméstica en la producción y reproducción

Las actividades de las unidades domésticas revelan los vínculos materiales que las conectan con los procesos sociales más amplios de producción y reproducción. En términos de la inserción en el proceso productivo, las unidades domésticas basadas en el trabajo asalariado de sus miembros se diferencian de las unidades productivas de base familiar (sean campesinas, artesanales, comerciales o de servicios), y éstas de las basadas en trabajo ocasional e inestable. En términos de la reproducción, como señala Rapp:

"Reproductive relations organize a social context for biology —different patterns of sexuality, of marriage, of fertility produce not only human beings; but they also produce participants in relations between the genders and the generations. In its broader sense, reproduction refers to all the activities in which households recreate themselves and in the process, contribute to the reproduction of the total society. Patterns of inheritance, domestic cycles, strategies for migration and employment are simultaneously part of household and of general social reproduction. It is through these relations of production and reproduction that conditions originating in larger arenas of society are internalized and experienced (and sometimes inverted or resisted) within households. Because households activities link members directly into the relations which continuously produce and reproduce the whole society, households can be seen to vary systematically by class in their ability to gain access to, accumulate, and transmit resources". (Rapp, *et al.* 1979, p. 176/77).<sup>11</sup>

Una parte importante de las actividades reproductivas de la unidad doméstica tiene que ver con actividades concretas de consumo. El consumo de los bienes y servicios que produce el sistema económico requiere tiempo y trabajo. Como señala Galbraith, en la sociedad occidental moderna, este trabajo es realizado fundamentalmente por la familia y especialmente por las mujeres. La tarea realizada por ellas no tiene compensación

monetaria sino que es justificada en términos de la "virtud social" (Galbraith, 1973).\*

Desde el ángulo del consumo, influyen en las actividades domésticas, además del funcionamiento del mercado, la provisión de bienes y servicios de naturaleza colectiva. Existen dos tipos claramente diferenciados de consumos colectivos. Por un lado, los servicios públicos o colectivos ligados al mantenimiento de la población como un todo (transporte, drenaje, electricidad y gas, saneamiento, etc.). Aunque éstos pueden estar organizados empresarialmente con fines de lucro, requieren coordinación y regulación centralizada del espacio social. La experiencia histórica muestra que la ampliación de estos servicios está ligada a la acción directa del estado, ya que no resultan suficientemente rentables para atraer la inversión privada. En consecuencia, se constituyen como servicios sujetos a los vaivenes de la política social del estado (Castells, 1976). Por otro lado, existen los servicios sociales de bienestar dirigidos a establecer el nivel social mínimo de bienestar de la población (en términos de salud, educación, etc.) a ser asegurado por el estado. La justificación de estos servicios se basa en la obtención de derechos y beneficios como extensión de la ciudadanía social. Otra parte de la política social de bienestar está dirigida a responder a la cuestión de quién se hace cargo del mantenimiento de las personas que no son autosuficientes, o sea, de aquellos cuyo ingreso monetario es inexistente o insuficiente para cubrir los costos correspondientes. Se trata entonces de la política que determina los mecanismos sociales de transferencias de ingresos y consumos.

Contrastan en esto el modelo del "estado de bienestar" que asume colectivamente los costos de estas tareas y actividades y el modelo liberal de la economía de mercado pura, que implica

\* "The convenient social virtue ascribes merit to any pattern of behavior, however uncomfortable or unnatural for the individual involved, that serves the comfort or well-being of, or is otherwise advantageous for, the more powerful members of the community".<sup>12</sup> (Galbraith, 1973, p. 30). Galbraith identifica el papel de la mujer en el consumo como "crypto-servant role of administrator" (p. 37).

que estos costos de mantenimiento deben ser cubiertos individualmente, o mejor dicho por las unidades domésticas de las cuales estas personas (niños, ancianos, enfermos, amas de casa, estudiantes, desocupados) son miembros. Las políticas sociales de transferencias entre categorías sociales han variado históricamente y entre sociedades. En la última década, a nivel ideológico y político de numerosas sociedades occidentales, incluyendo las latinoamericanas, hemos presenciado un fuerte embate de la ideología "de mercado", tendiente a incrementar la "privatización" de esos costos\*.

Dejaremos de lado aquí las variaciones inter-sociales en la organización productiva y reproductiva, y concentraremos la atención específicamente en la situación de los sectores subalternos en el mundo urbano actual. En esta realidad, la inserción de las unidades domésticas en los procesos sociales de producción, reproducción y consumo definen las posiciones de clase y la capacidad de acceder, acumular y transferir recursos. En principio, podemos caracterizar tres tipos de unidades domésticas populares urbanas, definidas en función de la inserción predominante de sus miembros en el sistema productivo: la unidad doméstica obrera, la pequeña empresa familiar y la organización social de la pobreza.

La base económica de la familia obrera, que permite su persistencia y reproducción, es el trabajo asalariado de sus miembros. La separación entre lugar de trabajo y hogar es clara y nítida. Por supuesto, el volumen de fuerza de trabajo que la unidad vende en el mercado varía:

"How much labor-power a working class household needs to send out is determined by many things: the cost of reproducing (or maintaining) the household, the workcareers and earning trajectories of individual members, and the domestic cycle (that is, the relations

\* Este embate se manifiesta programáticamente en propuestas tales como las de M. Freedman, *Freedom to choose*, y en políticas concretas de numerosos países, desde Estados Unidos e Inglaterra hasta Chile y Argentina.

between the genders and the generations, which specify when and if wives and adolescent children are available to work outside the home)". (Rapp, 1978, p. 283).<sup>13</sup>

La unidad doméstica obrera contiene dentro de sí puntos de tensión y contradicción: en efecto, la relación de producción básica se establece en el mercado de trabajo entre miembros individuales de la unidad doméstica que venden su fuerza de trabajo a cambio de salarios y beneficios sociales, mientras que la unidad doméstica basa su existencia en la colectivización y en la solidaridad de sus miembros. Dada la individuación de la participación en la fuerza de trabajo y en la percepción de los ingresos monetarios, los lazos dentro de la unidad doméstica deben ser muy fuertes para lograr contrarrestar las tendencias centrífugas e individualizadoras del mercado. La ideología de la familia, basada en el amor y el ideal de familia nuclear constituyen sin duda elementos de este cemento.

Una segunda fuente de contradicciones proviene de la distancia entre ideales y realidad. Idealmente, la familia nuclear es la constituyente de la unidad doméstica obrera, debiendo ser autónoma y autosuficiente en cuanto a los recursos necesarios para su mantenimiento y reproducción. Sin embargo,

"the ideal autonomy of an independent nuclear family is constantly being contradicted by the realities of social need, in which resources must be pooled, borrowed, shared. It is women who bridge the gap between what a household's resources really are, and what a family's position is supposed to be". (Rapp, 1978, p. 288).<sup>14</sup>

La inserción estable de las mujeres en una red de parentesco y vecindad funciona como mecanismo de ajuste para la estabilidad de la unidad doméstica obrera (Ramos, 1981, Lomnitz, 1975).

En contraposición con la estabilidad de la familia obrera, un segundo tipo de organización doméstica urbana —en la cual la familia obrera puede caer temporaria o definitivamente— es la de los sectores con una inserción inestable en el mercado de trabajo. En este caso, el ingreso monetario ligado a la venta de

la fuerza de trabajo no existe o resulta insuficiente para el mantenimiento y reproducción de la unidad, con lo cual ésta pierde su autonomía y autosuficiencia. A menudo esto implica una alta inestabilidad en la composición de la unidad doméstica y en los lazos familiares, y una apelación constante a las redes de relaciones informales y/o a los mecanismos de bienestar social, si es que existen. Esta inestabilidad puede ser temporaria y pasajera, ligada a procesos migratorios o momentos de transición en los que los individuos mantienen lazos en diversas unidades domésticas. El caso más típico es el del migrante campesino estacional que mantiene vínculos en su lugar de origen (Arizpe, 1981; Balán, 1982). Pero existe una inestabilidad crónica, manifiesta como constante de la realidad urbana, variando su magnitud e importancia social según la coyuntura económica de cada país (especialmente las tasas de desempleo) y la política de bienestar.

Finalmente, un tercer tipo de unidad doméstica de los sectores populares es la empresa familiar basada en el trabajo de los miembros, siendo al mismo tiempo una unidad productiva y reproductiva. En ella, las tareas domésticas y las tareas para la economía de intercambio no se distinguen con nitidez, no existe separación espacial entre el lugar de trabajo y el ámbito doméstico, ni tampoco una clara división del trabajo entre sexos y generaciones, aunque sí de poder y autoridad. Si bien la mujer-madre tiene a su cargo la responsabilidad por el trabajo doméstico, su participación en la empresa familiar puede ser significativa, al igual que la de los hijos. Los lazos intrafamiliares son en este caso reforzados por la unificación de las tareas productivas y reproductivas, dentro de un marco de diferenciación interna de poder y líneas de autoridad. La individuación y autonomización de los miembros subalternos —esposa e hijos— puede resultar más difícil y conflictiva, en tanto la lógica de reproducción de la unidad se basa en la participación en el trabajo familiar sin remuneración.

Por supuesto, estos tres tipos no se encuentran de manera pura y totalmente diferenciada. Las transiciones entre uno y otro son fluidas y existen numerosos casos mixtos. Al mismo

tiempo, en tanto las condiciones de vida de los sectores populares dependen de condiciones macrosociales comunes —tales como a) el nivel de actividad económica y la situación del mercado de trabajo, b) los servicios sociales producto de la política de bienestar y de las luchas sociales, y c) la existencia y vigencia de canales de expresión de intereses— la homogeneidad relativa en la posición de los sectores subalternos en el mundo del consumo y la reproducción crea condiciones de unificación de la condición popular, por encima de las diferencias en términos de la inserción productiva.

#### La dinámica interna: la unidad doméstica como organización formal

En un conocido manual de sociología, el capítulo dedicado a las organizaciones formales comienza señalando que:

"There is a fundamental difference between activities that are systematically planned to achieve some purpose and those that are spontaneous. Generally we call systematically planned, purposeful activities 'work' and spontaneous activities 'leisure', or 'play' ... sociologists often call work 'instrumental activities' and play 'expressive activity' ... But the most important distinction ... is whether a man plans his own activities, or whether his activities are *planned for him* ... Any social arrangement in which the activities of some people are systematically planned by other people (who, therefore, have authority over them) in order to achieve some special purpose is called a *formal organization*". (Stinchcombe, 1967, p. 154-155).<sup>15</sup>

Desde esta perspectiva, una unidad doméstica, dedicada a realizar una serie de actividades cotidianas dirigidas al mantenimiento de sus miembros sobre la base de una división del trabajo y de responsabilidades entre los mismos, con actividades y rutinas establecidas para cada uno, es una organización formal. Esto no niega la existencia de otros aspectos importantes y significativos de las unidades domésticas —especialmente los componentes afectivos y los lazos de parentesco, que incluyen la transmisión intergeneracional de deberes, derechos, ideologías

y formas de organización social. Pero la aplicación del modelo de las organizaciones formales a las unidades domésticas se justifica cuando el objetivo —como en el presente caso— es resaltar los aspectos instrumentales de la unidad doméstica, para así poner al descubierto actividades y relaciones sociales reales pero que, hasta ahora, han permanecido relativamente invisibles para la sociedad.

En primer lugar, como en toda organización, existe un propósito específico hacia el cual se dirigen las actividades planificadas de un conjunto de personas. En el caso de la unidad doméstica, este propósito específico puede ser caracterizado de manera muy global —asegurar el mantenimiento y reproducción de sus miembros, según criterios y parámetros que hacen alusión a un “nivel de vida adecuado”. Este propósito resulta difícil de aprehender. Teóricamente podría definirse un umbral mínimo de satisfacción de ciertas necesidades biológicas (comer o dormir) para la sobrevivencia. Pero el mismo proceso de satisfacción de estas necesidades biológicas mínimas, en tanto las actividades requeridas se desarrollan como relaciones sociales con significados, crea los fundamentos de la organización social y cultural. Es decir, aún las necesidades biológicas tienen un componente social en el proceso de su satisfacción. De hecho, las necesidades a ser satisfechas son histórica y culturalmente variables para los diversos grupos o clases de la población\*.

En el nivel micro-social de la unidad doméstica, la definición de las necesidades va cambiando a lo largo del ciclo doméstico, en tanto el nivel de vida (como patrón de consumo ligado a la satisfacción de necesidades “normales” para un grupo social en un período dado) se va definiendo a lo largo

\* Existen dificultades analíticas múltiples con el concepto de necesidades. Existen diversas definiciones del mismo; desde las administrativo-burocráticas o normativas, que incluyen las discusiones sobre el concepto de “necesidades básicas”, hasta las que hacen referencia al punto de vista de los actores o a las definiciones sociales compartidas ligadas a la noción de bienestar o nivel de vida adecuado o normal. Heller, 1976; Leiss, 1976.

del curso biográfico-histórico de la unidad en cuestión y de cada uno de sus miembros\*\*. En esta determinación intervienen: a) la combinación de las necesidades de cada uno de los miembros, de acuerdo con su inserción social (edad, sexo, ocupación); b) la adaptación cambiante de las necesidades domésticas a las coyunturas económico-sociales variables a lo largo del ciclo doméstico; y c) la propia historia del grupo doméstico, en tanto proceso temporal de acumulación (o pérdida) de recursos necesarios para las actividades ligadas al mantenimiento de los miembros.

La temática de la satisfacción plantea una dificultad adicional: la diferencia entre el nivel de definición de necesidades como parte del modelo de análisis (de acuerdo a parámetros externos a los actores) y la propia definición social de las necesidades. En la lógica del sentido común, se define como necesidad aquello de lo cual se carece, para lo cual no se cuenta con el stock de recursos para su satisfacción. Por ejemplo, la vivienda es, desde un punto de vista teórico, una necesidad constante de los grupos domésticos. Para ellos, en cambio, sólo se percibe como necesidad cuando no existen los recursos —producto de actividades pasadas— para satisfacer la necesidad de habitación. O sea, en la definición que cada grupo social hace de sus necesidades, éstas son identificadas con las “carencias”, es decir, con aquellas necesidades que no pueden ser satisfechas con los recursos habitualmente disponibles.

En síntesis, el propósito de la unidad doméstica es la realización del conjunto de actividades ligadas al mantenimiento de sus miembros, según estándares culturalmente definidos como un “nivel de vida normal”. Y esta “normalidad” debe, a su vez, ser descompuesta en la normalidad estadística de los comportamientos más comunes entre los miembros de un grupo, la normalidad en el plano de las creencias y en el plano de los valores. (Skolnick, 1975).

\*\* Sobre el nivel macrosocial de bienestar y el grado de desigualdad en la distribución social de los servicios correspondientes, existe una vasta literatura que va desde los clásicos de la economía del bienestar (Pigou) hasta el análisis de los servicios y derechos urbanos.



En segundo lugar, llevar a cabo las actividades ligadas a la satisfacción de las necesidades requiere el acceso a los *recursos* para realizarlas. Como en toda organización, la obtención de recursos es problemática y la unidad doméstica debe elaborar mecanismos para su obtención o creación, para su defensa, para su recreación o reproducción continua, y para su administración. Para el caso de las unidades domésticas de los sectores populares urbanos, los recursos pueden provenir de distintas fuentes —el trabajo y esfuerzo directo de los miembros, las transferencias formales de instituciones reconocidas para ese fin (especialmente el estado) y las transferencias informales basadas en redes de intercambio y ayuda mutua. A su vez, los recursos pueden ser monetarios o en bienes o servicios de uso directo. Combinando ambos criterios:

| FUENTE DE OBTENCION                                        | TIPO DE RECURSO                              |                                                                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Monetario                                    | No-monetario                                                      |
| Trabajo de integrantes                                     | Participación en la fuerza de trabajo        | Producción doméstica                                              |
| Transferencias formales (del estado, sindicatos, etcétera) | Pensiones, jubilaciones                      | Acceso a servicios públicos, obras sociales, subsidios indirectos |
| Transferencias informales (de parientes y vecinos)         | Ayuda mutua basada en reciprocidad / trueque |                                                                   |

Para estudiar el proceso de creación, defensa, reproducción y administración de recursos a lo largo del tiempo podría partirse de la situación ideal de constitución de la familia/unidad doméstica en el momento del matrimonio. En ese momento, los cónyuges traen a la **nueva empresa** algunos recursos materiales (desde el ajuar de la novia hasta los regalos de casamiento, enseres domésticos básicos, quizás inclusive la vi-

vienda propia) y su tiempo-qua-capacidad de trabajo, a ser vendida en el mercado de trabajo o utilizada en actividades domésticas. Traen también un “capital social”, consistente en la red de relaciones sociales de parentesco y amistad basada en la reciprocidad, a la cual se puede acudir para ciertos servicios a cambio de prestar otros. Y traen un capital de información sobre el mercado de bienes y servicios requeridos para las actividades ligadas a la satisfacción de las necesidades (conocimiento de vías de transporte, obras sociales, servicios médicos, etc.). A medida que pasa el tiempo, la estructura de la unidad doméstica se puede ir modificando, con la adición de nuevos miembros y la separación de otros. A su vez, la composición de los recursos también va variando. Existe una expectativa social de que el “capital económico”, la infraestructura doméstica básica, vaya aumentando y mejorando, adecuándose a las cambiantes necesidades del grupo (mejoras en la vivienda, equipamiento doméstico, etc.). Igualmente, lo que podría llamarse el “capital social” (siguiendo la terminología, aunque no estrictamente la conceptualización, de Bourdieu, 1977) también debe ser aumentado y recreado constantemente. Al respecto, para mantener la red de reciprocidad es necesario activarla constantemente, a través de intercambios cuya función es siempre doble: obtener o prestar el bien o servicio específico del cual se trata y al mismo tiempo “aceitar” el sistema de relaciones de reciprocidad para mantenerlo en funcionamiento (Ramos, 1981). Y también es necesario mantener y actualizar lo que, analógicamente, podría denominarse el “capital cultural” de las actividades domésticas, es decir, el conjunto de informaciones sobre recursos y fuentes para su obtención (desde cambios de horarios en la atención de un hospital, nuevos derechos que adquiere un obrero en relación a las asignaciones familiares, manejo de trámites y estructuras burocráticas, etc.).

Por otro lado, la capacidad de trabajo de los miembros también cambia a lo largo del tiempo. La asignación de esa capacidad de trabajo a la obtención de ingresos monetarios o a la producción doméstica constituye una de las áreas cruciales de la organización doméstica.



La unidad doméstica reproduce sus recursos para la venta de su producto —la capacidad de trabajo de sus miembros, actualizada por las tareas de mantenimiento que se realizan en el seno doméstico. Pero además, y en esto se diferencia de una empresa, requiere una operación ideológica: la de convencer a esos miembros de incorporar los recursos monetarios obtenidos a la estructura doméstica. Esta operación —parecida a la que debe realizar una organización de bien público para obtener sus recursos— contiene fuertes elementos ideológico-políticos: es necesario convencer al donante o inversor que la inversión que haga en esa organización le traerá beneficios futuros o que tiene una obligación “tradicional” hacia esa organización. La tipificación de los roles sexuales (el hombre “jefe de familia” proveedor de recursos y la mujer que cuida el hogar y los hijos) y el sistema de deberes y obligaciones entre padres e hijos constituyen los pilares ideológicos tradicionales sobre los que se apoya esta operación.

En cuanto a la administración de los recursos y su asignación a las diversas actividades, alguien debe hacerse responsable de las actividades, y de velar para que los recursos no sean utilizados para fines diferentes a los prescriptos. Existe la necesidad de organización, control y disciplina internos. Estas tareas son tradicionalmente asignadas a la mujer-ama de casa, aunque la responsabilidad por la organización doméstica que tiene la mujer no siempre le otorga poder. Su papel puede ser delegado o autónomo y puede contar con grados diversos de discreción y autoridad para implementar la división intradoméstica del trabajo. En parte, estas son cuestiones referentes no a la administración de los recursos, sino al sistema de autoridad y control dentro de la organización.

En resumen, para realizar las actividades prescriptas y planificadas, la unidad doméstica requiere recursos diversos. Como señala Stinchcombe en relación a toda organización formal, la defensa de los recursos y la recreación de los mismos son los principales problemas que llevan a la organización a establecer relaciones con el mundo exterior. El control financiero y la administración del uso de esos recursos son las partes centrales

del sistema de disciplina interna de las organizaciones (Stinchcombe, 1967, p. 167).

En tercer lugar, un elemento fundamental en la caracterización de las organizaciones es el *sistema de autoridad* por el cual la gente está organizada y dirigida en la realización de las actividades. Esto incluye la asignación de responsabilidades, la supervisión de las tareas y un sistema disciplinario. Quizás la unidad doméstica se distinga de otras organizaciones formales en los incentivos utilizados para motivar a los miembros para realizar las tareas que les son asignadas. La motivación es predominantemente moral, con relativamente poco uso de incentivos monetarios y coercitivos. En este punto, “moral” es un término muy amplio y vago. Las apelaciones morales dirigidas a los diversos miembros son diferentes según su ubicación en la estructura de la unidad doméstica: la abnegación de la madre, la responsabilidad del padre, la obediencia del hijo, son valores sociales tradicionales sobre los que se asienta el sistema de incentivos. De hecho, el uso de recompensas y castigos morales basados en tradiciones y definiciones sociales fundadas en un proceso ideológico de “naturalización” de la división del trabajo entre sexos y generaciones, hace que todo el sistema de autoridad no resulte totalmente explícito y transparente —especialmente en la familia “moderna” en la cual los valores democráticos e igualitarios ya han dejado su impronta. De ahí la necesidad de investigar empíricamente las diversas *prácticas* domésticas de asignación de responsabilidades, de control de tareas y de disciplina, diferenciándolas y relacionándolas con las expresiones verbales, con la expresión de la normatividad y con las ideologías sobre el tema.

Finalmente, toda organización formal tiene una *teoría* o conceptualización acerca de cómo organizar las actividades. La planificación de actividades reposa sobre la capacidad de teorizar o reflexionar sobre la mejor manera de alcanzar un cierto objetivo. En esto, no interesa el valor de verdad de la teoría, o sea, si es verdadera o falsa de acuerdo con algún criterio científico, sino el grado de aceptación de esa teoría —y de sus consecuencias— por parte de los planificadores y actores. En el

caso de la unidad doméstica y la organización de la satisfacción de las necesidades cotidianas, este teorizar constituye el sistema de creencias básicas que guía la organización doméstica. Más que una teoría racional, es un sistema de representaciones cambiantes, a veces internamente contradictorio. Se trata de un sistema cultural de valores y normas, así como de patrones de comportamiento, anclado en nuestras sociedades en la distinción básica entre las esferas pública y privada de la vida, en la "naturalidad" de la familia y de la división sexual del trabajo. A su vez, dentro de este sistema de representaciones, existen fuerzas contradictorias, provenientes de la ideología de la individuación y la autonomía personal, de modo que el análisis empírico de la dinámica interna de las unidades domésticas deberá descubrir las bases de la solidaridad y unificación de los miembros y al mismo tiempo las fuentes de conflicto y desarticulación\*.

\* Este planteo lleva implícita una crítica a los análisis micro-económicos de las actividades domésticas expuestas por la "New home economics". En efecto, la existencia de una conceptualización de las tareas no necesariamente implica que los actores se mueven de acuerdo con una teoría explícita o racional sobre costos y beneficios de la actividad doméstica, supuesto sobre el que se basa el análisis microeconómico neoclásico. Es muy posible que para ciertas actividades específicas en las que los parámetros son claros, los supuestos racionales de la utilidad marginal y el costo de oportunidad se ajusten a la realidad. Pero descubrir esto debiera ser el resultado de la investigación empírica y no un supuesto de la misma. Tampoco están claros los principios lógicos de la acción de los miembros de la unidad doméstica. Suponer, como lo hace esa escuela, que la acción está regida por una lógica marginalista colectiva (de la unidad doméstica) constituye una inversión del proceso de investigación; se parte como premisa de lo que debiera —si la realidad así lo indica— constituir el resultado de la tarea de investigación. Descubrir cuál es la teoría de la distribución de tareas y de beneficios y las variaciones entre grupos sociales en estos temas, constituyen preguntas de investigación. Pero además, el supuesto de la unidad doméstica como unidad de decisión requiere una profunda revisión, ya que oculta la condición social de la mujer, los mecanismos intradomésticos de generación y solución de conflictos, y el sistema de autoridad intra-familiar (Galbraith, 1973).

### Las bases sociales de la solidaridad y el conflicto intradomésticos

De lo dicho anteriormente se desprende que la unidad doméstica es una organización social multifacética. Si bien las actividades y tareas que se realizan tienen frutos materiales concretos más o menos inmediatos, en función de la supervivencia de los miembros (la comida que va a satisfacer el hambre, la ropa que va a cubrir del frío), al mismo tiempo contienen una dimensión afectiva de refuerzo, recreación, ruptura y autonomización de lazos y relaciones sociales, y una dimensión simbólica, ligada a valores e ideologías propias de cada clase o sector social. A su vez se trata de una unidad con intereses mancomunados, pero en la cual la misma división del trabajo y los procesos de redistribución sobre los cuales se basa determinan intereses divergentes y luchas por el control entre sus miembros:

"It is income pooling that enables the household to be perceived as a unit with unitary interests, despite the different relationships to production of its separate members. Because of the division of labor among family members, disunity is thus inherent in the 'unity' of the family". (Hartmann, 1981, p. 374).<sup>16</sup>

O sea, la unidad doméstica no es un conjunto indiferenciado de individuos que comparten las actividades ligadas a su mantenimiento. Es una organización social, un microcosmos de relaciones de producción, de reproducción y de distribución, con una estructura de poder y con fuertes componentes ideológicos que cementan esa organización y aseguran o ayudan a su persistencia y reproducción, pero también con bases estructurales de conflicto y lucha. Al mismo tiempo que existe una tarea y un interés colectivo general, de la unidad misma, los diversos miembros tienen intereses propios, basados en su propia ubicación en los procesos de producción y reproducción intra y extra-domésticos.

Los principios básicos de organización interna, siguen, en tanto familia, los cortes según categorías de edad, sexo y parentesco. Las diversas actividades y tareas alrededor de las

cuales se organiza la unidad pueden clasificarse en dos grandes grupos: las tareas de producción, o sea la organización de la división del trabajo, y el consumo, es decir la organización de la distribución de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Las decisiones sobre la división del trabajo están centradas en la respuesta a la cuestión, ¿quién hace qué?, ¿quién sale a trabajar afuera y quién hace el trabajo doméstico?, ¿cómo?, ¿de acuerdo con qué estándares?, etc. En cuanto al consumo, la cuestión es cómo organizar el gasto o el presupuesto familiar: ¿qué se gasta? ¿cuáles son las prioridades? ¿quién controla y decide? Hay una tercera área intermedia, que se refiere a cuanto del trabajo y/o ingreso de cada miembro se destina al "pozo común" o al presupuesto familiar en contraposición al uso individual no socializado de esos recursos. Estos son los ejes de las cuestiones que generan las líneas de conflicto y lucha intra-doméstica, así como las alianzas y la solidaridad.

Dentro del contexto socio político e ideológico de las sociedades capitalistas patriarcales, los hijos están subordinados a los padres, a quienes otorgan respeto y obediencia y frente a los cuales tienen la responsabilidad de colaborar y participar en el bienestar común, definido y mantenido por la autoridad paterna\*. Durante los últimos siglos, el mundo occidental ha sufrido fuertes procesos de individuación de los hijos y quiebra (o autonomización más temprana) de la autoridad paterna. Anderson (1971) compara la situación en las zonas rurales de origen de los migrantes a Lancashire en el período de la industrialización inglesa con la situación en las ciudades textiles. A partir de la reconstrucción histórica plantea que en la

\* La literatura reciente sobre el tema de las transferencias intergeneracionales proviene de dos corrientes, la teoría de la modernización y la transición demográfica y la microeconomía centrada en el valor de los hijos. En ambas se plantea la dicotomía entre egoísmo y altruismo como motivación para tener hijos; se tienen hijos porque eventualmente los beneficios materiales recibidos superan los costos; o se tienen hijos por la "satisfacción" alturista de dar sin esperar recibir más que recompensas y satisfacciones morales. (Caldwell, 1976; Willis, 1981).

ciudad los jóvenes tenían la opción de separarse e individualizarse en relación a sus padres. Si permanecían en la unidad doméstica conformada por su familia de origen era por conveniencia material\*. El foco del análisis de Anderson es la situación de los hijos en el momento en que ganan autonomía financiera a partir de su incorporación a la fuerza de trabajo, momento en que es claramente posible identificar intereses diferenciados. Dado el proceso de creciente autonomización de los jóvenes y de pérdida de la autoridad patriarcal, en la actualidad los enfrentamientos intergeneracionales pueden aparecer en momentos anteriores del ciclo de vida, en lo que se refiere a la contribución de los hijos al trabajo doméstico, al requerimiento de los padres de que consigan empleo para ayudar al mantenimiento familiar, o a la decisión acerca de si los recursos así obtenidos son de apropiación individual o familiar. Además, el enfrentamiento intergeneracional aparece también en el área de consumo, especialmente en las presiones de los jóvenes adolescentes para obtener una serie de bienes —que van desde la ropa "de moda", hasta los aparatos para escuchar música y los cassettes correspondientes— dictados por el mundo de la cultura juvenil de consumo. En el ámbito doméstico estas presiones se traducen en el conflicto acerca de la jerarquización de los consumos y la redistribución de los beneficios (Jelin, 1982b).

Históricamente parecería que el proceso de reivindicación de los intereses individuales ocurrió primero entre generaciones —los jóvenes frente a sus padres— que entre sexos. El esquema patriarcal se comenzó a quebrar en esa línea cuando la base material de subsistencia se transfirió de la propiedad de la tierra a ser transmitida hereditariamente de padres a hijos a la venta de fuerza de trabajo en el mercado, para la cual la unidad

\* En este estudio se hace total omisión del análisis de los lazos afectivos, como si éstos no se mantuvieran o no cimentaran las relaciones entre padres e hijos, o mejor dicho, parecería que aunque los padres pudieran esperar algo de los hijos, éstos tienen la opción de no cumplir con esas expectativas y "dejarlos plantados".

relevante es el individuo y no la unidad familiar. El proceso de individuación y reconocimiento de intereses y derechos propios de la mujer frente al hombre jefe de familia es mucho más reciente. De ahí que este tema, la dinámica de la división del trabajo y la lucha por el poder entre sexos, sea objeto de atención especial solamente en los últimos quince años, en la literatura sobre el trabajo doméstico, la subordinación de la mujer y la organización social de la reproducción.

En la dinámica doméstica entre sexos, las líneas de conflicto se plantean también en torno a la cuestión de la producción, especialmente alrededor de la responsabilidad doméstica cuando aumenta la participación en la fuerza de trabajo de las mujeres tradicionalmente a cargo de la misma. Los estudios de presupuestos de tiempo indican claramente la mayor carga de trabajo de las mujeres, y esto se está convirtiendo en tema de lucha y reivindicación femenina, tanto en el plano privado de cada familia como en los movimientos sociales. En el área de la distribución, sin embargo, la mujer madre parece mantener su posición de "defensora del bien común" del ámbito doméstico colectivo, frente a los embates de los demás miembros de la unidad. La salida a esta situación puede llevar por un lado, a una creciente individuación de la mujer, a través de una lucha por obtener más beneficios a favor de sus intereses personales. O, alternativamente, a una creciente extensión y socialización de la orientación básica de defensa de los intereses "humanistas" implícitos en el rol doméstico de la mujer\*.

\* En este punto, Elshtain propone una salida a través de la ampliación del "pensamiento maternal": "Maternal thinking reminds us that public policy has an impact on real human beings. As public policy becomes increasingly impersonal, calculating, and technocratic, maternal thinking insists that the reality of a single human child be kept before the mind's eye. Maternal thinking, like Antigone's protest, is a rejection of amoral statecraft and an affirmation of the dignity of the human person".<sup>17</sup> Elshtain, 1982, pág. 59.

## Resumen

Este trabajo discute los aportes que, desde diversas disciplinas y perspectivas teóricas, presentan nuevas formas de pensar y de problematizar la temática de la familia y la organización doméstica. Partiendo del sistema de relaciones sociales de la vida cotidiana centrado en las actividades de mantenimiento y reproducción, se ponen al descubierto mecanismos y procesos básicos de organización social. El análisis de los mismos lleva a privilegiar la complejidad y multidimensionalidad de la cotidianidad, la explicitación de la dinámica intradoméstica (en lo referente a las formas de la división social del trabajo, a los mecanismos de asignación de recompensas y a las líneas de autoridad) y la interdependencia entre el ámbito doméstico y el mundo social y político más amplio, que llevan a concebir el ámbito familiar como el espacio de confluencia entre el mundo público y la vida privada.

## Summary

This paper discusses several conceptual issues about the family and the household, which stem from the contributions of a variety of disciplines and approaches. The starting point is the system of social relations of everyday life, insofar as it is linked to maintenance and reproductive activities. The explicit discussion of these subjects uncovers some basic mechanisms and processes of social organization. This analysis leads to a perspective that stresses the need for the recognition of the complexity and multidimensional character of everyday life, the explicit consideration of the internal dynamics of the household (in terms of the social mechanisms of division of labour, of the system of rewards and the lines of authority) and the interdependence of public and private forces in shaping the family and household organization.

<sup>1</sup> "La expresión 'grupo doméstico', se utiliza con el fin de evitar algunas dificultades de definición e introducir un elemento de flexibilidad. Esta expresión es un término genérico que engloba tres tipos principales de unidades, a saber, la unidad de residencia, la unidad reproductiva y la unidad económica. La unidad económica, a su vez, es un término genérico que abarca a las personas comprometidas conjuntamente en el proceso de producción y consumo. En las sociedades agrícolas (así como en la producción artesanal) estas diversas unidades están íntimamente ligadas, mientras que en las sociedades industriales se las puede distinguir con nitidez". (Goody, 1972, p. 106).

<sup>2</sup> "En otras situaciones, tales como la de los campesinos no propietarios, los recolectores y cazadores o los trabajadores asalariados, se podrían identificar otros componentes significativos de la organización familiar, tales como el grupo comensal, el grupo de producción y el grupo presupuestario, dentro del cual existen intercambios recíprocos entre los miembros sin llevar contabilidad. Sin embargo, ... el conjunto de personas que realiza cualquiera de estas actividades puede cambiar a lo largo del ciclo productivo, del ciclo de intercambio, o del ciclo de vida del individuo. En consecuencia, desde un punto de vista analítico resultaría más estratégico comenzar investigando las *actividades* constitutivas de las relaciones domésticas en cada sociedad particular". (Yanagisako, 1979, p. 186).

<sup>3</sup> "El método que empleamos plantea a la familia no como punto de partida, como realidad manifiesta, sino como una resultante móvil, como forma incierta, cuya inteligibilidad se logra solamente si se estudia el sistema de relaciones que mantiene en el nivel socio-político. Esto requiere detectar todas las mediaciones políticas que existen entre estos dos niveles de registro, identificando las líneas de transformación que se sitúan en ese espacio de intersecciones". (Donzelot, 1979, p. XXV).

<sup>4</sup> "identificar líneas de transformación suficientemente sutiles como para dar cuenta de las singularidades asignadas a los roles familiares ... percibiendo a esos roles como el resultado estratégico de dichas formas diversas ... Este primer objeto, la familia, irá luego desvaneciéndose en su trasfondo, eclipsado por otro, lo social, frente al cual la familia es al mismo tiempo reina y prisionera". (Donzelot, 1979, p. 7).

<sup>5</sup> "Comprendido no en el sentido limitador y represivo, que se le asigna en la actualidad, sino con un significado mucho más amplio, que abarca todos los métodos para el desarrollo de la calidad de una población y la fortaleza de la nación". (Donzelot, 1979, p. 6-7).

<sup>6</sup> "En términos generales, las obligaciones y demandas domésticas parecerían ayudar a explicar las razones por las cuales las mujeres se ven, en todas partes, limitadas en el acceso a las actividades masculinas prestigiosas". (Rosaldo, 1980, p. 399).

<sup>7</sup> "Las relaciones domésticas son una parte esencial de la estructura política de una sociedad".

<sup>8</sup> "El punto de vista de Antígona es el de una mujer que se atreve a desafiar a los poderes públicos expresando deberes e imperativos familiares y sociales ... Para recapturar esta expresión y recuperar esta perspectiva —no solamente en función de y para las mujeres— se hace necesario ubicar a las hijas de Antígona en el lugar que, temblorosa y problemáticamente, continúan ubicándose: en el ámbito del mundo social donde la vida humana es nutrida y protegida cotidianamente. Este es un mundo que las mujeres no han abandonado, aunque tanto la sociedad dominada por los hombres como una parte de la protesta femenina lo han desvalorizado como la esfera de los chismes, el trabajo sucio y la decadencia social. Este es un mundo que las mujeres, conscientes de sus valores y tradiciones, pueden sacar a la luz para presionar sobre políticas e identidades públicas del presente ... Definir este mundo simplemente como la 'esfera privada' en contraste con la 'esfera pública' es engañoso. Para los norteamericanos, la noción de 'privado' evoca imágenes de estrecho exclusivismo. El mundo de Antígona, por lo contrario, es un espacio *social* que habla de y hacia, identidades propias de cada familia particular por un lado, pero que en otro nivel quizás más básico, toca una identidad humana profundamente oculta, ya que primero y principalmente, no somos seres políticos o económicos, sino hombres y mujeres de familia". (Elshtain, 1982, p. 45-56).

<sup>9</sup> "Las actividades domésticas son siempre parte de los procesos sociales 'más amplios' de producción, reproducción y consumo; como tales, varían según clase social. Las actividades domésticas no pueden ser analizadas independientemente de las relaciones socioeconómicas de las sociedades en las que están implantadas". (Rapp *et al.*, 1979, p. 176).

<sup>10</sup> "Las personas son reclutadas para las relaciones materiales de las unidades domésticas en base a un compromiso social con el concepto de familia. En tanto aceptan el significado social de la familia, la gente entra en relaciones de producción, reproducción y consumo —se casa, tiene hijos, trabaja para mantener a sus dependientes, transmite y hereda recursos culturales y materiales. En todas estas actividades, el concepto de familia al mismo tiempo refleja y enmascara la realidad de la formación y sostenimiento de la unidad doméstica. Este concepto también permite

ocultar la variedad de experiencias que distintas categorías de personas tienen en sus unidades domésticas. Estas experiencias son radicalmente diferentes según sexo, generación y clase". (Rapp, et al., 1979, p. 177).

<sup>11</sup> "Las relaciones de reproducción organizan un contexto social para los hechos biológicos —patrones de sexualidad, de matrimonio, o de fecundidad producen no solamente seres humanos, sino también participantes en relaciones entre géneros sexuales y generaciones. En un sentido amplio, la reproducción se refiere a todas las actividades a través de las cuales las unidades domésticas se reproducen a sí mismas y, en ese proceso, contribuyen a la reproducción de la sociedad total. A través de estas relaciones de producción y reproducción las condiciones originadas en áreas sociales más amplias son internalizadas y vividas (y a veces resistidas o invertidas) dentro de las unidades domésticas. Dado que las actividades domésticas vinculan a los miembros en las relaciones que continuamente producen y reproducen a la sociedad total, las unidades domésticas de distintas clases sociales varían sistemáticamente en su capacidad de obtener, acumular y transmitir recursos". (Rapp et al., 1979, p. 176-177).

<sup>12</sup> "La virtud social convencional adscribe méritos a todo patrón de comportamiento que, aunque incómodo para la persona involucrada, sirve al bienestar o comodidad de, o resulta ventajoso para, los miembros más poderosos de la comunidad". (Galbraith, 1973, p. 30).

<sup>13</sup> "El volumen de fuerza de trabajo que debe ser ofrecido por una unidad doméstica de la clase trabajadora depende de muchos factores: el costo de reproducir (o mantener) a la unidad doméstica, las carreras ocupacionales y trayectorias de ingresos de los miembros individuales, y el ciclo doméstico (es decir, las relaciones entre géneros y generaciones, que especifican si y cuando las esposas y los hijos adolescentes están disponibles para trabajar fuera del hogar)". (Rapp, 1978, p. 283).

<sup>14</sup> "El ideal de autonomía de una familia nuclear independiente se ve constantemente contradicho por la realidad de las necesidades sociales, en las cuales los recursos deben ser mancomunados, prestados, compartidos. Las mujeres son quienes cierran la brecha entre lo que los recursos de la unidad son en la realidad, y lo que se supone debe ser la posición social de la familia". (Rapp, 1978, p. 288).

<sup>15</sup> "Existe una diferencia fundamental entre las actividades que son sistemáticamente planificadas para obtener un resultado dado y las actividades espontáneas. Generalmente, denominamos 'trabajo' a las actividades sistemáticamente planeadas e intencionales, y 'juego' u 'ocio' a las actividades espontáneas... A veces, los sociólogos denominan al trabajo 'acti-

vidades instrumentales' y al juego 'actividades expresivas'... Pero la distinción más importante... está en si una persona planifica sus propias actividades o si sus actividades son planificadas *para ella*... Todo arreglo social en el cual las actividades de algunas personas están sistemáticamente planeadas por otras personas (quienes, en consecuencia, tienen autoridad sobre aquéllas) con el objeto de alcanzar un objetivo específico, se llama una *organización formal*". (Stinchcombe, 1967, p. 154-155).

<sup>16</sup> "El presupuesto común permite percibir a la unidad doméstica como una unidad con intereses comunes, a pesar de las relaciones diferenciadas de sus miembros en el sistema productivo. Debido a la división del trabajo entre los miembros de la familia, la falta de unidad es inherente a la 'unidad' de la familia". (Hartmann, 1981, p. 374).

<sup>17</sup> "El pensamiento maternal nos recuerda que las políticas públicas tienen impacto sobre los seres humanos reales. A medida que la política pública se vuelve crecientemente impersonal, calculadora y tecnocrática, el pensamiento maternal insiste en que la realidad de cada niño individual sea mantenida en el foco de la atención. El pensamiento maternal, como la protesta de Antígona, constituye un rechazo del arte amoral de gobernar y una afirmación de la dignidad de la persona humana". (Elshtain, 1982, p. 59).

## Bibliografía

- ANDERSON, Michael, 1971. *Family structure in nineteenth century Lancashire*. Cambridge, Cambridge University Press.
- ARIES, Philippe, 1962. *Centuries of childhood: a social history of family life*. Nueva York, Vintage.
- ARIZPE, Lourdes, 1981. La migración por relevos y la reproducción social del campesinado. En BALAN, Jorge (ed.) *Why people move*. París, UNESCO.
- BALAN, Jorge, 1982. Household formation, migrant labor, and the informal economy; notes on a case study of bolivians in Buenos Aires. Buenos Aires, CEDES, *mimeo*.
- BENDER, Donald R., 1967. A refinement of the concept of household; families, co-residence and domestic functions. *American Anthropologist*, Vol. 69, N° 5.
- BERKNER, Lutz K., 1972. The stem family and the developmental cycle of the peasant household; an eighteenth-century Austrian example. *American Historical Review*, Vol. 77, N° 2.
- BERKNER, Lutz K., 1975. The use and misuse of census data for the

- historical analysis of family structure; a review of household and family in past time. *Journal of interdisciplinary history*, Vol. 5, N° 4.
- BOURDIEU, Pierre, 1976. Marriage strategies as strategies of social reproduction. En FORSTER, Robert y Orest RANUM (eds.), *Family and society. Selections from the Annals: Economies, societies, civilisations*. Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- BOURDIEU, Pierre, 1977. *Outline of a theory of practice*. Cambridge, Cambridge University Press.
- BURCH, Thomas, Luis F. LIRA y Valdecir F. LOPES (eds.), 1976. *La familia como unidad de estudio demografico*. San José, CELADE.
- BUVINIC, Mayra y Nadia H. YOUSSEF, 1978. *Women-headed households: the ignored factor in development planning*. Washington, International center for research on women.
- CALDWELL, John C., 1976. Toward a restatement of demographic transition theory. *Population and development review*, Vol. 2.
- CARDOSO, Fernando H. y Enzo FALETTO, 1969. *Desarrollo y dependencia en América Latina*. México, Siglo XXI.
- DONZELOT, Jacques, 1979. *The policing of families*. Nueva York, Pantheon Books.
- EDHOLM, Felicity, Olivia HARRIS y Kate YOUNG, 1977. Conceptualising women. *Critique of Anthropology*, Vol. 3, N° 9/10.
- ELSHTAIN, Jean B., 1982. Antigone's daughters. *Democracy, a Journal of political renewal and radical change*, Vol. 2, N° 2.
- FORTES, Meyer, 1969. *Kinship and the social order*. Chicago, Aldine.
- GALBRAITH, John K., 1973. *Economics and the public purpose*. Boston, Houghton Mifflin.
- GOODY, Jack, 1972. The evolution of the family. En LASLETT, Peter (ed.), *Household and family in past time*. Londres, Cambridge University Press.
- GOODY, Jack, 1976. *Production and reproduction: a comparative study of the domestic domain*. Cambridge, Cambridge University Press.
- GOODY, Jack, Joan THIRSK y E. P. THOMPSON (eds.), 1978. *Family and inheritance: rural society in Western Europe, 1200-1800*. Cambridge, Cambridge University Press.
- GREENHALG, Susan, 1981. Chinese *chia* and the level of income equality in Taiwan; rethinking the recipient unit in income distribution studies. Lieja, IUSSP, mimeo.
- HAREVEN, Tamara K. (ed.), 1977. *Family and kin in urban communities, 1700-1930*. Nueva York, New Viewpoints.
- HAREVEN, Tamara K. (ed.), 1978. *Transitions: the family and the life course in historical perspective*. Nueva York, Academic Press.
- HARTMANN, Heidi, 1981. The family as the locus of gender, class, and political struggle; the example of housework. *Signs*, Vol. 6, N° 3.
- HELLER, Agnes, 1976. *The theory of need in Marx*. Londres.
- JELIN, Elizabeth, 1976. Migración a las ciudades y participación en la fuerza de trabajo de las mujeres latinoamericanas; el caso del servicio doméstico. *Estudios Sociales* N° 5, Buenos Aires, CEDES.
- JELIN, Elizabeth, 1982. Potencial organizativo de las mujeres; notas para una discusión. *Diálogo sobre la participación* 2. Ginebra, UNRISD.
- JELIN, Elizabeth, 1982. Las relaciones sociales del consumo; Organización del gasto de las unidades domésticas de sectores populares. Buenos Aires, CEDES, mimeo.
- KOWARICK, Lucio, 1975. *Capitalismo e marginalidade na America Latina*. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
- KUZNETS, Simon, 1976. Demographic aspects of the size distribution of income; an exploratory essay. *Economic development and cultural change*, Vol. 25, N° 1.
- LARGUIA, Isabel y John DUMOULIN, 1975. Aspects of the conditions of women's labor. *NACLA's Latin America and Empire Report*, IX.
- LASCH, Christopher, 1977. *Haven in a heartless world: the family besieged*. Nueva York, Harper & Row.
- LASLETT, Peter (ed.), 1972. *Household and family in past time*. Londres, Cambridge University Press.
- LEISS, William, 1976. *The limits of satisfaction: an essay on the problem of needs and commodities*. Toronto, University of Toronto Press.
- LOMNITZ, Larissa, 1975. ¿Cómo sobreviven los marginados? México, Siglo XXI.
- MALOS, Ellen (ed.), 1980. *The politics of housework*. Londres, Allison & Busby.
- MEILLASSOUX, Claude, 1977. *Mujeres, graneros y capitales*. México, Siglo XXI.
- MODELL, John, Frank F. FURSTENBERG, Jr. y Douglas STRONG, 1978. The timing of marriage in the transition to adulthood; continuity and change, 1860-1975. En DEMOS, John y Sarane S. BOOCOCK (eds.), *Turning points*. Chicago, American Journal of Sociology, suplemento al Vol. 84.
- MURDOCK, George P., 1949. *Social structure*. Nueva York, Macmillan.
- NUN, José, 1969. Sobrepoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal. *Revista Latinoamericana de Sociología*, Vol. 5, N° 2.
- OPPONG, Christine, 1982. Family structure and women's reproductive and productive roles; some conceptual and methodological issues. En ANKER, Richard, Mayra BUVINIC y Nadia H. YOUSSEF (eds.), *Women's roles and population trends in the Third World*. Londres, Croom Helm.
- PEATIE, Lisa, 1978. La organización de los "marginales". En KAZTMAN, Ruben y JOSE L. REYNA (eds.), *Fuerza de trabajo y movimientos laborales en América Latina*. México, Colegio de México.



ELIZABETH JELIN

- QUIJANO, Anibal, 1968. Dependencia, cambio social y urbanización en América Latina. *Revista Mexicana de Sociología*.
- RAMOS, Silvina E., 1981. Las relaciones de parentesco y de ayuda mutua en los sectores populares urbanos. Un estudio de caso. *Estudios CEDES*. Vol. 4, N° 1.
- RAPP, Rayna, 1978. Family and class in contemporary America; notes toward an understanding of ideology. *Science and society*, vol. XLII, N° 3.
- RAPP, Rayna, 1979. Anthropology. *Signs*, Vol. 4, N° 3.
- RAPP, Rayna, et al., 1979. Examining family history. *Feminist studies*, Vol. 5, N° 1.
- ROBERTS, Bryan, 1978. *Cities of peasants: the political economy of urbanization in the Third World*. Londres, E. Arnold.
- ROSALDO, Michelle Z., 1980. The use and abuse of anthropology: reflections on feminism and cross-cultural understanding. *Signs*, Vol. 5, N° 3.
- SINGER, Paul, 1975. *Economía política da urbanização*. San Pablo, Editora Brasiliense.
- SCHMUKLER, Beatriz, 1981. Mujer y familia en la reproducción de la pequeña burguesía. En AGUIAR, Neuma (ed.), *Mulheres na força de trabalho na América Latina*. Rio de Janeiro, Editora Vozes.
- SKOLNICK, Arlene, 1975. The family revisited; themes in recent social science research. *Journal of interdisciplinary history*, Vol. V, N° 4.
- STACK, Carol B., 1974 a. *All our kin: strategies for survival in a black community*. Nueva York, Harper & Row.
- STACK, Carol B., 1974 b. *Sex roles and survival strategies in an urban black community*. En ROSALDO, Michelle Z. y Louise LAMPHIRE (eds.), *Women, culture and society*. Stanford, Stanford University Press.
- STINCHCOMBE, Arthur, 1967. Formal organizations. En SMELSER, Neil J. (ed.), *Sociology: an introduction*. Nueva York, Wiley.
- TORRADO, Susana, 1981. The 'family life strategies' approach in Latin America; theoretical-methodological trends. Trabajo presentado en la Conferencia General de la IUSSP. Manila, mimeo.
- WALLERSTEIN, Immanuel y William MARTIN, 1979. Changes in household structure and labor-force formation. *Review*, Vol. III, N° 2.
- WILLIS, Robert J., 1981. The direction of intergenerational transfers and demographic transition; the Caldwell hypothesis revisited. Trabajo presentado al IUSSP Seminar on Individuals and families and income distribution. Honolulu, mimeo.
- YANAGISAKO, Sylvia J., 1979. Family and household; the analysis of domestic groups. *Annual Review of Anthropology*, Vol. 8.



## Institución Psicoterapéutica

1. RESIDENCIA TERAPEUTICA INTERMEDIA.
2. CLINICA PSIQUIATRICA: internación de pacientes agudos y descompensados sintomaticamente.
3. COMUNIDAD DEL TIEMPO: Hospital de Día Comunitario.
4. TALLERES TERAPEUTICOS
5. CLUB DE FIN DE SEMANA.
6. JARDIN DE OTOÑO (Tercera Edad).
7. CENTRO INSTITUCIONAL:
  - 7.1. DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION PSICOTERAPEUTICA.
  - 7.2. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CLINICA Y DOCENCIA.
  - 7.3. CONSULTORIOS EXTERNOS: Individual, grupal, familiar y de clínica psiquiátrica.
  - 7.4. INTERNACIONES DOMICILIARIAS Y URGENCIAS PSIQUIATRICAS.
  - 7.5. ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS.

Directores:

**Dr. Felipe Díaz Usandivaras**

**Dra. Mirta Irene Méndez Puig**

Soler 5961 - 1425 Capital Federal - Tel.: 771-8114/8108



# salud mental

ATENCION INTEGRAL DE LOS TRASTORNOS PSIQUICOS

- Psicoterapia Grupal - Individual - Familiar
- Clínica de Día
- Comunidad Terapéutica
- Internación

---

DIRECTOR PROFESOR  
DR. JORGE GARCIA BADARACCO  
SUB-DIRECTOR  
DR. NORBERTO PROVERBIO

---

CLINICA PSIQUIATRICA

## d i t e m

O'HIGGINS 2328 - BS. AS.  
TEL. 781-1306/7825/0557

---

Proceso psicodiagnóstico de la familia con niños desde el  
enfoque trigeracional

---

Lic. SILVIA L. QUAGLIA

---

*Rojas 141, 5º, Tel. 99-0180, 1405-Capital Federal*

---

El objetivo de este trabajo es la presentación de un modelo de evaluación psicológica de la familia, cuando el motivo de la consulta es la perturbación de uno o más de los hijos.

El enfoque teórico utilizado surge de la integración de teorías psicodinámicas y sistémicas que, siguiendo a A. Canevaro, "da cuenta de tres niveles dentro del sistema familiar que son progresivamente abarcativos e incluyentes . . . estos tres niveles, dentro de una estratificación más amplia de los sistemas humanos, recortan el área específicamente familiar y definen un contexto en el cual el individuo crece y va adquiriendo su identidad"<sup>1</sup>.

1. En el primer nivel INDIVIDUAL INTRAPERSONAL "cada uno de los miembros del sistema es visto en su mayor originalidad desde un punto de vista descriptivo; las fronteras individuales representan el foco de mayor atención"<sup>1</sup>. Conflictos, ansiedades y defensas predominantes hallarán en este nivel su explicitación.

2. El nivel RELACIONAL INTERPERSONAL “está representado por la red de interacciones que son determinadas por las distintas alianzas, coaliciones y triangulaciones en el interior del sistema familiar y en referencia al contexto de unión de ambas familias de origen”<sup>1</sup>.

Este nivel da cuenta de las pautas relacionales de la familia nuclear en una forma articulada con las de la familia extensa que conforman los grupos de origen de ambos cónyuges.

3. El tercer nivel GRUPAL SISTEMICO “es aquel donde el grupo se recorta más nítidamente en sus fronteras, por un lado con las familias de origen y por el otro con los macrosistemas comunitarios (trabajo, escuela, amigos, etc.). . . el foco de mayor atención está en las reglas del sistema y en su mitología”<sup>1</sup>.

El proceso diagnóstico elaborado a partir de este enfoque tiene como objetivo la modificación de un patrón relacional por el cual uno o varios hijos sintomáticos se han incluido en los conflictos conyugales no explicitados ni resueltos, llegando a la consulta, tal como lo señala A. González “por la vía más indirecta . . . la pareja se define como estabilizada y sin conflictos y el problema se centra en los hijos o en la relación de la pareja con éstos”<sup>2</sup>.

En un trabajo anterior señalé: “Una adecuada lectura de la sintomatología infantil, devela mensajes que la pareja conyugal se oculta mutuamente. El niño, triangulado en este déficit de comunicación de sus padres, denuncia una conflictiva a veces muy alejada de la percepción de todos los miembros de la familia”<sup>3</sup>.

El proceso diagnóstico propuesto consta de aproximadamente diez entrevistas y puede o no anteceder a la etapa de tratamiento ya que, desde mi experiencia, puede resultar terapéutico en sí mismo respecto del motivo de consulta.

En el transcurso de estas entrevistas se intentará lograr que la pareja y la familia incorporen una diferente construcción de su propia realidad e inicien el cambio de sus pautas relacionales de comunicación.

Describiré los movimientos que se llevan a cabo en este proceso:

### PRIMER MOVIMIENTO: Preentrevista telefónica

La denominada “situación analítica” por Bleger<sup>4</sup>, se inicia con la preentrevista telefónica. Autores como Stierlin<sup>5</sup> y Selvini Palazzoli<sup>6</sup> describen la importancia de este primer contacto, de utilidad múltiple; en principio permite al terapeuta formularse las primeras hipótesis sobre el caso.

Otro objetivo es la convocatoria del grupo familiar, no sólo padres y hermanos del paciente designado, sino además otros miembros significativos que se hallen involucrados emocionalmente con la familia.

He observado que la aceptación de esta convocatoria se encuentra muchas veces relacionada directamente con la íntima convicción del terapeuta de considerar al miembro designado como paciente como la expresión sintomática del sistema familiar.

Iniciar el proceso de este modo, no sólo sirve al entrevistador en la evaluación del contexto familiar, sino además y tal como lo señala Serrano “es beneficioso para el niño o el adolescente saber que no fue “juizado” de antemano, ya que sus padres y el terapeuta no tienen una relación preexistente”<sup>7</sup>.

Otro dato que se obtendrá en este primer contacto se refiere a la información sobre quién deriva, por qué (lo que remite al motivo de consulta manifiesto) y para qué. La comunicación con el derivador previa a la reunión familiar, suele aportar datos de suma utilidad en la elaboración de hipótesis, que hemos de diferenciar de actitudes prejuiciadas que entorpecen la mirada hacia el sistema.

El informe posterior al derivador (escuela, pediatra, psicopedagogo, etc.) deberá responder a los interrogantes que motivaron la consulta en un lenguaje claro que le sea de utilidad.

### SEGUNDO MOVIMIENTO: Primera entrevista con la familia

Habitualmente la convocatoria incluye a miembros de la familia de origen de uno o ambos cónyuges, la pareja parental y sus hijos.

A los niños que participan de la reunión se les ofrecerá la

alternativa de comunicarse lúdicamente, poniendo a su disposición juguetes seleccionados de acuerdo a su edad.

Minuchin señala: "la familia se modifica sólo si el terapeuta ha logrado incorporarse al sistema de un modo sintónico"<sup>8</sup>; así, el entrevistador debe recortarse claramente como líder de este nuevo sistema que ahora lo incluye.

En el trabajo ya citado<sup>3</sup>, señalé que la creación de la alianza terapéutica no es sencilla... "aun la expectativa más frecuente con la que llegan los padres a la consulta podría traducirse en "traemos a este hijo para que lo cambie"... el objetivo de cambio en esos casos se centra en la modificación de uno de los miembros identificado como perturbado y/o perturbador más que en una preocupación por la modalidad de contacto dentro del grupo familiar, a la que no se percibe como disfuncional.

El intento de ampliación del foco sólo centrado en el hijo sintomático, resultará exitoso sólo a través de cuidadosas maniobras que deben respetar el TIEMPO que cada sistema necesita para modificar sus pautas patológicas de interacción".

¿Qué evaluar en este movimiento? Los ítems que enunciaré surgen de varios autores: Canevaro<sup>9</sup>; Watzlawick y col.<sup>10</sup>; Satir<sup>11</sup>; Beavers<sup>12</sup>; Framo<sup>13</sup>; Haley<sup>14</sup>; Andolfi y col.<sup>15</sup>; Selvini Palazzoli<sup>6</sup>; Minuchin<sup>8</sup> y Boszormenyi-Nagy<sup>16</sup>.

1. Detectar el ordenamiento jerárquico del grupo; inclusión o no de miembros de las familias de origen en la distribución del poder.

2. Estilo de comunicación predominante; está de acuerdo o no a la etapa del ciclo vital en que se encuentran. Esta pauta alude a la capacidad de discriminación de cada uno de los miembros según su rol, sexo, edad y posibilidades.

3. Evaluación de la expresión lúdica y conductual de los niños en cuanto a si es adecuada o no a su edad cronológica y etapa del ciclo vital que atraviesan.

4. Estructura de la familia de acuerdo a la modalidad de contacto; grado de flexibilidad, capacidad de elaboración y reestructuración.

5. Alianzas y/o coaliciones generacionales o transgeneracio-

nales que dará cuenta de la diferenciación de los subsistemas.

6. Reacción del grupo ante las acciones individuales y/o subsistémicas; reconocimiento y respeto de los espacios personales.

7. Modalidad de expresión de los afectos y su incidencia en la cohesión grupal.

8. Modalidad de vida de la familia: qué le produce stress, cuáles son sus puntos de apoyo para resolver las crisis, cuáles son las transacciones preferibles y las alternativas disponibles.

9. Capacidad de utilización de recursos creativos en la resolución de dificultades o reiteración de patrones relacionales en forma estereotipada.

10. Características de la mitología familiar: permite o "bloquea los contactos con el exogrupo.

11. Capacidad de modificación de los roles y posibilidad de lograr un adecuado equilibrio entre relaciones simétricas y complementarias.

12. Reacciones de la familia ante el terapeuta y el registro de su contratransferencia que ha de ser convenientemente evaluada a los fines de una acomodación mutua que facilite un accionar creativo y modificador.

Este segundo movimiento, que puede resolverse en una o más entrevistas, requiere por parte del terapeuta la elaboración y explicitación de un microcierre cuyo contenido debe adecuarse a la porosidad del sistema familiar.

Habitualmente pueden prescribirse tareas que inician la modificación de los patrones relacionales del sistema como totalidad.

Siguiendo a Haley me refiero a "aquellas directivas que se proponen cambiar las formas de tratarse entre sí los miembros de una familia, introduciendo la ACCION"<sup>17</sup>. Las indicaciones, ya sean directas o paradójales involucrarán a toda la familia, aún cuando a uno o más miembros se les indique que se abstengan de intervenir.

Además, este es el momento de la explicitación del encuadre y la modalidad de trabajo durante el proceso diagnóstico. Esta tarea requiere un máximo reconocimiento del terapeuta

como líder lo que le permitirá la libertad necesaria en su accionar, como es por ejemplo poder de convocatoria.

Una vez concluido este encuentro, se solicita a la pareja concurra a las próximas entrevistas, despidiendo a los otros miembros participantes hasta otra oportunidad, según lo juzgue necesario el terapeuta.

### TERCER MOVIMIENTO: Mirada conjunta sobre la historia de la pareja.

En las siguientes dos entrevistas, el terapeuta hará el relevamiento de datos que le permitan confeccionar la ficha clínica familiar según la propuesta de A. Canevaro<sup>9</sup>. Se obtendrá así la historia de la familia materna y paterna de cada cónyuge.

Este autor señala: "la unión entre dos familias de origen va a ser telón de fondo en el que una nueva familia se va a desempeñar, marcando su estilo, tanto normal como patológico. Estas dos familias de origen van a existir SIEMPRE en la configuración, aún cuando haya un solo representante, formando ese campo virtual que hay que rastrear<sup>1</sup>.

El otro cónyuge, cuya historia y genograma se elaborará en el siguiente encuentro, desempeña en éste una tarea coterapéutica; es decir, se solicita su colaboración para ampliar o agregar datos que considere relevantes.

Este movimiento provee a la pareja y al terapeuta, de bases para una reflexión acerca de modelos de comunicación y conductas que se repiten o rechazan en la crianza de los hijos.

Así, se irá articulando la historia de cada cónyuge con la modalidad relacional de la familia nuclear y el motivo de consulta originario u otros que pudieran haberse delineado en la primera entrevista con la familia; por ejemplo problemas en la relación parental y/o conyugal; con otro hijo por el que inicialmente no consultaron; en las relaciones con las familias de origen, etc.

*Ejemplo:* Expresa María Clara (34 a.): "cada vez que Leonel (PD 4 a.) grita o se descontrola, yo, en vez de pararlo o ayudarlo a entender qué le pasa, me angustio... es lo

mismo que me pasaba cuando, siendo chica mi papá gritaba... yo no sabía dónde esconderme del miedo que sentía a que me pegara... con Leonel me siento como si yo tuviera 4 años y él fuera mi papá".

*Ejemplo:* Dice Víctor (37 a) "mi mamá tuvo que trabajar para mantenernos porque mi papá se la pasaba jugando al truco con sus amigos... a mí me hizo tanta falta que por eso no me gusta que mi mujer deje a los chicos para ir a trabajar, aunque...".

Estos momentos individuales analizados en conjunto, confluyen en el ENCUENTRO, que alude a la situación de constitución de la pareja. Se intenta detectar el tipo de elección de objeto<sup>18-19</sup>, expectativas y mandatos familiares que los incluyen como portadores de un mito<sup>6-20</sup>, que continuará a través de su descendencia.

Este movimiento culmina con una tarea que la pareja realizará en forma conjunta y sobre la que se trabajará en el siguiente encuentro: consiste en la elaboración escrita (de ser posible) de la historia de vida de *todos y cada uno de los hijos*, siguiendo una guía de pautas que el terapeuta les entrega.

No me detendré aquí en la enumeración de esas pautas que todo terapeuta de niños conoce a partir de A. Aberastury<sup>21</sup>, pero sí he de fundamentar que la investigación no se cifra sólo al paciente designado y que además se elabore en forma escrita.

La comparación de las pautas de crianza y evolución de cada uno de los hijos, suele arrojar datos sumamente valiosos sobre diferencias en la modalidad de contacto.

### CUARTO MOVIMIENTO: Mirada conjunta sobre la historia de la familia y los hijos.

En este encuentro se trabaja sobre el material elaborado y el modo que la pareja tuvo de confeccionarlo. Se detendrán especialmente en su lectura en aquellas pautas significativas, no sólo las referidas al paciente designado, sino también sobre las de los otros hijos.

El terapeuta debe estar en condiciones de explicarse no sólo

el significado del síntoma, sino además por qué se sostiene en la actualidad, es decir, para qué sirve *ahora*.

La mirada autorreflexiva conjunta y compartida por ambos cónyuges, es un objetivo terapéutico en sí mismo; de allí que esta tarea no se prescriba con el simple fin del relevamiento de datos, sino fundamentalmente como un modo de estimular una acción conjunta de los roles parentales.

La concreción en forma escrita permite la emergencia de los recuerdos, la confrontación, el diálogo, la consulta con otros miembros involucrados en la crianza, el reconocimiento de la ausencia... etc. Permite además al padre periférico recuperar la historia de sus hijos o al sobreinvolucrado conocer áreas a las que no tuvo acceso.

Del análisis conjunto de la historia evolutiva de los hijos y su articulación con la historia de vida de cada cónyuge, surgirán nuevas hipótesis que se validarán o descartarán en el siguiente movimiento.

Selvini Palazzoli señala: "la función esencial de una hipótesis consiste en ser la guía para llegar a una información nueva... el valor funcional de una hipótesis es mayormente el de garantizar la actividad del terapeuta que consiste en rastrear patrones relacionales"<sup>22</sup>.

#### QUINTO MOVIMIENTO: Recortes para la evaluación de patrones relacionales.

Llegado este momento, el terapeuta decidirá la conveniencia del rastreo de determinados patrones relacionales, no sólo para la obtención de datos, sino además cuando se intenta lograr que uno o más miembros visualicen in situ una específica modalidad de contacto.

A los fines de la evaluación del nivel GRUPAL SISTEMICO puede convocarse a la familia nuclear o recortes de ésta: díada madre-hijo/a; padre-hijo/a; subsistema filial.

Tomando los aportes de autores como Bleger<sup>23</sup>, Zuk G y Rubinstein D., Boszormenyi-Nagy<sup>24</sup>, Emilce Dío de Bleichmar<sup>25</sup>, los recortes diádicos son relevantes para la comprensión

de simbiosis mudas o de la complementariedad patológica, términos que aluden a un mismo fenómeno.

Utilizo este recurso no sólo en casos de pareja complementaria padre sobreinvolucrado-hijo/a, sino además en aquellos otros donde un padre se muestra desligado y/o periférico con uno o varios hijos.

Tanto la disolución de un vínculo patológico como el acercamiento de dos o más miembros distanciados, puede evaluarse en estas entrevistas y hallar así aproximaciones diagnósticas y pronósticas para un eventual proceso terapéutico.

Para la evaluación del nivel RELACIONAL INTERPERSONAL puede resultar necesaria la convocatoria de cada cónyuge con su familia de origen.

En la configuración donde ambos cónyuges proviene de una familia cohesivo-centrípeto, el terapeuta debe —como señala Canevaro—, "convocar físicamente o en el relato a los representantes de la familia de origen, procurando entender cuáles son los mecanismos disfuncionales que impiden el adecuado desprendimiento de ese miembro... asimismo tenderá a convocar familiares significativos de la familia de origen dispersivo-centrípeto, en presencia o en el relato, a fin de evidenciar y corregir la soledad y las carencias emocionales del cónyuge que se sobrecompensan en la patología"<sup>1</sup>.

En la práctica clínica he comprobado reiteradamente la validez de esta propuesta, ya que cuanto mayor es la dependencia emocional de uno o ambos cónyuges respecto de su familia de origen, menor es el compromiso que asumen en el matrimonio y como padres de la familia nuclear.

Para la evaluación del primer nivel INDIVIDUAL INTRAPERSONAL, el terapeuta puede juzgar necesario el recorte puntual de un miembro. Esta acción resulta imprescindible en los casos en los que se requiere el diagnóstico diferencial de un niño.

El material, seleccionado según las necesidades del caso, consiste básicamente en Hora de Juego y tests gráficos.

### SEXTO MOVIMIENTO: Cierre del proceso diagnóstico.

La convocatoria para este encuentro tiene fines estratégicos; así, puede cerrarse el proceso en presencia de la familia nuclear, incluir a miembros de las familias de origen, o bien sólo a la pareja.

El objetivo de este movimiento es doble: por un lado se promueve una síntesis de los emergentes durante todo el proceso y por el otro, es en este momento cuando se elabora la recomendación terapéutica.

Estos objetivos pueden llevarse a cabo en dos o más entrevistas.

Deseo subrayar el rol activo del terapeuta; durante las entrevistas señaló y/o interpretó material, adecuándose a la flexibilidad del sistema, o bien prescribió tareas con el objetivo de iniciar la modificación de patrones relacionales patológicos. Es decir, su actividad no se ciñe sólo al relevamiento de datos y la observación.

Durante el proceso diagnóstico, la familia ha ido incorporando otras modalidades de contacto. En un número significativo de casos he observado que una vez concluido este tramo diagnóstico, la patología por la que se llegó a la consulta, ha remitido. Esto permite la emergencia de otra problemática más profunda, y que consultantes y terapeutas abordarán en el momento que consideren adecuado.

Este modelo se adecua a casos típicos de familia con niños sintomáticos, pudiendo modificarse no sólo en función del caso, sino además respetando el estilo que cada terapeuta reconoce como el que le otorga mayor margen de operatividad.

### Resumen

El objetivo de este trabajo es la presentación de un modelo de evaluación psicológica de la familia cuando el motivo de la consulta es la perturbación de uno o más hijos.

Este proceso diagnóstico elaborado a partir del enfoque trigeneracional propuesto por A. Canevaro, tiene como objetivo la modificación de patrones relacionales patológicos y puede resultar terapéutico en sí mismo respecto del motivo de consulta.

Esta propuesta diagnóstica, que puede resolverse en aproximadamente diez entrevistas, permite en un número significativo de casos, la emergencia de otra problemática más profunda, que se abordará en el momento en que consultantes y terapeuta consideren adecuado.

### Summary

The objective of this paper is to present a model for the psychological evaluation of a family when they come to the consult because one or more of their children have perturbances.

The diagnostic process, elaborated from the trigenerational model described by A. Canevaro, has the objective of changing the pathological relational patterns and it also may become therapeutic by itself in reference of their claim.

This diagnostic proposal may be done in about ten meetings. Allows also, in a significant number of cases, the emergency of another more profound conflict, that may be approached when either consultant or therapist regard it suitable.

Bibliografía

21. ABERASTURY, Arminda; "La entrevista inicial con los padres". 75-144, en *Teoría y Técnica del Psicoanálisis de Niños*. Ed. Paidós. Bs. As. 1962.
15. ANDOLFI, M., MENGHI, P., NICOLO, A. M., SACCU, C.; "La interacción en los sistemas rígidos; un modelo de intervención en la familia con paciente esquizofrénico". Revista *Terapia Familiar* N° 4. 108-142. Ed. ACE, Buenos Aires, 1979.
12. BEAVERS, W. Robert; "Un modelo sistémico de familias para terapeutas familiares". Revista *Terapia Familiar* N° 11. 149-165. Ed. ACE. 1983. Buenos Aires.
23. BLEGER, José, "Estudio de la dependencia-independencia en su relación con el proceso de proyección-introyección". 15-38 en *Simbiosis y Ambigüedad*. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1968.
4. BLEGER, José; "Psicoanálisis del encuadre psicoanalítico" 237-250 en *Simbiosis y Ambigüedad*. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1967.
19. BERENSTEIN, I., PUGET, J.; "Algunas consideraciones sobre psicoterapia de pareja; del enamoramiento al reproche", en *Revista de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Tomo V. N° 1*. 25-40. Buenos Aires. 1982.
16. BOSZORMENYI-NAGY, Ivan; "Una teoría de relaciones; experiencia y transacción" en *Terapia Familiar Intensiva: aspectos teóricos y prácticos*. Ed. Trillas, México. 1976.
1. CANEVARO, Alfredo; "El contexto trigeneracional en terapia familiar. Un modelo de investigación clínica y abordaje terapéutico". Revista *Terapia Familiar* N° 9. 101-118. Ed. ACE. Buenos Aires. 1982.
9. CANEVARO, Alfredo; "Un modelo de ficha clínica familiar". Revista *Terapia Familiar* N° 2; 11-27. Ed. ACE. 1978. Buenos Aires.
25. DIO de BLEICHMAR, Emilce; "La psicoterapia del binomio madre-hijo en la simbiosis patológica" 232-236 en *Psicoanálisis de Niños y sus aplicaciones*. Compiladora A. Aberastury. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1972.
20. DOLTO, Françoise; "La Sagrada Familia" 19-30 en *El Evangelio ante el Psicoanálisis*. Ed. Cristiandad. Madrid. 1979.
13. FRAMO, James; "Fundamentos y técnicas de la terapia familiar intensiva" 179-256 en *Terapia Familiar Intensiva: aspectos teóricos y prácticos*. Ed. Trillas, México. 1976.
18. FREUD, Sigmund; "Introducción al Narcisismo". Tomo I. 1083-1096. *Obras Completas*. Biblioteca Nueva Ed. Madrid. 1948.
2. GONZALEZ, Alberto; *Análisis de la relación de pareja*. 13-19. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires. 1979.

17. HALEY, Jay; *Terapia para resolver problemas*. Ed. Amorrortu. Bs. As. 1980.
14. HALEY, Jay; *Terapia no convencional*. Ed. Amorrortu. Buenos Aires. 1980.
8. MINUCHIN, Salvador; "Formación del sistema terapéutico" 182-203 y "La reestructuración de la familia" 204-231 en *Familias y Terapia Familiar*. Ed. Gedisa. Barcelona, 1979.
3. QUAGLIA, Silvia; "La deserción como fracaso en la formación del sistema terapéutico" presentado en el Primer Congreso Argentino de Psicología del Niño. Universidad de Belgrano. Buenos Aires. 1982.
11. SATIR, Virginia; "La inclusión de los niños en terapia familiar". *Revista Argentina de Psicología* N° 19/20. 13-31. Ediciones Nueva Visión. 1975/76. Buenos Aires.
22. SELVINI PALAZZOLI, M., BOSCOLO, L., CECCHIN, G. y PRATA, G.; "Formulación de hipótesis, circularidad y neutralidad; tres guías para el conductor de la sesión". Ficha editada por la Sociedad Argentina de Terapia Familiar. Buenos Aires. 1982.
6. SELVINI PALAZZOLI, M., BOSCOLO, L., CECCHIN, G. y PRATA, G.; "Modalidad de trabajo del equipo" 17-25 en *Paradoja y Contrapadoja*. Editorial ACE. Buenos Aires. 1982.
7. SERRANO, Alberto; "La entrevista psicológica de la familia con enfoque en el niño". Revista *Terapia Familiar* N° 6. 109-127. Ed. ACE. 1981. Buenos Aires.
5. STIERLIN, Helm; "¿Cómo transcurre la primera conversación familiar?" 93-138. En *Psicoanálisis y terapia de familia*. Editorial Gedisa. Barcelona. 1980.
10. WATZLAWICK, P., BEAVIN, J. y JACSON, D.; *Teoría de la Comunicación Humana*. Ed. Tiempo Contemporáneo. Buenos Aires. 1973.
24. ZUK, G. y RUBINSTEIN, D.; "Revisión de conceptos utilizados en el estudio y tratamiento de familias de esquizofrénicos" 23-55 en *Terapia Familiar Intensiva: aspectos teóricos y prácticos*. Ed. Trillas. México. 1976.



## CEFYP

CENTRO DE FAMILIAS Y PAREJAS

### SEMINARIOS 2do. CUATRIMESTRE

27 de agosto al 1° de setiembre

**Maurizio Andolfi** - La provocación en sistemas rígidos. — La supervisión en vivo en terapia familiar. — El entrenamiento del terapeuta familiar.

Octubre - Noviembre

**Adolfo Loketek** - Terapia Familiar Sistémica y Psicosis — 8 clases — Jueves 13 a 15 hs.

Setiembre - Diciembre

**Silvia Galay y docentes de CEFYP** - Curso Breve de Terapia Familiar Sistémica — 15 clases — Jueves 19 a 22 hs.

Setiembre - Octubre

**María Ester Panizo** - Terapia Familiar Sistémica en Familias con Niños — 8 clases.

Serrano 1141, Capital

T.E. 771-6078



**17 años asistiendo a la familia  
en la comunidad y en la formación  
de profesionales en Salud Mental.**

Directora

Lic. **María Teresa Calvo**

Vicedirectora

Lic. **Hebe Perrone de Millet**

**CENTRO DE INVESTIGACION Y  
ASESORAMIENTO EN PSICOLOGIA**

Avenida Córdoba 4544  
teléfono 772-6147

Cambio epistemológico y cambio terapéutico. La superación de la oposición analógico/digital como precondition para la construcción de una ciencia unificada del hombre\*.

Lic **ALEJANDRO PISCITELLI**

*Julían Alvarez 2382, 2º, "6", Buenos Aires*

*No hay un método filosófico, aunque hay en rigor métodos; del mismo modo que hay terapias distintas (Wittgenstein).*

*Se puede encontrar gran parte del pensamiento de un individuo, una escuela o incluso una generación, dominada y determinada por una u otra forma de razonamiento, truco, lógica o presupuesto metodológico que —de ser explicitados— dejarían paso a una gran, importante y —quizás— debatible enunciado lógico o metafísico (A. O. Lovejoy).*

#### 1. La oposición digital/analógica como obstáculo epistemológico

La lingüística y la teoría de la comunicación han revelado la existencia de una polaridad mental fundamental: la que

\* Charla correspondiente al ciclo conjunto organizado por el Grupo de Estudios de Sistemas Integrados (G.E.S.I.) y la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, pronunciada el 22 de Abril de 1982.

existe entre las manifestaciones de la modalidad digital y la analógica. Cada una de éstas ofrece un modo diferente para expresar un sentido dado. En el modo *digital* se comunica el mensaje mediante el uso de un signo cuya relación con lo significado es convencional; por lo tanto arbitraria pero, cuya necesidad es compartida por todos sus usuarios. La segunda alternativa consiste en el uso de un signo que tiene una relación inmediata con lo que significa actuando en forma de símil o analogía —de allí su denominación de *analógica* (Bateson, 1976; Wilden, 1980).

*La comunicación analógica y digital: oposiciones y complementariedad.*

Aún cuando todos los sistemas naturales de comunicación emplean tanto las modalidades de transmisión analógica cuanto digital donde más fácil es identificarlas es en el caso de los sistemas artificiales. En las máquinas analógicas las computaciones utilizan un análogo de las cantidades físicas representadas: el reloj, la regla, el termómetro, el flotador de una bomba —al igual que el sistema hormonal del cuerpo humano— que depende de un ingreso de “más o menos” de algo en el torrente sanguíneo— son ejemplos de sistemas analógicos.

La máquina digital *difiere* de la analógica por cuanto involucra elementos discretos y escalas discontinuas. El abacado y nuestras dos manos son los primeros ejemplos históricos de máquinas de este tipo. Todo artefacto que posee la característica de “prenderse/apagarse” en sus circuitos eléctricos o digitales es un transmisor digital.

No encontramos una distinción tan clara ni en la comunicación *intra* ni en la *inter*-organísmica. Es cierto que dados dinero y tiempo ilimitados de comunicación es posible representar cualquier comportamiento analógico en forma digital —siempre y cuando dicha conducta pueda especificarse en un número finito de pasos utilizando términos no-ambiguos (Singh, 1973). No lo es menos que la mayoría de los procesos comunicacionales humanos *no* pueden segmentarse de este modo por cuanto no involucran, exclusivamente, procesos digitales.

A fin de sortear estas lecturas reduccionistas se ha sugerido pensar ciertos procesos complejos (transcripción del código genético; liberación de hormonas en el torrente sanguíneo, etc.) en términos no de impulsos —que presuponen un modelo energético subyacente cuando en realidad se trata de un sistema de información que “dispara” energía a fin de que se realice cierto “trabajo”— sino en términos de tipos lógicos y de clases. De seguir esta normativa podríamos afirmar que la neurona dispara (o no) sólo cuando se han cumplido una serie de requisitos digitales y analógicos. La complejidad lógica de un sistema de este tipo —para no hablar del sistema mente/cuerpo— es *irreducible* a una lógica proposicional diádica y se parece más a una lógica multimodal. He aquí la principal dificultad en cuanto a “computarizar” cualquier actividad humana<sup>1</sup>.

*Funciones de la comunicación digital y analógica*

Los humanos somos los únicos organismos que utilizamos ambos procesos de comunicación para transmitir mensajes. Más aún, somos los únicos seres vivos que podemos sustituir en nuestras interacciones una forma de comunicación por la otra con relativa facilidad.

El modo digital del lenguaje es denotativo. Habla de *todo* en el código de los objetos, los hechos y los acontecimientos. Su función es compartir la información descomponible; transmitir/reproducir esquemas y estructuras, etc. Lo analógico sólo habla de relaciones.

La digitalización puede ser de primer nivel (ej: llamadas de alimentos en los gibones) en las cuales el significante sólo alude

<sup>1</sup> No toda idea puede representarse como una combinación finita de operaciones si/no de las neuronas que: o bien dispararían o bien no lo harían. Los caminos posibles de estimulación cerebral no sólo incluyen impulsos. Dar cuenta de estos circuitos implica considerar, asimismo, la frecuencia de la serie de impulsos en un solo axón; la sincronización de los impulsos, la disposición espacial de la sinapsis, el tiempo de sumación de los disparos, etc. Cada uno de estos aspectos no son digitales sino analógicos (Von Neumann, 1958; Wilden, 1980).

a la presencia o ausencia de un referente único o invariable para la especie; o de segundo nivel como en el caso humano (doble arbitrariedad del signo) donde, a partir de unidades mínimas a-significativas se generan mensajes mediante combinaciones que siguen reglas arbitrarias pero compartidas.

La verbalización y la simbolización implican la digitalización de lo analógico siendo que éste antecede a aquella por cuanto el chico se comunica analógicamente con sus esfínteres mucho antes de utilizar el lenguaje articulado.

Siendo como es importante distinguir un tipo de comunicación del otro, rara vez se los encuentra en estado puro. Sin lo digital no podríamos hablar. Por ser procesos de comunicación ambos se distinguen de las transferencias energéticas. Lo digital implica niveles de organización más altos y por lo tanto, niveles de tipos lógicos más bajos.

La traducción de lo analógico a lo digital implica, comúnmente, una ganancia en información (organización) y una pérdida en sentido. A la inversa la traducción de lo digital a lo analógico —como en el caso del síntoma psicossomático— implica, generalmente, una pérdida de información y un aumento del sentido. Este tipo de traducción provoca a menudo paradojas y contradicciones (Weakland et al., 1971; Watzlawick, 1977).

Cada forma de comunicación lleva consigo un tipo especial de *diferencias*. Las diferencias analógicas son diferencias de magnitud, de frecuencia, de distribución, de organización, etc. Las diferencias digitales pueden, en cambio, codificarse en *distinciones* y *oposiciones* lo que ocurre cuando existen elementos discretos con límites bien definidos.

### *La oposición analógico/digital y la especialización hemisférica*

Albergamos en nuestra caja craneana dos mellizos con habilidades tanto contrastantes cuanto complementarias. En fecha tan temprana como 1844 el anatomista Wigan había descubierto que nuestra cabeza es la sede de una torturada y bi-sociante mente. ¿Por qué está esta mente partida en dos? ¿A qué se

debe que nuestros centros decisionales estén repartidos en puntos distantes de la superficie cerebral?

La primera pregunta encierra un enigma casi total. Su respuesta remite a la filogénesis y al proceso de encefalización. La existencia de vestigios de lateralización en los primates superiores muestra que ésta no resulta, como comúnmente se cree, de la especialización lingüística. Decir empero, que la especialización hemisférica representa una obvia ventaja adaptativa sólo es una petición de principios. Por suerte se puede decir algo más interesante para responder a la segunda pregunta.

i) En una persona diestra el hemisferio izquierdo es el dominante. Su principal función consiste en *traducir* las percepciones en representaciones lógicas, semánticas y fonéticas. Es el instrumento de comunicación con el mundo externo sobre la base de la codificación lógico/analítica del mundo circundante. Su área de performance es la lingüística, el pensamiento analítico y todos los aspectos vinculados con la comunicación digital. Se lo denomina hemisferio verbal o *principal* y en la terminología psicoanalítica su funcionamiento es sinónimo de proceso secundario.

ii) Muy otra es la función del hemisferio derecho. Su especialización radica en la aprehensión *holística* de las relaciones complejas; las pautas que conectan; las configuraciones y las estructuras. La capacidad cuasi-holográfica del hemisferio derecho está basada en el principio *pars-pro-toto* es decir, en el reconocimiento inmediato de las totalidades sobre la base de apenas un detalle fundamental (olores, caricaturas, etc). Es el hemisferio responsable de la construcción de las clases lógicas y de la formación de conceptos.

Puede identificarse al hemisferio derecho con el proceso primario<sup>2</sup>. Sus asociaciones no son lineales. Al igual que el *Id*

<sup>2</sup> Rechazamos la tesis del neurólogo inglés Eccles (1973) para quien sólo el H.I. es auto-conciente. A pesar de remedar las características del inconsciente el H.D. no es totalmente autónomo (Galín, 1977). Su funcionamiento no es *separable* de su coordinación/oposición con el H.I.

freudiano, el hemisferio derecho es atemporal; su lenguaje es arcaico y poco estructurado; sus conceptos resultan ambiguos y su aritmética es más que elemental. Las percepciones cuantitativas que provee son, en cambio, sumamente precisas y está mejor equipado que su mellizo para la percepción de configuraciones espaciales complejas.

Posee una visión del mundo sumamente estructurada. Su principal recurso son las imágenes —la analogía, el como-si. Le competen la rememoración de recuerdos y de estados afectivos y sensaciones a ellos vinculados y la producción/reproducción de sonidos musicales.

El listado de propiedades aparentemente privativas de uno u otro hemisferio cerebral, es exactamente el mismo que corresponde a la antinomia digital vs. analógico. Así hemos responsabilizado al H.I. por las actividades analíticas, proposicionales, simbólicas, verbales, etc. y al H.D como al locus de las actividades sintéticas, imaginativas, connotativas, emocionales, etc.

Estos listados contrapuestos (ver Cuadro N° 1) se fundamentan en resultados experimentales que no discutiremos. Resulta llamativo, empero, la insistencia con que se enfatiza en dichos trabajos la separación e *incompatibilidad* de las funciones hemisféricas<sup>3</sup> (Springer & Deutsch, 1981) en vez de su integración en un sistema de canal único:

Tentados por un reduccionismo *autonomista* olvidamos el papel fundamentalmente integrador de la interacción hemisférica: ... la impresión resultante (de la especialización hemisférica) es que cada hemisferio tiene un dominio específico de funcionamiento. Aunque hay un elemento indiscutible de verdad en esta proposición se trata de una verdad de bajo nivel que desconoce las profundidades de la actividad cognitiva (Cook, 1980: 96).

<sup>3</sup> Los fisiólogos y los psicólogos cometen una conocida falacia al localizar en forma analítica los centros de la sed y de la agresión en el hipotálamo o a las habilidades matemáticas en el hemisferio izquierdo prescindiendo del hecho que dichas localizaciones anatómicas son ininteligibles a menos que se las ubique en el *contexto* de un cerebro vivo y un individuo-en-su-entorno (Bateson, 1976; Crook, 1980).

## CAMBIO EPISTEMOLOGICO Y CAMBIO TERAPEUTICO

| ASPECTO ANALOGICO                         | ASPECTO DIGITAL                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. COMUNICACION INTRAORGANISMICA          |                                         |
| Sistema total                             | Parte del sistema                       |
| 2. COMUNICACION INTERORGANISMICA          |                                         |
| Distinciones establecidas por el receptor | Distinciones establecidas por el emisor |
| Contacto de toda la comunidad             | Texto de una comunicación particular    |
| Similaridad                               | Substitución                            |
| 3. DISTINCIONES LOGICAS                   |                                         |
| Concreto                                  | Abstracto                               |
| Territorio                                | Mapa                                    |
| 'Más o menos'                             | 'Esto o Aquello'                        |
| Continuo                                  | Discontinuo                             |
| Observador en el sistema                  | Observador fuera del sistema            |
| Subjetivo                                 | Objetivo                                |
| Relativista                               | Absoluto                                |
| Eco-sistema                               | Entidades                               |
| Sistema abierto                           | Cierre                                  |
| 4. COMUNICACION HUMANA                    |                                         |
| Sentidos                                  | Lenguaje denotativo                     |
| Emoción                                   | Razón                                   |
| Imágenes                                  | Significantes                           |
| Símbolos naturales                        | Símbolos artificiales                   |
| Diferencia                                | Oposición                               |
| Interactivo                               | Individual                              |
| 5. SISTEMAS                               |                                         |
| Relaciones                                | Entidades                               |
| Valor de uso                              | Valor de cambio                         |
| Proceso                                   | Acontecimiento                          |
| Calidad                                   | Cantidad                                |

... antes que "dos personalidades dentro de la cabeza" somos personalidades únicas con dos elementos de control primarios cuyo funcionamiento coordinado es la regla (Cook, 1980: 118)

### *Las ciencias humanas frente a la oposición analógico/digital*

La existencia de dos lenguajes complementarios sugiere que ambos deben ser los *representantes* diferenciales de dos *imágenes* del mundo harto distintas puesto que el lenguaje no sólo refleja el mundo anclado en una estructura social que a su vez hace posible (Bernstein 1975) sino que, además, lo re-crea (Whorff, 1973). Esta polaridad tiene una milenaria historia que se remonta a los orígenes de la filosofía, la mitología, etc.<sup>4</sup>.

Es la marca del genio integrar ambas modalidades expresivas (Koestler, 1979). A esta síntesis entre las modalidades expresivas analógica y digital se refería el gran matemático Gauss cuando afirmaba: "Conozco la solución, lo que falta ahora es descubrir el camino que seguí para encontrarla". Las disputas acerca del peso relativo de lo analítico (digital) y lo intuitivo (analógico) florecen en campos tan dispares como la fundamentación de las matemáticas; las formas religiosas; el valor cognitivo de las expresiones artísticas, etc.

Existe una antífonía de opiniones semejante en los intentos de seleccionar una metodología capaz de producir conocimiento

<sup>4</sup> ¿Es posible que el lenguaje que aprendemos *altere* la operación física de nuestro cerebro? Así lo cree el neurofisiólogo japonés Tadano bu Tsunoda para quien el lenguaje que se aprende durante la infancia alteraría el modo en que los hemisferios izquierdo y derecho desarrollarían sus talentos específicos. Como resultado de tests de escucha dicóticos, el científico japonés cree probada la existencia de diferencias fundamentales en el modo en que los cerebros Caucásico y Japonés procesan los datos sensoriales. Sostiene —para sorpresa de muchos— que los Japoneses procesarían las emociones en el H.I. mientras que los occidentales lo hacemos con el H.D. Cuestionable como lo es esta tesis no por ello resulta menos inquietante. En la medida que las diferencias del funcionamiento cerebral se atribuyen más a la lengua materna que a los factores genéticos de origen étnico entra en colisión con la sociobiología augurando, por ello, prometedoras revisiones teóricas (Sibatani, 1980).

tos válidos en el terreno de las ciencias del hombre. Los enfrentamientos entre positivistas y anti-naturalistas; entre los partidarios de la explicación y los devotos de la comprensión; entre los fanáticos de la cuantificación y los idólatras de la hermeneútica ilustran la tendencia pendular que privilegia alternativamente un lenguaje o modalidad en desmedro de la otra. Otra forma de releer esta polémica es presentándola como el intento de *hegemonizar* el estilo cognitivo correspondiente ya sea al hemisferio derecho, ya sea al hemisferio izquierdo.

¿Hasta qué punto pueden estudiarse la sociedad y los individuos del mismo modo que se estudia la naturaleza? La forma concreta adoptada por la oposición digital/analógico en el terreno de la epistemología de las ciencias humanas se verifica en las respuestas sistemáticamente irreconciliables dadas a este interrogante por dos tradiciones de investigación en pugna.

i) La tradición naturalista se basa en la noción de ley de Hume hallando sus raíces en Galileo y en el neo-platonismo del Renacimiento tardío. Proclama la unidad de método y de doctrina entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza intentando efectuar una *reducción* de lo analógico a lo digital.

ii) Los anti-naturalistas, en cambio, rechazan esta reducción. Inspirados en la hermeneútica *teológica* de Schleiermacher, su linaje filosófico se remonta a Weber, a Dilthey, al idealismo trascendental de Kant contando entre sus ancestros incluso a la concepción aristotélica de la explicación. Establece la *irreducibilidad* de lo analógico a lo digital lo que equivale a proclamar su forzada *inconmensurabilidad*.

No resulta una sorpresa menor advertir que, a pesar de las notorias diferencias que separan a ambas escuelas, las mismas están unidas por un presupuesto compartido: la ontología *empírica* que sus cultores profesan.

Trátese de M. Weber o de P. Winch; de R. Radcliff-Brown o de E. Leach salta a la vista, en todos los casos, una concepción del conocimiento y un programa de articulación de los datos empíricos con la teoría ya sea ingenuos, ya sea erróneos. No cabe duda que los autores mencionados —así como muchos

otros— adhieren aún a precauciones epistemológicas que desdibujan este compromiso. Más comunmente no sucede así.

### *Epistemología de la oposición digital vs analógico*

El recientemente fallecido epistemólogo británico G. Bateson preguntó a su audiencia en el curso de una genial conferencia: ¿Cuántos de los que me están escuchando me ven? Respondiendo a la multitud de manos que se alzaron como testimonio afirmativo lacónicamente comentó: "Parece que a los chiñados les gusta estar en compañía (Bateson, 1976).

Ni sus alumnos veían a Bateson, ni nosotros contemplamos árboles, oímos melodías o nos congratulamos de la belleza de una naturaleza que estaría *ahí-afuera*, lista para ser engullida. Enunciados de la forma 'Vemos tal cosa' o 'Ustedes me ven' no son una mera *pintura* de la realidad. Proposiciones tan 'obvias' presuponen la existencia de modos de acceso a la información y dejan traslucir la eficacia de una selección cultural lingüística y social (Bertalanffy, 1975; Watzlawick, 1977) que determinan cuán 'real' es lo real.

Al levantar sus manos, los alumnos de Bateson exteriorizaron una concepción de la naturaleza del mundo y del conocimiento correspondiente a una etapa de desarrollo de la teoría científica y las relaciones de producción en vez de reflejar una verdad *natural* y atemporal.

No por compartidas sus convicciones eran más verdaderas. Los errores epistemológicos se refuerzan mutuamente —al formar parte de un *sistema* de conceptos— convirtiéndose, de este modo, en garantes de su propia validez (Althusser, 1968).

Las epistemologías erróneas no son *biodegradables*. Ni el paso del tiempo, ni la paciencia teórica contribuyen a su disolución —probablemente sólo sirvan para reforzarlas. Su neutralización así como su reemplazo exige un complejo trabajo conceptual.

En el campo de fundamentación de las ciencias humanas este *reemplazo categorial* puede adoptar dos modalidades con-

trapuestas: i) abandonar toda esperanza de otorgar rigor al conocimiento 'inexacto' postulando la existencia de métodos diferenciales de generación de conocimiento. Se atiende en este caso a la naturaleza diferencial de la realidad pero se pierde toda posibilidad de establecer un árbol unificado del conocimiento; ii) defender la existencia de una unidad de producción/reconocimiento de conceptos en todas las áreas de lo real. Esta opción puede articular las diferencias pero corre el riesgo de perderlas de vista.

¿Están las nuevas corrientes epistemológicas en condiciones de resolver este dilema? ¿Cuáles son las manifestaciones en esta práctica de estas nuevas orientaciones? El reexamen de la interacción hemisférica y la oportunidad de superar el obstáculo epistemológico supuesto en el enfrentamiento entre la comunicación analógica y digital proveen algunos indicios de respuesta a estos inquietantes interrogantes.

Cada uno de los hemisferios cerebrales (cf. supra) juega un papel específico en la construcción de las imágenes del mundo. La *síntesis* de nuestra experiencia del mundo en una imagen corresponde al hemisferio derecho. Compete al H.I racionalizar esta imagen, separar al todo en sujeto y objeto, diferenciar, reificar la realidad y deducir consecuencias. A medida que las inferencias van ocupando el lugar del 'hecho' original las imágenes tienden a consolidarse en 'profecías de autocumplimiento' lo que las vuelve progresivamente incuestionables.

Si se pretende modificar una imagen con un grado de fosilización e inmovilismo tan grande —como el que corresponde a las creencias últimas o a los postulados de racionalidad— se vuelve indispensable conocer qué es lo que quiere cambiar (las imágenes del mundo cuestionadas) a la vez que tener acceso a medios que permitan efectuar este cambio. Pasar del 'qué' al 'cómo' implica realizar un cuidadoso *trabajo* sobre el hemisferio derecho en el cual se conciben y expresan las imágenes del mundo —y donde se localiza nuestro 'sufrimiento' del mundo. Para que este trabajo resulte efectivo debe recurrirse a un lenguaje no digitalizado. Así como el terapeuta debe aprender el lenguaje del hemisferio derecho del paciente utilizándolo

como vía privilegiada para el cambio psicológico (Watzlawick, 1979) los críticos de la epistemología dominante debemos aprender a hablar un lenguaje nuevo que nos saque de los impasses y atolladeros provocados por la hiper-digitalización y la hiper-analogización.

Existen tres técnicas conocidas capaces de resolver el primer tipo de problemas: i) el uso de esquemas de lenguaje propios al hemisferio derecho; ii) el bloqueo del hemisferio izquierdo; iii) la prescripción de comportamientos específicos que combinan propiedades previstas en i) y ii).

¿Cuál es la situación análoga en el campo epistemológico? ¿Qué técnicas pueden utilizarse para realizar una conversión epistemológica? ¿Cuál es el estado de la teoría capaz de utilizar o fundamentar dichos instrumentos transformadores?

## 2. Del cambio terapéutico al epistemológico

Un punto de acuerdo entre las ciencias humanas, sus reflexiones filosóficas y la psicoterapia se halla en su preocupación compartida por la problemática del cambio. El interrogante: *¿qué es lo que debe cambiarse —si es que, después de todo, algo debe cambiarse—?* varía en función de las imágenes disímiles que las distintas filosofías y formas de practicar la ciencia se hacen de su objeto de estudio: el hombre. Examinaremos dicho punto de intersección revisando las cuestiones del cambio en el terreno terapéutico para luego compararlas con sus equivalentes en el ámbito epistemológico.

Un paciente es alguien que sufre. Su sufrimiento se origina en el desfase existente entre dos imágenes del mundo: la que tiene del mundo *real* y una segunda imagen *interna* que no se ajusta a la primera. Existen dos modos de salvar este hiato: i) ya sea modificar la imagen proveniente de la realidad externa —lo que implica cambiar esa realidad; ii) ya sea *adaptar* la imagen interna a la externa.

Entendemos por imagen del mundo a la síntesis más completa y abarcadora del conjunto de experiencias, convicciones, influencias, interpretaciones, evaluaciones, jerarquizaciones, etc.,

que un individuo genera/refleja. Se trata de una construcción sumamente elaborada —moldeada en una matriz social irreductible a interacciones psicológicas puras (Bhaskar, 1979)— siendo los procesos de comunicación su vehículo social.

Las transformaciones de ideas e informaciones no afectan al mundo mismo —a pesar de las protestas en contrario de los empiristas— sino a nuestras *representaciones* del mundo. Nietzsche intuyó el carácter *viviente* de nuestras imágenes afirmando que quienes tienen un “porqué” para vivir, soportarán cualquier “cómo”; mientras que quienes hayan perdido ese “porqué” no sobrevivirán —ni querrán sobrevivir— aun en el habitat más confortable que se quiera imaginar<sup>5</sup>.

La eficacia causal del simbolismo; la capacidad de las imágenes y la voluntad de imponerlas o reprimirlas como instrumentos de transformación del mundo; las conexiones existentes entre las estructuras del imaginario y la estructura de las relaciones sociales, no por difícilmente explorables se desvanecen o resultan menos importantes de lo que generalmente se quiere creer (Douglas, 1978).

La revolución *kepleriana* en la física contemporánea provocada por el reconocimiento de la importancia de los estados mentales —socialmente mediados— en la conformación del mundo *vivido* forma parte de esta revalorización. Físicos de la talla de Edwin Schrödinger no titubearon en afirmar que la “imagen del mundo de cada individuo es y siempre será una construcción de su mente y es imposible probar que tenga alguna otra existencia, salvo la que el mismo individuo les otorga” (1958).

Hizo falta la obra de Kuhn (1974) para que los teóricos de las *ciencias blandas* se permitieran generalizar los resultados provistos por la física teórica desde principios de siglo: la relativización de la medición; la función del observador en la

<sup>5</sup> Ilustraciones recientes de casos en los cuales este “porqué” existe y cuando deja de existir una vida nada vale corresponden al viaje de Louise Bryant a Finlandia/Rusia en búsqueda de J. Reed en la película *Reds* y la despedida a la vida de Ken Harrison en la película *Al fin y al cabo es mi vida*.

construcción de los objetos de conocimiento; la "incommensurabilidad" de observaciones realizadas desde lugares distintos; la alteración de lo observable a partir de la presencia de un observador, etc.; a todos y cada uno de los rincones de la ciencias humanas.

A despecho de estos resultados tanto teóricos como practicantes continúan cometiendo el pecado de lesa empirismo consistente en el destierro de la subjetividad. La objetividad pura es un *mito* tan poco operativo como la pura subjetividad (Lakoff, 1980). Toda descripción del mundo implica alguien que la realiza. Se vuelve entonces necesario, por recursividad, una descripción de quien hace la descripción —y para ello necesitamos de una teoría del observador (Von Foerster, 1974)<sup>6</sup>.

Curiosamente en algunas oportunidades, los psicólogos, sociólogos o antropólogos han podido superar —en estado *práctico*— los obstáculos que dificultan el "progreso" de la epistemología. Tenemos como prueba la teoría del cambio desarrollada por la psicoterapia comunicacional. Un análisis de sus planteos arroja cierta luz acerca del tipo de cambio que es necesario promover en la epistemología.

### *Teorías y tipos de cambio*

*Cambiar algo para que nada cambie*: apotegma político; genialidad del *Príncipe*; máxima cuyo cumplimiento asegura el mantenimiento del poder al hacer circular los mensajes, los bienes y las mujeres del modo más viscoso y auto-preservador que se pueda. La frase enseña en qué medida cambios parciales y fragmentarios son *compatibles* con una estabilidad a más largo plazo. Los cambios a los que se refiere son de un tipo

<sup>6</sup> La idealización que los científicos sociales proponen de un "observador puro" vuelve imposible la identificación de los observadores "reales" al ignorar que dicha idealización es, precisamente, otra imagen del mundo. Esta imagen —añade Schrödinger— es igual al todo y por lo tanto *no* puede estar contenida en él como una de sus partes (Von Foerster, 1960; Piaget, 1970).

menor; desplazamientos mínimos de relaciones que mantienen inamovibles a los elementos (individuos). Cambios dentro de un grupo que no afectan ni su composición, ni su naturaleza.

Matemáticamente un grupo es un conjunto que posee las propiedades siguientes: i) está compuesto por elementos con una propiedad común. La composición de sus elementos da siempre otro elemento del grupo. Numerosos cambios en las relaciones de sus elementos son permisibles. No así con elementos o reglas externas al grupo; ii) la composición de elementos siguiendo secuencias distintas siempre da el mismo compuesto; iii) contiene un elemento "neutro" tal que su composición con todo otro elemento da por resultado este último; iv) en todo sistema que satisface la noción de grupo existe para cada elemento otro "inverso" tal que la composición de un elemento y su inverso da el elemento neutro.

Existe una sorprendente analogía entre los cambios menores condensados en la máxima gattopardista citada anteriormente y las propiedades correspondientes a la Teoría de los Grupos someramente esbozada en el párrafo anterior. ¿Qué sucede, empero, cuando un cambio altera la estructura misma del grupo (institución, organización, familia, Estado) analizado? ¿A qué teoría recurrir para conceptualizar este otro tipo de cambio para el cual la teoría de los grupos resulta, por definición, insuficiente? Los teóricos de la comunicación humana pidieron auxilio —para esta importante tarea— a la teoría de los tipos lógicos (Watzlawick, 1976; Bateson, 1976).

En este caso los miembros (elementos) forman parte de una clase (grupo). Uno de los axiomas centrales de esta teoría es que "la clase de todas las clases no puede ser una clase de sí misma" [la humanidad = la clase de todos los individuos no es, ella misma, un individuo]. Sin embargo este axioma es constantemente *transgredido* en los distintos niveles de la enunciación: sintáctico, semántico y pragmático. Se producen, de este modo, las paradojas del mismo nombre (Hughes & Brecht, 1979; Hofstadter, 1980).

Los trabajos de Palo Alto han puesto de manifiesto, precisamente, en qué medida la conducta patológica puede entenderse



como violación de los axiomas de la teoría que modeliza el comportamiento real (Watzlawick, 1976).

Resumiendo. La teoría de los grupos provee un modelo para pensar el tipo de cambios que se produce en el interior de un sistema que, en sí mismo, permanece inmodificado. La teoría de los tipos lógicos, por su parte, ofrece un modelo para examinar los vínculos que existen entre un miembro de una clase y las transformaciones que permiten el pasaje de un nivel lógico a otro nivel lógico superior.

El ciberneta Ashby formuló en términos inequívocos la diferencial fundamental que existe entre estos dos tipos de cambio:

... La palabra cambio aplicado a una máquina [un autó-mata de estados finitos] puede significar dos cosas distintas: en primer lugar el pasaje de un estado a otro (...) que representa el comportamiento de la máquina; en segundo lugar, el paso de una transformación a otra, o sea, un cambio del comportamiento provocado por el experimentador o por un factor externo (Ashby, 1972).

Llamamos cambio-1 a las modificaciones del primer tipo reservando la noción de cambio-2 para las segundas. El cambio-2 es un cambio de segundo orden —cambio del cambio.

Volviendo a las analogías matemáticas anteriores resulta claro que las propiedades de los grupos (existencia de inverso; conmutación, etc.) no son miembros del grupo —no son propiedades en el grupo, sino del grupo. Están en una relación de nivel lógico superior respecto del grupo como puede apreciarse si se modifica la naturaleza de la operación en el caso de la composición [mientras que el elemento neutro para la suma es el 0; el elemento neutro para la multiplicación es el 1]. Los grupos son invariantes a nivel del cambio-1. En la medida que sus reglas internas son modificables están, empero, expuestos igualmente al cambio-2. No cabe por tanto *oponer* en forma irreconciliable la teoría de los grupos a la teoría de los tipos

lógicos. Se trata, en realidad, de instrumentos de modelización *complementarios*.

### *Cambio-1 y Cambio-2 en ciencia y epistemología*

Una disciplina autónoma (práctica científica) es una construcción teórica altamente compleja, compuesta por: i) una categoría de fenómenos que le son propios; ii) un sistema de información; iii) un sistema informador; iv) un cuerpo de transformadores; v) un cuerpo de conceptos; vi) teorías integradoras; vii) métodos (Palmade, 1979).

El crecimiento del conocimiento científico se realiza siguiendo un proceso *recursivo* de aplicación de estos procedimientos y reglas al universo material y comunicacional. En el caso específico de las ciencias de la materia, las teorías integradoras sirven de barreras para dictaminar *cuáles* interrogantes son válidos y qué *anomalías* (aún molestas) son compatibles con el sistema de conceptos elaborado y aceptado previamente. Llamamos *ciencia normal* al conjunto de transformaciones experimentales y teóricas que tienen lugar dentro de estos parámetros (Kuhn, 1974).

Es verdad que durante los períodos de ciencia normal se producen innovaciones, modificaciones y nuevos aportes al sistema de conocimientos. Sin embargo, ninguno de estos aportes *incrementales* modifica o pone en cuestión la imagen del mundo o la concepción de la ciencia que sus practicantes cultivan. La función de la práctica científica —en estos períodos— es producir fenómenos de conocimiento equivalentes a los cambios-1.

La historia de la ciencia muestra, a su vez, que en ciertas coyunturas las anomalías *prolifera*n; se combinan entre sí produciendo un efecto de bola de nieve. Su existencia, confinada habitualmente a los márgenes de la interrogación de la comunidad científica, alcanza súbitamente los lugares de privilegio discursivo. En este proceso las anomalías cambian de status y se convierten en *enigmas*. Pero estos últimos, a diferencia de las

primeras, urgen su solución so pena de poner en peligro la existencia misma de las disciplinas en cuyo seno afloran.

Llamamos *ciencia revolucionaria* a este período de convulsiones y cuestionamientos. Podemos mencionar como ejemplos de cambio-2 en la historia de la ciencia: el pasaje de la astronomía ptolemaica a la astronomía copérnico/kepleriana; la conversión de una rama mayoritaria de la alquimia a la química; la defenestración de la teoría del éter en nombre de las modernas teorías de la luz, etc (Bachelard, 1975; Raymond, 1974).

Es posible, en forma análoga, concebir la existencia de una *práctica epistemológica* diferencial. Tendríamos por un lado una conceptualización orientada fundamentalmente al estudio de las micro-transformaciones; el análisis de las modificaciones invariantes; la permanencia de los conceptos y técnicas de análisis. Llamaremos epistemología *continuista* a esta práctica cuyo objeto privilegiado de análisis son los cambios-1 o modificaciones intra-científicas. Su vocero más célebre es el filósofo inglés Karl Popper pero a la misma categoría pertenecen los positivistas lógicos; los defensores del modelo de subsunción causal (Hempel, Oppenheim); los post-popperianos (Watkins, Lakatos, etc).

Como contrapartida existen los partidarios de una epistemología *discontinua* centrada en los fenómenos de ruptura, apertura, macro-transformaciones especialmente apta para analizar los cambios de tipo-2: las rupturas epistemológicas y las revoluciones categoriales. Sus figuras más conocidas son los defensores de una perspectiva sociológica en filosofía de la ciencia (Kuhn, Feyerabend, Toulmin, Hanson, Polanyi) y la tradición francesa post-bachelardiana (Canguilhem, los althusserianos, Serres, etc).

La categorización de una transformación como cambio-1 o cambio-2 no obedece a su naturaleza sino a su *posición* en una red de relaciones —en uno de cuyos nódulos se haya el observador. La determinación del tipo de cambio depende, pues, del nivel de análisis en que se ubique el observador.

Por ello si bien existen siempre casos de cambio-1 y cambio-2 en cada uno de dichos niveles (terapéutico, cotidiano,

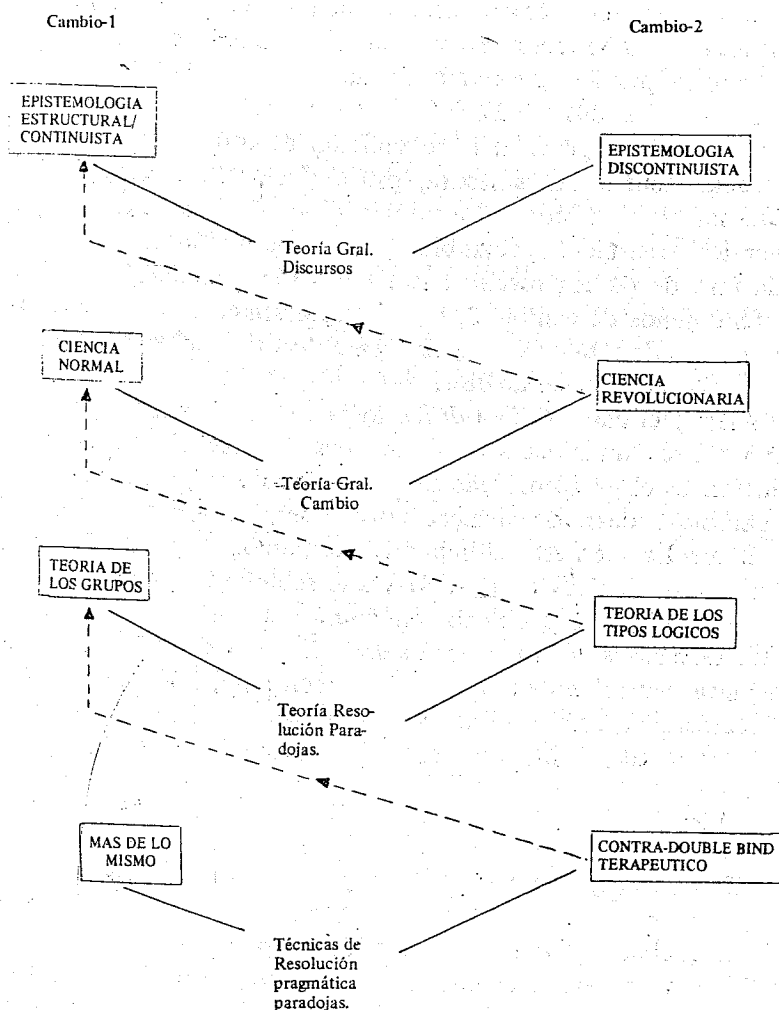
científico, epistemológico, etc) a medida que la reflexión se *relativiza* —añadiendo nuevos escalones explicativos— los tipos de cambio pueden *permutar* de acuerdo al árbol jerárquico adjunto (ver cuadro N° 2).

Queda claro pues: i) la subsunción de todas las categorías (síntoma, teoría del síntoma, práctica científica, etc) de las columnas 1 y 2 como “ejemplares” de las macro-categorías generales: cambio-1 y cambio-2; ii) la oposición explícita en cada uno de dichos niveles entre los fenómenos de cambio-1 y los fenómenos de cambio-2; iii) el desplazamiento de las categorías de un tipo hasta convertirse en categorías del tipo opuesto al cambiar el nivel de análisis.

Así: i) el cambio-2 *modifica* lo que desde la perspectiva del cambio-1 es una solución ya que visto desde el cambio-2 la solución es el problema que se intenta resolver; ii) mientras que el cambio-1 descansa siempre en el “sentido común” el cambio-2 resulta inesperado, imprevisible, paradójico; iii) la aplicación de las técnicas de cambio-2 a la solución implica focalizar la atención en el problema tal como éste se presenta *ahora*. Estas técnicas se ocupan de los *efectos* y no de las causas. La pregunta central no es *¿qué?* sino *¿porqué?*; iv) la utilización de técnicas de cambio-2 arranca la situación del peligro generador de paradojas creado por la flexibilidad del intento de solución.

### *De la metáfora al concepto*

Al igual que las teorías matemáticas que pierden validez a medida que se van alejando de su ámbito generativo, nuestro intento de generalizar algunos planteos terapéuticos al campo de la *pragmática de las cosmovisiones* se desdibuja apenas queremos conceptualizarlo con mayor rigor. Con tal fin conviene desvincularse de algunos presupuestos comunicacionales que debilitan precisamente esta transferencia conceptual. Debemos rechazar, en especial, la tesis según la cual el encuadre más eficaz para la intervención deliberada en los hechos humanos es



aquel burilado en términos de explicaciones superficiales (que) y no de explicaciones profundas (porque).

Esta reducción —objetable de por sí a nivel de la cotidianidad y la terapéutica— es imposible de mantener a medida que se progresa en el estudio de los esquemas y formaciones catego-

## CAMBIO EPISTEMOLOGICO Y CAMBIO TERAPEUTICO

riales que hacen posible la construcción de la experiencia (Goffman, 1975).

Más aún, el análisis del cambio de las categorías fundamentales de la percepción y la racionalidad (cambios-2) necesitan de exámenes genéticos profundos y complejos y de la reconstrucción y reescritura de historias individuales y sociales imposibles de realizar exclusivamente bajo la bandera de la problemática del "qué"<sup>7</sup>.

En la síntesis precedente hemos presentado el proceso que permite acceder progresivamente a estos esquemas categoriales bajo la forma de una *oscilación* constante entre cambios de tipo-1 y cambios de tipo-2. En lenguaje menos esotérico esta oscilación revela que el cambio de la epistemología por el cual estamos abogando es sinónimo de una epistemología del cambio (-2). Es decir, una epistemología abierta, discontinuista, activa, integradora, etc.

¿Existe alguna escuela o estilo de pensamiento que exhiba estas características? ¿Qué posibilidades efectivas tenemos hoy de sortear las interminables disputas sectoriales en el campo de las ciencias inexactas a fin de aumentar la confiabilidad, legitimidad y utilidad de sus resultados? ¿Cómo podría utilizarse operativamente una epistemología con tales características teniendo en vista la reducción de ambigüedades y la eliminación de controversias resultantes de oposiciones teóricas *salvajes*?

La importancia del paradigma estructural/sistémico radica, justamente, en su intento de dar respuesta a estos interrogantes.

<sup>7</sup> La principal modificación que introducimos a esta problemática consiste en mostrar que las preguntas "¿qué?" y "¿porqué?" no son excluyentes. Erran tanto, pues, los pragmatistas de la comunicación cuando sostienen que los desplazamientos sintomatológicos descritos por el psicoanálisis no se deben a la naturaleza del espíritu sino a la naturaleza de la teoría (freudiana) cuanto los psicoanalistas que descuidan las descripciones comunicacionales tildándolas de "chapa y pintura" terapéutica. Estas incomprendiones mutuas —el culto del "qué" en desmedro del "por qué" (o viceversa)— se originan en modelizaciones simplificadas teñidas de prejuicios empiristas, formalistas o fenomenologistas —todos igualmente esterilizantes.

Después de introducir algunos conceptos básicos con cuyo concurso se ha pretendido resolver estos problemas, haremos un comentario crítico final acerca de la distancia que aún separa la realización de este programa de sus promesas originales.

### 3. Estructura, sistema y la unificación del conocimiento

El cambio epistemológico propuesto no consiste en reemplazar lo disciplinario por lo interdisciplinario. Una alquimia verbal de tal naturaleza opera exclusivamente a nivel *ideológico* produciendo escasos —o ningún— efectos científicos (Palmade, 1979). La síntesis postulada apunta, en cambio, a producir un estudio *transdisciplinario* de los sistemas adaptativos —simbólicos, imaginarios y reales. Estos sistemas abiertos autoorganizados constan de estructuras diferenciales regulando sus relaciones con una serie *estratificada* de entornos. A diferencia de los sistemas generales de la teoría física clásica y en contraposición a la mecánica de los sistemas generales (análisis de sistemas, funcionalismo) los sistemas adaptativos dependen del tiempo; responden a memorias internas y se autoreproducen (Allen, 1981; Atlan, 1979).

Un perfil epistemológico semejante tiene numerosos antecedentes en la época moderna. La metáfora del sistema abierto está implícita en la concepción de la novela como búsqueda; en el modelo freudiano del deseo del objeto perdido; en el proyecto Sartre-heideggeriano de llenar lo que se conceptualiza como una pérdida primordial.

La desventaja de estas metáforas radica en su pretensión de “arrancar” al sistema abierto del contexto eco-bio-social real convirtiendo los sistemas de relaciones que denominamos “individuo”, “yo” o “mente” en partículas elementales. El objetivo de reconciliación implícito en dichos modelos literarios, psicológicos o filosóficos descansa en utopías o en formas filosóficas románticas —no alcanza (ni tampoco pretende) una reconciliación en/con lo real (Wilden, 1980; Morin, 1980).

#### *Las demandas del contexto*

El *fundamentalismo* científico pre y para-sistémico está

basado en tres supuestos erróneos: i) el desconocimiento de las nociones de *cierre y contexto*; ii) la negación del hecho que todo contexto está compuesto por niveles; iii) la dificultad en dar cuenta de los problemas planteados por la intersección de tipos lógicos en los sistemas biológicos y sociales.

La delimitación del contexto es un problema de *puntuación* ya sea a nivel de una relación dada ya sea a nivel de las relaciones entre sí. También los límites del sistema están organizados jerárquicamente. Un sistema cerrado es aquel para el cual su contexto es *irrelevante*; un sistema abierto, en cambio, es aquel que depende de su entorno para la existencia y la supervivencia.

Los conceptos de estructura y de sistema mediante los cuales se intenta abrir este nuevo frente epistemológico ha sido formulado en el contexto de imágenes del mundo globales (la controversia entre el mecanicismo y el organicismo) en *conflicto*. Estos conceptos “nuevos” han sido arrastrados por la lucha interminable que enfrenta al holismo vs. el elementarismo; la emergencia vs el reduccionismo; la complejidad simple vs la complejidad organizada.

El enfoque estructuralista tiene en su haber la superación del nivel *ingenuo* de observación y su sustitución por medio de *modelos* que representan la organización subyacente de los objetos y acontecimientos estudiados:

... el término “estructura social” no tiene nada que ver con la realidad empírica, sino con los modelos que se hacen a partir de la misma... las relaciones sociales consisten en la materia prima a partir de la cual se construyen los modelos de la estructura social (Levi-Strauss, 1958).

La organización; forma o *pauta que conecta* constituye la estructura de los fenómenos estudiados. Ser estructuralista consiste, por lo tanto, en la utilización de lenguajes (matemáticos o

no) que permitan la representación de dichas estructuras ocultas<sup>8</sup>.

El problema central del estructuralismo consiste en la imposición de orden y organización en las actividades identificando niveles de estabilidad o constancia transitoria frente al cambio. El programa implica, más concretamente, una ordenación de formas *generales* así como el análisis de sub-sistemas o estructuras en el ámbito de estructuras englobantes de nivel superior.

Bajo esta perspectiva es posible considerar a la T.G.S. como una *variante* del estructuralismo —especialmente holístico. A pesar de una conexión tan estrecha no debe verse a la TGS ni como el prerequisite filosófico para la existencia del estructuralismo ni como el programa de investigación exclusivo generado por dichos requisitos. Se trata, más bien de:

... un modelo interdisciplinario general que ha sido formulado en el contexto de los prerequisites, pero que, en vez de ser una aplicación específica del programa estructuralista, intenta delinear los aspectos significativos de todas las estructuras, organizaciones o sistemas (Overton, 1975: 75).

Es misión de la T.G.S. explorar las similitudes estructurales o *isomorfismos* en varios campos del saber, proveyendo definiciones de conceptos estructurales tales como "totalidad", "organización", "teleología", "diferenciación", etc. (Bertalanffy,

<sup>8</sup> A fin de que el estructuralismo no se convierta en una versión adicional del análisis de las entidades *inferidas* (Wartofsky, 1971) deberá poder especificar la naturaleza de las estructuras estudiadas. Esta juega un papel vital en las explicaciones comprometiendo a sus usuarios con una tradición filosófica crítico/idealista caracterizada por: primacía de la función sobre la substancia; adopción de un holismo emergentista y una causalidad dialéctica; una epistemología constructivista, etc. La combinación de estas características conforma un *sistema metafísico* común a autores tan disímiles en otros respectos tales como Chomsky, Piaget, Levi-Strauss, etc.

1975). La T.G.S. se halla, por lo tanto, a mitad de camino entre el conocimiento detallado, provisto por las disciplinas particulares y los presupuestos filosóficos y metateóricos que vertebran el estructuralismo (Bunge, 1977)<sup>9</sup>.

### *El "sistema abierto" como atractor*

La idea de "sistema abierto" es el concepto operatorio central de la T.G.S. Por tal entendemos al conjunto de procesos que regulan y controlan los flujos de materia, energía e información dentro de una estructura (Miller, 1971). La teoría de los sistemas abiertos es una *generalización* de la cinética y la termodinámica clásicas. Los sistemas abiertos —en contraposición a los sistemas cerrados estudiados por la física tradicional— se hallan en estado estacionario, tienen historia y gran parte de los procesos que en ellos tienen lugar están lejos de las situaciones de equilibrio (Prigogine, 1980).

Las diferencias entre un organismo sano normal y un organismo enfermo no pueden definirse en términos de las teorías *elementaristas* a las cuales se acudió tradicionalmente para explicar el comportamiento de las máquinas simples (péndulos, relojes, etc). Dichas diferencias que son fácilmente apreciadas por nuestra *intuición* biológica resultan difíciles de representar mediante medios simbólicos.

En un organismo sano a diferencia de un cuerpo enfermo los innumerables procesos físico/químicos están *ordenados*. Este concepto, empero, no pertenece al arsenal operatorio de la física clásica a menos que se lo tome en su acepción *meccanicis-*

<sup>9</sup> Ni la lectura sistémica ni el método hipotético-deductivo *determinan* la naturaleza de la realidad bajo estudio (Watzlawick, 1977). Ambos producen recortes mediante los cuales se construyen los objetos teóricos. Estas operaciones están *sobredeterminadas* por variables tecnológicas, sociales, políticas, etc. que ningún purismo metodológico a la *Weber* puede eliminar. La ciencia no es un mero *juego* lingüístico. No es, tampoco, el discurso que sirve de *medida* a toda enunciación posible. Hay que evitar a toda costa tanto el convencionalismo a ultranza cuanto un *fundamentalismo* científico simplificador.

ta: "ordenable es toda aquella actividad o proceso cuya acción puede ser imitada por una máquina".

Una vez aceptada la noción de sistema abierto, el problema siguiente que el enfoque sistémico debe encarar es la *separación* del sistema viable especial que se quiere analizar (Iberall, 1973) del resto del universo sin que esta separación de lugar a una división *aniquiladora* (Beer, 1961).

No es suficiente, por lo tanto, definir al sistema abierto como aquel todo compuesto por algos interrelacionados de modo indiscriminado. Hace falta, además, *especificar* en cada caso particular (problema, crisis, situación histórica analizados) *cuál* es la naturaleza de los componentes y qué *formas* adoptan las relaciones que los vinculan.

Para efectuar una selección de variables relevantes el sistémista apoya su investigación —al igual que cualquier otro científico— en una tradición acumulativa de conocimiento provista por los métodos analíticos convencionales (Popper, 1969).

Ello no obsta para negar la posibilidad de generar nuevas categorías de conocimiento (equifinalidad, crecimiento relativo, competencia, etc) a partir precisamente del *recorte* sistémico que permite su exportación fuera de su ámbito de origen (Miller, 1978).

### La perversión epistemológica

No es necesario ir muy lejos para descubrir que el principal enemigo del cambio epistemológico somos nosotros mismos o para detectar en qué medida la epistemología enferma está enquistada en la organización y transmisión del saber (Bourdieu, 1976).

La vigencia de la clase magistral convierte al proceso pedagógico —necesariamente bi-direccional— en un circuito de sentido único gracias al cual el sujeto *supuesto saber* imparte su sapiencia *imaginaria* informando/deformando sin que la resistencia del oyente (su posibilidad de corregir los mensajes que recibe) pueda utilizarse en forma activa.

De estas aparentes mini-imposiciones a las macro-imposicio-

nes, al control y al abuso de poder sólo hay un corto trecho que la humanidad recorrió presurosa a lo largo de los últimos 10.000 años (Godelier, 1974).

La epistemología mala —al igual que la falsa moneda— todo lo contamina. No es el poder en sí el que corrompe sino la idea misma de poder (Bateson, 1976). En la medida que nuestra idea de poder sea tan errónea como el resto de nuestras ideas el caos actual continuará. No es casual que nuestros sistemas políticos estén organizados de tal modo que favorecen la acumulación del poder en manos de aquellos que tanto lo desean —impidiendo efectivamente su traspaso a manos de aquellos que no lo detentan actualmente.

El poder no corrompe solamente. Como todo mito, al mismo tiempo, *fascina* (Foucault, 1976). Contra los mitos no existe otro antidoto salvo *otros* mitos. No alcanza con desmascarar los errores de la epistemología dominante acudiendo a las reservas de lucidez de los individuos aún dispuestos a *auto-reprogramarse*.

Hace falta, además una *huelga* prolongada de la inteligencia; una convocatoria a la capacidad imaginativa para que recree y funde nuevas mitologías: ni tan destructivas, ni tan dogmáticas como las que hoy abundan. Dejemos de pensar, para pensar de otro modo. Dejemos de actuar, para actuar de un modo distinto.

Un graffito del Mayo parisino: *Prohibido prohibir* ofrece una clave para este nuevo viaje epistemológico. Debemos pasar de una civilización de las *proscripciones* a una civilización de las *prescripciones*. Necesitamos un modo de convivencia que mantenga la variedad, que refuerze las diferencias, que tolere las discrepancias (Von Foerster, 1976).

Abogamos por una civilización menos hipnotizada por sus supuestos logros y más atareada en la solución de sus contradicciones internas. El cambio de la epistemología sólo será posible cuando las condiciones *reales* del mundo en que vivimos haya cambiado (Wilden, 1980). Es por ello que el cambio de la epistemología presupone, pero al mismo tiempo exige, una epistemología del cambio.

## Resumen

La especialización hemisférica —hipótesis neurológica y psico-lingüística heurísticamente fecunda— debe tomarse por lo que realmente vale: una construcción teórica con decididas limitaciones. Tentados por el reduccionismo hemisférico tendemos a olvidar el papel fundamentalmente integrador de la interacción hemisférica. Históricamente esta disociación se tradujo en la perpetuación de una tradición maniquea que aisló a la intuición del razonamiento, a la comprensión de la explicación, a lo analógico de lo digital. Paradójicamente estas tendencias disociadoras creyeron encontrar en la diferenciación cerebral funcional a su 'locus' justificatorio. ¡Es hora de terminar con estas dicotomías!

Así como el terapeuta aprende el lenguaje del paciente utilizándolo como vía privilegiada para el cambio psicológico, los críticos de la epistemología neo-realista y reduccionista dominante debemos aprender a hablar un lenguaje nuevo que nos arranque de los impasses originados en las posturas hiper-analogizantes o hiper-digitalizantes que privilegian alternativamente uno u otro aspecto del comportamiento humano. A tal fin debemos efectuar una revolución kepleriana en epistemología —semejante en cierto sentido al cambio-2 en psicoterapia.

Se trata de desarrollar una epistemología discontinuista que tiene antecedentes en autores post-bachelardianos y post-popperianos pero que sólo encuentra su realización práctica en los trabajos de los cibernetas y los epistemólogos experimentales tales como S. Beer, W. McCulloch, G. Bateson, F. Varela y H. Maturana. Este artículo —que sólo abreva en sus enseñanzas periféricamente— desbroza algunos de los obstáculos y señala algunos de los caminos que la revolución epistemológica (y terapéutica) están en tren de recorrer.

## Summary

Hemispheric specialization —an heuristically rich neurological and psycholinguistic hypothesis— must be given its due: it is a theoretical construct with clearcut drawbacks. As we happen to be tempted by the hemispheric reductionism we are led to forget the basic role that hemispheric interaction plays as an integrative feature in human behavior. This severance has shown itself historically in carrying over a manichean tradition that has isolated intuition from reasoning, understanding from explanation, analogic from digital. It is a sound paradox that these trends may have thought they could find their final justification in the mind's two brains. Time has come to remedy these illusions!

As Critics of the prevailing neo-realist and reductionist epistemology we must learn to speak a new language that may substract us from the dead ends to which we have been carried by hiper-analogical or hiper-digitalized approaches fostering alternatively one or the other sides of human behavior. Striving to reach this goal we must produce a 'keplerian' revolution in epistemology similar, to some extent, to change-2 in psychotherapy.

We must develop a critical epistemology rooted in fact in post-bachelardian and post-popperian authors but whose only existing example must be found in the work of cyberneticians and experimental epistemologists such as S. Beer, W. McCulloch, G. Bateson, F. Varela and H. Maturana. This paper does only deal cursorily with their teachings. Most of its content is addressed to the obstacles and points to some of the ways that this epistemological (and therapeutic) revolution are on the verge of trodding.

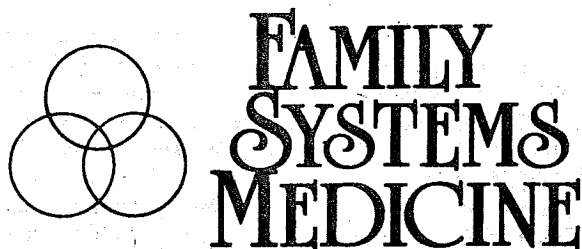
## Bibliografía

- ALLEN, P. y SANGLIER, M; "Dinamic models of urban growth". *Journal for social and biological structures*, 1, 1978; 265-280.
- ALTHUSSER, L. *La revolución teórica de Marx* (1965). México: Siglo XXI, 1968.
- ASHBY, W. R. *Introducción a la cibernética* (1956). Bs. As.: Paidós, 1972.
- ATLAN, H. *Entre le cristal et la fumee. Essai sur l'organisation du vivant*. París: Seuil, 1979.
- BACHELARD, G. *La formación del espíritu científico* (1967). Buenos Aires: Siglo XXI, 1973.
- BATESON, G. *Pasos para una ecología de la mente* (1972). Buenos Aires: Lohle, 1976.
- BEER, S., *Decision and control*. New York: John Wiley and Sons, 1961.
- BERTALANFFY, L. von *Teoría general de los sistemas. Fundamentos, conceptos, desarrollos* (1968). México: FCE, 1975.
- BHASKAR, R. *The possibility of naturalism. A philosophical critique of the contemporary human sciences*. New Jersey: Humanities Press, 1979.
- BOURDIEU, P. *La reproducción* (1972). Barcelona: Laia, 1976.
- BUNGE, M. The General System Theory challenge to the classical philosophies of science. *International Journal of General Systems*, 1977, 4.

- COOK, N. D. *Stability and flexibility. An analysis of natural systems*. Oxford: Pergamon Press, 1980.
- CROOK, J. H. *The evolution of human consciousness*. Oxford: Clarendon Press: 1980.
- DOUGLAS, M. *Símbolos naturales. Exploraciones en cosmología* (1973). Madrid: Alianza, 1978.
- ECCLES, J. *The human mystery, Gifford Lectures 1977/8*. Berlin: Springer-Verlag, 1979.
- FOUCAULT, M. *Historia de la sexualidad T. I. La voluntad de saber* (1976). Méjico: Siglo XXI, 1977.
- GALIN, D. Lateral specialization and psychiatric issues: speculations and developments and the evolution of consciousness. *Annals of the New York Academy of Sciences* 1977, 299: 397-411.
- GODELIER, M. *Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas*. Madrid: Siglo XXI, 1974.
- GOFFMAN, E. *Frame analysis: an essay on the organization of experience*. New York: Harper & Row, 1975.
- HOFFSTADTER, D. R. *Godel, Escher and Bach: an eternal golden braid*. New York: Vintage, 1980.
- HUGHES, P. & BRECHT, G. *Vicious circles and infinity: an anthology of paradoxes*. Middlesex: Penguin, 1979.
- IBERALL, A. S. *Toward a general science of viable systems*. New York: Mc Graw Hill, 1972.
- KOESTLER, A. *Janus: a summing up*. New York Vintage Books, 1979.
- KUHN, T. S. *La estructura de las revoluciones científicas* (1970). Méjico: FCE, 1972.
- LAKOFF, G. *Metaphors we live by*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980.
- LEVI-STRAUSS, C. *Antropología Estructural I* (1958). Bs. As.: Eudeba, 1966.
- MORIN, E. *La Methode T. I. La nature de la nature*. París: Seuil, 1977.
- OVERTON, W. General systems, structure and development. En K. Riegel y G. Rosenwal (eds): *Structure and transformation. Developmental and historical aspects*. New York: Wiley & Sons, 1975.
- MILLER, J. G. The nature of living systems. *Behavioral Science*, 1971, 16 (4), 277-301.
- MILLER, J. G. *Living systems*. New York: Mc Graw Hill, 1978.
- PALMADE, G. *Interdisciplinaria e ideologías*. Madrid: Narcea, 1979.
- PIAGET, J. *El estructuralismo*. Buenos Aires: Proteo, 1968.
- POPPER, K. *El desarrollo del conocimiento científico. Conjeturas y refutaciones*. (1962). Buenos Aires: Paidós, 1967.
- PRIGOGINE, I. *Tiempo, Estructura y Fluctuaciones. Cuadernos del G.E.S.I.*, 1980, 2.
- RAYMOND, P. *Le passage au materialisme*. París: Maspero, 1973.

- RUDRAUF, J. Ensayos sobre la dialéctica de los niveles de comunicación en la intervención terapéutica. *Terapia familiar*, 1980, V. 4; pág. 87-98.
- SCHROEDINGER, E. *¿Qué es la vida?* (1944). Barcelona: Avance, 1976.
- SIBATANI, A. The japanese brain. *Science* 80, 198, December.
- SINGH, J. *Teoría de la información, del lenguaje y de la cibernética*. (1966). Madrid: Alianza, 1972.
- SPRINGER, S. & DEUTSCH, G. *Left brain; right brain*. San Francisco: W. H. Freeman & Co, 1981.
- VON FOERSTER, H. On self-organizing systems and their environments. En P. Yovitz (ed): *Self-organizing systems*. New York: Pergamon, 1960.
- VON FOERSTER, H. Notes pour une epistemologie des objets vivants. En E. Morin (ed): *L'unité de l'homme. Invariants biologiques et universaux culturels*. París: Seuil, 1974.
- VON NEUMANN, J. *Man and the computer*.
- WATZLAWICK et al. *Teoría de la comunicación humana* (1966). Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1971.
- WATZLAWICK P. *Cambio. Principios de planteo y resolución de problemas* (1975).
- WATZLAWICK P. *El lenguaje del cambio. Elementos de comunicación terapéutica*. (1978).





A Journal at the Confluence of Family Therapy,  
Systems Theory and Modern Medicine

A new publication joining psychological and biomedical approaches to health care and adding a penetrating focus on the family as the primary unit of diagnosis and treatment. It investigates all illness from a family systems perspective, focusing on how families are organized around chronic illness, accidents and catastrophic illness, in order to determine how the family organization enables or disables patient care and compliance with medical regimens, and in turn is affected.

Topics include: Hierarchical Issues in a Systems Approach to Illness and Health; A Family Approach to Patient Compliance; Psychosomatic Families; Terminal Illness and Death; What Is the Family in Family Medicine?

#### CIRCULATION AND FREQUENCY

First Issue: Spring 1983. Family Practice Physicians, Family Therapists, Psychologists, Clinical Social Workers, Nurses, and related research and clinical disciplines.

Publication is quarterly in March, June, September and December. Subscription rate is \$27 per year for individuals, \$44 for institutions.

Editor:

Donald A. Bloch, M.D.

Assoc. Eds:

Michael L. Glen, M.D.

Barry Dym, Ph.D.

Donald Ransom, Ph.D.

Correspondence to: Mrs. Alice Weisman; Advertising and Promotion Director; Box 419, Larchmont, N.Y. 10538; (914) 834-3920

---

Terapia familiar y psicoanálisis individual. Integración de recursos terapéuticos

---

Lic. EDUARDO MANDELBAUM

---

*Uriburu 1001, (1642) San Isidro*

---

La integración de recursos terapéuticos aparece como una necesidad referida al tratamiento de pacientes psicóticos y de sus grupos familiares, en los albores de la organización de la Comunidad Terapéutica Psicoanalítica, al promediar la década del '60. En el contexto multifamiliar que la comunidad ofrece a pacientes y terapeutas se hace posible el abordaje de distintos aspectos de la psicopatología psicótica a partir de diferentes encuadres psicoterapéuticos. Jorge García Badaracco se ha ocupado de describir el proceso terapéutico como un proceso de recrecimiento o redesarrollo que el paciente integra a partir de sus diversas experiencias en los ámbitos que le son dispuestos comunitariamente. El tipo y cualidad de los logros obtenidos con este enfoque nos alentaron a elaborar hipótesis de trabajo, susceptibles de ser verificadas en la experiencia clínica, acerca de la posibilidad de enriquecer y movilizar ciertos aspectos del psicoanálisis de pacientes no-psicóticos, mediante la integración de tratamientos que implican la operación directa sobre la

patología vincular, tales como el tratamiento psicoanalítico de la pareja y del grupo familiar. Analizaré, aunque más no sea brevemente, algunas conceptualizaciones sobre el concepto mismo de "integración de recursos terapéuticos".

Debemos diferenciar primeramente si tal integración será llevada a cabo por un equipo de terapeutas, o por uno solo. La complejidad de los fenómenos involucrados aumenta naturalmente al ser varias las personas que se reúnen en un equipo para realizar distintas operaciones terapéuticas. Los niveles de análisis que a continuación describiré son el resultado de la observación y seguimiento durante varios años, de equipos terapéuticos que funcionaban en la sala 3 del Hospital Nacional José T. Borda.

El primer nivel de análisis se refiere al encuentro y articulación entre distintos cuerpos teóricos y conceptuales, muchas veces pensados a partir de campos experienciales muy distintos. Así por ejemplo las hipótesis de observación, que en la teoría psicoanalítica incluyen la teoría de la transferencia, leerán una fenomenología muy distinta a aquella observable en entrevistas psiquiátricas, que no tomen en cuenta las ideas acerca de la transferencia. Otro ejemplo del tipo de integración teórica, al que se refiere este nivel de análisis, sería el que intenta conjugar la hipótesis psicoanalítica sobre el funcionamiento intrapsíquico con lo observable en las experiencias diádicas o familiares.

El segundo nivel de análisis propuesto corresponde a las distintas técnicas o abordajes terapéuticos concretos donde deberán solventarse problemas tales como la relación entre encuadres, ubicación de los terapeutas en cuanto a sus modalidades operativas, estilos, etc. La compatibilidad o incompatibilidad parcial o total, temporaria o definitiva entre los diferentes recursos también deberá ser motivo de análisis y evaluación en este nivel de integración. Un tercer ángulo a tener en cuenta al pensar en el concepto de "integración de recursos", se refiere a que los recursos son desarrollados por agentes concretos: esto es, personas entrenadas en uno u otro quehacer y que entrará a jugar una dinámica particular que reflejará necesariamente as-

pectos del paciente, su conflictiva individual y familiar y que decidirá en última instancia, su destino terapéutico.

Un cuarto nivel de análisis corresponde a la integración que el paciente llevará a cabo por sí mismo y en sí mismo de las diferentes vivencias, "insights", comprensiones, etc., en cada encuadre psicoterapéutico, en función del desarrollo de su propio proceso terapéutico. Este es el aspecto de la integración que corresponde al mundo interno del paciente.

En lo que sigue me referiré sobre todo al análisis de diferentes aspectos observados en el acontecer de tratamientos psicoanalíticos individuales, integrados con tratamientos familiares, realizados por el mismo terapeuta.

Con el desarrollo del tratamiento psicoanalítico, a partir de los descubrimientos de Freud, nos encontramos con la perspectiva de que la enfermedad mental, expresada en síntomas y alteraciones de la personalidad, propia de un individuo e inatacable hasta entonces en su reinado intrapsíquico, se hace, a partir del descubrimiento y utilización de la transferencia, pasible de ser vivenciada, desarrollada y resuelta, en un vínculo con otro, el analista. Para ser curada, psicoanalíticamente, la patología mental deberá transformarse en patología vincular. Freud llama a este fenómeno "desarrollo y resolución de la neurosis de transferencia". Durante muchos años, el analista intentará comprender a la luz de lo ocurrido, entre su paciente y él, cómo aquellos fenómenos que enfermaron se hacen nuevamente presentes. Se repetirán asimismo las condiciones y carencias patogenéticas; y asistiremos simultáneamente una y otra vez, a la repetición traumática de lo que fue y a la búsqueda incesante de lo que no hubo.

Desde esta descripción conceptual, acerca del tratamiento psicoanalítico individual, pasaremos ahora a intentar describir nuestra lectura del tratamiento psicoanalítico de la familia.

En el grupo familiar distinguiremos dos tipos de fenómenos transferenciales: aquellas transferencias que se depositan sobre el terapeuta y que pueden comprenderse desde el modelo psicoanalítico clásico y los fenómenos transferenciales que se dan entre los miembros de la familia de un modo complejo y

que se supone además una historia y un tiempo compartidos.

Desde este enfoque de la familia, puede entenderse la patología grupal e individual como la detención o la regresión en los procesos de desarrollo de cada uno de los individuos, "atrapados" en esa espesa trama de deseos, fantasías anacrónicas, aspiraciones reprimidas y estructuras inconscientes que son el sustrato de las proyecciones transferenciales mutuas.

La labor del terapeuta no será entonces sólo interpretar la "neurosis de transferencia" con el fin de resolverla, sino que deberá, además, crear las condiciones necesarias para que las personas involucradas en las tramas patológicas puedan ir dando los pasos necesarios en sus procesos terapéuticos como para ir surgiendo poco a poco de sus investiduras transferenciales y aparecer a los ojos de los demás y de sí mismos, como son en realidad.

Aquel que haya trabajado psicoanalíticamente con familias tendrá en su experiencia esos momentos, sumamente dramáticos, en que un padre, una madre o un hijo, alcanzan a reconocer a "un otro", más allá de sus deseos narcisísticos, sus fantasías omnipotentes, o infantiles, con las que hasta ese momento recubría y manipulaba la representación del objeto amado. Este fenómeno de "reconocimiento" de los rasgos reales del objeto se da en un clima emocional muy especial, en que se mezclan sentimientos de pena, sentimientos depresivos, afectos positivos reparatorios, y elementos reflexivos como los que concurren a la obtención del "insight" del psicoanálisis clásico. Pero estos "insights" tienen la característica de ser compartidos y de aportar comprensiones profundas para cada uno de los miembros de la familia.

Desde este punto de vista, el trabajo de elaboración individual, con un paciente que haya pasado por esa experiencia con sus objetos originales, se hace sumamente rico y permite la profundización, por ejemplo en el esclarecimiento de identificaciones primarias y secundarias muy tempranas, así como la elaboración de fantasías persecutorias muy arcaicas. Una paciente de 30 años, que trabajaba con encuadre individual y familiar, había traído a su análisis las identificaciones concien-

tes e inconcientes con una madre, a la que vivía como fría y hostil y a la que había introyectado como tal. Tenía serios conflictos por lo tanto con aspectos importantes de su femineidad y conscientemente renunciaba a desarrollar sus aspectos maternos ya que tenía maltratar a sus futuros hijos como ella se había sentido maltratada. La terapia familiar reveló cómo detrás de esa figura hostil y fría con que ella revestía a su madre, que por otra parte le confirmaba sus mensajes amargamente decepcionantes, presa de su propia patología, se escondía en realidad una niña carenciada y asustada como su propia hija, a quien esta mamá veía como una figura demandante y exigente de la que debía huir. El trabajo terapéutico en las sesiones de familia llevó a una revisión profunda de lo depositado en cada extremo de este vínculo patológico, mientras el análisis individual facilitaba la reflexión e "insight" de la hija sobre su no-necesidad real de repetir las carencias de su madre y dar oportunidad al surgimiento de sus propios y legítimos deseos de maternidad.

El desarrollo de los diferentes encuadres simultáneos permite una serie de operaciones terapéuticas diversas, de las que mencionaré sólo algunas y en cierto modo sumariamente, ya que esta modalidad de tratamiento, sobre todo con pacientes no-psicóticos, tiene pocos años de desarrollo.

En el psicoanálisis de pacientes con escaso desarrollo yoico, en el que el proceso de crecimiento se ha detenido por la intensidad libidinal que requieren el mantenimiento de vínculos simbióticos, no es extraño llegar a momentos en que grandes montos de hostilidad, al servicio de la transferencia negativa, harán peligrar el vínculo terapéutico. Si tal actuación no sobreviene, nos encontraremos al menos con un intenso bloqueo para el desarrollo normal del análisis.

El paciente tomado por identificaciones primitivas con objetos hostiles, se defenderá por largo tiempo de todo intento del analista de recuperar un plano de reflexión. En estos casos, la simultaneidad de experiencias terapéuticas puede transformarse en un arma muy valiosa. Utilizaré un ejemplo clínico para ilustrar este punto: Un paciente joven, con características de

personalidad fuertemente paranoide y rasgos psicopáticos intensos, había transferido sobre mí, luego de un período de vacaciones, la imagen de una madre agresiva e invasora, por quien este muchacho sentía atacado el vínculo con su padre, al que defendía áspidamente de lo que sentía como mis agresiones. Esta situación amenazaba estereotiparse y mis interpretaciones eran vividas como ataques hacia mi paciente o a su relación idealizada con el padre. Las intensas cargas emocionales que este paciente ponía en juego en cada sesión, correspondientes a etapas muy primitivas de su desarrollo yoico, inundaban el campo de la relación terapéutica, despertando en él y en mí fantasías sobre una actuación que interrumpiría el análisis. Esas fantasías se correspondían con otras hechas conscientes en el tratamiento acerca de que el padre sólo podría haberse "salvado" de la madre, huyendo y separándose.

Las sesiones de terapia familiar en esos momentos, reprodujeron, dramatizándolo, tales vicisitudes vinculares. La madre atacaba en las sesiones al padre que maniobraba de modo tal que el hijo debía salir a defenderlo. El hijo se veía así enfrentado a su madre, en tanto que el padre desaparecía de la escena tras un silencio prudente. En la elaboración terapéutica de esta conflictiva, se pudo profundizar en las dificultades de la relación en la pareja, así como en los aspectos psicopatológicos del padre y la madre, como para que éstos pudieran hacerse cargo en una perspectiva más depresiva, de lo difícil de sus propias situaciones.

Al centrarse la conflictiva matrimonial en sus protagonistas, el hijo recuperaba en las sesiones familiares un espacio propio y más individuado, que le permitía comprender aspectos dolorosos de la relación entre sus padres, pero sin confundirse con ellos.

Paralelamente a este proceso, en su terapia individual cedía la ansiedad persecutoria desde la que proyectaba sobre mí esa madre agresiva y hostil de la que podría discriminarse en las sesiones de familia y yo recuperaba mi lugar como analista, al tiempo que mis interpretaciones, al volver a ser tales, encontraban un paciente como oyente y no solamente un niño acosado y hostil.

## TERAPIA FAMILIAR Y PSICOANÁLISIS INDIVIDUAL

La posibilidad que un paciente tiene de comprobar cómo y por qué funciona su psiquismo, no sólo en la intimidad de la relación terapéutica individual, sino además en la reedición conflictiva en sus interacciones cotidianas, tales como se pueden visualizar en las sesiones familiares, permite un vivenciar más a fondo las comprensiones que pueden alcanzarse en el análisis individual.

Me refiero a que la indagación psicoanalítica se enriquece en estos casos cuando el paciente alcanza a comprender cómo se despliegan en sus vínculos actuales, componentes patológicos que va descubriendo, tanto en su génesis como en su estructuración actual al cotejar y confrontar lo que va percibiendo y vivenciando contemporáneamente en los diferentes encuadres.

Un ejemplo clínico permitirá ilustrar esta situación: P., varón de 30 años, asistía con sus familiares a sesiones en las que se trataba la situación de A., hermana menor de P., internada con diagnóstico de esquizofrenia simple. La hermana mayor S. también padecía de trastornos graves, aunque no concurría a las sesiones, ya que no podía y no quería salir de su casa. Por la descripción de sus padres podía inferirse que S. padecía algún tipo de esquizofrenia paranoide, que había incluido en el pasado ingesta masiva de alucinógenos. La madre de P., A. y S. era una mujer de cierta edad, permanentemente agresiva y desconfiada, profundamente pesimista y escéptica acerca de todas sus posibilidades vitales. Descalificaba permanentemente las intervenciones del analista y descargaba sobre el padre agresiones y agravios sumamente crueles, sin solución de continuidad. El padre respondía defendiéndose malamente e intentando razones desde su defensa, con lo que no conseguía sino irritar cada vez más a su mujer. En la relación con la hija mujer alternaba con seducciones groseras hasta vivencias de absoluta perplejidad. Con el hijo oscilaba desde rivalidades y enfrentamientos violentos, hasta regresiones en que se comportaba como un chico confuso y desorganizado.

Eran evidentes por otra parte los modelos de identificación que ofrecían a P. estos padres. La madre se presentaba como una figura fálica y castradora detentando un poder sobre el

padre y el resto de la familia, que ejercía de modo de inhibir prácticamente cualquier intento reparatorio. P., aunque criticaba abiertamente estos aspectos de su madre, cuando se veía envuelto en alguna situación emocional violenta, se identificaba totalmente con ella. Utilizaba sus palabras, gestos y actitudes en su relación con el padre y no pocas veces conmigo, cuando mis intentos de interpretar las situaciones, eran fácilmente confundibles con las débiles racionalizaciones del padre y atacado por lo tanto como éste.

Este padre no podía ofrecerse tampoco satisfactoriamente, ni como padre, ni como hombre, y P. le expresaba muchas veces un desprecio doloroso ya que le reprochaba latentemente su capitulación como hombre ante su madre, y la simbiosis entre ésta y su hija mayor S.

El fracaso del desempeño de las funciones maternas y paternas de ambos padres se patentizaba además en el dolor y culpa que producía la enfermedad e internación de A.; A. era vivida como la hija que había tenido mejores posibilidades y con la que también se había fracasado. La madre y P. se aliaban en denuncias celosas acerca de los ambiguos acercamientos del padre a A., a quien aparentemente querían proteger pero que delataban como seducida por el padre.

En el comienzo de las sesiones yo me desempeñaba sólo como terapeuta familiar. P. concurría acompañado de su esposa y al poco tiempo solicitó entrevistas con su pareja ya que querían resolver conmigo y en privado cómo anunciar a la familia acerca de su inminente separación. Comencé entonces una serie de entrevistas con la pareja contemporáneas a las entrevistas familiares. A poco de andar surgió claramente, en el material de la pareja, que parte importante de sus dificultades conyugales tenían que ver con una serie de inhibiciones y temores en P. acerca de una cierta homosexualidad latente que lo angustiaba mucho. En este punto P. solicitó tener conmigo entrevistas individuales. Una vez establecidas éstas, surgieron sueños y otros indicios que hicieron que pudiéramos revisar más a fondo y abiertamente la problemática referida a la identidad sexual, sus temores, confusiones y recuerdos traumáticos infan-

tiles referidos a fijaciones anales. Este clima de erotizaciones perversas que impiden las adecuadas elaboraciones instintivas pregenitales era fácilmente perceptible en las sesiones de familia. La madre había denunciado ya los juegos eróticos entre la paciente internada A. y su padre.

La modalidad de integración de recursos terapéuticos permitió que P. visualizara cómo sus dificultades de personalidad, referidas en este caso a identificaciones perversas infantiles, descubiertas a través de sus entrevistas individuales, se actualizaban en sus interacciones con su relación de pareja, permitiéndole comprender asimismo hasta qué punto su relación de objeto actual, era influida por sus relaciones de objeto infantiles.

Al mismo tiempo, las entrevistas familiares nos ponían en contacto con aquellos padres que habían determinado estas severas dificultades en el desarrollo de P. pero, en condiciones dramáticas, ya que como ocurre en ciertas familias psicóticas, los padres del inconsciente son fuertemente parecidos a los externos, y éstos en su enfermedad, funcionan aún como los padres patogénicos de la infancia. Este proceso terapéutico que podía describir como "tridimensional", para diferenciarlo del relato analítico clásico que aparece como una imagen "bidimensional" significó para P. un inicio de una revisión a fondo de aspectos centrales de su conflictiva infantil y de ciertos aspectos de su vida y determinantes traumáticos que se le aparecieron con toda claridad. El sentimiento resultante de su experiencia fue la de comprender profundamente que tenía posibilidades de curarse y vivir mejor, si se daba espacio para intentar elaborar todo aquello que aparecía a su comprensión.

Otro ejemplo del tipo de operación terapéutica consiste en la posibilidad del paciente de cotejar escenas y fantasías infantiles acerca de sus vínculos con sus objetos originales a la luz de sus interacciones en la terapia familiar. Un paciente en análisis individual había referido, como una parte importante de sus temores a no cambiar, aspectos paralizados de su vida emocional que tenían que ver con el recuerdo de su madre altiva y orgullosa que el paciente había vivido como muy fuerte ya que

daba muestras de autoabastecerse. A pesar de que conscientemente este hombre se rebelaba contra esa madre distante que tanto lo había hecho sufrir, se sentía identificado con ella y tendía a comportarse fría y despreciativamente con los demás ya que esto le producía la sensación de autoabastecimiento y no dependencia que atribuía a su madre.

Cuando la terapia familiar demostró la impotencia afectiva y la fragilidad yoica que se escondían tras la máscara de frialdad y distancia de la madre, el paciente tuvo una serie de profundas movilizaciones emocionales que incluyeron patéticos esfuerzos, revelados en la terapia individual, para evitar el resquebrajamiento de esa imagen hierática con la que tanto había padecido y a la que sentía en el fondo, tan igual. En este caso por ejemplo, los encuentros emocionales profundos entre la madre y mi paciente, pudieron trabajarse detenidamente en el ámbito de las sesiones individuales, donde además aparecían las nuevas experiencias emocionales que el paciente se iba permitiendo a partir de un cambio fundamental en la percepción del vínculo con su madre.

También es sumamente positiva la posibilidad de "descubrir" a través de interacciones terapéuticas con su familia actual, que malos recuerdos y modelos traumáticos de la infancia pueden ser esclarecidos como resultados de encadenamientos de "malos entendidos" sucesivos, que no permitieron por ejemplo la percepción adecuada de los afectos positivos puestos en juego. Muchas veces, cuando el terapeuta puede dar cuenta de esta situación en que empiezan a visualizarse aspectos reparatorios profundos escondidos tras la polvareda que levanta el conflicto, comienzan importantes procesos reparatorios, en todos los miembros del sistema.

No es infrecuente que en pacientes con fallas estructurales en su personalidad, que funcionan en base a abigarradas introyecciones parciales tales como las que se adscriben al "falso self" Winicottiano o la personalidad "como si", que el análisis descubra la presencia de importantes aspectos del yo, ligados simbióticamente a personas del mundo externo significativas, tales como la madre, por ejemplo. En estos casos se hace muy

difícil para el analista "convencer" al paciente para que deje estas profundas ligazones narcisísticas ya que vive cualquier experiencia de crecimiento como una amenaza de muerte o desintegración para el yo. El establecimiento de entrevistas vinculares o familiares, demuestran hasta qué punto el paciente recibe mensajes de la madre, que le confirman subliminalmente qué tragedia sería para ésta el crecimiento y separación del hijo.

La madre, proyectada en este hijo, recrea sus propias carencias infantiles y teme el crecimiento de su hijo como temía el propio.

Si la terapia vincular consigue disipar estas amenazas y la madre y el hijo pueden intentar experiencias emocionales de crecimiento compartidas, nuevas percepciones sobre un crecimiento que no significa necesariamente soledad y muerte, pueden ser entrevistas.

Desde el análisis individual, ayudamos al yo del paciente a que haga una experiencia emocional de maduración y continencia de sensaciones muy asustantes asociada a primitivos impulsos agresivos y eróticos. Pero el paciente sólo puede hacer esto cuando percibe que su madre se siente protegida a su vez y él, libre ya del mandato de vivir para ella, puede otorgarse experiencias más propias que tienen que ver con su propio desarrollo estancado. Citaré como ejemplo parcial de lo expuesto el caso de un paciente aquejado por una impotencia secundaria pertinaz, entre otros síntomas importantes. El trabajo analítico sobre la comprensión de las fantasías sexuales vinculadas a antiguos temores referidos a los genitales femeninos, ya sea a través del temor a la "vagina dentada" que este paciente simbolizaba además como una vagina que retendría a su pene, o las exigencias de una sexualidad de "supermacho" que por la línea de las idealizaciones del pene paterno, lo paralizaban hasta la angustia y la consecuente impotencia, fueron preparando el terreno para intervenciones terapéuticas posteriores, pero no resolvieron el problema. El análisis reveló además, el mensaje referido al alto contenido de fijación a la madre y fidelidad a ésta, que incluía el síntoma, pero las confusiones

del paciente sobre estos puntos, le permitían organizar mejor sus pensamientos sobre el tema y profundizar en su investigación, pero su búsqueda de objetos sexuales y nuevas experiencias seguían muy limitadas o impedidas casi del todo. Debido en parte a esta situación y a otras asimismo confluyentes, decidí incluir a la madre en entrevistas con el hijo, como parte del proceso terapéutico del mismo.

Hubo a partir de ese momento un alivio inmediato en las ansiedades de este paciente, ya de por sí, ansioso por su estructura de personalidad.

El mensaje latente que luego descubrimos que él interpretaba de esta situación, era que el terapeuta aparecía como un padre que venía a verse con mamá (el padre de mi paciente había fallecido trágicamente), para hacerse cargo de ella y permitirle seguir con su crecimiento como hombre. Las entrevistas en que se trató la sintomatología sexual del hijo, fueron sumamente importantes. La madre se mostró como muy dispuesta a ubicarse desde una perspectiva en la que podía dialogar sobre las dificultades sexuales que ella había vivido con su marido y cómo éstas eran parte de un vivir que no debía interpretarse dramáticamente.

Básicamente apareció como una mujer real desarmando fantasías de hiperexigencia que su hijo depositaba en las mujeres de su fantasía y ayudando a corporizar una imagen de mujer mucho menos castradora e idealizable de lo que el hijo exponía en su discurso. Paralelamente con este proceso, en el análisis individual comenzaron a aparecer relatos y asociaciones con experiencias de acercamientos menos fóbicos a mujeres que aparecían vividas mucho menos persecutoriamente y se favoreció un análisis pormenorizado de las asociaciones vinculadas con distintos momentos de los juegos eróticos, la penetración y el coito que llevaron finalmente a un proceso gradual de recuperación de la potencia sexual.

El análisis minucioso de las interacciones entre las experiencias analíticas y la individual presenta un riquísimo campo a explorar sobre las formas tempranas de organización del psiquismo y las leyes y condiciones necesarias para producir modi-

ficaciones terapéuticas, tanto en el paciente designado como en su grupo familiar.

Hoy podemos afirmar que esas leyes y condiciones son las de favorecer un proceso de recrecimiento y redesarrollo, en el sentido de una mejor maduración emocional y que también pacientes neuróticos se benefician de la aplicación de estos recursos integrados en la consecución de sus propios procesos terapéuticos.

### Resumen

La integración de Recursos Terapéuticos aparece como una necesidad referida al tratamiento de pacientes psicóticos y de sus grupos familiares al organizarse la primera Comunidad Terapéutica Psicoanalítica, al promediar la década del '60. Los logros obtenidos con este enfoque alentaron la elaboración de hipótesis a verificar en el campo clínico, acerca de la posibilidad de enriquecer y movilizar aspectos del psicoanálisis de pacientes no-psicóticos integrando recursos terapéuticos que implican la operación directa sobre la patología vincular, tales como el tratamiento de la familia o la pareja, interactuando con el análisis individual.

El concepto de "integración de recursos terapéuticos" acepta cuatro vertientes para su análisis. La primera se refiere a que tal integración supone el encuentro y articulación de distintos cuerpos teóricos y conceptuales, pensados a veces desde campos experienciales muy distintos. Un ejemplo sería la articulación de las hipótesis sobre funcionamiento intrapsíquico y su articulación con lo observable en sistemas familiares.

Un segundo nivel de análisis debe tomar en cuenta la articulación de diferentes técnicas concretas, con diferentes encuadres y diferentes modalidades operativas.

Una tercera consideración será la de la interacción de los agentes concretos que deberá asumir la forma de trabajo en equipo que reflejará necesariamente aspectos del paciente y su familia, como se señaló en otros trabajos.

El cuarto nivel de análisis considera la particular integración que el paciente realiza en su mundo interno a partir de la simultaneidad de sus experiencias terapéuticas. El presente trabajo es el resultado de las observaciones realizadas por un solo terapeuta en su desempeño como analista familiar e individual.



Se describe la hipótesis de la cura analítica como cura de una relación vincular; la estructurada transferencialmente con el analista y a partir de esta comprensión se describen dos tipos de transferencia en la terapia familiar; la que ocurre con el analista y la que ya viene estructurada entre los miembros de la familia. La labor terapéutica consistirá en crear las condiciones necesarias para que personas involucradas en tramas patológicas puedan surgir de sus investiduras transferenciales recíprocas y aparecer a sus ojos y a los de los demás, como son en realidad. Se describe el clima particular de sesiones que ocurren "insights" que facilitan el "reconocimiento" de los objetos. Se refiere la utilidad de tales experiencias para el análisis individual de identificaciones primarias y secundarias de características patológicas que pueden así modificarse en un tiempo menor que el requerido por el tratamiento convencional. Se añaden ejemplos clínicos.

Se ejemplifica además la posibilidad de reducir por medio de estas técnicas, el efecto negativo de altos montantes de transferencia negativo hostil, que puedan llevar al bloqueo o la interrupción del tratamiento.

Otra posibilidad que se abre y concurre al proceso terapéutico, es la de que el paciente pueda vivenciar cómo aquello que percibe en su tratamiento individual se despliega dramáticamente en sus vínculos actuales y transformar estas vivencias en mero material para su elaboración. La relación entre los materiales que se ofrecen para ser analizados en los distintos encuadres simultáneos tienen entre sí un efecto potenciante a través de una interacción dialéctica.

Otro aspecto resultante de la integración de recursos terapéuticos es la de permitir confrontar escenas y fantasías infantiles acerca de los vínculos con los objetos originales a la luz de sus interacciones en la terapia familiar.

También es sumamente positiva la posibilidad de "descubrir" a través de interacciones terapéuticas con la familia actual que muchos recuerdos y modelos traumáticos de la infancia puedan ser esclarecidos como resultados de encadenamientos de "malos entendidos" sucesivos que no permitieron por ejemplo la percepción adecuada de los afectos positivos puestos en juego.

La interacción de recursos parece asimismo ser muy útil en pacientes vinculados en forma simbiótica profunda, que presentan fantasías de muerte o desintegración asociadas a experiencias de crecimiento de modo tal que temen y sabotean permanentemente sus progresos terapéuticos. Se ejemplifica clínicamente.

El análisis minucioso de las interacciones entre las experiencias analíticas y la individual presenta un riquísimo campo a explorar sobre las formas

tempranas de organización del psiquismo y las leyes y condiciones necesarias para producir modificaciones terapéuticas, tanto en el paciente analizado como en su grupo familiar.

## Summary

The thought of integrating therapeutic resources appears as a real need in the treatment of psychotic patients and their families, in the organization of the psychoanalytic therapeutic community, in the 60's. From the personal observation and successful treatment, the author explains his findings in the analytical treatment of non-psychotic individuals and families.

Consideration of the integration of resources is divided into four levels: a) Interacting theories that have to be integrated; b) Definite techniques and framings; c) Interaction of the therapeutic team; d) Integration of the patient's inner world and experience.

The similarities and differences between individual and family treatments, taking into consideration the theory of transference with the therapist and among the members of the family, are explained.

Part of the therapeutic objectives is to create the necessary conditions so that members of the group with pathologic traits could divert themselves from their reciprocal transference bonds and be seen by the rest of the group as they really are.

The value of the integration of the therapeutic resources can be demonstrated by the following examples: working through primary and secondary pathogenetic identification, decreasing the intensity of hostile transferences, that threatens the continuation of the treatment, express in the family environment the insight and feeling experienced during the individual therapy, through the dialectic interaction of different types of analytical material.

Another aspect is the confrontation, during family therapy, of old scenes and objectal fantasies in the internal child world, discovered through individual analysis.

The usefulness of the "integrated technique" is also demonstrated in cases of deep symbiotical binds to actual meaningful objects.

The integration of resources presents a rich material to explore the early ways of psyche organization and the norms and necessary conditions to produce therapeutic modifications in the analyzed patient as well as in his family group.



Bibliografía

1. ACKERMAN, N. M. y otros; *Psicoterapia de la familia neurótica*. Horme, Buenos Aires, 1969.
2. BOSZORMENYI-NAGY, Iván y FRAMO, J. L.: *Intensive Family Therapy, Theoretical and Practical Aspects*. Harper and Row, N.Y., 1965 (hay traducción española).
3. FREUD, S.: La transferencia en "introducción al psicoanálisis", en Tomo II de *Obras completas*. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1948.
4. FREUD, S.: La dinámica de la transferencia en "técnica psicoanalítica", en Tomo II de *Obras completas*, op. cit.
5. FREUD, S.: Recuerdo, repetición y elaboración, en el Tomo II de *Obras completas*, op. cit.
6. FREUD, S.: La identificación en "psicología de las masas", en el Tomo I de *Obras completas*, op. cit.
7. GARCIA BADARACCO, J. E.: *Relato oficial sobre comunidad terapéutica*. IV Congreso Mundial de Psicodrama y I Simposium de Psicoterapia de Grupo. Buenos Aires, 1969.
8. GARCIA BADARACCO, J. E. y CAÑEVARO, A.: "La reacción terapéutica negativa y la influencia familiar", en *Patología y terapéutica del grupo familiar*, págs. 221-225, Fundación Acta, Buenos Aires, 1970.
9. GARCIA BADARACCO, J. E.: "Integración del psicoanálisis individual y la terapia familiar en el proceso terapéutico del paciente psicótico". *Revista de Psicoanálisis*, T. XXXV, N° 3, 1978.
10. LAING, R. D. y ESTERTON, A.: *Cordura, locura y familia*, F.C.E., México, 1967.
11. LAPLANCHE, J. et PONTALIS, J. B.: "Transfert". *Vocabulaire de la Psychanalyse*. Presses Universitaires de France, 1968.
12. MANDELBAUM, E. M.: "Integración de recursos terapéuticos", Seminario sobre "Recursos terapéuticos", Hospital Nacional José T. Borda, 1974.
13. MANDELBAUM, E. M.: "Comentarios sobre terapia familiar y el equipo terapéutico desde la experiencia clínica", *Revista Terapia Familiar*, año IV, N° 7/8.
14. STIERLIN, H.: *Psicoanálisis y terapia de familia*, Icaria Editorial S.A., Barcelona, 1979.

Medicina familiar

Lic. CELIA ELZUFAN y Lic. HUGO HIRSCH

Av. Libertador 5881, 1° A, (1428) Capital Federal

*El punto de vista interaccional en la familia, nos reitera el hecho de que en la vida estamos juntos, para mejor o para peor, tanto en la salud como en la enfermedad; hasta que la muerte nos separe. Y algunas veces aun más allá de que la muerte nos separe.*

John Weakland

Desde la antigüedad hubo pensadores y corrientes de opinión que adjudicaron gran importancia a la influencia que la familia puede tener en la salud física y mental de cada uno de sus miembros. Es sabido —aunque no siempre recordado— que las relaciones familiares pueden afectar enormemente el desenlace de ciertas enfermedades, su grado de recuperación, el modo en que el dolor es percibido y manejado, la forma en que un tratamiento es llevado a cabo, etcétera.

¿De qué modo podemos explicar esta influencia? En principio, debemos remitirnos a la obvia interrelación de lo que —constituyendo en esencia un solo fenómeno— ha sido dado en denominarse: "soma y psique".

Cualquier trastorno orgánico suscita por ejemplo frecuentes sentimientos depresivos. A la inversa, se puede verificar experimentalmente que en estado de hipnosis es posible alcanzar profundas modificaciones fisiológicas.

Uno de los conceptos que más difusión ha tenido en las últimas décadas como intento de comprender la interrelación entre los aspectos fisiológicos y psicológicos es el "stress". La reacción del ser humano al stress es un proceso psicofisiológico esencial que capacita a los individuos para responder a los múltiples desafíos que tiene que confrontar diariamente. Esto, según cómo estén organizadas sus relaciones interpersonales. Wolff llegó a la conclusión de que el stress es el resultado de la interacción entre el organismo interno y el contorno.

El stress, desde el punto de vista médico, es el precio del desgaste del organismo. Existe quien lo define como el estado manifestado por un síndrome específico de procesos fisiológicos inespecíficos, más que como una unidad en sí misma. Acontecimientos psicosociales influyen en lo fisiológico y provocan el colapso de los procesos que permiten al organismo enfrentar las presiones psicológicas, dando como resultado enfermedades psicosomáticas. Los estudios más recientes hechos por H. Wolff destacan la importancia de la interacción entre los individuos y el contexto social.

Se ha generalizado la opinión —avalada por estadísticas— que adjudica un mayor riesgo de enfermedad y muerte a aquellas personas que atravesaron hace poco una situación crítica (muerte del cónyuge, por ejemplo).

Debe tenerse en cuenta sin embargo, que para explicar la influencia de la familia sobre la salud de sus miembros es necesario introducir un concepto más: La INFLUENCIA INTERPERSONAL. Las emociones, la hipnosis, el stress, se dan siempre en el marco de relaciones interpersonales, formando parte de ellas. Cualquier emoción es respuesta al estado de una relación y al ser expresada va a provocar una respuesta que a su vez va a influir en ella. La hipnosis es un aspecto de una relación particular entre dos o más personas y el stress en los seres humanos, casi inevitablemente implica que la situación

crítica involucra relaciones con otros significativos. Si bien es seguro que nuestra interacción con los otros significativos influye sobre nuestro estado físico y mental, poco se sabe todavía sobre la incidencia de patrones específicos de interacción en la aparición o mantenimiento de determinados síndromes.

Se podrían considerar diferentes formas de interacción que podrían ser relevantes para la aparición de una enfermedad particular. Siguiendo ideas de Weakland, podríamos pensar tres formas básicas:

- 1) Cierta forma de interacción en un período suficiente de tiempo podría constituir en sí misma una condición suficiente para la aparición de la enfermedad. No tenemos ningún ejemplo evidente de esta clase.
- 2) Un cierto tipo de interacción podría constituir la condición necesaria pero no suficiente, para la instalación de determinada enfermedad. Aun cuando un virus pueda ser considerado como agente, el organismo sólo se vería afectado por él si su sistema inmunológico no funciona con efectividad lo que puede ocurrir en el caso de estar expuesto a cierto tipo de situaciones interactivas. (Esto podría eventualmente abarcar desde la gripe hasta el cáncer).
- 3) Finalmente, hay formas de interacción que, si bien no dan lugar al surgimiento de una enfermedad o estado fisiopatológico particular, sí contribuyen de manera muy definida a su desarrollo y desenlace, para mejor o para peor. Esa influencia puede ser directa, en el sentido de interferir con funciones corporales necesarias para la recuperación. En otros casos las facilita, así como la sugestión hipnótica aparenta hacerlo en ciertos casos. En un sentido más general, los patrones de interacción pueden apoyar o impedir la útil aplicación de los tratamientos médicos necesarios.

Existen entonces distintas formas de interacción que deberán ser modificadas de acuerdo a la situación utilizando diversos tipos de estrategia.

En el caso de las formas de interacción que contribuyen al

desarrollo y desenlace de las enfermedades, podemos observar con frecuencia tipos de interacción en los que aparecen pacientes que pueden ser denominados MINIMIZADORES y MAXIMIZADORES. Los primeros no toman en cuenta las indicaciones médicas aludiendo no tener problemas mientras que un allegado significativo se hace cargo de la preocupación y los exhorta constantemente a cumplir una serie de directivas médicas.

Los otros maximizan su problema hasta el punto de perder el sentido de la vida. En esta categoría se encuentran con frecuencia aquellos casos en los que se ha producido una limitación vital subjetivamente importante. Ejemplo: si tengo que seguir viviendo sin mi dentadura prefiero la muerte. Aunque en ciertos aspectos las diferencias son obvias, también incluimos en esta categoría a la gente que tiene un pronóstico de vida muy limitado y consecuentemente, deja de hacer todo esfuerzo por sobrevivir.

Aquí pensamos que se trata de establecer lo que hemos denominado "CIRCUITO VITALIZADOR", cuya función es combatir la desesperanza del familiar, promoviendo en su lugar un circuito beneficioso. Cuando el familiar consigue transmitirle al paciente el valor que posee para él, éste podrá comenzar a sentir que la vida adquiere sentido; lo que, a su vez, suscitará cierta esperanza en el familiar quien podrá así reforzar sus expresiones de necesidad de que su "otro querido" viva y en consecuencia, ayuda a que la vida tenga nuevamente sentido.

En estos casos se trata de trabajar amplificando la "necesidad de sentirse necesitado". La familia no precisa creer que el paciente va a recuperarse, solamente necesita creer que puede recuperarse, aunque sea parcialmente.

La misma idea de que el estudio de los patrones de interacción tiene relevancia para la comprensión de las enfermedades, puede ser aplicada al problema del dolor. No nos ocuparemos aquí del problema de la etiología del dolor, sino más bien de las condiciones que pueden dar lugar a su permanencia, incremento o disminución por razones psicológicas derivadas de la interacción. Es sabido por ejemplo, que un boxeador no experi-

menta el mismo dolor ante los puñetazos durante la pelea que luego y que un dolor de la cabeza puede ser insoportable en el contexto de una conversación aburrida y sólo una ligera molestia en una reunión muy interesante.

Creemos que es posible utilizar fructíferamente la noción o concepto de que en una unidad familiar, ciertas clases de interacción pueden promover la sensación del individuo de sentirse adecuadamente protegido o amparado, disminuyéndose su sensibilidad al dolor. Además, la unidad familiar puede ayudar al individuo a desfocalizarse de su dolor, disminuyendo así su intensidad (tal como lo hacen los buenos hipnotizadores); o por el contrario, a incrementar su percepción del mismo, con la consiguiente dosis de sufrimiento.

Hasta aquí hemos mencionado los siguientes ámbitos:

- A. Enfermedades en cuya aparición o mantenimiento la interacción desempeña un papel importante.
- B. Enfermedades cuya evolución depende del cuidado con que el paciente siga las indicaciones médicas.
- C. Enfermedades que dependen de la voluntad de vivir.
- D. Aspectos interaccionales del dolor; en todos estos ámbitos son pertinentes ciertas preguntas:
  - 1) ¿Qué significa para esta familia particular esta enfermedad o síntoma?
  - 2) ¿De qué modo reacciona ante ella?
  - 3) ¿Qué consecuencias tiene para esta familia?
  - 4) ¿Cuál es el impacto que la actuación del médico tiene sobre esta familia?
  - 5) ¿Qué respuesta producen ellos?

Tratar de formularnos y respondernos estas preguntas es la tarea básica para poder implementar el modelo de una medicina que realmente sea familiar.

En sucesivos artículos pensamos ir formulando con más precisión los principios que guían nuestra intervención en cada situación, ofreciendo al mismo tiempo material clínico ilustrativo.

Por el momento nos interesa destacar aquí que las ideas y principios a que hicimos referencia forman parte de lo que

empieza a denominarse MEDICINA FAMILIAR, disciplina naciente cuya finalidad es —si se nos permite el atrevimiento— contribuir a establecer las técnicas con que ayudar a que las familias premien la salud y no la enfermedad, algo que en el mediano plazo, puede tener consecuencias revolucionarias.

### Resumen

Los terapeutas familiares podrían integrarse al equipo médico y efectuar una contribución a su efectividad, por ser conocedores de la influencia de la interacción familiar en el surgimiento, desarrollo y desenlace de las enfermedades. Podrían incidir bloqueando conductas mantenedoras de problemas, complementando técnicas y métodos poco convencionales tanto en los enfermos crónicos como agudos.

Este artículo describe además algunas de las diferentes formas en que la interacción podría influir en la creación de circuitos interaccionales benéficos y revitalizados, que permitan premiar la salud en lugar de la enfermedad.

### Summary

Family therapists could be included in the medical team and offer a contribution to its effectiveness. Their knowledge of the influence of family interaction at the onset, development and course of disease could help to interdict the behaviours that persist maintaining the problems. To obtain this, they could implement uncommon methods and techniques of practical importance as much in acute as in chronic diseases.

This paper also describes some of the different ways in which interaction can influence the creation of interactional circles that could benefit and revitalize ways to reward health instead of illness.

### Bibliografía

- HUGGEN, F. J. A.; *Family Medicine*, Ed. Brunner Mazel; EE.UU., 1982.  
 PELLETIER, Kenneth R.; *Mind as Healer - Mind as Slayer*, Ed. Delacorte, 2da. edición, EE.UU., 1977.  
 SELYE, Hans; *La tensión en la vida (el stress)*, Compañía General Fabril Editora, 2da. edición, Buenos Aires, 1964.  
 WEAKLAND, John H.; "Family Somatics", en *The International View*, Ed. Norton, EE.UU., 1977.



**CENTRO PRIVADO  
DE TERAPIAS BREVES**

**CURSOS 2do. CUATRIMESTRE — AÑO 1984**

**Algunos modelos del enfoque interaccional.**

Este curso constará de cinco módulos. En cada uno de ellos se expondrá un modelo de enfoque interaccional distinto. Los participantes podrán intervenir en uno de ellos o en los que deseen:

- MENTAL RESEARCH INSTITUTE (M.R.I.)
- Modelo desarrollado por Whitaker.
- Modelo Estructural.
- Escuela de Milán.
- Modelo Estratégico de J. Haley.

**Entrenamiento para colegas del interior. Desempantanando terapias.**

**TALLER: "Familias con pacientes orgánicos".**

**INFORMES:** Av. Libertador 5881, 1er. Piso "A", 785-1111, 782-9851, 783-3352, de 14 a 18 horas.

# Family Process

A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF FAMILY STUDY RESEARCH AND TREATMENT

EDITOR/Carlos E. Sluzki, *Pittsfield, MA.*

EDITORIAL BOARD/Lyman C. Wynne, *CHRM., Rochester, NY*, Edgar H. Auerswald, *Maui, HI*, Michael Goldstein, *Los Angeles, CA*, Helm Stierlin, *Heidelberg, W. Germany*, Robert Ryder, *Storrs, CT*, Margaret T. Singer, *Berkeley, CA*, M. Duncan Stanton, *Rochester, NY*, Carl Whitaker, *Madison, WI*.

FAMILY PROCESS, in continuous publication since 1962, is the definitive journal in the field of family psychotherapy. Original articles report on theory and practice of family treatment, research and training. In addition, regular departments of FAMILY PROCESS are devoted to reviews of books and audiovisual materials.

Among the many contributors in recent years have been Mara Selvini-Palazzoli, Paul Dell, Carl Whitaker, Cloe Madanes, M. Duncan Stanton, Lynn Hoffman, and Carol Anderson.

## FAMILY PROCESS

Subscription Department  
P.O. Box 6889  
Syracuse, N.Y. 13217

Gentlemen:

DATE \_\_\_\_\_

Please enter my subscription for FAMILY PROCESS (U.S. funds drawn on a U.S. bank)

### INDIVIDUAL SUBSCRIBERS

### INSTITUTIONAL SUBSCRIBERS

(paid by personal check)

☐ \$24.00 per year United States

☐ \$35.00 U.S.

☐ \$27.00 per year Canada & Latin America

☐ \$38.00 Canada & Latin America

☐ \$30.00 per year All other countries

☐ \$42.00 All other countries

NAME \_\_\_\_\_

ADDRESS \_\_\_\_\_

CITY \_\_\_\_\_

STATE/COUNTRY \_\_\_\_\_

ZIP \_\_\_\_\_

ALL SUBSCRIPTIONS ARE ENTERED ON A CALENDAR YEAR BASIS

Las Mil y Una Noches del terapeuta de familia. Reflexiones acerca de las familias con trastornos contextuales

Lic. MARIA CRISTINA ROJAS\* y Lic. SUSANA MATUS\*\*

\*Vuelta de Obligado 2912, (1429) Capital Federal.

\*\*Mendoza 4625, (1431) Capital Federal

## Introducción

Este trabajo surge de nuestra práctica clínica y presenta algunas reflexiones acerca de las llamadas "familias con trastornos contextuales".

Todo terapeuta de familia se ha cuestionado alguna vez acerca de las dificultades particulares que implica su tarea. La que consideramos dificultad central, es la instalación y supervivencia del lugar terapéutico. Analizaremos a lo largo del presente trabajo las características particulares que dicho proceso adquiere en las familias con trastornos contextuales.

Nuestro marco referencial es la Teoría Psicoanalítica y para el abordaje familiar el modelo Psicoanalítico Estructural para el Análisis de las Relaciones Familiares.

En las familias con trastornos contextuales encontramos problemáticas relacionadas con violencia y psicosis: en ellas se lleva a cabo un ataque al lugar terapéutico que va desde la descontextualización de la interpretación a las distintas formas

de la conducta violenta. Analizaremos estos puntos, así como la transmisión de la irracionalidad en estas familias.

Planteamos además la necesidad de arbitrar recursos técnicos especiales para la instalación y supervivencia del lugar terapéutico en las familias con trastornos contextuales. Describimos un recurso que consideramos indicado para el trabajo con estas familias. Consiste en la realización de un largo diagnóstico a modo del "período de prueba" previo a la indicación terapéutica, que Freud señala cuando trata la iniciación del tratamiento<sup>8</sup>. Tomamos como núcleo de dicha tarea diagnóstica el relato de las historias familiares, a la manera de las historias inconclusas de Las Mil y Una Noches.

Estas ofrecen a familia y terapeuta el tiempo y el espacio necesarios para llevar a cabo la difícil tarea de establecer un código compartido y fundar una relación transferencial que pueda servir de soporte al tratamiento posterior.

#### Conceptos básicos del modelo psicoanalítico estructural para el análisis de las relaciones familiares.

Este modelo<sup>4</sup> concibe a la familia como un sistema. En él distingue dos órdenes de relaciones familiares: el de las relaciones observables como dato empírico y otro orden estructural, inconsciente para los integrantes del grupo familiar, que llamaremos estructura familiar inconsciente.

Esta estructura implica un conjunto de relaciones entre cuatro términos: madre, padre, hijo y tío materno o representante directo o simbólico de la línea materna. Dichas relaciones son: a) relación de alianza (marido-mujer), b) relación de consanguinidad (mujer-tío materno), c) relación de filiación (padres-hijos) y d) relación avuncular (hijo-familia materna)<sup>1 2</sup>.

De esta manera, la estructura familiar inconsciente aparece como un sistema relacional entre dos familias.

Si la alianza adquiere preponderancia sobre la relación con la familia materna, se dará una salida exogámica verdadera. Si en cambio la alianza es sólo formal, la relación con la familia materna tendrá preponderancia sobre el vínculo conyugal y

sobre la relación de filiación, manteniéndose una situación endogámica. Esto implica un déficit en la función paterna, en tanto el hombre no ha podido realizar una primera interdicción, separando a su mujer de la familia de origen. Por tanto se verá limitado en la realización de la segunda interdicción, que instaura la prohibición del incesto entre padres e hijos.

#### Lugar terapéutico

En el abordaje clínico, tenemos como objetivo la instalación de un lugar terapéutico.

Conceptualizamos dicho lugar como favorecedor de la función paterna, en otros términos, como promotor de un espacio que permite la ruptura del encierro narcisista, ayuda a la discriminación de los miembros entre sí y da posibilidad a su integración en el medio extrafamiliar.

El supuesto teórico que subyace a esta concepción relaciona la posibilidad de salida exogámica con la instauración de la ley de prohibición del incesto, ejercida por dicha función paterna.

Para pensar acerca de la instalación del lugar terapéutico, tenemos en cuenta la articulación de los siguientes ejes conceptuales que separamos sólo a los fines de su análisis, pues los consideramos tres dimensiones de un mismo fenómeno: el campo de relaciones intersubjetivas en la situación terapéutica.

Estos son: a) Contexto terapéutico; b) Código compartido entre familia y terapeuta; c) Estructura familiar inconsciente.

a) *Contexto terapéutico*: definimos el contexto como un conjunto repetible de normas y circunstancias que determinan que algo tenga una significación y no otra en esa situación. El contexto terapéutico que nosotros proponemos, está delimitado por el encuadre terapéutico, e implica como condición fundamental la aceptación de que el terapeuta hable de un otro sentido desconocido para los integrantes del grupo familiar.

b) *Código compartido entre familia y terapeuta*: En toda situación de comunicación interpersonal poseer un código compartido implica la posibilidad de comprender de una misma manera la significación y el sentido de los mensajes emitidos.

Para que esto sea posible los interlocutores deben en primer término, pertenecer a una misma cultura y adherir por ende a las mismas explicaciones causales de los fenómenos de la realidad. Por ejemplo la lluvia para un individuo perteneciente a una cultura primitiva podría atribuirse a la voluntad de los dioses y tendría así un sentido distinto del que le daría un sujeto de nuestra cultura, quien lo relacionaría con el ciclo del agua en la naturaleza.

Asimismo observamos que un individuo que va de un país a otro cuyo idioma conoce, se ve sin embargo imposibilitado de captar el sentido de algunas palabras hasta tanto llegue a conocer las normas y circunstancias que enmarcan los mensajes. Nótese que código y contexto aparecen entonces como las dos caras de una misma moneda.

Existen dos niveles de transmisión de significados: el nivel del entendimiento, que depende del conocimiento y utilización de un mismo código, y el nivel de la captación de los sentidos, que depende, como señalamos en los ejemplos antedichos, del conocimiento del contexto. Sólo se entiende cabal y adecuadamente los significados cuando se captan los sentidos<sup>6</sup>.

Este nivel de captación se halla afectado en el psicótico<sup>11</sup>, que se maneja con un orden de causalidad siempre singular, de su propia creación. Integra los enunciados del otro en su propio sistema referencial, no compartido ni compartible por el conjunto del grupo.

Los "a priori compartidos"\*<sup>2</sup> que permiten la comunicación

\* AULAGNIER, Piera: *Los destinos del placer. Alienación, amor, pasión*. Barcelona, Ediciones Petrel, 1980: "La presencia de cierto número de convicciones compartidas por el conjunto de los sujetos sobre las causas de lo que aparece en el espacio de la realidad y sobre nuestra manera de percibir ese mismo espacio, es lo único que puede asegurar que se preserven dos condiciones indispensables para que el Yo pueda catectizar sus pensamientos, ponerlos en palabras y satisfacer esa exigencia de comunicarse cuya economía nadie puede realizar totalmente. Formularé esas dos condiciones de la manera siguiente: —Una certeza implícita ("la mayoría de los locutores tienen una captación idéntica de la realidad humana"). —La garantía de que una parte de nuestros enunciados gozará "a priori" de una "presunción de inocencia".

interpersonal, ya están dados en el neurótico, pero su establecimiento deberá ser la primera y más difícil tarea a realizar con el psicótico.

En la situación terapéutica, las condiciones de posibilidad para llegar a compartir un código están dadas básicamente por la explicitación del encuadre y la formulación acerca del nivel inconsciente de las relaciones familiares. En otros términos, cuando pensamos en un código compartido, para la instalación y conservación del lugar terapéutico, lo hacemos teniendo como objetivo el establecimiento de un contexto que implica la posibilidad de generar un lugar dador de nuevas significaciones, propias de una organización familiar exogámica.

Partimos de la hipótesis que hay una discriminación entre el código paterno y otro código, proveniente de la línea materna, que entroniza la endogamia y por tanto elude la aceptación de la castración y la ley. Cabe aclarar que el contexto propuesto por el terapeuta no es arbitrario, está sujeto a una legalidad que lo determina y de la cual él sólo es representante. Por ejemplo, cuando se trabaja con familias de nivel sociocultural diferente de la clase social de pertenencia del terapeuta, es posible confundir inadvertidamente, la propuesta de un código compartido con la de la propia ideología y escala de valores del terapeuta.

c) *Estructura familiar inconsciente*: El contexto y código compartidos dan al terapeuta las condiciones para acceder a las reglas altamente inconscientes y celosamente guardadas de la estructura familiar inconsciente, que son las que aportan significado a los mensajes provenientes de la familia. Dichas significaciones son transmitidas a la familia en forma de interpretaciones y construcciones, con el objetivo de promover la elaboración y evitar la repetición.

#### Familias con trastornos contextuales: ataque al lugar terapéutico

La captación del sentido, según señalamos, depende de la posibilidad de reconocer el contexto dentro del cual se emite

un mensaje. Dicho reconocimiento estará dado por ciertas fuentes de información que Bateson<sup>3</sup> llama "marcadores de contexto". Por ejemplo, en el teatro, el escenario, la disposición de los asientos, el telón, etc., son los indicadores que permiten al espectador diferenciar la ficción de la realidad. Esto hace que el público no corra el escenario ante el pedido de auxilio de la protagonista.

Es a partir de su relación con los objetos primordiales que el individuo adquiere significaciones propias de su contexto familiar, las que deberá modificar cuando se inserte en un medio extrafamiliar. Para ello, deberán funcionar los "marcadores de cambio de contexto". Estos permiten la clasificación de los contextos y la captación de la diferencia de sentido que el cambio contextual implica. Por ejemplo, esta discriminación de contextos se pone a prueba cuando el niño empieza su escolaridad y se espera de él que diferencie a su maestra de su mamá, a sus compañeros de sus hermanos y responda de manera adecuada a las pautas dadas por la nueva institución. Hay familias que capacitan a sus hijos para este pasaje; otras en cambio, sostienen un código narcisista que le impide a sus miembros la discriminación y salida hacia otros ámbitos. Esta incapacidad deriva de una situación intrafamiliar también indiscriminada, en la cual no están claramente diferenciados los lugares. Por ejemplo, familias en las que el padre está ubicado en un lugar fraterno o filial con respecto a su esposa. Del mismo modo la situación terapéutica implica el establecimiento de un nuevo contexto —caracterizado centralmente por la significación inconsciente de los mensajes.

Así, cuando una familia comienza un tratamiento se plantean también dos posibilidades: que acepte o no el encuadre y las significaciones particulares promovidas en la nueva situación, en otros términos que pueda o no discriminar el contexto terapéutico respecto del familiar.

Llamaremos familias con trastornos contextuales, a aquellas en las que no funcionan adecuadamente los marcadores de cambio de contexto. Son familias que escuchan las interpretaciones desde un contexto privado, no compartido; de este

modo las descontextualizan y no captan el verdadero sentido de las mismas. Cabe aclarar, que dentro de este subgrupo encontramos también, familias que aparentemente diferencian el contexto terapéutico del familiar, porque aceptan las pautas formales del encuadre, pero que de todos modos atacan permanentemente la posibilidad del terapeuta de acceder a las significaciones provenientes de la estructura familiar inconsciente.

Con frecuencia frente al temor al colapso psicótico y la necesidad de preservar intocado el sistema familiar, surge la violencia en sus diferentes manifestaciones intimidatorias hacia el terapeuta.

Piera Aulagnier<sup>1</sup> diferencia dos tipos de violencia: una violencia primaria, radical y necesaria para la constitución del sujeto, que es ejercida por la madre como portavoz de las significaciones ambientales. Y una violencia secundaria, que representa un exceso de la violencia primaria y que es perjudicial para el funcionamiento del sujeto. En otros términos, la violencia primaria es aquella por la cual la madre imprime al infans significaciones contextualmente adecuadas al orden de su necesidad. En cambio, la violencia secundaria representa un exceso de la primaria, en tanto imprime significaciones que no son pertinentes a su demanda y cuyo efecto es estimular la dependencia del infans más allá de lo necesario. Esto se produce, por ejemplo, cuando el padre no se constituye como objeto de deseo para la madre y por tanto no puede funcionar como discriminador y regulador de la relación madre-hijo.

Pensamos que la violencia ejercida contra el terapeuta, remite a una situación de violencia secundaria. Esta, como hemos dicho se genera por un déficit en la función paterna y tiende a su vez a sostener tal déficit a través del ataque al pensamiento y la palabra del terapeuta.

El ataque al lugar terapéutico suele ponerse en juego incluso desde la elección de terapeuta. Por ejemplo, una familia puede orientar la búsqueda hacia alguien de la misma colectividad, con el propósito inconsciente de neutralizar a través de las semejanzas la presencia del terapeuta en tanto factor de discriminación.



Finalmente diremos que las familias con trastornos contextuales, parecen carecer inicialmente de la posibilidad de instalación del lugar terapéutico. Sostenemos la necesidad de utilizar todos los recursos técnicos posibles para intentarlo, si bien esta tarea es exitosa sólo en algunos casos.

### Las mil y una noches del terapeuta de familia

*Caso clínico:* Presentamos fragmentos de sesiones de una familia con trastornos contextuales. El grupo familiar está constituido por: el padre, José (58); la madre, Blanca (59); los tres hijos: Alberto (33), Silvia (29) y Beatriz (24); y el yerno, Diego (30), esposo de Beatriz. Los padres son primos hermanos, sus madres son hermanas. La madre de José (tía de Blanca) y una hermana de Blanca (prima de José) son definidas por la familia como "videntes". Silvia es obesa y dice también poseer poderes de videncia. Beatriz se enferma luego de la muerte de la tía vidente y de su propio casamiento con Diego. Es atendida en hospital de día por episodios en los que supone poseer poderes sobrenaturales. Diego, el yerno trabaja con el suegro. Beatriz y Diego conviven con los padres de Beatriz y con Silvia, desde el comienzo de la enfermedad de Beatriz, aunque tienen su propia casa.

### *Fragmento de la segunda sesión: Acerca de la descontextualización:*

La familia habla de la muerte de dos hermanas maternas. Beatriz trae la idea de que la tía vidente se "chupó" la enfermedad de la otra y por eso murió. El terapeuta interpreta que así como Beatriz cree que si la tía no hubiera sabido de la enfermedad de la hermana no se hubiera contagiado, la familia cree que si ellos saben acerca de la enfermedad de Beatriz se van a contagiar.

MADRE: Inexacto, irreal la enfermedad es de ella.

ALBERTO: La enfermedad de Beatriz empezó con la muerte de la tía vidente, líder de la familia.

TERAPEUTA: Beatriz se hace cargo no sólo de la enfermedad de la tía sino de los miedos de toda la familia.

BLANCA: Pero la enfermedad de ella no era contagiosa.

El terapeuta explica que no es que se van a contagiar sino que hay una persona que se hace cargo del miedo de todos.

JOSE: Mi esposa se hace cargo de toda la casa.

BEATRIZ: (*Al terapeuta*) Tengo miedo que su trabajo sea al divino botón. Siempre fue así, me contestaron otra cosa a lo que yo pregunté.

En este fragmento se manifiesta la descontextualización que afecta la captación del sentido de las interpretaciones y obliga al terapeuta a una reformulación constante.

Este ataque es el mismo que la familia realiza hacia sus miembros, en la medida en que cada uno de ellos intenta formular un pensamiento discriminador.

### *Fragmento de la cuarta sesión: sobre la transmisión de la irracionalidad<sup>5</sup>.*

BEATRIZ: Estoy angustiada. Tengo miedo de morirme. Creo que tengo poderes, cargo malas energías. Me imagino cosas y creo que se van a cumplir. Yo recuerdo que poco antes de casarme ví en la calle a un ex-novio mío y pensé: "no lo voy a ver más, se va a morir" y al poco tiempo supe que había muerto en un accidente.

TERAPEUTA: Tal vez cuando Beatriz habla de muerte habría que entender separación. Posiblemente en aquel momento la separación de su ex-novio, marcada por su casamiento era sentida como muerte. Aquí también en las sesiones el tema es la separación entre padres e hijos y tal vez por eso reaparece el miedo a la muerte.

Esto es calurosamente aceptado por toda la familia. El terapeuta advierte luego que su formulación fue interpretada desde el contexto familiar como una "videncia". Así éste es aceptado en tanto se lo asimila a la abuela paterna (tía materna) y a la tía materna (prima paterna); de este modo se le transfiere el lugar del representante de la familia materna. Esta

situación, que estimula por una parte la transferencia positiva en tanto vínculo de confianza, debe por otra parte ser captada e interpretada para evitar la neutralización del terapeuta en el contexto familiar. El espiritismo y la videncia son en esta familia el núcleo básico de creencias irracionales que constituyen un código incuestionable y transmitido generacionalmente por vía endogámica y sin modificación alguna.

Toda esta situación resistencial, expresada además en planteos constantes de deserción, propone al terapeuta el desafío de encontrar recursos para la instalación y supervivencia del lugar terapéutico. En este caso particular consideró necesario un diagnóstico operativo y de mayor duración. Propuso que se contaran las tres historias familiares en juego: la de la familia de Beatriz, la de la familia de Diego y la de la pareja de Beatriz y Diego. A partir de la individuación de Diego, curiosamente, cada miembro de la familia quiso contar su historia individual. La familia denota así una actitud ambivalente, ya que por un lado muestra la imposibilidad de integrarse en el nuevo contexto de la sesión, pero por otro lado encuentra ella misma un recurso que favorece la discriminación.

En *Las Mil y Una Noches*<sup>7</sup>, la princesa Scherezade, logra sobrevivir con el relato de las historias inconclusas, cada vez una noche más. En este caso las historias familiares, permitieron realizar cada vez una sesión más.

*Fragmento de la décima sesión: De la violencia.*

El padre pide al terapeuta que trate a la pareja de Beatriz y Diego, en lugar de la familia, para que decidan o no su separación.

El terapeuta señala que el problema no pasa por la separación de Diego y Beatriz, sino por lo mucho que le cuesta a Beatriz separarse de los padres y a éstos dejar que se arregle sola. Continúa la discusión del tema, muy resistido por la familia, hasta que en un momento dice Beatriz al terapeuta: Vos me vas a volver loca. Y sale corriendo del consultorio. Diego corre tras ella. José (al terapeuta): Si le pasa algo va a ser culpa suya.

Este fragmento muestra como una familia con trastornos contextuales, en el momento en que el terapeuta está más cerca de hacer conscientes las significaciones provenientes de la estructura familiar inconsciente, utiliza recursos extremos de violencia-amenaza para sostener y preservar el sistema endogámico. Así como José y Blanca sostienen dicho sistema casándose entre primos, Beatriz y Diego, lo hacen, en la medida en que el yerno es incluido por la familia como un hijo más.

Sin duda, en esta sesión se dramatiza la conflictiva nuclear del grupo familiar, relacionada con la imposibilidad de aceptación de un código paterno y la consiguiente exogamia. El padre real, ausente como función discriminadora, aparece como portavoz del código de la familia materna.

Desde el lado de la familia, la intervención terapéutica es vivida como la intrusión violenta del tercero que separa la célula narcisista. De este modo, la violencia primaria intrínseca a la interpretación<sup>1</sup>, es decodificada por esta familia como violencia secundaria, lo cual promueve una respuesta de la misma índole: violencia secundaria ejercida a través de la amenaza.

Desde el lado del terapeuta, la violencia ejercida sobre él desestructura momentáneamente su capacidad de pensamiento y significación. Esto puede explicarse desde dos puntos de vista: en primer término, cuando el ataque al lugar terapéutico es masivo y ya no es efectivo el papel preservador del encuadre, el terapeuta se descontextualiza y queda expuesto como persona real, ya no virtual. Se da así entonces, la posibilidad de la irrupción de afectos que normalmente no aparecen en la situación terapéutica (angustia, miedo, enojo, sensación de parálisis). Por otro lado, señala Berenstein, la emergencia de violencia en la sesión regrede al terapeuta a una situación de desamparo originario<sup>5</sup>, caracterizada por la imposibilidad de significar. ¿Cómo sale el terapeuta de esta situación? Privilegiamos como recurso el pensar acerca de la familia en ausencia de ellos, para tratar luego de redefinir y recuperar el lugar terapéutico, instalando un sentido a través de la palabra, allí donde hubo conductas violentas.

Queremos ahora explicitar cuál es el lugar de la palabra en

el proceso terapéutico con familias con trastornos contextuales.

Como psicoanalistas utilizamos como instrumento la interpretación, que pone un sentido a través de la palabra, allí donde no lo hubo, allí donde la familia dramatiza o actualiza lo no simbolizado<sup>1 3-10</sup>. Por ejemplo, en nuestro caso el terapeuta explicita a la familia, que la situación de amenaza ocurrida en la sesión anterior, tiene un sentido que es desconocido para ellos. Señala que dicha situación de violencia fue el resultado de la angustia frente a la amenaza de separación de Beatriz respecto de sus padres, y les pide entonces que reflexionen sobre esto. De este modo, el analista aparece como mediador de la función simbólica, en tanto ofrece a la familia la posibilidad de pensar y hablar acerca de lo actuado.

No sólo el discurso del analista puede develar nuevas significaciones, sino que la palabra de la familia también puede hacerlo, en la medida en que este discurso se halle contextualizado en la situación terapéutica, que implica un otro que escucha y para quien se habla.

Con frecuencia observamos que las familias con trastornos contextuales, se resisten a las interpretaciones del terapeuta, ya sea descontextualizándolas o reaccionando con violencia. Se hace necesario, por tanto, realizar un trabajo preparatorio, para la instalación de un código compartido que permita la comunicación y el hallazgo de nuevas significaciones.

Es habitual realizar el diagnóstico familiar en sólo una breve serie de entrevistas.

En cambio, con las familias con trastornos contextuales creemos necesario un diagnóstico prolongado a la manera del "período de prueba" que Freud plantea en *Sobre la Iniciación del Tratamiento*<sup>8</sup>, para determinar si la familia estará en condiciones de entrar al período de tratamiento propiamente dicho y aceptar a su vez esta indicación.

En el caso planteado, el período inicial consistió centralmente en el relato de las diferentes historias familiares. Pensamos que dichos relatos otorgaron a la familia y al terapeuta, como en Las mil y una noches, el tiempo y el espacio necesarios para la constitución de la relación transferencial sobre la

que se sustenta la posibilidad de la cura. "La primera meta del tratamiento es ligar al paciente a la cura y a la persona del médico" (S. Freud, Op. cit.)<sup>8-9</sup>.

Pensamos que el recurso de las "mil y una noches" constituye para terapeuta y familia, una vía regia para la instalación del proceso terapéutico, en tanto demanda a la familia poner en palabras su historia, reconstruyéndola para la escucha de un otro.

Durante este encuentro de la familia con su historia, el terapeuta señala relaciones, que le permiten gradualmente introducirla en el conocimiento del nuevo contexto terapéutico.

Por otro lado, "las mil y una noches" confrontan a cada uno, con las historias de los otros. Esto permite poner al descubierto las diferencias que cada miembro puede tener acerca de lo vivido. De este modo cada uno posee nuevos elementos para pensar al otro, lo que produce desmistificaciones y abre la puerta al establecimiento de nuevos sentidos familiares.

Podemos concluir entonces, que el largo diagnóstico fue para el terapeuta, como las mil y una noches para la princesa Scherezade, una aventura de supervivencia tendiente a producir modificaciones en la dirección de la cura. La supervivencia de Scherezade posibilita al rey una nueva forma de existencia, del mismo modo si el terapeuta sobrevive en su función, la familia tiene la oportunidad de nacer a la exogamia.

La experiencia muestra que no siempre el final es el de los cuentos, y que el instrumento terapéutico posee limitaciones. No todas las familias exigen al terapeuta el recurso extremo de "las mil y una noches", que plantean las familias con trastornos contextuales. Pero en todos los casos es necesario, que se tenga en cuenta la constitución del lugar terapéutico como trabajo primordial.

## Resumen

Analizamos en el presente trabajo las características particulares que el proceso de instalación y supervivencia del lugar terapéutico adquiere en las llamadas "familias con trastornos contextuales".

Nuestro marco referencial es la Teoría Psicoanalítica y el abordaje familiar lo hacemos desde el modelo Psicoanalítico Estructural para el Análisis de las Relaciones Familiares.

En las familias con trastornos contextuales consideramos problemáticas relacionadas con violencia y psicosis, así como la transmisión de la irracionalidad.

Planteamos la necesidad de arbitrar recursos técnicos especiales para la instalación y supervivencia del lugar terapéutico. Describimos un recurso que consideramos indicado para este propósito. Consiste en la realización de un largo diagnóstico a modo del "período de prueba" previo a la indicación terapéutica que Freud señala cuando trata la iniciación del tratamiento. Tomamos como núcleo de dicha tarea diagnóstica el relato de las historias familiares, a la manera de las historias inconclusas de Las Mil y Una Noches. Estas ofrecen a familia y terapeuta el tiempo y el espacio necesarios para llevar a cabo la difícil tarea de establecer un código compartido y fundar una relación transferencial que pueda servir de soporte al tratamiento.

## Summary

In this paper we analyze the particular features of the process of establishing the "therapeutic place" and its survival in the so called "families with contextual troubles".

Our theoretical framework is the Psychoanalytic Theory and the Structural Psychoanalytic Model for the Analysis of Family Relationships.

In those families with contextual troubles we take into consideration the difficulties related to violence and psychosis as well as the "transmission of irrationality".

We propose the need to use specific techniques in order to establish and to achieve the survival of the "therapeutic place". We describe one technique we consider appropriate for this purpose. It consists of a long lasting diagnostic, resembling Freud's "Trial Period" prior to the therapeutic indication pointed out when he describes the start of the treatment.

## LAS MIL Y UNA NOCHES DEL TERAPEUTA DE FAMILIA

We take the family stories paralleling the unfinished tales of the Arabian Nights as the core of the diagnostic task. These stories offer both the family and the therapist, the necessary time and space to carry out the difficult task of establishing a shared code and to set up a transferential relationship as a basis for the treatment.

## Bibliografía

1. AULAGNIER, Piera; *La violencia de la interpretación*, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1977.
2. AULAGNIER, Piera; *Los destinos del placer: alienación, amor, pasión*. Ediciones Petrel, Barcelona, 1980, página 73.
3. BATESON, Gregory; *Pasos hacia una ecología de la mente*, Ediciones Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1976, página 273.
4. BERENSTEIN, Isidoro; *Familia y enfermedad mental*, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1976.
5. BERENSTEIN, Isidoro; *Psicoanálisis de la estructura familiar*, Editorial Paidós, Barcelona, 1981.
6. BERENSTEIN, Isidoro; "Notas sobre el funcionamiento psicótico", en *Psicoanálisis*, Revista de APDEBA, Volumen IV, N° 2, Buenos Aires, 1982.
7. BETTELHEIM, Bruno, *Psicoanálisis de los cuentos de hadas*, Editorial Grijalbo, Barcelona, 1977.
8. FREUD, Sigmund; "Sobre la iniciación del tratamiento", *Obras Completas*, Tomo XII, página 107, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1980.
9. FREUD, Sigmund; "Sobre la dinámica de la transferencia", *Obras Completas*, Tomo II, página 93, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1980.
10. FREUD, Sigmund; "Lo inconsciente", *Obras Completas*, Tomo XIV, página 193, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1979.
11. FREUD, Sigmund; "Neurosis y Psicosis", *Obras Completas*, Tomo XIX, página 151, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1979.
12. LEVY-STRAUSS, Claude; *Antropología Estructural*, EUDEBA, Buenos Aires, 1977.
13. MANNONI, Maud; *El niño, su enfermedad y los otros*, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1976.

---

## Proceso de producción y pautas de mantenimiento de síntomas<sup>1</sup>

---

Dr. CARLOS E. SLUZKI\*

---

Cuando una familia consulta por síntomas en uno o más miembros, o entre los miembros, la exploración del terapeuta tiende a responder a dos líneas de preguntas: I) ¿Por qué aparecieron los síntomas o conflictos? es decir, cuál fue el proceso por el cual fueron incorporados al sistema; y (II) ¿cómo son mantenidos los síntomas o conflictos por el sistema? es decir, cuál es el patrón interpersonal a través del cual la familia preserva o retiene el síntoma. De hecho, cuando se intenta refinar una definición de la noción central en terapia

<sup>1</sup> Versión en castellano de los siguientes artículos: "Process of symptom production and patterns of symptom maintenance", *Journal of Marital and Family Therapy*, 1981, 7, 273-280 y "A brief rejoinder to a brief rejoinder". *Journal of Marital and Family Therapy*, 1982, 8, 399-401. Versión del autor. Traducción de la Psic. Susana Ferdkin y del autor. Publicado con permiso del autor y del editor.

\* Profesor de Psiquiatría y de Medicina Familiar y Comunitaria, Universidad de California, San Francisco, Dept. of Family and Community Medicine, San Francisco General Hospital, San Francisco, CA 94110, U.S.A.

familiar de que "los síntomas cumplen funciones en la familia", este intento conduce a planteos alternativos: (I) la retención de síntomas en familias puede ser explicada en términos de algún *proceso de producción colectiva*, alguna razón tal como evitación de otro conflicto, realineamiento de coaliciones, mantenimiento de un status quo, etc. (es decir, la causa o génesis); y (II) la retención de síntomas puede ser explicada en términos de algún *patrón colectivo de mantenimiento*, algún proceso circular de causación mutua por el cual la reducción del comportamiento sintomático actúa favoreciendo en otros miembros de la familia conductas inductoras de síntomas (es decir, su matriz interaccional presente).

Estos dos tipos de hipótesis proceden de distintas lógicas, causa-efecto y sistémica/cibernética, evocan diferentes *líneas de interrogantes*, el por qué y el cómo, requieren diferentes *conjuntos de datos*, reconstrucción histórica y observación del aquí-y-ahora, y conducen a diferentes *estrategias de tratamiento*. Este artículo intenta especificar algunas de las diferencias entre estas dos aproximaciones territorialmente vecinas pero discontinuas aún en sus supuestos de base; es posible generar hipótesis acerca de por qué ha aparecido un síntoma dado sin tener la más vaga idea de qué comportamiento de los miembros del sistema familiar contribuye a mantener y sostener a los síntomas; y, viceversa, es posible descubrir las pautas de mantenimiento de los síntomas sin pretender establecer qué es lo que condujo a que los síntomas aparecieran en primer lugar.

#### Proceso de producción del síntoma

El desarrollo de una hipótesis acerca de la génesis interaccional del síntoma, es decir, acerca de la razón colectiva para su adopción por una familia dada en un momento dado, orienta al terapeuta en la dirección de la reconstrucción del contexto original de aparición del síntoma, deduciendo qué función puede haber cumplido *entonces* y favoreciendo modos no sintomáticos de lidiar con la causa original *ahora*.

La meta última de esta estrategia es favorecer la adopción,

#### PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE SINTOMAS

por parte de la familia, de modos alternativos de relacionarse con conflictos latentes (lo que requiere, por cierto, la incorporación de la noción de conflicto latente y de represión o desplazamiento colectivo), de modo que elimine el valor económico del síntoma. El foco es entonces, la reconstrucción de la causa de origen del síntoma y la subsiguiente eliminación de su función colectiva a través de lidiar con la causa. El siguiente es un ejemplo de esta lógica y estrategia.

La aparición de un síntoma severo en un niño —intensos ataques de asma— que exige de los padres una atención persistente y concentrada es rastreada a un período inmediatamente siguiente a la muerte de un hermano del niño. El terapeuta concluye que el síntoma y las conductas de los otros miembros de la familia que derivan de éste, actúan como moratoria colectiva relacionada con esa muerte (además de un ritual desplazado de reparación y expiación de culpas) y dejando de lado el síntoma del paciente identificado, concentra su atención en favorecer la elaboración del duelo de manera persistente y gradual, proveyendo así a la familia la posibilidad de lidiar con el tema evitado. El síntoma a su vez, desaparece.

El ejemplo representa una lógica basada en la reconstrucción del contexto de iniciación y la deducción de qué función puede haber cumplido el síntoma entonces y *desde* entonces. Con la resolución del conflicto que le dio origen, el terapeuta espera que la matriz de apoyo del síntoma se disolverá por sí misma y el síntoma desaparecerá. Consecuentemente, este modelo moviliza una estrategia terapéutica que trata la *causa* con el objeto de resolver sus *efectos*.

Queda claro así que el interrogante de ese enfoque no está centrado en cómo es mantenido el síntoma sino en por qué esta ahí. Sin embargo, debe notarse que el procedimiento no es siempre reconstructivo: a veces, en el curso de la sesión, la familia despliega un acto de su drama ante los ojos atentos del terapeuta. Por ejemplo, se comienza a discutir un tema, florece el síntoma, y el tema se disuelve en una alternativa inocua. Estas "muestras" o réplicas suelen aparecer repetidas veces en la sesión y ser utilizadas por el terapeuta para generar, corrobo-

rar o corregir una hipótesis sobre la génesis del síntoma basada en una reconstrucción histórica.

De hecho, ese isomorfismo entre patrones de comportamiento puede ser utilizado para explicar desde dentro del modelo aquellos éxitos terapéuticos que tienen lugar aún cuando el terapeuta no consigue —o no intenta— arribar a una reconstrucción del conflicto de origen. En ese caso, se argumenta, el conflicto original puede haber sido elaborado por delegación, por así decir, cuando la representación isomorfa actual ha podido ser resuelta colectivamente.

Podría aducirse, añadiendo una vuelta de tuerca a la discusión, que muchas pautas sintomáticas persisten en la familia aún cuando el contexto de la situación de origen haya cambiado radicalmente: algunos participantes pueden haber muerto, o haberse ido, algunos nuevos pueden haberse incorporado, o la substancia del conflicto mismo puede haber desaparecido hace tiempo. ¿De qué manera podría seguir siendo útil comprender el *por qué* del síntoma aún cuando se haya dado un cambio de contexto? El síntoma, ¿mantiene siempre su *por qué*? En favor de una respuesta afirmativa a esta última pregunta, se puede argumentar (siempre desde la perspectiva del modelo) que, una vez que la familia ha incorporado el síntoma como instrumento interaccional, la pauta se activa cada vez que tiene lugar una situación del *tipo* de la situación original. En otras palabras, el sujeto y su entorno significativo utilizan la pauta interaccional para lidiar con la clase de sucesos a la que perteneció como miembro el acontecer original, el cual aparece como sombra genética de cada nueva edición del problema.

El centro de atención de esta sección ha sido la lógica que subyace al desarrollo de hipótesis centradas en los procesos de producción del síntoma y las estrategias terapéuticas que derivan de ella. Una línea diferente de interrogantes, de lógica y de estrategias se hará evidente en la sección siguiente, centrada en el examen y la modificación de los procesos que constituyen el soporte interaccional (interpersonal) del síntoma.

### Pautas de mantenimientos del síntoma

Las hipótesis acerca de las *pautas de mantenimiento del síntoma* se desarrollan a partir de la observación y la exploración del contexto interaccional del síntoma *en el presente*. Este punto de vista se basa en la premisa de que, independientemente de cual haya sido su origen primero, los síntomas o conflictos de cualquier tipo sólo pueden persistir si son mantenidos por pautas interaccionales actuales.

La pregunta guía es ¿de qué manera la matriz interpersonal —compuesta por los comportamientos de todos los participantes— mantiene o sostiene al síntoma? (en lugar del interrogante ¿qué causó la aparición del síntoma?)

Los síntomas y su contexto interpersonal son concebidos como piezas de una secuencia recursiva auto-perpetuante de comportamientos. La investigación apunta a descubrir los principios sistémicos que gobiernan a las familias, en términos de patrones colectivos de conducta *de los que el síntoma es una parte*. El *por qué* del síntoma es relegado en favor de la descripción/explicación del *cómo*, es decir, de aquellos comportamientos de cada uno y todos los participantes que contribuyen en el presente a la persistencia o mantenimiento del comportamiento sintomático. El síntoma mismo es considerado como un eslabón en una secuencia sin fin de causalidad circular o recíproca. En la exploración de esa secuencia se pone particular énfasis en aquellas conductas del portador del síntoma y de los otros miembros de la familia que son generadas o suprimidas por la aparición de los síntomas.

Una vez que se ha determinado cuáles son los mecanismos que contribuyen al sostenimiento de la secuencia que contiene al síntoma, la estrategia terapéutica consistirá en disrumpir aquellos mecanismos secuenciales, bloqueando así la aparición recurrente del síntoma. ¿Cuál será el resultado de un bloqueo exitoso de la pauta interactiva que contiene el síntoma y por lo tanto de la aparición del síntoma? Hay dos alternativas posibles. Una es que otro conflicto o problema inunde el sistema familiar, un tema que estaba relegado al trasfondo del campo

cognitivo/emotivo, obscurecido por la figura dramática del comportamiento sintomático y que salta como figura una vez que el síntoma desaparece. La otra posibilidad es que *ningún* síntoma o problema o conflicto reemplace al síntoma bloqueado. El hecho de que esta última posibilidad ocurra con extraordinaria frecuencia en la práctica clínica lleva a asumir que la secuencia interactiva que incluye y perpetúa el síntoma permanece anclada en la familia *más allá de su tiempo crítico útil*. El síntoma puede quedar así atrapado en una secuencia interaccional recursiva funcionalmente autónoma (en un equivalente sistémico a lo que Gordon Allport llamó "autonomía funcional de los motivos"). Esto contribuye a explicar la observación tan frecuente de que la desaparición del síntoma es seguido sólo de una sensación de inmenso alivio colectivo, correspondiente al hecho que la familia alcanzó nuevos grados de libertad.

Diferenciados radicalmente del pensamiento psiquiátrico y psicodinámico tradicional, esta última instancia implica que los síntomas y las pautas interactivas persistentes pueden perder su asociación con un eventual conflicto colectivo que los desencadenó y los ancló a su origen. Podría aún ser propuesto, dentro de este punto de vista, que muchos síntomas —y su secuencia interactiva manteniendo— no poseen un conflicto desencadenante discernible y que su existencia es el resultado de fenómenos fortuitos que llevó a que se anclaran progresivamente por la participación colectiva, en la medida que las pautas de mantenimiento de síntomas se convierten en principios organizativos del grupo: aseguran rituales y rutinas, introducen orden y predictibilidad, se transforman en marcadores de la identidad colectiva.

El siguiente fragmento ejemplifica las estrategias de bloqueo de la matriz interpersonal de mantenimiento del síntoma, mencionadas más arriba, e ilustra alguna de sus posibles consecuencias.

Una familia de cuatro miembros (padre, 76 años; madre, 56; hija, 13; e hijo, 12 años) es referida por un pediatra debido a dolores de cabeza recurrentes en el hijo, que ha motivado un número inusual

de consultas en los últimos dos meses, y que llevaron al pediatra a considerar estudios exploratorios invasivos, incluyendo angiogramas y pneumoencefalogramas. Debido al carácter mayor de esos estudios, el pediatra mismo decide requerir una segunda opinión, que condujo a la entrevista familiar. En la primera entrevista, la madre, verdadera cancerbera verbosísima del grupo familiar, informa que su hijo se ha quejado de cefaleas y mareos, de a varios días seguidos por vez. "Lo traje al hospital numerosas veces para saber de qué se trata, podrían ser problemas con la vista, con el oído, con el cerebro, emocional, lo que sea." En el curso de la discusión, el padre introduce al pasar un síntoma menor: "También le sangra la nariz" cosa que es definida como ocasional y sin importancia por la madre, ya que ocurre cada seis meses y se resuelve sin problemas. Explorando la presencia de cefaleas en la familia, surge la información que la madre, luego de un accidente de motocicleta 25 años atrás, ha tenido frecuentes e intensos dolores de cabeza. La hija tiene cefaleas ocasionales y el padre nunca las tiene. El uso del dolor de cabeza como instrumento interpersonal es connotado positivamente por el entrevistador quien reacciona a la descripción de la hija acerca del modo en que los padres reaccionan a sus dolores de cabeza comentando: "Ah, es bueno saber que puedes apretar un botón y tener gente que te cuide y te mime cuando los necesitas. Es muy útil." Explorando el síntoma, el hijo afirma que el dolor aparece quizás dos veces por semana, en general al regresar de la escuela, y desaparece antes de cenar. Continuando con la exploración, el hijo afirma que el síntoma no le preocupa, que ha tenido estos dolores ocasionales desde que tiene memoria, y que no hay nada diferente en los dolores actuales. La madre expresa un desacuerdo enérgico con esta descripción. Se hace evidente al entrevistador que la fecha de iniciación ha sido fijada por la madre: corresponde a la aparición de *su preocupación* por los dolores de cabeza del hijo, más que de los dolores. La exploración de eventos contextuales en los meses recientes o en el futuro inmediato no aportó información útil adicional. La posición del padre con respecto a los dolores de cabeza es clara: "Bueno, yo estoy en la misma habitación y a mí no se me queja." Preparando el terreno para una intervención terapéutica, el síntoma de la epistaxis es "inflado" y reexplorado; predeciblemente, el padre, que había expresado preocupación por ese síntoma, es el otro al que le sangra la nariz. La intervención terapéutica central es formulada: durante las próximas



tres semanas, la madre —quien es “una experta en dolores de cabeza y sensible al tema”— debe ser considerada la experta en sangrado de nariz, y viceversa con el padre. Cada vez que el hijo tenga dolores de cabeza, debe recurrir solamente al padre y la madre debe rehusar involucrarse, aun cuando esto vaya en contra de sus impulsos naturales como madre. Cada vez que le sangre la nariz, debe activarse la pauta inversa: el hijo debe recurrir sólo a su madre y el padre rehusar involucrarse. Fueron predichas dificultades importantes en llevar a cabo la recomendación, y aún se sugirió que les resultaría imposible seguir la sugerencia. A la hija se le recomendó, a su vez, que escribiera un diario, de quejas *menores* “para aumentar su sensibilidad a las señas corporales.” Todos aceptan la prescripción (el padre la encuentra “muy razonable”) y se cierra la entrevista.

Al final de la primera entrevista, el terapeuta ha podido establecer una matriz de mantenimiento de síntomas —un claro ejemplo de proceso causal mutuo de amplificación de la desviación (tal cual fue definido por Mayurama, 1968; y aplicado por Hoffman, 1971), en el que la reacción excesiva de unos genera una percatación excesiva en otros que a su vez genera una reacción excesiva, y así sucesivamente. Como resultado, el terapeuta pudo proponer una prescripción sencilla con el objeto de bloquear la secuencia, si bien para entonces no había producido hipótesis alguna acerca de qué servicio cumplía —si es que cumplía servicio alguno— en términos de necesidades colectivas<sup>2</sup>.

Como se esperaba, en la sesión siguiente, tres semanas después, el hijo no había experimentado ningún dolor de cabeza —ni epistaxis—,

<sup>2</sup> Podría argumentarse que la preferencia del terapeuta por investigar estas pautas puede sesgar la recolección de datos y que si hubiera elegido explorar con mayor entusiasmo las causas de origen de los síntomas, habría podido establecer hipótesis coherentes en esa dirección. Por cierto que sí. Aún más, de hecho, éste es siempre el caso cuando se trazan hipótesis de cualquier tipo en ciencias del comportamiento así como en las ciencias “más duras”: la elección de parámetros y el establecimiento de prioridades en cuanto a observables, constituye un acto ideológico. En buena medida, *vemos lo que esperamos ver*.

## PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE SINTOMAS

ni habían aparecido razones alternativas de consulta. La madre introdujo un tema totalmente diferente, su actividad notoriamente intrusiva en la escuela del hijo: durante las últimas semanas pasaba un par de horas por semana sentada en el aula, literalmente controlando la tarea del maestro, y discutiéndole cada vez que desaprobaba sus criterios pedagógicos. Una discusión sencilla pero muy controlada por el terapeuta (quien se aseguró de que la madre escuchara el planteo claro del hijo en el que le pedía que no se inmiscuyera en su escuela) bloqueó la tendencia de la madre a demoler sus argumentos con afirmaciones culpógenas y les permitió llegar a un acuerdo de que la madre dejaría de instalarse en la escuela. Al comienzo de la sesión la madre había mencionado que ella aún tenía cefaleas. El tema es reintroducido por el terapeuta como algo que lo preocupa, y la madre afirma saber cómo aliviar sus dolores de cabeza: debe perder peso. Un desafío del terapeuta: “5 kilos en tres semanas” define ese objetivo como pertinente para la sesión siguiente.

La estrategia del bloqueo fue exitosa: el síntoma interaccional cefalea-preocupaciones ha desaparecido. Sin embargo, un tema alternativo, y un paciente identificado también alternativo, han aparecido.

La pareja parental vino a la tercera sesión sin los niños. La madre pidió no ser registrada en video y, quebrando una fachada dura hasta ese momento, comenzó a llorar mientras cuenta que cuatro meses atrás su marido —quien desde siempre ha administrado el pequeño negocio de música que posee la familia— cometió algunos errores de contabilidad que puso de manifiesto que no estaba en condiciones de continuar a cargo del negocio. El médico clínico de la familia le sugirió a ella, o al menos ella así lo infirió, que estos episodios podían ser los primeros indicios de un deterioro senil. El marido, a su vez, resta importancia a esos episodios, que define como menores, si bien reconoce que está perdiendo interés por el negocio, que declina lentamente en un barrio poco propicio para ese ramo de actividad. Esta crisis fue discutida en la sesión, y el terapeuta redefinió el cambio del marido en términos de su locus evolutivo en el ciclo vital, afirmando su derecho a considerar la posibilidad de retirarse de la banal rutina diaria con el objeto de

dedicarle más tiempo a examinar su larga, rica vida, y al mismo tiempo connotó positivamente la preocupación de la esposa por él. Ambos aceptaron el nuevo enfoque de la situación. Fueron vistos conjuntamente durante dos sesiones adicionales, en las que el tema central fue la reorganización de la familia en función de la perspectiva de su retiro del trabajo.

En esta tercera entrevista adquirió carácter explícito una crisis familiar —en la que un pasaje de fase dentro del ciclo vital de la familia arriesgaba derivar en otra rotulación médica en un nuevo paciente identificado. Mediante el manejo redefinido de la crisis, la familia fue ayudada en el proceso de reorganización mientras se evitaba los riesgos de una rotulación médica —tanto de los dolores de cabeza como de la demencia— y el consecuente procesamiento de acuerdo al rótulo<sup>3</sup>.

Este caso clínico ha sido elegido porque requiere una diferenciación clara de los modelos subyacentes a la tarea terapéutica, ya que, en la superficie, podría ser utilizado también como ejemplo por aquellos terapeutas que utilizan como modelo la lógica causal tipo “proceso de producción de síntomas”. Desde el punto de vista sincrónico, sistémico, a-causal, ilustra sin embargo una situación terapéutica en la que el foco en las pautas de mantenimiento del síntoma conduce a una estrategia orientada al bloqueo de las secuencias recursivas que incluyen al síntoma, y este bloqueo es seguido por el pasaje al plano principal de un problema que existía hasta entonces como fondo y que por su nueva notoriedad se hace accesible a las intervenciones del terapeuta.

A diferencia de la lógica seguida en la sección anterior, lo que se argumenta es que los síntomas —y su pauta de mantenimiento—, lejos de constituir la manifestación superficial de conflictos más profundos, *constituyen* el conflicto. Por lo tanto, la presencia de un conflicto o un síntoma o una crisis no

<sup>3</sup> Esta situación persiste aún dos años después de la consulta, de acuerdo a información del seguimiento.

## PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE SINTOMAS

denuncia la existencia de “patología” precedida o encubierta por el síntoma, ni de conflicto precediendo a la crisis. La experiencia clínica indica que la eliminación de síntomas y sus pautas de mantenimiento sólo conducen a una mayor libertad del sistema —es decir, aumenta el número de alternativas en lugar de la repetición del “juego sin fin”, como lo llamara Watzlawick (1972). Si ocurre que, luego de la eliminación de la pauta de mantenimiento, otro conflicto o síntoma invade el campo —es decir, se hace central para la familia—, el terapeuta tendrá que decidir si se trata de un conflicto acerca del cual acordará un nuevo contrato terapéutico con la familia o bien lo definirá como un evento corriente del ciclo evolutivo de la familia que tendrá que ser enfrentado de la manera en que la mayor parte de esos eventos son enfrentados: por los mismos interesados. Ocurre que si se da por sentado que, cuando se resuelven terapéuticamente los síntomas motivo de consulta, esto conduce a la aparición de síntomas o conflictos ocultos, este supuesto sólo aumentará la posibilidad de rotular nuevos desarrollos como “síntomas” o “conflictos”, y el terapeuta habrá contribuido, con esa lógica, a la autoperpetuación de una terapia recurrente o ilimitada.

Aún un enfoque amplio de resolución de conflicto tipo “exploremos qué problemas tienen como familia y elaborémoslo” contiene el germen de una profecía autocumplidora: las familias siempre enfrentan transiciones de diferente tipo inherentes a su condición de proyecto colectivo a largo plazo. Estos pasajes evolutivos, inevitablemente problemáticos, corren el riesgo de ser definidos como “motivo razonable de consulta” por familias y terapeutas por igual, lo que aliena a dichos procesos del dominio de la vida cotidiana y los aloja en el terreno de la psicopatología, o por lo menos los rotula como “problemas familiares”, lo que suele resultar suficientemente virulento.

En resumen, sólo cuando emergen síntomas o conflictos “nuevos” (¡tal vez ese mismo concepto es una contradicción por definición!) de manera clara y paralizante es que se justifica

proponerse una nueva intervención terapéutica, centrada en el nuevo problema.

El lector encontrará, en la literatura sobre terapia familiar, abundantes ejemplos del tipo de estrategias de intervención centradas en las pautas de mantenimiento de los síntomas<sup>4</sup>. Las diversas líneas de trabajo sistémicas han desarrollado estrategias y lógicas terapéuticas centradas en las pautas interactivas mismas, en las estructuras interpersonales que replican dichas pautas y en las construcciones de la realidad que le dan soporte ideológico (Sluzki, 1983). Entre ellas merecen especial atención acá los tipos de intervención llamados "paradójicos", entre los que se cuenta la prescripción del síntoma y del comportamiento complementario de todos los participantes, la connotación positiva de intención de los participantes (cuyo efecto general de sentido es el mismo) y otras re-rotulaciones. El objetivo de estas intervenciones es modificar las pautas interactivas que incluyen al síntoma a través de la modificación de su superestructura ideológica, a saber, la representada por la organización de la realidad tal cual es percibida y/o actuada por los participantes. Los dos ejemplos siguientes se centra en este tipo de intervenciones terapéuticas.

Una pareja, ella terapeuta y él carpintero (probablemente un "drop out" de los años '60, que abandonó sus estudios universitarios para dedicarse a tareas vividas como más esenciales en el sentido etimológico del término), consultan debido a un aumento de problemas e insatisfacción en la pareja más allá del límite de lo habitual y confortable para ambos. La pauta es: una en la que ella siente que él la desatiende y él, que ella espera demasiado de él. En la sesión ella lo mira atentamente, en tanto que él tiende a mirar al espacio con un rostro bastante inexpressivo. Luego de explorar el contexto del síntoma, que es cíclico, frecuente y predecible, y habiendo propuesto al final de la primera entrevista algunas conductas para intentar romper la pauta, sin ningún cambio visible en la segunda, el

<sup>4</sup> Ver, por ejemplo, Haley (1967), Erickson (Haley, 1973), Hoffman (1971, 1981), Madanes (1981), Selvini Palazzoli y col. (1978), Sluzki (1979), Watzlawick y col. (1982).

terapeuta manifiesta en el curso de esa entrevista que lo que ellos traen como problema es en realidad un elemento intrínseco de la relación: ella —terapeuta— disfruta y necesita de los contactos interpersonales. El —carpintero— disfruta y busca la soledad. Ese es el modo en que cada uno es, por legítimas necesidades o preferencias personales. Si cada uno espera que el otro sea diferente, cada uno se sentirá tironeado más allá de su bienestar. De ese modo, la frustración será inevitable en la relación en tanto ellos definan este rasgo de la relación como un *problema* y por lo tanto susceptible de ser cambiado. Debido a esas consideraciones, se les recomendaba suspender la terapia para evitar el malentendido. La reacción de la pareja fue de alivio, y terminaron su terapia con gratitud. De acuerdo a datos de seguimiento obtenidos un año después, la relación retomó una modalidad gratificante para ambos. El círculo vicioso de recriminaciones y exigencias mutuas —la solución intentada para resolver el pseudo-problema, que se convirtió a su vez en el real problema de la pareja— desapareció sin ser reemplazado por ningún otro problema.

Un hombre de 29 años, rotulado de esquizofrénico desde hace 6 años, es entrevistado conjuntamente con su familia (madre y dos hermanos), que lo ha apoyado en el curso de sus múltiples vicisitudes. Su historia incluye el hecho de que el padre abandonó la familia cuando el paciente tenía seis años. A su vez, el paciente había estado casado y tenía tres hijos cuando tuvo un affaire que fue descubierto por su esposa, quien lo expulsó del hogar —o bien él abandonó su hogar en esas circunstancias— unos años atrás. Poco tiempo después de ese episodio comenzó a producir síntomas delirantes, alucinaciones y conductas abiertamente inadaptadas (por ejemplo, se masturbaba en público y defecaba en el living-room de su casa). Desde entonces, su historia es un continuo de hospitalizaciones, medicamentos, remisiones, altas y recaídas que llevaban a nuevas hospitalizaciones. En el curso de la entrevista se hizo evidente que, cuando el paciente expresaba conductas psicóticas, la familia mantenía distancia y cuando no, lo abrumaba con atenciones infantilizantes, cosa que cesaba cuando surgía un síntoma. Al finalizar la primera entrevista familiar, que ocurría luego de una nueva hospitalización, el terapeuta dijo a los presentes: "Es evidente que es de máxima importancia para la familia —usted (paciente) incluido— diferenciar claramente entre su padre —abandonador y traidor tal cual ustedes lo describieron— y usted, que a través de la declaración de

insanía no es responsable de acción alguna que pueda hacerlo parecer a su padre. Por lo tanto, respetando esta necesidad familiar, suspenderemos todo intento de curarlo, ya que lo que usted hace es necesario para toda la familia." De hecho, no fue propuesta otra reunión familiar y sus encuentros individuales con terapeutas fueron suspendidos. Se le ofreció la oportunidad de pedir medicación todos los días si así lo deseaba, porque (tal cual se dijo en la sesión familiar) "la medicación es un modo de definirlo como paciente psiquiátrico casi tan bueno como sus síntomas."

Un mes después, el paciente pidió el alta del hospital, y se ha mantenido libre de síntomas durante los 12 meses del seguimiento, un lapso sin precedentes en su historia psiquiátrica.

Ambos ejemplos ilustran intervenciones sistémicas del tipo llamado paradójal, en las que las intervenciones aparentemente mantienen los síntomas mientras connotan positivamente las acciones o las intenciones de todos los participantes. Sin embargo, en el último de los casos, aún cuando resulte un ejemplo claro de este modelo, parece curiosamente borrar la distinción entre las hipótesis centradas en pautas de mantenimiento y las centradas en procesos de producción del síntoma. Esto se debe al hecho de que la efectividad de una intervención paradójica se mida por su capacidad para afectar los patrones de comportamiento de los participantes, pero para poder obtener ese efecto dramático de alteración de las convicciones que los observadores llamamos "paradojas", la intervención debe apoyarse en componentes contextuales comunes a los miembros del grupo, entre los cuales se destaca el marco histórico contra cuyo fondo se recorta el patrón sintomático. En otras palabras, las intervenciones de tipo contextual-paradójico se enuncian frecuentemente en el *lenguaje* de la metáfora histórica provista para la familia.

Examinemos este fenómeno más en detalle. Toda historia familiar —y las historias familiares constituyen versiones microcósmicas de La Historia— puede ser descripta como un conjunto de sucesos y circunstancias seleccionados y ordenados por los miembros de la familia según reglas o pautas o estructuras convenidas por los mismos miembros. La historia familiar es la

descripción/explicación compartida por los miembros de la familia (o del grupo cuya historia se esté analizando) acerca de a) las características personales y/o colectivas de miembros pasados del grupo o las características pasadas de miembros presentes, así como de los miembros del exo-grupo que interactuaron con los primeros; b) la naturaleza y secuencia de los hechos y circunstancias en las que se vieron involucrados los miembros pasados y presentes de la familia; y c) los principios explicativos que otorgan orden, sentido y significado a dichas secuencias y a los actos de los participantes. La historia familiar constituye, en última instancia, un principio unificador, un código privado del grupo familiar que refleja (ante el observador externo al grupo) y recuerda (a quienes comparten la historia) acuerdos acerca de reglas interactivas, acerca de significados atribuidos y de principios organizadores de los datos de la realidad, acerca de valores, normas y explicaciones.

La historia familiar es percibida y representada como una parte tan estable del contexto familiar como lo es el entorno físico o el cultural. Con todo, el elenco de actores pasados y presentes, sus atributos, los escenarios, los desarrollos anecdóticos, las resoluciones y las moralejas que constituyen la historia compartida por los miembros de una familia —una historia que les otorga sentido de identidad colectiva con continuidad temporal— es un *construct*, es un rompecabezas construido con piezas selectas de la realidad pegadas con el cemento de las convicciones. Cada pieza es un fragmento reconocido por todos los miembros, y su combinatoria configura una gestalt, un guión o guía general. El guión reactualiza y activa en los participantes una multitud de acuerdos con respecto a cómo organizar los elementos de la realidad y cómo puntuar las secuencias (es decir, dónde se considera que un suceso comienza, sigue y termina, lo que permite definir héroes y villanos, iniciadores y seguidores, etc.) y evoca las normas y los valores compartidos por los miembros, así como las prescripciones y proscripciones de comportamiento y los corolarios éticos e imperativos morales derivados de dichos guiones. Cada vez que un fragmento de la historia familiar es denotado o connotado

por uno de los miembros de la familia, se activa en todos los miembros los términos de sus acuerdos.

Cuando, por una revelación insólita por ejemplo, se cambia el arreglo de los fragmentos en cualquier parte del rompecabezas colectivo, cuando la familia arriba a una nueva gestalt o guión o figura que resulta de una organización novedosa de las piezas preexistentes (cada pieza es un componente elemental de la historia), el resultado será un cambio en las reglas de procedimiento familiar evocado por ese fragmento específico de su historia. Por lo tanto, una realidad alternativa equiprobable, estratégicamente seleccionada y propuesta con tino terapéutico, es decir un cambio en la historia previamente acordada por la familia, tiene el potencial de perturbar o disolver las pautas de mantenimiento de los síntomas a las que otorgaban soporte ideológico y por lo tanto, resulta en la eliminación de los comportamientos sintomáticos. Y esto no prueba que la construcción alternativa sea "correcta" (ni siquiera más correcta que la construcción preexistente) sino sólo que la nueva construcción no requiere la presencia de la pauta ni del comportamiento sintomático.

Así, a pesar de su lenguaje de raigambre histórica, el modelo que subyace a este tipo de intervenciones no se basa en la eventual comprensión de los procesos de producción de síntomas, sino en el proceso radicalmente diferente de detección y bloqueo de las pautas de mantenimiento de los síntomas. Esta estrategia está basada a su vez, en un paradigma sistémico, representativo de la epistemología que dio nacimiento al campo de la terapia familiar.

## Resumen

En la búsqueda del proceso de producción del síntoma por un lado, y de las pautas de mantenimiento del síntoma por el otro, reside una diferencia central entre las dos orientaciones prevalentes en el campo de la terapia familiar, la aproximación psicodinámica y la sistémica. Ellas involucran hipótesis conceptuales y operacionales provenientes de diferentes lógicas, diferentes conjuntos de datos, diferentes líneas de exploración de los datos y diferentes estrategias de tratamiento. Los rasgos distintivos de cada una de estas líneas son discutidos y ejemplificados, poniendo especial énfasis en la visión interaccional sistémica.

## Summary

In the search for the process of symptom production, on the one hand, and for the patterns of symptom maintenance, on the other, lies the key difference between the two main orientations in the field of family therapy; the psychodynamic and the system-oriented approaches. They imply conceptual and operational hypotheses stemming from different logics, different sets of data, different lines of inquiry and, alas, different treatment strategies. Clearly distinctive traits of each of these two lines are discussed and exemplified, with special emphasis on the interactional, systemic view.

## Bibliografía

- ALLPORT, G. W.: *Personality: A Psychological interpretation*. New York, Holt, 1937.  
 HALEY, J.: *Estrategias en psicoterapia*. Barcelona, Toray, 1967.  
 HALEY, J.: *Uncommon Therapy: The Psychiatric Techniques of Milton H. Erickson*. New York, Norton, 1973.

CARLOS E. SLUZKI

- HOFFMAN, L.: Deviation amplifying processes in natural groups. En Haley, J., comp.: *Changing Families*. New York, Grune & Stratton, 1971.
- HOFFMAN, L.: *Foundations of Family Therapy*. New York, Basic Books, 1981.
- MADANES, C.: *Strategics Family Therapy*. San Francisco, Jossey-Bass, 1981.
- MARUYAMA, M.: The second cybernetics: Deviation amplifying mutual causal processes. En W. Buckley, comp.: *Modern Systems Research for the Behavioral Sciences*. Chicago, Aldine, 1968.
- SELVINI PALAZZOLI, M., CECCHIN, G., PRATA, G. y BOSCOLO, L.: *Paradox and Counterparadox*. New York, Aronson, 1978.
- SLUZKI, C. E.: Marital therapy from a systems perspective. En T. Paolino y B. McCrady, comp.: *Marriage and Marital Therapy*. New York, Brunner/Mazel, 1979.
- SLUZKI, C. E.: Process, structure and worldviews: toward an integrated approach to systemic family therapy. *Family Process*, 22(4), 1983.
- WATZLAWICK, P., BEAVIN, J. H. y JACKSON, D. D.: *Teoría de la comunicación humana*. (2da. Ed.) Barcelona, Herder, 1981.
- WATZLAWICK, P., WEAKLAND, J. H. y FISCH, R.: *Cambio, formación y solución de los problemas humanos*. Barcelona, Herder, 1982.

---

Terapia familiar intergeneracional. Intervención breve en una familia con problemas de alcoholismo y depresión<sup>1</sup>

---

GUILLERMO BERNAL, Ph.D. y CARMENZA RODRIGUEZ DRAGIN, M.A.

---

Universidad de California, San Francisco, y Escuela Profesional de Psicología, Berkeley.

---

El sector de la población de origen latinoamericano en los EE.UU. está en rápido crecimiento. El censo de 1980 en EE.UU. indica que de una población total de 220 millones de habitantes, alrededor de 15 millones son de origen latino (U.S. Bureau of the Census, 1982). Esta cifra asciende aproximadamente a unos 23 millones cuando se tiene en cuenta la tasa de nacimiento e inmigración (incluyendo personas indocumentadas) (Macías, 1977). Este rápido crecimiento de la población hispana en los EE.UU. sugiere la necesidad de incrementar, entre otros, los servicios de salud mental, no solamente en cantidad si no en calidad. Dicho incremento requiere que profesionales de habla hispana dedicados al campo de la salud mental, en general, y colegas latinoamericanos especializados en

<sup>1</sup> Este artículo fue presentado en una ponencia en el XIX Congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología en Quito, Ecuador, en julio de 1983.

técnicas psicoterapéuticas concentren esfuerzos para ofrecer métodos efectivos de tratamiento a personas latinas en los EE.UU.

El presente artículo representa un aporte a este llamado a la unión de esfuerzos. El objetivo de esta presentación es el exponer y discutir las técnicas que estamos utilizando actualmente en San Francisco, California, en un proyecto orientado al tratamiento psicoterapéutico de familias latinas recién inmigradas a los EE.UU. A continuación se expondrán cuatro aspectos del tratamiento: 1) Discusión del marco teórico en el cual se funda el tratamiento; 2) Exposición de las técnicas de intervención psicoterapéutica empleadas, las cuales se discutirán utilizando un caso clínico; 3) Análisis del tratamiento psicoterapéutico desde el punto de vista del marco teórico presentado; y 4) Discusión de los procedimientos utilizados para evaluar la efectividad de las técnicas psicoterapéuticas empleadas.

### Marco teórico

Las bases teóricas de nuestro trabajo terapéutico con familias se fundan en principios propuestos en la Terapia Familiar Intergeneracional o Contextual (TFI). Esta orientación, desarrollada por Iván Boszormenyi-Nagi, utiliza un sistema multidimensional en el análisis de los procesos familiares y en el diseño del tratamiento. Las siguientes son cuatro de las dimensiones básicas utilizadas en este sistema de terapia contextual.

A) Dimensión Existencial: Los análisis en esta dimensión enfatizan la herencia o legado cultural, e incluyen aspectos tales como condiciones étnicas, raciales, económicas, sociales e históricas de la familia. B) Dimensión Psicológica: Esta dimensión tiene en cuenta elementos dinámicos que juegan un papel importante en la vida del individuo tales como necesidades, conflictos, defensas, etc. C) Dimensión Sistémica o Transaccional: En esta dimensión se analizan el conjunto de patrones de conducta que rigen las relaciones familiares. Una tarea importante en esta dimensión es identificar los sistemas de interacción cuya función es el mantenimiento de elementos sintomáticos. El principio fundamental por el cual se rige esta dimensión

es el modificar estos patrones de conducta. D) Dimensión Ética-Relacional: La consideración principal en esta dimensión es la justicia que rige las relaciones entre las diferentes generaciones que componen la familia. La historia intergeneracional y el balance de los méritos y obligaciones transmitidas de una generación a otra es el elemento fundamental en esta dimensión. La tarea principal que plantea el enfoque intergeneracional o contextual, en general, es la de tomar conciencia de cuáles son los patrones generacionales vinculados a la producción de síntomas; esto con el objetivo de transformar tales patrones a través de un rebalanceamiento de deudas y créditos familiares.

La integración que la Terapia Familiar Intergeneracional (TFI) hace de las dimensiones mencionadas permite el desarrollo de hipótesis, a diferentes niveles, sobre la naturaleza del problema, ofreciendo un análisis más completo de la situación y permitiendo una intervención más efectiva.

### Intervención psicoterapéutica: el caso de la familia Méndez

Esta sección está compuesta de dos partes. La primera, provee información relevante sobre la familia en cuestión. La segunda, expone el sistema de intervención psicoterapéutica.

#### *Información sobre la familia Méndez<sup>2</sup>*

*Motivo de Consulta.* La familia fue referida por un centro comunitario de alcoholismo. La familia solicitó una consulta en este centro como consecuencia de síntomas de depresión, ideas suicidas, síntomas somáticos (dificultad al respirar, fatiga, dolor en los músculos), sentimientos de desesperación, irritabilidad, y en general, sentimientos de infelicidad presentados por el Sr. M. El Sr. M. manifestó que los síntomas somáticos eran producto de ataques de asma, de la cual había sufrido desde temprana edad. Durante los tres meses previos al tratamiento, el Sr. M. fue hospitalizado alrededor de cinco veces como consecuencia

<sup>2</sup> Para proteger el anonimato de los participantes en la terapia familiar, a la familia cuyo caso es presentado se le dio un nombre ficticio.

de los síntomas mencionados. La pareja vio como posible causa de la presente crisis un período de tres meses de abstinencia de alcohol por el cual el Sr. M. había pasado después de haber decidido dejar el licor completamente. El Sr. M. declaró que una de las causas principales por las cuales había decidido dejar el licor era el hecho de que la hija mayor evitaba acercársele y parecía que le tuviera miedo, lo cual sucedía especialmente cuando se encontraba embriagado.

Otros problemas presentados por el Sr. M. fueron dificultades de conciliar el sueño y extremada preocupación por la situación de su familia en el país de origen; preocupación que se generalizó hasta el punto de experimentar sentimientos de pánico por el futuro de su familia más cercana en los EE.UU. Según el señor M. uno de los temores que experimentaba era el que cayera una bomba atómica, o que hubiera un terremoto que lo destruyera a él y a su familia. Estos pensamientos estaban acompañados de ideas suicidas. En ocasiones el Sr. M. manifestó que a él no le gustaba quedarse en la casa solo por el temor de encontrar una oportunidad propicia para quitarse la vida.

*Inmigración a los EE.UU.* El Sr. M. inmigró a los EE.UU. hace tres años, y la Sra. M. hace dos años. El matrimonio tiene dos niñas, una de cinco años y otra de tres. Las dos niñas inmigraron a los EE.UU. hace dos años, en compañía de la madre. Desde su llegada a los EE.UU., hasta tres meses antes de iniciar el tratamiento, el Sr. M. declaró que él abusaba del alcohol diariamente. Ambos, el Sr. y la Sra. M. manifestaron tener dificultades con el inglés. El Sr. M. estudió contaduría en el país de origen. En los EE.UU. el Sr. M. ha estado trabajando en un restaurante como lavaplatos.

*Historia Familiar.* El Sr. M. es el segundo de cuatro hermanos (una mujer y tres hombres). Excepto el Sr. M. y uno de los hermanos, el resto de la familia vive en el país de origen. El padre del Sr. M. es un profesor retirado, quien abusa del alcohol frecuentemente. La Sra. M., es la única mujer y la segunda de tres hermanos. La familia, excepto la Sra. M. vive en el país de origen. La Sra. M. describe al padre como una

persona que bebía y se embriagaba con frecuencia. Según la Sra. M., la madre era una víctima del padre, sufrida y trabajadora. La Sra. M. recuerda su niñez como una época de privación y sacrificio e identifica al padre como la persona responsable de las dificultades económicas de la familia.

*Historia Marital.* El Sr. y la Sra. M. contrajeron matrimonio en 1973, en el país de origen. La pareja relata que los primeros años de matrimonio fueron difíciles. El primer niño que tuvieron murió cuando tenía un año de edad. Según el Sr. y la Sra. M., el niño no caminaba, ni se sentaba solo, y sufría de problemas respiratorios. La Sra. M. manifestó sentirse muy afectada porque su esposo era muy indiferente con ella y con el primer niño. El niño parece haber fallecido de problemas respiratorios en un hospital. El Sr. y la Sra. M. culpan al hospital de negligencia. La muerte del niño pareció haber marcado una nueva etapa en el matrimonio. Según la Sra. M., el esposo cambió completamente después de la pérdida del niño. En esta época ella lo describe como una persona más cariñosa y que pasaba más tiempo con ella.

### *Intervención Psicoterapéutica*

El tratamiento consistió en doce entrevistas llevadas a cabo en un lapso de cinco meses. El curso del tratamiento puede ser dividido en tres etapas. Una etapa inicial que cubrió aproximadamente las tres primeras entrevistas. Este período fue dedicado a obtener información preliminar, a establecer "rapport" con la familia y a fijar un contrato de tratamiento. En el contrato de tratamiento se delimitaron un número determinado de sesiones y se establecieron metas que la familia quería alcanzar. Esta etapa se caracterizó por una rápida mejoría de los síntomas por parte del Sr. M. En este período, el Sr. M. manifestó sentirse más aliviado de los ataques de asma; según él, los momentos de desesperación y angustia también se redujeron considerablemente.

Una segunda etapa abarcó aproximadamente las cuatro siguientes entrevistas. En esta etapa, los temas de discusión se



concentraron en elementos de la relación interpersonal entre la pareja y de la pareja con sus respectivas familias. Esta etapa se caracterizó por una progresiva acentuación de los síntomas presentados por el Sr. M. hasta el punto de requerir hospitalización. Previo al tratamiento, tanto como durante el mismo, el Sr. M. estaba recibiendo atención médica.

La última etapa, se caracterizó por una progresiva mejoría por parte del Sr. M. Cierta estabilidad emocional fue evidente en esta última etapa. El Sr. y la Sra. M. manifestaron sentirse menos ansiosos al discutir temas cruciales referentes a la relación entre ellos, y de ellos con sus respectivas familias. Durante este período del tratamiento fue notable un acercamiento entre la pareja, el cual culminó con la decisión de contraer nupcias por la iglesia (la pareja estaba casada por civil) aparentemente como símbolo para reafirmar la relación. Cuatro meses después del tratamiento, la familia indicó que los síntomas no habían resurgido y que la familia se estaba manteniendo en buen nivel de funcionamiento.

#### Análisis de la intervención psicoterapéutica

A continuación examinaremos el caso de la familia Méndez desde una perspectiva intergeneracional, usando las cuatro dimensiones propuestas por dicha orientación (existencial, psicológica, sistémica y ética). En cada dimensión analizaremos los eventos ocurridos, las hipótesis derivadas de estos eventos, el tipo de intervención psicoterapéutica y los resultados obtenidos de dicha intervención.

#### *Dimensión Existencial*

El análisis de esta dimensión revela que la familia se encontraba en una situación extremadamente agravada. El hecho de la inmigración trajo consigo la disrupción de los lazos familiares y sociales, la pérdida del contacto con la cultura de origen y con el idioma nativo. El cambio de cultura ocasionó, igualmente, una situación económica precaria como consecuencia de poseer limitadas destrezas ocupacionales y en el idioma. El

análisis de esta dimensión hace evidente un cambio drástico en la disponibilidad de redes de apoyo social, esto sumado a la escasez de recursos económicos de la pareja, y a la exigencia por parte del nuevo ambiente de alcanzar una adaptación inmediata.

La hipótesis existencial plantea que los problemas familiares están vinculados a la situación material, en este caso a cambios en el medio ambiente. Estos cambios ambientales, ponen al sistema familiar en una posición vulnerable a crisis emocionales por la tendencia de la familia a producir respuestas sintomáticas debido a la ausencia de respuestas nuevas y adecuadas de adaptación. En el caso de la familia M., era importante no solamente educar a la familia sobre las etapas por las cuales se pasa en el proceso de adaptación, sino también movilizar fuentes de apoyo social que pudieran proporcionar recursos para responder a las necesidades inmediatas de la familia. Por ejemplo, fue crucial proveer a la familia con contactos médicos para resolver problemas de salud, referir a la familia a centros educacionales para que desarrollaran destrezas en el nuevo idioma, y proporcionar fuentes de información que pudieran orientar a la familia en cuestiones legales con respecto al proceso de inmigración. En fin, fue importante servir de intermediarios para proveer a la familia con los recursos comunitarios disponibles en el nuevo ambiente. La familia pareció responder favorablemente con este tipo de intervención. Como se vio anteriormente, en la primera y última etapa del tratamiento hubo una notoria reducción en los niveles de ansiedad y tensión en la pareja.

#### *Dimensión Psicológica*

Esta dimensión analiza procesos individuales psicológicos de cada miembro de la familia. En este caso, por ejemplo, el Sr. M. presenta un cuadro clínico de ansiedad y depresión, ideas suicidas, dependencia al alcohol, ataques de pánico y síntomas somáticos. La Sra. M. por su parte aparece como una persona con un alto nivel de dependencia emocional, temerosa de tomar

decisiones por sí misma, pasiva, de una baja autoestima y con gran temor a ser rechazada.

Las hipótesis en esta dimensión están dirigidas a plantear razones que pueden estar manteniendo los síntomas a un nivel individual. El abuso de alcohol del Sr. M., por ejemplo, se presta a ser interpretado como una forma de automedicación y como una respuesta a situaciones que le causan tensión excesiva. El alcoholismo del Sr. M. también se puede interpretar como una forma de manejar impulsos agresivos y destructivos en contra de su familia de origen, de su esposa y de sí mismo. La dependencia del alcohol parece haber sido identificada en la nueva cultura como un síntoma y no como un evento social, como parecía haber sido visto en el país de origen. Parece ser que el haber sido identificado como una persona alcohólica produjo en el Sr. M. la motivación suficiente que lo llevó a tomar la decisión de dejar el uso del licor. Esta decisión trajo consigo, por supuesto, el resurgimiento de toda una sintomatología de tipo depresiva y fóbica. La Sra. M. al parecer "vio" la dependencia del alcohol del esposo como el foco hacia el cual podía dirigir toda sus energías. Censurar la conducta del esposo le permitía desviar la atención de sí misma y hacer menos obvios los conflictos personales.

El análisis de esta dimensión permitió la conceptualización y entendimiento de los procesos dinámicos del conflicto familiar y el planteamiento de técnicas adecuadas de intervención que respondieran no solamente a las necesidades de la familia como grupo sino también a las necesidades individuales de sus miembros.

### *Dimensión Sistémica*

Esta dimensión analiza las relaciones interpersonales en un sentido horizontal; esto es, entre los miembros de la familia que pertenecen a una misma generación, en este caso, entre el Sr. y la Sra. M.

La sintomatología de ambos parece mantenerse a través de un círculo vicioso. La conducta alcohólica del Sr. M.

aparentemente es mantenida y estimulada por la conducta pasivo-agresiva de la Sra. M. y viceversa. La pasividad de la Sra. M. provoca disgusto y agresividad en el esposo, el cual encuentra justificación para recurrir a la bebida. El demanda de ella el que sea más activa, pero la critica cuando ella hace algún intento por ser más independiente. Ella, a su vez, se torna más pasiva como reacción a las críticas de su esposo y lo critica severamente por la conducta adictiva.

Cuando el Sr. M. dejó el alcohol, nuevos patrones de conducta surgieron en las relaciones interpersonales de la pareja. El se deprimía, se sentía ansioso y manifestaba una variedad de síntomas físicos. Ella lo apoyaba y confortaba; una vez que él se sentía mejor, ella se deprimía. Este patrón se repitió varias veces. Cuando él se sentía mal, ella se sentía bien y viceversa.

La hipótesis sistémica plantea que los síntomas son una forma de mantener un balance homeostático en el sistema disfuncional. La intervención en este caso fue dirigida a establecer tareas concretas que permitieran romper estos patrones disfuncionales de interacción. Ante todo, se discutieron las razones que legitimizaban los sentimientos de tristeza y depresión por parte del Sr. y la Sra. M. y se enfatizó la importancia de pasar por una etapa de "duelo" por las pérdidas experimentadas como consecuencia de la inmigración. Al Sr. M. se le pidió que por un tiempo determinado, concentrara la atención en los sentimientos de depresión y que durante ese tiempo permaneciera triste lo más que pudiera. Durante ese tiempo, el Sr. M. debería llevar una especie de diario corto el cual escribiría durante las noches de insomnio. En este diario él debería tomar nota sobre el tipo de pensamientos que lo perturbaban. A ambos, el Sr. y la Sra. M., se les pidió también que hicieran un árbol genealógico de las respectivas familias. Una vez completas, las tareas asignadas fueron discutidas en diferentes sesiones.

### *Dimensión Ética*

Esta dimensión identifica patrones de la relación interpersonal en la familia que son transmitidas de una generación a otra.

Específicamente, esta dimensión analiza los principios de justicia que rigen dicha relación, por ejemplo, obligaciones filiales, lealtades, méritos y explotaciones relacionales. La intervención a este nivel ayuda a mejorar situaciones de deudas concretas y expectativas entre las diferentes generaciones identificando los desbalances en la relación, esto es, las "injusticias" que rigen la relación y que alimentan el conflicto.

En el caso del Sr. y la Sra. M., son evidentes dos patrones principales: uno que se refiere al alcoholismo del Sr. M. y el otro que se refiere a la dependencia de la Sra. M. El Sr. M. se relaciona con la Sra. M. a través de la conducta alcohólica. Esta forma de relación incluye entre otras cosas, el menosprecio y no reconocimiento del aporte de la Sra. M. en la relación. Este patrón de interacción parece permitirle al Sr. M. continuar el legado paterno manteniéndose leal con su familia de origen al estar repitiendo pautas similares a las del hogar de sus padres. A su vez, la Sra. M. demuestra lealtad invisible a su familia de origen y repite pautas relacionales de sus padres al estar casada con un hombre con problemas de alcohol y al asumir el rol de una persona dependiente, sufrida y víctima del esposo.

Esta lealtad a la familia de origen del Sr. y la Sra. M., lealtad por supuesto invisible, parece servir como una forma de manejar deudas y obligaciones existenciales que el Sr. y la Sra. M. tienen con sus respectivas familias al haberlas "abandonado", inmigrando a los EE.UU. Parece ser que el conflicto de lealtad se agudiza para la pareja al encontrarse ésta en "mejores" circunstancias de las que está el resto de la familia en el país de origen. Dicha lealtad con la familia de origen plantea intereses que están en contradicción con los intereses surgidos para la familia M. en los EE.UU., como consecuencia de residir en una cultura diferente. Una forma de mantenerse leal o de retribuir a la familia de origen implica reproducir en la relación de pareja patrones destructivos usados en las familias de origen. La actualización de esta dinámica le permite a la pareja mantenerse en un estado de no-adaptación y evitar el establecer vínculos más permanentes con el nuevo ambiente social, reflejando también una lealtad invisible a la cultura y país de

origen. Este conflicto de lealtad parece haberse manifestado con un incremento de los síntomas de alcoholismo, depresión y desajuste matrimonial.

La intervención terapéutica se dirigió a crear conciencia de estos patrones intergeneracionales y a establecer un plan para desarrollar nuevos vínculos con las familias de origen. Los nuevos vínculos representan formas más concretas y adaptadas de expresar lealtad y sirven como retribución con la cual el Sr. y la Sra. M. pueden balancear las obligaciones que tienen con sus respectivas familias. El Sr. y la Sra. M. iniciaron la toma de conciencia de los patrones de relación interpersonal que ellos estaban manteniendo entre sí a través del diálogo que surgió sobre la pérdida del hijo primogénito. Tal diálogo abrió las puertas para examinar, por un lado, los sentimientos de culpabilidad que ambos tenían, y por otro, el distanciamiento que tales sentimientos de culpabilidad produjeron en las relaciones entre la pareja, y de la pareja con sus respectivas familias de origen. Dicho diálogo culminó con la decisión que la pareja tomó de casarse por la iglesia. Esta decisión, por una parte, representa el deseo de estrechar los vínculos entre la pareja, y por otra es una forma concreta de retribuir a las familias de origen y de establecer vínculos más cercanos con ellas.

### **Evaluación del tratamiento**

Los efectos de la intervención fueron evaluados midiendo (a) el nivel de depresión y (b) el nivel de funcionamiento familiar. Estas dos áreas fueron examinadas en cuatro ocasiones: al comienzo —en la primera y tercera entrevista; al final del tratamiento —en la décima entrevista; y cinco meses después del tratamiento —en la décima primera entrevista.

### **Evaluación del nivel de Depresión**

El nivel de depresión fue evaluado usando la "Escala de Depresión de Estudios Epidemiológicos (CESD)", desarrollada por Radloff (1977) para investigar síntomas de depresión en

poblaciones estadounidenses<sup>3</sup>. Los puntajes de esta escala tienen valores que se extienden de “0” a “60”, siendo “0” ausencia de depresión y “60” un máximo de síntomas depresivos, con una media de 16 y una desviación estandar de 8. Los resultados obtenidos por la pareja en esta prueba aparecen en la tabla 1.

Estos resultados indican que hubo una marcada reducción de los síntomas depresivos en el Sr. M. de la primera a la última administración (esta última cinco meses después del tratamiento), mientras que en la Sra. M. los síntomas se redujeron notablemente después de la primera administración, pero mostraron un incremento cinco meses después de concluirse la terapia. Dichos resultados parecen indicar que el tratamiento produjo un desbalance en la homeostasis del sistema familiar. La mejoría experimentada por el Sr. M. resultó en un aumento en el nivel de depresión de la Sra. M. Desde el comienzo hasta el final de la terapia, ambos mostraron una notoria reducción en el nivel de depresión quizás como consecuencia del impacto que produjo la intervención inicial (movilización de fuentes de apoyo social en un momento especialmente crítico para la familia).

#### *Evaluación del Funcionamiento Familiar*

El funcionamiento familiar fue evaluado usando la “Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES)”, diseñada por Olson, Sprenkle & Russell (1979). Este instrumento mide dos parámetros de las relaciones familiares: “cohesión”, esto es, el nivel de dependencia o independencia que existe entre los

<sup>3</sup> Debemos aclarar que los métodos y técnicas empleados no han sido estandarizados en la población latina. Así por ejemplo, se han encontrado apreciables diferencias en los puntajes obtenidos en el CES-D aplicados en poblaciones anglosajonas y latinas. Lang, Muñoz, Bernal y Sorensen (1982) encontraron que en una muestra en la comunidad latina de San Francisco, California, a la cual se le administró el CES-D el promedio de la muestra fue 13,5 (masculino = 10,4; femenino = 16,1). En contraste, el promedio de tres muestras en una población anglosajona indicó valores más bajos (M = 9,25, 8,17 y 7,94 respectivamente).

#### TERAPIA FAMILIAR INTERGENERACIONAL

*Tabla 1*

Puntajes obtenidos por el Sr. y la Sra. M. en la escala de depresión (CES-D) en las cuatro administraciones

| <i>Administración</i> | <i>Sr. M.</i> | <i>Sra. M.</i> |
|-----------------------|---------------|----------------|
| Entrevista No. 1      | 30            | 12             |
| Entrevista No. 3      | 18            | 8              |
| Entrevista No. 10     | 19            | 5              |
| Entrevista No. 11     | 3             | 16             |

miembros de la familia; y “adaptabilidad”, es decir, el nivel de flexibilidad o rigidez de la familia para adaptarse al medio ambiente.

Un puntaje alto en “cohesión” (por encima de 73.1) indica aglutinamiento, es decir, un alto nivel de dependencia entre los miembros de la familia. Un puntaje bajo (por debajo de 56.9) indica desligamiento o escasa relación entre los miembros del sistema familiar. Este parámetro tiene una media de 65 y una desviación estandar de 8.4. Puntajes por encima de 73.1 y por debajo de 56.9, en una población anglo-norteamericana indican patología en el funcionamiento familiar.

Un puntaje alto en adaptabilidad (por encima de 56.1) indica relaciones familiares caóticas es decir, excesivos cambios en las relaciones; mientras que un puntaje bajo (por debajo de 43.9), indica rigidez o inflexibilidad para aceptar nuevos patrones de adaptación familiar. Este parámetro tiene una media de 50 y una desviación estandar de 6.6. Puntajes por encima de 56.1 y por debajo de 43.9, indican un funcionamiento patológico.

Los resultados de la prueba de cohesión y adaptabilidad familiar aparecen en la tabla 2.

Tabla 2

Puntajes obtenidos por la pareja en la prueba de cohesión y adaptabilidad familiar (FACES) en las cuatro administraciones

| Administración    | Sr. M. | Sra. M. | Pareja |
|-------------------|--------|---------|--------|
| Cohesión          |        |         |        |
| Entrevista No. 1  | 80     | 54      | 68.5   |
| Entrevista No. 3  | 74     | 75      | 74.5   |
| Entrevista No. 10 | 72     | 75      | 73.5   |
| Entrevista No. 11 | 74     | 80      | 77.0   |
| Adaptabilidad     |        |         |        |
| Entrevista No. 1  | 56     | 56      | 56.0   |
| Entrevista No. 3  | 63     | 64      | 63.5   |
| Entrevista No. 10 | 65     | 56      | 60.5   |
| Entrevista No. 11 | 55     | 67      | 61.0   |

En el área de adaptabilidad no se encontraron mayores variaciones entre los puntajes. Tales puntajes, de acuerdo a las normas establecidas con familias norteamericanas, parecen indicar que las relaciones familiares tienden a ser más de tipo caótico, es decir, dichas relaciones no mantienen un patrón consistente. Los resultados en el área de cohesión indican que la familia tiende a funcionar en una forma más bien aglutinada y dependiente, siendo el Sr. M. el que parece tener más necesidad de apoyo. Después de iniciado el tratamiento (tercera entrevista), hubo un incremento en el puntaje de cohesión que se mantuvo hasta terminar el tratamiento (décima entrevista). Este incremento parece indicar que después de iniciado el tratamiento, la pareja tendió a orientarse hacia relaciones más aglutinadas e interdependientes (dependencia mutua), incremento que perduró cinco meses después del tratamiento. Esta orientación hacia relaciones "aglutinadas" parece indicar que

una vez que la ansiedad de la crisis inicial se redujo, la familia retornó al nivel usual de relaciones interpersonales. A pesar de que no fue mayor el cambio durante el período de la terapia, el puntaje en cohesión incrementó una desviación estandar de la primera a la última entrevista. De acuerdo con las normas establecidas por Olson, Sprenkle & Russell (1979), con poblaciones norteamericanas, los puntajes tanto en adaptabilidad como en cohesión en esta familia sugieren un nivel patológico de relación familiar.

Estos resultados parecen indicar que la intervención terapéutica promovió un funcionamiento más interdependiente o "aglutinado" en el sistema familiar. Es posible que a pesar de que este nivel de "aglutinamiento" es interpretado como un nivel patológico de funcionamiento familiar de acuerdo a las normas estadounidenses, realmente, este puntaje está representando un nivel normal de funcionamiento familiar en el contexto de los valores culturales latinoamericanos. Este puntaje parece estar reflejando lo que algunos autores llaman "familismo" es decir, una orientación hacia un estrecho vínculo en las relaciones familiares. Estos resultados indican que es necesario establecer normas adecuadas que se ajusten al sistema de valores latinoamericanos y que reflejen en forma más precisa diferentes niveles de funcionamiento familiar en hogares latinos.

Cinco meses después del tratamiento, la pareja indicó que los síntomas presentados por el Sr. M. y que motivaron la consulta inicial no habían vuelto a manifestarse, tales como depresión, ataques de asma, ideas suicidas, ideas catastróficas. La pareja igualmente manifestó que el acercamiento en la relación matrimonial se había incrementado. A pesar de los progresos en la relación familiar, la pareja pareció experimentar una recaída. El Sr. M. llegó un día embriagado a la casa después de más de un año de abstinencia de alcohol. Tal recaída coincidió con el séptimo aniversario de la muerte del hijo primogénito. Esta "coincidencia" fue discutida con la pareja como la única forma que el Sr. y la Sra. M. encontraron para celebrar el aniversario de la muerte de su hijo. Esta discusión facilitó no solamente un entendimiento más profundo de la

dificultad que ambos tenían para hacer el duelo, sino que le ayudó a la familia a encontrar formas más adecuadas de hacer dicho duelo. Adicionalmente, la familia, y en particular el Sr. M. recibieron un merecido reconocimiento de nuestra parte por los esfuerzos realizados en mantener la sobriedad del Sr. M. por tan largo tiempo. La familia fue estimulada para que continuara con tales esfuerzos.

### Conclusiones finales

Entre las técnicas utilizadas en el tratamiento de esta familia pareció definitivo, primero que todo, responder a la crisis inicial, proporcionándole a la pareja los medios necesarios para que pudiera responder a problemas inmediatos de tipo médico, educacional, legal, y de apoyo social. Esta intervención produjo una reducción del alto nivel de ansiedad en que se encontraba la familia. Una vez "resuelta" la crisis, la familia estuvo en condiciones más adecuadas de "empezar" la terapia. Un elemento decisivo en la terapia fue el crear conciencia de los patrones de relación interpersonal que la familia estaba utilizando, y la similitud que dichos patrones tenían con los patrones relacionales utilizados en las respectivas familias de origen. La toma de conciencia de estos factores de la relación interpersonal facilitó el análisis del sistema de deudas y derechos que el Sr. y la Sra. M. tenían con sus respectivas familias, al mismo tiempo que se establecieron formas más adecuadas de retribución al legado familiar. El alcoholismo del Sr. M. y la excesiva dependencia de la Sra. M. parecían estar enmarcadas en el sistema que la familia M. había establecido para mantenerse invisiblemente leales con las familias de origen. Una vez que este sistema de retribución fue revelado, el Sr. y la Sra. M. parecieron estar en mejores condiciones de adoptar nuevos y más adaptados sistemas de retribución y abandonar patrones insanos, de interacción. Esperamos que este trabajo haya respondido a nuestro objetivo inicial de estimular el intercambio de información entre los terapeutas de familia que trabajan con familias latinoamericanas tanto en Norteamérica como en Sudamérica.

### Resumen

En el trabajo clínico con familias latinas recién emigradas a San Francisco, California, que es expuesto, cuatro aspectos son analizados en el tratamiento clínico: 1) Marco teórico, 2) Contexto familiar, 3) Desarrollo de hipótesis sistémicas-familiares, 4) Evaluación de la intervención psicoterapéutica. En el marco teórico se exponen principios, conceptos y técnicas de la Terapia Familiar Intergeneracional. Las hipótesis terapéuticas se elaboran en base al análisis del contexto familiar, partiendo del marco teórico de terapia intergeneracional. En estas hipótesis se establecen conexiones entre síntomas y ambiente familiar. Las hipótesis se confirman o desconfirman en el curso del proceso terapéutico. La intervención terapéutica está orientada a reducir manifestaciones sintomatológicas e incrementar el nivel de funcionamiento de las relaciones familiares por una parte, y de las relaciones de la familia con el nuevo ambiente social, por otra. Finalmente, los principios teóricos expuestos son analizados a través de un caso clínico de terapia familiar con una familia emigrada de Centro América y residente en EE.UU. desde hace tres años. La evaluación de la intervención terapéutica se lleva a cabo antes, durante y después del tratamiento terapéutico, usando escalas e inventarios diseñados para tales propósitos.

### Summary

In the clinical work with latin families recently emigrated to San Francisco, California, which is described, four aspects are analyzed in the clinical treatment: 1) The theoretical framework, 2) The family context, 3) The development of hypotheses of family systems, 4) The evaluation of psychotherapeutic intervention.

In the theoretical framework, the principles, concepts and techniques of intergenerational family therapy are described. The therapeutic hypotheses are elaborated on the basis of an analysis of the family context, starting from the theoretical framework of intergenerational therapy. In these hypotheses, corrections are established between symptoms and the family context. The hypotheses are verified or refuted in the course of the therapeutic process.

The therapeutic intervention is orientated to reduce the symptoms and increase the level of functioning of family relationships on one hand

ard the relationships of the family with a new social environment on the other.

Finally, the theoretical principles described, are analyzed through a clinical case of family therapy with a family emigrated from Central America and resident in the United States for three years. The evaluation of the therapeutic intervention was made before, during and after the therapeutic treatment, using scales and inventories designed for such purposes.

## Bibliografía

- BERNAL, G., "Cuban Families". En M. McGoldrick, J. Pearce, J. Giordano (Eds.), *Ethnicity and Family Therapy*. New York; Guildford Press, 1982.
- BERNAL, G.; "Parentification and De-parentification in Family Therapy". En A. S. Gurman (Ed.), *Questions and Answers in Family Therapy*. New York; Brunner/Mazel, 1982a.
- BERNAL, G., & FLORES-ORTIZ, Y. "Latino Families in Therapy; Engagement and Evaluation." *Journal of Marital and Family Therapy*, 1982, 8, (3), 375-365.
- BERNAL, G., & ALVAREZ, A. I.; "Culture and Class in the Study of Families". En C. Falicov (Ed.), *Cultural Perspectives in Family Therapy*, Rockville, Md.; Aspen Press, 1983.
- BERNAL, G., & FLORES-ORTIZ, Y. "Intergenerational Family Therapy with Chicano and Mexican Immigrant Families". En C. Hatcher (Ed.), *World of Family Therapy*, San Francisco, CA; Jossey-Bass, en imprenta.
- BOSZORMENYI-NAGY, I. & SPARK, G. *Invisible Loyalties*. New York; Harper & Row, 1973.
- BOSZORMENYI-NAGY, I. & ULRICH, D. "Contextual Family Therapy". En A. Gurman & D. Kniskern (Eds.), *Handbook of Family Therapy*. New York; Brunner/Mazel, 1981.
- HALEY, J. *Problem Solving Therapy*. San Francisco, CA; Jossey-Bass, 1978.
- LNAG, J. G., MUÑOZ, R. F., BERNAL, G., & SORENSSEN, J. L.; "Quality of Life and Psychological Well-Being in a Bicultural Latino Community". *Hispanic Journal of Behavioral Sciences*, 1982, 4, (4), 433-450.
- MACIAS, R. F.; "U.S. Hispanics in 2000 A.D. - Projecting the Number. *Agenda*, 1977, 7, 16-20.

## TERAPIA FAMILIAR INTERGENERACIONAL

- MINUCHIN, S.; *Families and Family Therapy*, Cambridge, Mass.; Harvard University Press, 1974.
- OLSON, D. H., SPRENKLE, D., & RUSSELL, C.; "Circumplex Model of Marital and Family Systems I; Cohesion and Adaptability Dimensions. *Family Process*, 1979, 18, 3-28.
- RADLOFF, L. S.; "The CES-D; A Self-Report Depression Scale for Research in the General Population." *Applied Psychological Measurement*, 1977, 1, 385-411.
- SLUZKI, C. E. "Migration and Family Conflict." *Family Process*, 1979, 18, 379-390.
- U. S. BUREAU OF THE CENSUS. *Persons of Spanish Origin by State: 1980*, Washington, D.C., 1982.
- ZUK, G. H.; *Family Therapy: A Triadic Based Approach*. New York; Behavioral Publications, 1971.



centro médico  
psicológico  
buenos aires

Director: Dr. Octavio Fernández Mouján  
Secr. Asistencia: Dr. Sergio Bruzzo I.  
Secr. Docencia: Lic. Herminia Ferrata  
Secr. Editorial: Dra. Ana M. Goldberg

**ASISTENCIA.** Deptos. asistenciales: niños, adolescentes, adultos, 3ra. edad, grupos, familias, psicoterapias breves, psiquiatría dinámica, etc. Comunidad Terapéutica de niños. Comunidad Terap. de adolesc. y adultos. Plan de extensión asistencial (honorarios reducidos). **DOCENCIA.** Escuela de Post-Grado de Psicología Clínica y Psiquiatría Dinámica. Seminarios (abierta la inscripción 2do. cuatrím.) Escuela de Agentes de Salud. **PREVENCION.** Talleres de reflexión. Prevención en instituciones. Orientación Vocac. **EDITORIAL.** Revista "Cuestiones". Tema del No. 1: Identidad - aparece en agosto.

Oro 2240, 1425 Buenos Aires

Tel. 773-8289 y 772-8851

# CERF

*Centro para el estudio de  
las relaciones familiares*

**Dirección:** Lic. Alberto González      Lic. Olga Benzádon de González

## ESCUELA PARA TERAPEUTAS FAMILIARES

IV AGOSTO. CURSO BASICO: ENTREVISTA FAMILIAR INICIAL. Martes de 13 a 15,30 hs. Conceptos de base para el DIAGNOSTICO. PAUTAS precisas para su realización. Coordinador: Psicóloga Olga B. de González.

V SEPTIEMBRE. SEMINARIO TEORICO: MODELOS CIBERNETICOS Y MODELOS BASADOS EN LOS SISTEMAS VIVIENTES. Martes de 13 a 15.30 hs. Profesor Gregorio Klimovsky. Ingeniero Víctor Bronstein. Psicólogo Alberto González.

CURSO: NARRACION Y CUENTO. Lunes de 12 a 14 hs. Instrumentación de Terapia Familiar en pacientes con cáncer. Dr. Julio Correa.

VI OCTUBRE. CURSO ESPECIALIZADO: EL GRUPO FAMILIAR Y EL "NIÑO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE". Martes de 13 a 15.30 hs. Coordinador: Psicóloga Olga B. de González. Equipo Docente del C.E.R.F.

VII NOVIEMBRE. CURSO ESPECIALIZADO: MODELO DE FAMILIA PSICO-SOMATICA. Martes de 13 a 15.30 hs. Coordinador: Psicólogo Alberto González. Equipo Docente del C.E.R.F.

INFORMES: 824-1188 de 8.30 a 17.30, Soler 3765, 4to. "J", Nro. 18

## CENTRO

de

D ocencia

I nvestigación y

A sistencia

P sicológica

**Directores:**

Dr. Roberto P. Montanelli

Dr. Carlos N. Díaz Usandivaras

**PSICOPATOLOGIA DE ADULTOS**

**PSICOPATOLOGIA INFANTO JUVENIL**

**PISCOPEDAGOGIA Y CLINICA DEL APRENDIZAJE**

**PSICOTERAPIA DEL GRUPO FAMILIAR**

**DOCENCIA - INVESTIGACION**

**ACASSUSO 907 - SAN ISIDRO - T.E. 743-8645 - Bs. AS.**

**Diálogo entre el Licenciado Jorge Colapinto y el Dr. Alfredo Canevaro, Buenos Aires, 1983**

**Dr. Canevaro:** Quisiera que habláramos sobre tu experiencia en training en los EE.UU. Mi deseo sería que me contaras cómo se trabaja en la Philadelphia Child Guidance Clinic, cuáles son los criterios actuales de training, las pautas con las cuales en general se manejan y en especial vos, en tus desarrollos personales.

**Lic. Colapinto:** O.K. Desde que yo empecé a trabajar en training en EE.UU., siempre hubo una especie de tensión entre dos posiciones alternativas acerca de cómo entrenar gente. Esta tensión todavía sigue, también el diálogo y la discusión. Supongo que con características similares a las que se pueden plantear acá. Por un lado está la tendencia a centrar el training en lo conceptual, en la teoría, en cómo leer las realidades familiares y en lo que sería la teoría de la técnica. Este es un polo de la tensión, el otro polo es la cuestión de la enseñanza de técnicas; lo que serían las recetas de cómo intervenir en los distintos tipos de situaciones. En general el público norteamericano, los terapeutas que quieren ser entrenados, por características tradi-



cionales de la sociedad americana tienden más bien a la demanda del segundo tipo: cómo se hacen las cosas. La gente que en general se acerca a los institutos de training son quienes a través de un libro, de un workshop o de ver una demostración, quedan muy impresionados, muy impactados con algunos de los grandes maestros, Minuchin, Haley o Whitaker o quien sea y entonces quieren saber cómo se hace eso, quieren aprender la técnica, esa es la solicitud. Algunos de los centros de entrenamiento responden directamente a este pedido e incluso cuando el terapeuta pide conceptualización, la respuesta que se da desde un instituto que está centrado en la enseñanza de la técnica es: no, tiene que aprender cómo hacer, la comprensión va a venir después.

*Dr. Canevaro:* ¿Enfocan más la segunda orientación?

*Lic. Colapinto:* Lo que te quiero decir es que hay institutos o centros de enseñanza de los dos tipos, los que están más centrados en lo conceptual y usan la experiencia clínica como demostración de lo conceptual, como ejemplo de lo conceptual y los que están centrados en dirigir al aprendiz a producir ciertas intervenciones: haga esto, no haga esto, haga aquéllo. El porqué, no se discute o se discute después.

*Dr. Canevaro:* De cualquier manera las dos orientaciones son o representan más el aspecto cognitivo del aprendizaje. ¿Cómo se hace con los aspectos emocionales del aprendiz?

*Lic. Colapinto:* En realidad no es que sean las dos un aspecto cognitivo, yo creo que la primera representa la aproximación cognitiva, la segunda representa más bien una aproximación experiencial en el sentido de tener un cierto comportamiento terapéutico, como por ejemplo: “No deje hablar a la señora” o “acerque su silla al padre”, sin entender, sin haber discutido previamente por qué. Esto es importante.

*Dr. Canevaro:* Yo me refiero a lo emocional profundo, a la historia del terapeuta, ¿cómo está condicionado en su relación?, ¿cuáles son los motivos que lo impulsan a hacer terapia familiar? Porque no todo el mundo quiere hacer terapia familiar, no todo el mundo puede o no todos lo toleran. ¿En qué medida el componente personal es trabajado en training?

*Lic. Colapinto:* Ahí hay también distintas escuelas de pensamiento, en cuanto al training, hay centros donde el trabajo del terapeuta con su propia familia es fundamental, toda la línea de Murray Bowen, por ejemplo, pone mucho énfasis en que el terapeuta tiene que hacer una revisita a su familia de origen, incluso irse tan lejos en las generaciones como sea posible la exploración.

*Dr. Canevaro:* Algunos trabajan también con la familia actual, ¿no?

*Lic. Colapinto:* Algunos trabajan con la familia actual, yo de esto no estoy muy al tanto, sé que ocurre pero no sé quiénes son. Siguiendo en el gradiente, hay centros donde las dinámicas emocionales del terapeuta y sus aspectos personales que traen de su historia o de su entorno actual, son introducidos en el momento del aprendizaje, en las discusiones grupales, aunque no necesariamente a través del trabajo sistemático como puede hacer Bowen (mandar al terapeuta a ver a su familia), pero sí se habla de esas cosas en los grupos de enseñanza.

*Dr. Canevaro:* ¿Hay alguna otra técnica en la que el aprendiz o el terapeuta en situación de aprendizaje, refiere lo que le está pasando?

*Lic. Colapinto:* Sí, es un equivalente de lo que sería el análisis de la contratransferencia; “¿qué puede ser que yo esté poniendo de lo mío?”, “¿por qué me puede resultar a mí difícil trabajar con una familia donde hay un hijo parentalizado en relación con el posible hecho que yo haya sido un hijo parentalizado en mi propia familia de origen? Esto es una cosa que nosotros no hacemos.

*Dr. Canevaro:* ¿Deliberadamente?

*Lic. Colapinto:* Nosotros deliberadamente, a lo más que llegamos es a reconocer la existencia de un estilo personal en el terapeuta, lo nombramos, lo identificamos, le podemos decir a un terapeuta: “tu estilo es trabajar a distancia y en el caso de esta serie de familias te puede convenir practicar cómo acercarte” o a la inversa “tu estilo es trabajar muy desde adentro de la cosa y te puede convenir entrenarte en tomar más distancia” pero, no avanzamos más allá de eso, no vamos a las raíces

históricas, ni siquiera a las raíces situacionales para hablar de la familia actual del terapeuta.

*Dr. Canevaro:* Otro punto que me interesa es...

*Lic. Colapinto:* Perdoname que te quiero agregar otra cosa. En ese sentido y es interesante, hay algunos paralelos. El tema de los paralelos entre la terapia y el training es todo un tema, donde cada uno tiene distintas posiciones. En ese sentido hay algunos paralelos entre la forma nuestra de terapia y la forma nuestra de aprendizaje. Concretamente la identificación de una pauta de conducta como algo que puede estar relacionado a otro contexto, a la familia de origen, incluso a la familia actual, cumple la función de proveer un marco que sea operativo, que sea funcional, que sea práctico, por ejemplo: a mí me puede resultar práctico, en el proceso de aprendizaje, decirle a un estudiante: "tus características son, trabajar con poca distancia, lo cual por algún comentario casual que hiciste probablemente tenga que ver con cómo fueron las cosas en tu familia de origen y ahora entonces lo que tiene que hacer es practicar esta otra cosa", con lo cual yo le doy una especie de marco evolutivo para que ponga su propio estilo en perspectiva y acepte la posibilidad de alternativas. Se entiende que esto sea así por lo que ocurrió antes, pero lo decisivo es que hay otras formas posibles de intervenir. Esto es muy parecido al uso que nosotros hacemos de la historia en terapia estructural, donde usamos la historia para validar el presente, "se comprende que ustedes hayan llegado a esta situación por todo lo anterior" pero no caemos en la cosa de la historia como destino, como cosa que ya te predetermina o te limita la posibilidad de alternativa. En ese sentido hay un paralelo entre lo que es terapia y lo que es aprendizaje.

*Dr. Canevaro:* Acerca de la figura del instructor. Vos por ejemplo, en charlas que hemos tenido, hablás de Minuchin con un gran respeto, una gran devoción y por ejemplo, como instructor, el rol que vos desempeñás con tus alumnos ¿cómo lo manejas, cuál es el concepto sobre el cual te asentás? ¿establecés una relación de simpatía o incluso de antipatía personal

vivida y relacionada o tratás de ser aséptico?, ¿qué paralelo hay entre la terapia y el aprendizaje también en este sentido?

*Lic. Colapinto:* Para mí en la terapia el elemento de *joining*, establecer una relación de simpatía con la familia, es muy importante, eso es parte del modelo estructural. En el contexto de aprendizaje el *joining* no es tan necesario, no lo es dedicarle tanto tiempo a ese elemento de establecer una relación de simpatía, de confort entre el instructor y el terapeuta. El motivo es contextual y posiblemente específico de la situación en la que yo enseño, donde la gente viene porque quiere aprender, ya ha cerrado sus posibilidades. No es como la familia que hay que ganarla, esta es una persona que ha tomado su decisión, que viene a este curso, que por lo general es caro, que ha tomado el compromiso por un año, que ya lo ha pagado, sería similar a la relación de consulta en terapia, donde el consultor no tiene que hacer el *joining* de la misma manera que el terapeuta porque ya viene con toda la figura del experto que empieza desde un *joining* ya trabajado, por el que hizo el pedido de la consulta. En lo que sí se parece el aprendizaje a la terapia es en que mi relación con el estudiante, sin establecer necesariamente un nexo de simpatía personal, sí incluye el elemento del desafío, no en el sentido de confrontación sino en el sentido de empujar a hacer más cosas o cosas distintas, "esto es lo que tenés que hacer, no me digas que no lo podés hacer, esto es lo que tiene que ocurrir, esto es lo que hace falta, pensá cómo lo podés hacer", eso es parecido a la terapia. Otro elemento es una especie de disciplina que yo aplico, eso también es mi versión personal de la enseñanza de la terapia estructural que tiene que ver con lo que hablábamos antes de los extremos, enfoque en lo conceptual, enfoque en lo técnico. Yo me rehúso, en principio, a enseñar técnica, a veces no lo puedo evitar pero siempre trato de evitarlo. Es muy frecuente que el estudiante me pregunte: "¿cómo se hace esto; cómo lo hago, cómo hago para movilizar a esta persona a hacer esta cosa que no quiere hacer o que el otro no la deja hacer?; ¿cómo consigo que el papá proteja la relación privilegiada con el hijo de una intromisión de la madre; qué técnica puedo usar;

qué les puedo decir; cómo puedo disponer los muebles de la habitación para que eso pase?" Ante ese pedido, sistemáticamente respondo tratando de hacer que el terapeuta piense y sobre lo que yo trato de intervenir, lo que yo trato de manipular, si se quiere, no es la conducta del terapeuta tanto como la percepción del terapeuta. No la teoría, no es que trato de que conceptualice y piense en términos teóricos. Es más bien la percepción, la captación de la situación. Por ejemplo yo puedo diagnosticar que el terapeuta está atascado en tratar de conseguir que la mamá, que se queja de su marido porque él no sigue una disciplina lo suficientemente estricta con el hijo que tiene una deficiencia de aprendizaje y tiene que ser constantemente estructurado y estimulado, a que no lo persiga tanto al señor, o bien que el señor se defienda mejor de su señora. Entonces el terapeuta puede estar buscando por ese lado infructuosamente y pensando qué técnicas puede usar para producir el cambio de una u otra manera. Lo mejor que yo le puedo dar al terapeuta en esa situación, es la posibilidad de pensar que cuando el señor lo ayuda al chico a atarse los cordones de los zapatos, en contra de las exigencias de la mujer que quiere que deje al chico atarse los cordones solo, eso se puede leer desde un ángulo como un favorecimiento de la regresión, pero también desde otro ángulo se puede ver como una cuestión de espontaneidad, de disfrute, el chico está entrando en una edad en que el padre piensa: bueno, todos estos años trabajando tan fuerte para educarlo a este chico, ahora yo quiero disfrutarlo. Entonces ahí se abre la posibilidad de ver al padre no como el pobre tipo que está a la defensiva de una iniciativa de la mujer sino como el tipo que puede introducir la espontaneidad, la alegría y el disfrute en la familia y la noción de que no todo es trabajo duro para armar este rompecabezas que nos ha deparado el destino. Ese sería un ejemplo en el que yo trato de que el terapeuta pueda percibir la situación de una manera distinta, que tenga una nueva gestalt, con la idea de que si la tiene se le va a ocurrir la intervención adecuada.

*Dr. Canevaro:* Es interesante lo que vos decís. A mí me sucede con alumnos, con quienes promuevo un abordaje inge-

nuo de la familia, ver que los sociólogos que no tienen una experiencia clínica previa, tienen un abordaje mucho más enriquecedor a mi gusto que el de los psicólogos.

*Lic. Colapinto:* ... a mí me pasa allá con los asistentes sociales.

*Dr. Canevaro:* Es interesante porque están quizás habituados al abordaje mucho más natural y menos estereotipado de los problemas clínicos.

*Lic. Colapinto:* Perciben estructuras.

*Dr. Canevaro:* Exactamente, ¿eso también vos lo has percibido?

*Lic. Colapinto:* Sí, tal cual. Hay gente que ya tiene el entrenamiento profesional para pensar en estructuras y que le resulta incluso difícil pensar en individuos y eso en este tipo de modelo es útil.

*Dr. Canevaro:* Y además es un contacto mucho más espontáneo que el que tiene generalmente un terapeuta, psicólogo o psiquiatra que tiene un contacto de una manera ya un poco artificial.

*Lic. Colapinto:* ... y tiene que hacer la traducción ...

*Dr. Canevaro:* ... claro, entonces se traduce por una falta de empatía quizás momentánea.

*Lic. Colapinto:* Ese es otro tema que está en relación con lo que hemos estado trabajando acá, con los grupos, el grupo chico y el grupo grande, que es el asunto de lo que yo llamo, los modelos útiles y los modelos inútiles de pensamiento. Una de las cosas que yo hago con mis alumnos y en ese sentido estoy tomando posiciones cada vez más radicales es tratar de que piensen solamente en los términos que podrían compartir con la familia. Lo que yo he notado mucho es que, por ejemplo cuando mis alumnos empiezan a percibir demasiadas coaliciones, luchas de poder, saboteos dentro de la familia, o que la mamá está haciendo esto para jorobarlo al padre, se ven en un brete, se quedan muy atados de manos porque esos son contenidos que para poder volcárselos a la familia, los tienen que traducir, pasarlos en limpio y decírselos a la familia de una manera que la familia los pueda entender. Entonces, en térmi-

nos de neuronas disponibles, ocurre que el terapeuta está trabajando con una cantidad de información, que tiene que estar reprimiendo o suprimiendo y traduciendo a la familia en términos aceptables. Por eso yo estoy desde hace un par de años embarcado en una constante tarea de forzar a mis alumnos a que piensen en términos positivos acerca de la familia porque de esa manera pueden estar más libres de ser espontáneos y de hablar directamente, sin sentir que tienen que estar ocultando su conocimiento. En términos de percepción otra vez, si mi alumno está percibiendo que la mamá interrumpe la interacción entre el padre y el hijo porque piensa que el padre es un animal que le está haciendo daño al hijo, yo voy a tratar de que el alumno más bien perciba que la mamá interrumpe esa transacción como una manera de proteger a los dos, al hijo de la brusquedad del padre pero también al padre de la desilusión porque el hijo no cumple o porque el hijo no es como debiera ser. Con la idea de que si el terapeuta ve a la familia de una manera benevolente, si ve todos estos intentos de acomodación como básicamente inspirados en buena voluntad aunque el efecto sea desastroso, entonces su comunicación con la familia, su diálogo con la familia va a ser mucho más fácil, el terapeuta va a estar mucho más suelto en la sesión y no va a estar maquinando connotaciones positivas, "¿cómo hago yo para traducir esta situación que es objetivamente espantosa en algo que no suene tan feo?" Yo prefiero empezar antes y que no lo vea como una situación espantosa objetivamente, que lo vea como una situación en la que todo el mundo está tratando de poner el hombro y ayudar y el resultado de la combinación es desafortunado, pero las intenciones de base son buenas.

**Dr. Canevaro:** ¿Qué hacés, luego de lograda esa espontaneidad, en el sentido de la soltura con que el terapeuta pueda manejar a su libre arbitrio la sesión haciendo gala de recursos espontáneos pero de los cuales emerjan conductas terapéuticas evidenciables? Porque los que tenemos más experiencia vemos, que no programamos tanto el contacto con una familia sino que en esa interacción espontáneamente van surgiendo los grandes lineamientos que es lo que los alumnos no entienden bien

de dónde han surgido. Mi tendencia personal sería promover ese estilo de interacción. Me gustaría saber vos qué pensás. Lograda ya la espontaneidad después hay que ver qué se hace con esta espontaneidad, porque no hay que confundirla con una norma social.

**Lic. Colapinto:** Es cierto, lo que pasa es que la espontaneidad no es lo primero que se logra. Yo planteo la espontaneidad, desde el principio de la relación de aprendizaje como objetivo, como ideal, como faro. Mis alumnos se convierten en espontáneos después que terminaron el ciclo de aprendizaje, cuando puedo verlos trabajar después que han aprendido, entonces hacen cosas espontáneas, pero hasta el último día de estar en la situación de aprendizaje tienen esa relación de: ¿qué opina el otro de lo que yo estoy haciendo? Hay una especie de tensión creativa que también tiene que ver con las características del modelo, que es que cada sesión que yo superviso tiene un objetivo estructural. Cuando empieza una sesión, el terapeuta y yo nos ponemos de acuerdo en que es necesario lograr una cierta configuración. Entonces la espontaneidad del terapeuta está regulada por el objetivo que tiene que alcanzar. Yo les digo: podés usar las técnicas que quieras pero a esto tenés que llegar. En ese contexto pasan muchas cosas, pasa toda la negociación entre el terapeuta y el supervisor a través de la comunicación telefónica, etc. "pero decime cómo lo hago, qué tengo que hacer, estoy atascado", y allí es donde yo trato de cambiarle la percepción al terapeuta y trato de restringir al máximo el input técnico de "hacé esto o hacé lo otro". Pero lo que permanece como factor organizador, que en cierto modo modera la pura espontaneidad, es la meta estructural. Tenemos que llegar a una situación en que el papá permita que los dos hermanos mayores tengan su propia vida delimitada del resto de la familia y que estos puedan tener conversaciones en las que los padres no se metan, por ejemplo. Esto es un esquema muy simplificado, pero lo que ocurre muchas veces es que en mitad de la sesión tenemos que interrumpir y decir: esta sesión no va a terminar nunca si ese es el objetivo que perseguimos, conformémonos con otro o sigamos una vía distinta. Pero en

general es como que las sesiones están organizadas no en términos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino en términos de esto es 10, y para 10 hace falta 9, para 9 hace falta 8 y para 8 hace falta 7 y entonces empezamos al revés. El resultado es una tensión, es una pelea constante entre la demanda del terapeuta ("qué es lo que tengo que hacer ahora, qué es lo que sigue") y dejarlo al terapeuta librado a sus propios recursos por períodos de tiempo más o menos prolongados.

**Dr. Canevaro:** ¿Cómo juega el modelo de las experiencias terapéuticas compartidas que vos tengas con tus alumnos? Es decir, ¿hasta dónde vos utilizás tu experiencia clínica concreta compartida con ellos, también como modelo de aprendizaje? Viendo una familia en la cámara de Gesell y discutiendo con ellos. Es decir, hasta dónde permitís una identificación con tu estilo, con tu persona, con tus recursos, así como me imagino que muchos han hecho con Minuchin. ¿Qué grado o porcentaje de esto entra en el entrenamiento docente?

**Lic. Colapinto:** Depende de la formación previa del alumno y depende de cómo el alumno llegó. En ese sentido está habiendo un cambio. Hasta hace dos o tres años el 95% de los alumnos que recibíamos en la clínica era gente que había visto ya bastantes trabajos de Minuchin y de otra gente que trabaja con modelo estructural y tenía sus propias imágenes de cómo es el modelo estructural. Ahora estamos recibiendo cada vez más gente que se quiere entrenar en terapia familiar y sabe que la clínica es una de las mecas, pero no tienen demasiada noción ni siquiera visual de qué es el modelo estructural o por ahí han visto una o dos sesiones en video-tape pero no lo suficiente para formarse una idea de cómo funciona el modelo. Con este último grupo yo estoy haciendo algo que no hacía antes que es empezar el entrenamiento con sesiones de demostración, que yo hago con distintas familias y además los ayudo a ver video-tapes de otra gente como para que tengan una especie de marco de referencia de qué se trata esto. Mis demostraciones funcionan como modelo y la gente empieza a hacer cosas tipo mimesis, imitan mis gestos, no mi acento extranjero, pero imitan cosas. Lo que ocurre también y esto es una función del

contexto, es que la mayoría de nuestros alumnos, es un requisito para ser aceptados mientras se están entrenando, tienen una práctica bastante intensiva fuera de la clínica, en otras instituciones, unos pocos en práctica privada, la mayoría en otras instituciones. Como vienen a la clínica una vez por semana, eso ayuda a que haya una progresiva integración o mezcla del estilo personal de ellos con el que están imitando. No lo tengo muy estudiado este asunto pero me da la impresión como que hay un momento de choque inicial donde tratan de abandonar totalmente su estilo personal y seguir el modelo de algo que vieron, reproducir incluso sesiones enteras y a medida que va pasando el aprendizaje las cosas originalmente desechadas vuelven a aparecer en el estilo personal.

**Dr. Canevaro:** ¿Cómo es en un corte temporal? ¿Uds. tienen programado distintas fases en términos de tiempo? ¿Cuánto tiempo vos considerás que puede ser un entrenamiento suficiente, cuántos años lleva?, y si es una vez por semana ¿durante cuánto tiempo?

**Lic. Colapinto:** Yo pienso que, esto es personal, para el aprendizaje del modelo estructural, lo ideal son dos años a este ritmo (una vez por semana) y lo que es tanto o más importante —si me dan a elegir, yo sacrificaría el segundo año— es que después de eso, el terapeuta siga trabajando en equipo, con gente que comparte el modelo (trabajar en equipo quiere decir tener gente atrás del espejo) como disciplina. La experiencia que nosotros tenemos es que cuando viene gente a entrenarse, cambia mucho la cosa que vuelvan a una institución donde ya hay otro tipo que está haciendo lo mismo, o que vuelvan a un lugar donde son los únicos. No basta que haya otra gente que piensa sistémicamente, porque ya hay suficientes diferencias entre los distintos modelos sistémicos como para que haga falta el apoyo, el soporte de otro tipo que también piense "estructuralmente", no "paradojalmente", por ejemplo, para que el aprendizaje se mantenga, se desarrolle y se expanda. Hay que tener en cuenta que todas estas maneras de pensar son medio locas, van a contrapelo de la organización cotidiana de la vida para el 99% de la población y para el 70% de la profesión y

entonces mantenerlo vivo como disciplina requiere el apoyo de un grupo.

Lo de los dos años, es una cosa que ya lleva algún tiempo, yo creo que ya hace tres años que tenemos un segundo año en el programa de Externs en la clínica, donde se da un progresivo avance hacia los terapeutas jugando rotativamente el papel de supervisores unos de otros, entonces hay un corte de nivel bastante marcado entre el primero y el segundo año. El grupo de segundo año siempre se caracteriza porque ya trabajan con problemas específicos como enfermedades psicosomáticas, etc., o alguna otra característica, pero la constante es que siempre empiezan a supervisarse el trabajo unos de otros, como modelo de lo que tiene que ser la continuación de la formación.

*Dr. Canevaro:* También ustedes tienen residencia, en la que se trabaja todos los días de la semana.

*Lic. Colapinto:* Eso funciona en los veranos. Los programas de verano (hay uno en junio, otro en julio y otro en agosto) son tres semanas y media, cuatro días en la semana. Es un programa compactado, muy intenso, donde todo pasa en rápida sucesión, revisar textos, ver familias, clases teóricas, presentaciones de otros video-tapes, etc. Muy poco tiempo para procesar la experiencia mientras está ocurriendo. Eso es parte del proyecto.

*Dr. Canevaro:* ¿Y qué pasa con las familias que ven determinados alumnos, en términos de ligazón con ellos o continuación de la problemática?

*Lic. Colapinto:* En el caso del programa de Externs no hay problema porque en el período de un año la mayoría de las familias terminan y cuando se va acercando el final del curso o bien no toman nuevas familias o bien las toman con una consigna muy clara de que se van a reunir solamente por dos o tres sesiones para evaluación de la situación familiar y que después van a ser asignados a otro terapeuta. En el caso de los prácticum de verano, lo que se les dice a las familias es que el terapeuta va a estar disponible por dos o tres semanas y que al cabo de las tres semanas se decidirá si es necesario una continuación y con quién o no. Es un poco el principio de módulos que se le presenta a la familia, éste es el primer módulo y la

intervención puede terminar acá o no, pero si no termina acá, va a seguir con otro terapeuta.

*Dr. Canevaro:* En caso de que esa familia tuviera necesidad de una nueva revisión de la situación determinada, ¿concorre a la clínica aunque sea con otro terapeuta?

*Lic. Colapinto:* En ese caso la familia es derivada a un terapeuta del staff de la clínica. No pasa, por ejemplo, que una familia sea derivada del prácticum de junio al prácticum de julio; esas cosas no le hacemos a la familia.

*Dr. Canevaro:* Para ir finalizando..., dentro de las grandes líneas que vos conocés, ¿cuáles podrías diferenciar en torno a maestros de terapia familia que hagan docencia? Por ejemplo, tengo entendido que Haley supervisa pero no hace personalmente terapia.

*Lic. Colapinto:* Ni hace terapia, ni entra en la habitación.

*Dr. Canevaro:* Lo que debe diferenciarlo mucho de Minuchin, de Bowen o de otros terapeutas.

*Lic. Colapinto:* Yo en realidad, salvo esa diferencia que vos mismo mencionaste entre Haley y Minuchin, conozco muy poco de las modalidades típicas de otros maestros. Hay toda una serie de justificaciones teóricas, a favor o en contra de que el supervisor entre a hacer coterapia o entre a hacer una demostración para el beneficio de terapeutas, hay muchas explicaciones teóricas. Yo creo que en definitiva, remiten a motivaciones del supervisor. Hay gente que tiene ganas de hacerlo y hay gente que no tiene ganas de hacerlo, básicamente es eso. Los argumentos teóricos en favor y en contra son muy relativos. Yo tengo mi propio criterio y creo que es el criterio de mucha gente pero no lo puedo confirmar: es intervenir en una sesión que está teniendo otro terapeuta, cuando hay una situación de riesgo, (por ejemplo riesgo de perder a la familia, de que la familia no venga más), o bien cuando hay una situación de excelente oportunidad, o sea si hay posibilidad de dar una vuelta de tuerca más y es una pena perder ese momento, entonces lo puedo hacer. En el contexto en que habitualmente trabajamos nosotros, que es un contexto con mucha continuidad, donde no hay demasiado apuro, es posible. En un contex-

to de aprendizaje más limitado, como por ejemplo lo que hice acá, sistemáticamente entré al final de las entrevistas. Eso tiene más que ver con que, si yo estoy proponiendo un modelo de pensamiento extraño a lo que es habitual en el terapeuta, una de las situaciones que yo no quiero que ocurra es que el terapeuta que está aprendiendo el modelo, quede con la impresión de que algo que yo le propuse no puede suceder. Que tal proceso que yo le pedí que iniciase en la familia, no se puede terminar o queda a medio terminar o queda hilvanado pero no cosido. En ese caso el valor de la demostración es un poco mostrar que hay una forma de hacerlo; y en situaciones de experiencia de aprendizaje breve, donde no hay continuidad, donde cada terapeuta tiene una sesión de exposición del modelo, esto yo creo es importante para que el terapeuta quede con una versión más redondeada de qué es lo que yo quiero decir cuando le pido que haga algo.

**Dr. Canevaro:** Como última pregunta ¿cómo ves el futuro de la docencia y del entrenamiento en terapia familiar, de acá a diez o veinte años? ¿cómo se abre de acá a fin de siglo?

**Lic. Colapinto:** Yo creo que va a continuar el actual proceso de expansión cuantitativa que hay en terapia familiar. Yo creo que éste es un momento, tomando la analogía del mercado de acciones, de colección de ganancias. La gente que se ha entrenado, que ha tenido mucha experiencia y mucha práctica o en algunos casos gente que no ha tenido tanta experiencia y tanta práctica, pero ha abierto su propio institutito, está capitalizando sobre lo que se ha hecho en estos años.

A nivel de trabajo clínico, en este momento no estamos pasando por un período particularmente creativo. Después de la generación de los grandes maestros, Whitaker, Minuchin, Bowen, las italianas, etc., está tardando en aparecer la siguiente generación. Creo que va a haber toda una expansión de los distintos centros de enseñanza que van a ser todos procesos de enseñanza de este nivel de conceptos que se ha alcanzado. Se va a popularizar la enseñanza de la terapia familiar y después va a venir un momento de retracción. El mercado se va a dar cuenta que seguimos todos diciendo lo mismo y entonces van a

empezar a aparecer, otra vez centros “élite”, “este lugar por allá perdido tiene esta manera muy especial, muy distinta y muy novedosa y muy revolucionaria, tal vez muy subterránea, clandestina casi, de hacer terapia”. Lo que pasa que la terapia familiar en EE.UU. por lo menos, ya está casi convertida en el establishment, se ha oficializado, ha adquirido respetabilidad, se está burocratizando una barbaridad, las asociaciones profesionales están funcionando casi como las más tradicionales, como la asociación psicoanalítica por ejemplo. Pero al mismo tiempo están empezando a aparecer algunos movimientos “revolucionarios” que publican sus diaritos con mimeógrafo porque no tienen plata para competir con las grandes revistas. Yo creo que eso dentro de algunos años va a cristalizar en tres o cuatro centros que se van a convertir otra vez en mecas, van a crecer y se van a burocratizar, etc.

Creo que los próximos quince o veinte años van a ser básicamente un período, primero de más expansión cuantitativa y después de retracción, van a empezar a perder clientes porque va a ser ya demasiado conocido todo... y ésa es la vida, ¿no?

**Dr. Canevaro:** Muy bien, te agradezco mucho.



# THIS IS YOUR JOURNAL

Share it with your friends and colleagues.

For those interested in subscribing, an order form is provided below.

Please Enter My:

## Individual Subscription

☐

1 year @ \$20  
(4 issues)

☐

Check is enclosed

☐

Bill me for this order  
plus postage and handling

## Institutional Subscription (libraries and multi-reader establishments)

☐

Enclosed is a check for \$30 (1 year's subscription)

☐

Bill us \$30 plus postage and handling

(Orders outside of North America, add \$2 per year for postage and handling)

Name \_\_\_\_\_

Institution \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip \_\_\_\_\_

Mail to: JOURNAL  
OF MARITAL  
AND FAMILY  
THERAPY  
924 W. 9th  
Upland, CA  
91786



American  
Association  
of Marital and  
Family Therapy

## Ateneo clínico

*El presente ateneo fue realizado sobre la base del material clínico presentado por la Dra. Eloisa Barrientos, el Dr. Luis Izcovich y la Dra. Beatriz Videla en la Soc. Arg. de Terapia Familiar (noviembre 1983). Fueron invitados a participar en el ateneo el Dr. Edmundo Zimmerman, el Dr. Carlos M. Díaz Usandivaras, la Dra. Aurora Pérez y la Lic. María Rosa Glasserman.*

María Laura (9 años), niña psicótica sin trastornos orgánicos, ingresa a este hospital, en junio de 1983.

El equipo de Admisión realiza entrevistas con la niña y su familia, tests y otros exámenes clínicos, derivándola a este servicio.

## Motivo de consulta:

Concurren la madre y la niña. María L. es morocha, lleva el cabello muy corto y viste un conjunto jogging de color oscuro (parece un varón).

Esta primera entrevista tiene por finalidad indicar los horarios de las diferentes terapias.

La madre (Irene, 34 años) se muestra ansiosa, fastidiada con la hija, la obliga a saludar. María L. se niega, parece ausente.

En el consultorio, María L. sonríe, llorisquee, agita las manos, murmura. Permanece de pie. La madre la mira de reojo y enojada refiere:



"Es así como la ven. Fue una beba normal, sanita. Yo la esperé con ansiedad y alegría, pero no sé qué le pasa, no habla. Cuando ella quiere sí habla. Creo que la cosa es conmigo. A los dos años me hicieron notar que no hablaba normalmente, sólo decía palabras sueltas. Me hace señas y yo le entiendo. Es buenita, pero caprichosa. Me obliga a repetir todo. Juega siempre sola, con dos juguetes de igual forma que los tiene en la mano sin soltarlos. Habla sola, canta, repite órdenes: 'María L. andá al baño, portate bien, etc.'. Con el hermano, Mario (11 años), juega porque él le tiene paciencia. El nunca le pega".

Irene refiere haber tenido tres embarazos:

- 1) Mario (1972).
- 2) NN (abortó espontáneamente a los dos meses, 1973).
- 3) María Laura (1974).

"Tuve que hacer reposo durante el embarazo de María L. Tenía miedo, me internaron un poco antes de la fecha de parto. Al final todo anduvo bien, normal, hasta los dos años, que llevé a la nena al Hospital de Clínicas, allí me dijeron que era inmadura. Tuvo terapia con una psicóloga hasta los 5 años; como hubieron algunos cambios, le pusieron psicopedagoga, maestra a domicilio y escuela diferencial. Pero no anduvo, no hablaba.

Continuó tratamiento privado con su terapeuta inicial, pero yo decidí traerla aquí porque no adelantaba. La terapeuta estuvo de acuerdo".

Una de las terapeutas que realiza la entrevista, enciende un cigarrillo con fósforos. María L., hasta el momento indiferente, se acerca e intenta apagarlo, lo sopla. Al irse, espontáneamente dice "chau".

\* \* \*

Describimos los momentos más significativos de las primeras cinco sesiones.

#### Primera sesión:

La familia concurre puntualmente. Los padres: Adolfo Ma-

rio (52 a.), Irene (34 a.), los hijos: Mario (11 a.) y María Laura (9 a.).

Nos presentamos como par terapéutico, y ya en el consultorio los dejamos elegir libremente los asientos. Irene y Adolfo se ubican juntos en el centro. Mario al lado del padre, María L. al lado de la madre. Se muestran tensos, pero sonrén. María L. lloriquea. El padre la acaricia, le habla, sonrén. La madre fastidiada le dice que debe callarse. María L. continúa lloriqueando. Los padres refieren sus expectativas en forma demandante, acerca de este nuevo tratamiento. Explican que piensan la importancia de estar con médicos en lugar de psicólogos. Recabamos información sobre esta preferencia. Como respuesta, Adolfo cuenta su frustración en relación al anterior tratamiento.

ADOLFO: Nosotros cumplimos. Pero algo no anduvo. No entiendo cómo la mandaron al colegio. Ella no hablaba bien, no se comunicaba. La madre decidió traerla aquí, y la terapeuta estuvo de acuerdo, porque ya no podía hacer nada por la nena.

Los padres se muestran ansiosos, quieren saber la causa de la enfermedad.

ADOLFO: Alguna causa debe haber, ustedes que son médicos deben saberlo.

TERAP.: Recién comenzamos este tratamiento. Con el tiempo, iremos conociendo detalles que nos permitirán ayudarlos.

Irene se muestra tensa.

IRENE: Conmigo en casa, María L. es de una forma, con el padre es diferente. Me lo hace a mí. No me habla, pero cuando está sola habla.

TERAP.: ¿Qué dice?

IRENE: Canta o repite órdenes, sin dejar sus dos juguetes. Es vaga y caprichosa. Quiere que acaricie todo lo que toca.

TERAP.: ¿María L. lo hace a propósito?

ADOLFO: No, no es cierto. Ella está enferma. Se pierde de disfrutar.

TERAP.: Y vos, Mario, ¿qué contás?

ADOLFO: El es muy buen alumno, sólo que la maestra se queja porque es muy charlatán, igual que en casa, habla todo el tiempo. (Mario no dice nada, mira al padre y sonríe).

Segunda sesión:

Adolfo comienza la sesión diciendo: "Bueno, en general andamos bien..."

TERAP.: ¿Y en particular?

ADOLFO: Estamos bien...

IRENE: Me quedé pensando, que yo digo que María L. es vaga y caprichosa... Bueno, se supone que hay un problema.

ADOLFO: Se sabe que hay un problema.

IRENE: Hay que decirle para que diga. No le sale decirlo sola. Si ella quisiera...

María L. se ensucia las manos con témpera. Llorisquee y le muestra las manos a la madre.

IRENE: Quiere limpiarse, no tolera estar sucia.

María L. grita. La madre, al mismo tiempo que le ofrece un caramelo, se lo introduce en la boca. La niña lo rechaza.

TERAP.: Se le pide a María L. que diga, sin embargo cuando muestra su enojo, se intenta silenciarla con un caramelo.

Adolfo intenta justificar a su hija. Irene quiere decir algo. Este se lo impide.

TERAP.: Escuchemos a Irene.

IRENE: Yo sólo quiero que me hable. No me contesta.

TERAP.: María L. la deja a solas con sus propias preguntas y respuestas.

ADOLFO: Yo quiero encontrar la causa.

IRENE: Yo no sé, yo no le hice nada.

TERAP.: ¿Se siente culpable?

IRENE: Bueno, es que a veces pienso que la cosa es conmigo. Me da bronca que no me hable.

ADOLFO: Bueno, lo tenés a Mario, el habla mucho, es un charlatán (sonríe).

En esta sesión armamos el genograma.

Irene confunde datos. Le cuesta recordar el nombre y edades de sus hermanos: "Es que somos muchos. Cuatro hermanastros y ocho hermanos de sangre." No confiesa espontáneamente los dos matrimonios de la madre (Berta, fallecida en 1976), quien separada del primer matrimonio, se casó con el padre de Irene.

"Delante mío, hubo un hermanito que falleció a los 18 meses de broncoespasmo. Mamá tenía hijos cada 2 años. Papá falleció a los 47 años. Yo tenía 12 años. El me adoraba. Cuando papá murió, los más chicos se quedaron con mamá. Yo tuve que vivir con Elba, que estaba casada con Ernesto (hermano de Adolfo). Así conocí a mi marido. De jovencita trabajé como empleada en el taller de ellos y después me casé."

Adolfo acota: "Y yo era el patrón."

"Mi hermanito muerto y yo, llevamos el nombre de nuestras abuelas, ya fallecidas al momento de nuestro nacimiento. Mamá falleció en 1976. Yo no la ví, ella estaba en San Juan. A veces pienso volver a verla, me cuesta creer que se murió. María L. tenía 2 años, no se debe acordar nada."

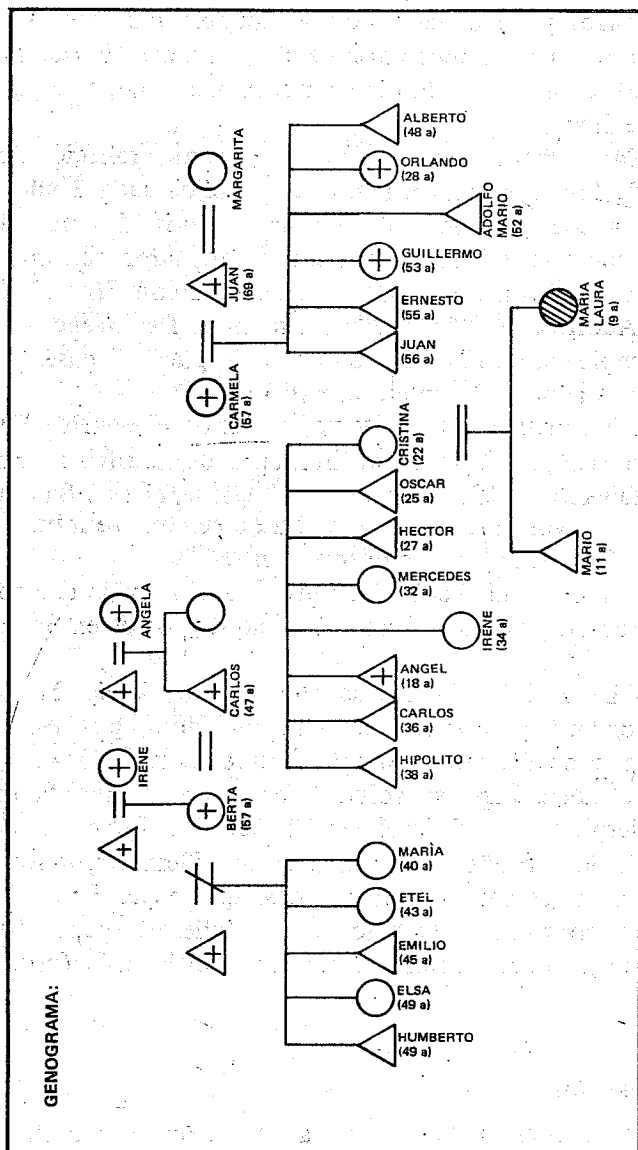
"La familia de Adolfo es muy unida, muy linda; nosotros éramos unidos, ahora algunos viven aquí y otros en San Juan."

ADOLFO: Mis abuelos se quedaron en Italia. Mis padres trabajaron mucho. Tuve una infancia dura, por eso quiero que mis hijos disfruten. Mamá (Carmela), falleció cuando yo tenía 16 años. Papá se volvió a casar con Margarita muchos años después. El falleció en 1965. Mi hermana Orlanda falleció a los 28 años. Otra hermana, Guillermina, falleció hace poco, por trastornos cardíacos igual que papá. Todos los hermanos y sobrinos trabajamos en el taller de papá (hacemos cinturones), todos nuestros hijos nos continuarán (mira a Mario).

Tercera sesión:

La terapeuta no concurre a la sesión de familia. Irene pregunta por la doctora. Explico que no ha concurrido, y que

Genograma:



por lo acordado en el contrato de tratamiento, la sesión se hará con el terapeuta.

Irene relata que estuvo pensando toda la semana en la sesión anterior, porque había hablado de cosas que hacía mucho no recordaba. Se pone triste, recuerda su infancia, y Adolfo intenta calmarla con palabras, inhibiendo la manifestación de pena de Irene. Adolfo parece temeroso.

Siento que Irene se siente desilusionada por la ausencia de la terapeuta y me coloca en un lugar de impotencia.

Cuarta sesión:

Cuando comienza la sesión María L. está enojada. Llora, gime. La madre comenta que la niña tiene una rabieta: "Tal vez no le gusta venir". A partir de esto, podemos trabajar el enojo de los padres, por la ausencia de la terapeuta en la sesión anterior. Adolfo, en especial tiene dificultades para manifestar sus sentimientos hostiles. Tampoco los tolera en los otros: "No soporto que se falte al trabajo, yo no lo hago nunca; yo cumplo."

Irene se sentó dándole la espalda al terapeuta, en el momento que se habla de los sentimientos hostiles, ella se ubica de frente al terapeuta y le pide disculpas.

IRENE: Hoy quería contar algo que pensé toda la semana, pero ahora no me acuerdo. Anoche, cuando veíamos "Matrimonios y algo más", María L. quiso que cambiáramos de programa. Lo hicimos y siguió protestando, hasta que el papá tuvo que darle una palmada.

ADOLFO: La castigué y después le hice mimos (sonríe). No me gusta que grite porque molesta a los vecinos, me preocupa el entorno.

IRENE: (Mirando de reojo a la hija), ... los vecinos saben del problema ...

TERAP.: Debe ser confuso para María L. que se la castigue y después se la acaricie.

IRENE: ... Sí, yo a veces me pregunto qué estoy haciendo, porque enojada estaba.

ADOLFO: ¿Qué pasa cuando luego de castigarla se sienten deseos de acariciarla?

TERAP.: ¿Qué le pasa a Ud. con su enojo?

ADOLFO: Y, está enferma... (sonríe).

IRENE: Ahora yo le muestro que estoy enojada. Porque ella me obliga a repetir, me lo hace a mí... aunque está cambiada, ahora juega con objetos de diferente forma

TERAP.: María L. pidió un cambio de programa. Usted tenía algo programado que no recuerda; su hija la obliga a repetir, ¿cuál sería el cambio?

IRENE: Y..., siempre se hacen cambios... los muebles (se ríe)... me acordé que cuando era chica mi prima pelirroja no me quería porque soy morocha. Ahora ella quiere ser como yo. Yo fui muy querida por papá, por ser su primera hija.

TERAP.: Ud. nació luego del fallecimiento de un hermanito de 18 meses. ¿Qué recuerdos hay de él?

IRENE: Yo no lo conocí. Dicen que era rubio como un ángel. Se llamaba Angel. Mamá prefería a los varones, no les pegaba, ni los obligaba a hacer nada. Por eso, yo quería una nena. En mis dos embarazos —(son tres)—, quise una nena, y me costó tanto... María L. era la nena que yo quería (la mira de reojo y fastidiada), pero ahora, bueno, es diferente, creció.

#### Quinta sesión:

Por una información errónea, el terapeuta comienza sólo la sesión. La terapeuta se incorpora, 25 minutos después.

Irene hace una expresión de desazón, al enterarse que la terapeuta aún no había llegado.

IRENE: Mario no quiso venir porque se despertó con el labio hinchado y le daba vergüenza. ¿Quiere hacernos alguna pregunta? (Silencio). No hay muchas novedades. Como siempre, cuando mi marido llega a casa, todos queremos hablarle. Yo lo hago cuando los chicos duermen.

TERAP.: Usted tiene un turno preferencial.

IRENE: Sí, porque Mario habla mucho.

ADOLFO: Mario se queja porque hay cosas que no lo

dejamos hacer, dice que cuando tenga hijos les va a hacer lo mismo.

Se integra la coterapeuta. Irene le relata todo lo hablado hasta el momento, dirigiéndole la mirada en forma permanente y evitando al terapeuta. Se le señala esta actitud. Irene la corrobora y aclara: "Lo que sucede, es que la doctora me resulta familiar."

IRENE: Me siento menos pendiente de María L. Ahora se desempeña sola. En realidad, siempre estuve pendiente de los dos chicos. Mi marido no lo sabe, pero cuando ellos duermen les controla la respiración.

TERAP.: Ahora parece pendiente de nosotros, si venimos, qué vamos a decir...

ADOLFO: Mario dice que no quiso venir por el labio hinchado y además porque aquí no puede hablar.

IRENE: Aquí también se saca turno.

TERAP.: Parece que Adolfo puede hablar con todos y acerca de todos. Muchas veces contesta por usted, por Mario o María Laura. Usted Irene, ¿qué dice?

IRENE: Me siento mal, porque mi hermana Elba tuvo otro ataque. Le tiembla el brazo. Me da pena y miedo. Ella es como mi mamá. Fue por ella que empecé a salir con Adolfo. Hasta los 19 años no me dejaba salir. Con Adolfo se sentía tranquila.

TERAP.: Hay varias mujeres significativas: su mamá, su hija, su hermana Elba y también la doctora. Pareciera que los vínculos con las mujeres son muy estrechos y los hombres quedaran excluidos. Hasta que no vio a la doctora, usted estuvo intranquila.

IRENE: Yo necesito que ella esté. Es que entre mujeres es diferente.

TERAP.: Irene, aquí no estamos solas entre mujeres. Hay dos varones: su esposo y el doctor. El doctor y yo trabajamos juntos, pero usted puede reconocerlo sólo cuando yo se lo recuerdo. Usted dice que necesita estar pendiente, controlar, mirar... Parece Irene, que no tolera ver que falte.

Irene sonríe, parece desconcertada. María L. hasta el mo-

mento indiferente, dice algo que no entendemos. Terminamos la sesión.

# Incluimos la sexta sesión

La familia llega puntual. En el consultorio eligen los asientos. Adolfo e Irene se sientan enfrentados. Mario al lado del padre, María Laura al lado de la terapeuta.

Se miran, nos miran; el matrimonio parece tenso entre ellos.

ADOLFO: A ver Irene, empezá a hablar vos, ya que siempre te saco la palabra, (sonríe). ... ¿rencoroso yo?

IRENE: Bueno, no es cuestión que yo hable porque vos no lo hagás ... que hable otro ...

(Silencio).

TERAP.: ¿Qué pasa? Hoy se sentaron enfrentados.

IRENE: No, nada, quizá estamos un poco agres..., tenemos ganas de hablar. Hace una semana que no tenemos sesión, y empiezo a acostumbrarme que algo falta. ... Mario, contá vos que tenés un campeonato de basquet en el colegio y ...

TERAP.: ¿Querés contarlo vos?

MARIO: Bueno, a la tarde hay un campeonato de basquet y yo participo. Me gusta la gimnasia ...

ADOLFO: A mí de chico me gustaba, yo jugaba básquet. A Mario lo llevo a ver fútbol; ahora está un poco peligroso. Los domingos vemos básquet por televisión. María L. besa al padre, a la madre, recorre el consultorio, abre la puerta, la cierra.

IRENE: María L. está mucho mejor, juega más, tiene otros chiches... Está más observadora, es como que empezara a tener en cuenta a la gente. Ayer vino el pintor y ella se quedó mirando cómo hacía el trabajo ... Lo único que ahora le tiene miedo a los perros. Desde que empezó el tratamiento ... Antes jugaba hasta cansarlo con el perro de mi hermana, y ahora no puede acercarse, hay que encerrarlo.

María L. repite "perro".

IRENE: Estoy más nerviosa, porque mi hermana Elba sigue mal. Creo que en casa grito un poco más. Pero todo está bien.

ADOLFO: Sí, está más nerviosa, pero lo de la hermana la tiene mal ... Será eso ... (Adolfo parece disgustado).

IRENE: Lo que pasa es que yo hablo fuerte.

ADOLFO: Claro, vos sos del campo.

IRENE: Debe ser eso, pero en casa todo está bien excepto el problemita de María L. En Grupo de Madres dijeron que las mamás teníamos que asumir el problema de nuestros hijos, porque hay madres que no quieren ver.

TERAP.: Y usted, ¿qué piensa?

IRENE: Y que yo tuve que asumir lo de María L., porque si no me lo decían, no me hubiera dado cuenta ...

TERAP.: ¿Qué era lo tan notorio, en María L.?

IRENE: Y que cuando tenía dos años sólo decía: papá, mamá, agua, pedía ir al baño y como yo veía a Mario que fue sanito, la nena parecía diferente.

TERAP.: Son de diferentes sexos, no son la misma persona, el tiempo de aprendizaje de cada uno es diferente.

IRENE: Sí, pero veía a Mario, siempre me guié por Mario ...

TERAP.: ¿Y cómo fue que llegó al Clínicas?

IRENE: Teníamos un pediatra familiar, atendió a todos los sobrinos de Adolfo, que nunca me dijo nada de la nena. Estando de vacaciones, consulté otro pediatra y me dijo que la chica era inmadura. Así fuí al hospital. Primero la atendieron en Fonoaudiología, durante dos meses y no avanzó; después le hicieron una audiometría, era normal pero no respondía. Al final, la vió un neurólogo, sólo le tomaron los reflejos, pero no le hicieron ningún E.E.G. Los reflejos estaban bien, sólo que no tenía fuerza en las manitos ... después de 6 meses la mandaron a terapia.

ADOLFO: De beba, se le caían las cosas de las manos, como si no le importaran. Era blanda ... pero claro, el pediatra nunca nos dijo nada, yo confiaba ...

TERAP.: Se entiende un poco más porque los médicos no son tan confiables como la doctora. Tampoco lo son las psicólogas.

Adolfo se siente molesto. Discute con el terapeuta. Le cuesta escuchar. Reconoce que todavía está probando la eficacia del médico.

IRENE: Se le subió la tanada.

TERAP.: Parece que Adolfo sólo puede aceptar su enojo siempre que una causa se lo explique. Al comienzo de la sesión, podía hablar de los nervios de Irene, (que le molestan), justificándolos que eran por la situación familiar. Es como si "el por qué" le sirviera para frenar sus sentimientos hostiles. Usted dijo: "¿rencoroso yo?".

Adolfo se queda serio. Terminamos la sesión.

### Terapia individual

Terapeuta: Dra. Beatriz Videla

La primera entrevista se realiza con María Laura y la madre para concertar días y horarios de atención. La madre habla de las dificultades de María Laura para jugar, sólo juega con 2 o 3 juguetes que están rotos y no logra entretenerse mucho tiempo, pero el problema mayor es "que María Laura no habla".

Se debe interrogar a la madre para conocer más datos. María Laura está muy quieta, mira para todos lados, parece no darse cuenta qué pasa alrededor suyo.

La mamá parece tranquila, no hay angustia en el relato y excepto los problemas de Laura, dice que los demás están bien, que son una familia armónica y organizada. María Laura parece ser extraña a la misma; no pertenecer.

Cuando se inicia el tratamiento, María Laura trae unos juguetes de su casa: un patito de plástico mordido, un cubo de plástico con figuras rotas y sucias, una cajita y envase de remedios, vacía. Le gusta jugar con envases vacíos.

El primer día le cuesta separarse de la madre, camina lento, se detiene, avanza. En el consultorio mira para todos lados, en especial la puerta que estaba cerrada. Le hablo de su miedo a lo nuevo y a la iniciación de un tratamiento, ya que ella fue atendida por diferentes profesionales, a los que dejó de ver. Le enseño la caja de juegos, ella no puede acercarse a la caja, sólo coloca sus propios juguetes dentro de ella.

En las siguientes sesiones parece más tranquila, saca un juguete de té de plástico, lo mira, lo toca, saca cada tacita,

plato y bandeja, los acaricia en los bordes salientes, se los lleva a la boca, los roza con los labios, se queda quieta, mira alrededor, saca el patito que ella trajo y repite el mismo juego.

Dice algunas palabras, repitiendo lo que yo digo: consultorio de Laura, pato, tacita.

Durante 6 o 7 sesiones se repite el mismo juego, con la variación que ya va sola al consultorio llevando la caja, no está ansiosa, y en las dos últimas sesiones sólo juega con el patito. No toca ni mira los otros juguetes.

María Laura me impresiona como rodeada por una nebulosa.

En este momento, estoy trabajando con dos sesiones semanales.

### Discusión

*Dr. E. Zimmerman:* Voy a comenzar con un comentario acerca de la primera entrevista y la primera sesión también, para pasar a referirme luego al material de la seis sesiones familiares subsiguientes.

Los padres rechazan una causación psicológica para la enfermedad. Se quejan porque los anteriores terapeutas "la habían mandado a la escuela", aún cuando se trata de una escuela diferencial a la cual fue después de haber hecho progresos en su tratamiento. Dice la madre: "alguna causa debe haber, ustedes que son médicos deben saberlo". Hay aquí una confrontación de lo médico versus lo psicológico. Se busca una causa médica, es decir, orgánica y no psicológica que supuestamente los inculparía. Frente a la no respuesta de los terapeutas a su demanda, Irene se pone tensa y esboza una explicación de tinte paranoide "Ella me lo hace a mí (el no hablar), no al padre". Hay una polémica entre los padres, ¿la conducta de María Laura es intencional o producto de la enfermedad? ¿Es mala o enferma? La madre parece inclinarse hacia la primera alternativa, que es mala, el padre opta por la segunda. El otro tema que

plantea esta sesión es el significado que el hablar tiene para esta familia. María Laura es definida por la madre como la que no habla en público, pero sí sola. Y Mario como el que suscita las quejas de la maestra. Es muy charlatán en la definición del padre, quien a su vez no deja hablar a Mario y contesta por él la pregunta que le formula el terapeuta. "Yo sólo pido que me hablen" dice Irene y recuerda aquí a las madres de las anoréxicas que suplican "Yo sólo te pido que comas un bocadito". Con su negativa a hablar, María Laura controla a la familia. Su silencio culpabiliza a la madre, "No le hice nada" alega. A cambio de una María Laura silenciosa, el padre ofrece un Mario charlatán. Me pregunto qué significado tendrá esta propuesta de trueque. ¿A qué otros trueques o intercambios reales o simbólicos alude? ¿Son los hijos intercambiables? Esta permutación de identidades no es extraña al universo de la madre, tal como se desprende de la lectura de su genograma y de la confusión de Irene al hacerlo "¡Es que somos muchos!". Ella es la primera hija mujer del segundo matrimonio de la madre. Cuando nació, la madre acababa de perder a un chiquito de 18 meses, Angel. A continuación explica que su madre se embarazaba cada 2 años, lo cual hace suponer que en el momento de la muerte del hermanito la madre estaba embarazada de Irene. En el genograma hay una diferencia de sólo 2 años entre ella y el hermano vivo que la antecede. Ella ocupa entonces el lugar de otro, el Angelito rubio que murió a los 18 meses. O más bien, hubiera deseado ocuparlo para ser querida por una madre que prefiere a los varones. Más segura parece la posición de Irene frente al padre, por quien por ser primera hija mujer, se ha sentido adorada. A la muerte del padre Irene pasó a la órbita de la familia materna, los hermanastros, en donde conocerá a Adolfo, 18 años mayor que ella, con quien intentará repetir el vínculo privilegiado que supuestamente tuvo con el padre. "Mi hermanito y yo llevamos el nombre de nuestras abuelas fallecidas", dice Irene. Una de esas abuelas se llamaba Angela. Hay un deslizamiento metonímico de Angela a Angel que facilita la ambigüedad sexual de la identificación. Irene "no puede creer" que su madre haya muerto. Tal vez su propia

madre no creyó que Angel había muerto y lo reemplazó fantasmagóricamente por la criatura que llevaba en su vientre.

En este punto yo agregó que también me parece que hay en el padre una dificultad de elaboración de los duelos; posiblemente Adolfo tampoco pudo hacer el duelo por su madre muerta cuando él tenía 16 años. Más adelante se lo describe como inhibiendo la expresión de los sentimientos en el resto de los miembros de la familia.

La muerte no deja huellas en esta familia. El duelo es denegado, proyectando esa denegación en los hijos. "María Laura tenía 2 años cuando mamá murió", dice Irene, "no se debe acordar nada".

Ahora, ¿de qué cosas que ocurrieron en su segundo año de vida no querrá acordarse Irene? Digo lo de los 2 años porque creo que es un lapso muy significativo para esta mujer. ¿No será del embarazo de su madre y del nacimiento de Mercedes, la hermana que la sigue con 2 años de diferencia y que por ser mujer seguramente ha venido a disputarle la muerte de su padre? Podemos pensar una hipótesis, que el lugar de María Laura ya está determinado para Irene desde antes de su nacimiento. Podría ser, por ejemplo, el de una hermana o un hermano que viene a robarle sus privilegios del mismo modo que ella lo hizo con Angel, el hermano muerto de quien quiso ocupar el lugar.

La cuarta sesión muestra la utilización que se hace de M. Laura como depositaria de los sentimientos hostiles de los padres por la ausencia del terapeuta. Se le atribuyen "estos sentimientos", tal vez no le gusta venir y al mismo tiempo se coarta su expresión.

El discurso y las actitudes de los padres son confucionantes. Se confunde el sentido literal con el simbólico, los sentimientos propios con los de M. Laura, se la castiga y luego se la mima, se la define simultáneamente como enferma y como caprichosa. El discurso de Irene es por momentos confuso. Ante la mención que hace el terapeuta de los cambios de M. Laura, Irene responde: "Siempre se hacen cambios, los muebles. Me acordé que cuando era chica mi prima pelirroja no me quería porque

soy morocha. Ahora ella quiere ser como yo. Yo fui muy querida por papá por ser la primera". Habría que señalar que en la medida que existan estos intercambios, creo que la que puede ocupar el lugar de la primera podría ser ahora M. Laura. En el discurso de Irene se pasa rápidamente de un cambio de conducta referido a M. Laura, a un cambio de lugar de los muebles y a una inversión de papeles, "la prima que antes no la quería y que ahora quiere ser como ella". Los lugares, las personas, los objetos, el pasado y el presente son fácilmente permutables. Irene dice "es la nena que yo quería" pero después la mira de reojo y fastidiada dice "bueno, pero ahora es diferente, creció". Es decir que con el crecimiento M. Laura se transformó de querida en odiada. Uno podría pensar que originalmente pudo haber sido la hija mujer con quien Irene intentó repararse de la mala relación que tuvo con su madre, pero algo pasó que a Irene esta hija se le transformó. ¿Y en quién se transformó para Irene? Se transformó acaso en ella misma, morocha, no Angel rubio, desplazada por la hermana menor, en el varón competidor rechazado (recuérdese la descripción inicial de M. Laura, jogging, cabello corto, parece un varón) o se transformó en alguien que le quitó a la mamá. La madre murió cuando M. Laura tenía 2 años. Es decir que los 2 años de su hija —hermanita le robaron a la madre. Hay un rápido intercambio proyectivo entre Irene y nosotros, una confusión de presente y pasado. Irene dice que controla la respiración de los chicos cuando duermen. Cuando duermen, es decir el momento que aprovecha para hablar con Adolfo su marido, que siente que sus hijos le disputan.

Quería agregar que en esta familia son de mayor importancia los hombres por el hablar. Parece que el hablar fuera un privilegio masculino y que hay toda una línea de continuidad. Para el padre hay un lugar para Mario que es el taller; como que viene de su padre, sigue en él y en el resto de la familia de los varones, pero no hay un lugar para M. Laura. Entonces pensaría que el lugar que hay para las mujeres es referido a las hermanas que son hermanas muertas.

María Laura callada es una rival menos, pero Irene parece

asustada de su propia ambivalencia y necesita verificar que no ha dañado mágicamente con el pensamiento a sus hijos, auscultando su respiración.

Tiene que sacar turno para hablar y enseguida se siente mal porque dice que su hermana Elba tuvo otro ataque. Se repite aquí un fragmento del pasado en el que se evoca la rivalidad edípica hacia la madre y la hostilidad hacia ella, supongo que por su abandono y sus respectivos embarazos. Pero se ve también aparecer transferencialmente su odio hacia los hombres, padres, hermanos que la despojaron de una madre por quien se sintió rechazada por su condición de mujer. La sexta sesión muestra una mejoría de M. Laura, "está mucho mejor, juega más, está más observadora, tiene otros chiches", relata su madre, coincidente con una evolución que ha llevado a una mejor discriminación y a un mayor despliegue de agresividad de y entre los padres.

Señalo: los padres se sientan enfrentados, "¿rencoroso yo?" dice Adolfo; "estamos un poco agres..." se interrumpe Irene, "en casa grito un poco más" dice Irene, la discusión de Adolfo con el terapeuta y el comentario de Irene a raíz de esto: "se le subió la tanada".

Aparece un cambio en la sintomatología de M. Laura que se vuelve más neurótica, desarrolla una fobia hacia los perros.

Como resumen muy breve: M. Laura impresiona como una nena robotizada o vaciada, carente de una configuración propia de la que ha sido despojada por un exceso de identificaciones proyectivas por parte de los padres o por lo menos por parte de la madre seguramente. No habla porque es demasiado hablada por otros, no tiene lugar para ella misma y trata de encontrarlos en sus soliloquios relacionándose autísticamente con los dos juguetes, los padres supongo, que lleva en la mano.

**Dr. Carlos Díaz Usandivaras:** Lo primero que quería aclarar es que me resulta muy difícil ver en este material solamente a la familia. Yo veo acá el sistema familiar por una parte y por otro lado el sistema familia-terapeutas. Son dos niveles del registro de observación. Por lo tanto quería hacer algunas aclaraciones: Yo pienso y trabajo con un esquema bastante diferente al



esquema con que supongo trabajan estos terapeutas. Por lo tanto en lo que se refiere a mi observación en el manejo o de lo que pasa en el sistema terapeuta-familia, pueden surgir unas discrepancias bastante marcadas. Por otro lado lo que quiero aclarar es que es mucho más fácil criticar o ver las cosas desde acá, desde el papel escrito, que desde la situación del fragor de la lucha con la familia, que como ésta tiene un altísimo poder de inducción. Yo creo que es una familia muy difícil, no sé qué hubiera hecho yo con esto. Me resulta mucho más fácil decir qué haría yo ahora leyendo el material.

En principio tomé sobre el material clínico algunos párrafos y voy a tratar de comentar alguna de estas cosas, siempre partiendo de cómo puedo entender por un lado el sistema familiar y por otro el sistema familia-terapeuta. Y esto voy a tratar de hacerlo, tratando de ordenar un poco la observación en función de cuatro variables, que tienen que ver; la primera con la construcción de la realidad que hace la familia, es decir, cuál es su concepción de lo que les pasa, cuál es la hipótesis que ellos traen, cuál es la epistemología de esta familia y consecuentemente cuál es la epistemología del equipo terapéutico con que están trabajando. Por otro lado, el otro ítem sería lo que se refiere al proceso de comunicación, es decir, lo que se refiere a la interacción, y por otro lado la interacción también de los terapeutas con la familia. El tercer ítem sería con respecto a la estructura, es decir, cuál es la estructura de la familia, y cuál es la estructura del sistema familia-terapeuta que se está formando. Y por último un elemento que yo llamaría la logística del proceso terapéutico o de esta situación, que tiene que ver con una cierta evaluación de cuales son los elementos que esta familia le está dando, le está brindando al equipo terapéutico para lograr cambios en esta situación.

Partiendo de la primera entrevista o preentrevista. En principio quisiera destacar que siempre que uno saca un material del contexto obviamente lo hace en función de un esquema propio o en función de una serie de situaciones que ya están predeterminando esa elección. El material está encabezado con la rotulación de niña psicótica. Yo no lo objeto, aunque para

mí no es demasiado relevante el diagnóstico de que sea psicótico o no, en uno decía que había una transformación o cierta modificación de la psicosis a manifestaciones más neuróticas, pero lo que sí creo es que el encabezarlo con esto de alguna manera ya nos prejuicia y creo que también está prejuiciando la actitud del equipo terapéutico y de alguna manera planteando o aceptando una cierta epistemología de la familia, que yo diría es la epistemología de una familia que trae una niña muy enferma.

Concurren la madre y la niña. Esto me hace pensar que la madre es la preocupada por la anormalidad de M. Laura. Por lo menos, aparte de la función parental obvia, da la impresión de que la madre, y esto se reitera después, tiene más manifestas preocupaciones por esta enfermedad. Y se habla de una serie de diferentes terapias, que de alguna manera, aunque es obviamente la manera de manejar este tipo de casos, está satisfaciendo las demandas terapéuticas de la familia y su epistemología de enfermedad, medicina, caso grave, etc.

Hay en la primera entrevista una secuencia que creo que tiene cierto significado, donde aparece la madre ansiosa y fastidiada que obliga a saludar a M. Laura. M. Laura se niega a saludar y está como ausente. La madre se enoja por la conducta de M. L. Acá ya nos está mostrando que no hay complementariedad madre-hija ni jerarquía, sino una especie de escalada simétrica entre ambas, es decir, la madre quiere que salude, M. L. no quiere saludar y la madre se enoja pero gana M. L.

La madre dice que M. L. no habla pero cuando ella quiere sí habla. Dice "la cosa es conmigo, es caprichosa". Yo pienso que éste es un elemento importante desde el punto de vista logístico. Creo que la madre está dando un elemento muy importante a los terapeutas, que yo hubiera utilizado desde otra línea; es la posibilidad de redefinir esta situación, porque el síntoma, de acuerdo a cómo lo plantea la madre, es cómo funciona en realidad, no es que no habla sino que no quiere hablar. Y esto indica que se pudo aceptar la definición de la madre de caprichosa. Fundamentalmente porque a una chica psicótica la tienen que curar los médicos y a una chica capri-

chosa que no habla no porque esté gravemente enferma, sino porque no quiere, la pueden corregir los padres. Esto es importante porque es una primera movida, diría yo, en la cual los terapeutas podrían haber involucrado a los padres, podrían haber definido esto como una cosa de toda la familia, como algo realmente familiar, donde la familia, tendría mucho que hacer. De la otra manera, los que tienen mucho que hacer son los médicos, los psicólogos, todo el equipo terapéutico. Y tal como yo pienso en la terapia familiar lo que importa es que la familia trabaje.

La madre dice que Mario, el hermano, le tiene paciencia, que nunca le pega. Esto da pie para pensar que la madre exasperada, le pega. Y entonces me da la impresión que el equipo terapéutico defiende a la niña enferma confirmando la epistemología de la familia, es decir, si la madre quiere corregir a la niña los terapeutas la defienden, como además es bastante común y por otro lado es lo que a todos nos mueve, es decir, ante un chico víctima de un castigo uno suele aliarse con el chico, cosa que en este caso no hubiera sido la mejor política. Yo creo que hubiera sido más terapéutico aliarse con la madre y no con la nena.

La madre sigue contando que tuvo que hacer reposo durante el embarazo, que tenía miedo y que M. L. es inmadura. Después sigue contando la historia, que hubo terapia con una psicóloga hasta los 5 años, después una psicopedagoga, una maestra a domicilio, una escuela diferencial, toda la historia como se ha ido gestando esta manera de pensar de la familia con respecto a M. L. Es decir, como se ha ido gestando la epistemología que trae la familia, la construcción de una realidad; ya desde el embarazo, la madre estaba muy enganchada con M. L. Por otro lado muestra también como los médicos, lamentablemente, ayudamos muchas veces a este proceso, porque acá ha habido mucha colaboración a través de estudios y demás. Y nos muestra también las soluciones intentadas por esta familia que pasan siempre por la ayuda externa; parecería que dicen poco o nada de lo que han hecho ellos para buscar soluciones, es decir soluciones desde ellos.

La madre dice "no hablaba y decidí traerla aquí y la terapeuta estuvo de acuerdo". De esta manera la consulta actual aparece como más de lo mismo, es decir, como que ellos han estado intentando una serie de soluciones con las cuales no han obtenido resultados. Y cómo esta consulta parecería ser una etapa más, no diferente, es decir, no es la búsqueda de otra cosa sino que es repetir la misma cosa tal vez en mayor escala, porque de acuerdo a lo que ellos creen es de más calibre hacerlo con un médico que con un psicólogo. Es como tomar algo para la tos y con una cucharada no se calma, entonces se toman dos y no se calma, entonces se toman diez. El médico equivaldría a más terapia o a terapia más fuerte.

Ya en lo que es la primera sesión de terapia, creo que es importante destacar la importancia que tiene el primer contacto con la familia. En ese primer contacto se pueden dar cosas muy importantes y fundamentalmente que el equipo terapéutico pueda cuestionar la epistemología de la familia que es lo que mantiene y perpetúa la enfermedad.

En la primera sesión por un lado tenemos algunos datos, por ejemplo, que el padre es 18 años mayor que la madre. Yo no sé si esto puede ser relevante o no, pero a mí se me ocurre que este señor por su edad puede ser un poco más fiaca y evitador de conflictos que lo que sería si tuviera 15 años menos. Es decir que a medida que pasan los años no tenemos tantas ganas de lidiar con chicos, de tomarnos ese trabajo. Aparece otra secuencia que me parece interesante que es la siguiente: M. L. lloriquea, el padre la acaricia, habla, sonrío, la madre fastidiada dice que M. L. debe callarse y M. L. continúa lloriqueando. Creo que están bastante claras las diferentes conductas o el desacuerdo entre ambos padres sobre la conducta de M. L. La madre combate la anormalidad y en cambio el padre la instiga. M. L. hace así lo que quiere. M. L. está triangulada en el desacuerdo de ambos padres que luchan a través de ella. Parece finalmente que M. L. es quien manda. Hay otra secuencia después en la que el padre se queja de los profesionales, los culpa de que la terapia no anduvo y dice "nosotros cumplimos, la madre decidió traerla aquí y queremos

saber la causa de la enfermedad". Yo pienso que aparece otra vez la epistemología de la familia, la construcción que hacen ellos de su realidad, en la cual el padre se exime de la responsabilidad, la adjudica a su vez a los profesionales que son buscados por la madre y así es ella, la que fracasa. El padre viene en realidad a demostrar que esto también tiene que fracasar. Hasta acá creo que hay una evidente situación de simetría oculta entre el padre y la madre. El padre manifiesta que quiere saber la causa de la enfermedad y yo creo que los terapeutas aceptan un juego a través de su propia epistemología, pero creo que no tiene por qué ser transmitida de la misma manera a la familia, porque permite una mala definición de lo que tiene que ser la terapia, por la comprensión y no por el cambio. Porque el padre no dice en ningún momento "yo quiero que M. L. hable" o "yo quiero que M. L. cambie" lo que él dice es "por qué pasa esto", "quiero saber cuál es la causa de la enfermedad". Es un preocupado por la etiología de las cosas. El padre dice "alguna causa debe haber", "ustedes médicos deben saberlo".

El terapeuta dice "recién comenzamos, con el tiempo veremos detalles que puedan ayudarnos". La madre se muestra tensa y dice "conmigo es de un forma y con el padre es diferente", "me lo hace a mí, no me habla, sola habla". Yo pienso que acá el equipo terapéutico se deja agobiar por la responsabilidad. Acepta definir la terapia como conocimiento y confirma la situación, asume cargar con el peso planteando la concepción de la terapia prolongada. Es decir, "con el tiempo conoceremos".

Pienso que de esta manera se hace una coalición involuntaria con el padre contra la madre, que está visiblemente incómoda porque el padre es el que está llevando toda la situación y ella queda totalmente de lado. La madre intenta otra vez mostrar la dramática estructura de la familia, pero los terapeutas se quedan en el contenido y no en lo relacional y estructural de la familia, porque cuando la madre dice "conmigo es de una forma y con el padre es diferente, me lo hace a mí, no me habla, sola habla", está claramente definiendo el contenido relacional del síntoma. La terapeuta le pregunta qué dice, es

decir que se queda en el contenido. La madre entonces le contesta que canta o repite órdenes, es vaga y caprichosa. Entonces la terapeuta le pregunta "¿lo hace a propósito?", y el padre sale a defenderla "no, no es cierto, ella está enferma, se pierde de disfrutarlo". Y la terapeuta lo incluye en este momento a Mario y le pregunta "y vos Mario, ¿qué contás?". El padre dice "él es muy buen alumno". Pienso que esta sola secuencia ya está definiendo y mostrando toda la situación de la familia y me da la impresión de cómo los terapeutas están tragados por el sistema, porque los terapeutas, con esa manobra de preguntarle a la madre si lo hace a propósito —es una evidente coalición con la niña enferma cuando la madre la califica como vaga y caprichosa, y acepta de hecho la manera de pensar del padre— se alían con él, provocan a la madre con la pregunta. El padre sale a defender a M. L. Pienso que con esto convalidan la teoría de la enfermedad que ellos traen.

**Dra. Aurora Pérez:** ¿yo puedo decirte algo? La pregunta sería ¿cuál es la teoría de la enfermedad que ellos traen?, porque una de las cosas que está clara es que no comparten los padres la misma teoría de la enfermedad. A mí me parece que en esta secuencia lo que se está jugando es quién tiene la culpa de que esta nena esté enferma. Y me da la impresión de que el padre culpa a la madre y la madre dice que no.

**Dr. Díaz Usandivaras:** En la secuencia anterior está la acusación en la que yo decía un poco irónicamente acerca de la obsesión del padre por la etiología. Es la obsesión del padre por ver quién tiene la culpa, por acusar a la madre.

**Dra. Pérez:** "Me lo hace a mí" quiere decir que es mala, está enferma, es loca, es decir, se juegan de todas maneras cualquiera de los dos rótulos mala o loca. Pero me parece que hay una lucha por definir la enfermedad en dos secuencias, en "me lo hace a mí, no me habla" y el padre dice "no lo hace a propósito, está enferma, se pierde..." y luego cuando Irene dice "se supone que hay un problema", Adolfo dice "se sabe que hay un problema", es decir, se está buscando a quién el terapeuta le va a dar alternativamente la razón.

**Lic. M. R. Glasserman:** Yo creo que en lo manifiesto ellos

plantean un desacuerdo, pero en cuanto a la idea que tienen de la chica ellos tienen una complicidad, porque la teoría del padre acerca de la enfermedad es que la chica no disfruta, no que sea loca, no disfruta y la madre dice "a mí no me hace feliz, me hace rabiar", o sea que los padres coinciden en que esta chica no disfruta, de eso está enferma, de que no les da el gusto a lo que cada uno de ellos esperaba que esta chica trajese a la familia. Entonces el problema que tienen los terapeutas es que esta gente aparentemente estaba divorciada pero profundamente están aliados en una concepción acerca de lo que esta chica debería haber sido para el núcleo familiar y no les está dando el gusto.

*Dr. Zimmerman:* A mí me parece como que hay dos líneas distintas de interpretación, es decir, lo que señaló María Rosa se parece un poco más a lo que yo había dicho primero, que había dos versiones de la enfermedad, eso implicaría una línea interpretativa en la cual lo que marcaríamos es la diferencia entre los padres, mala versus loca, caprichosa, etc. Aurora y Carlos señalaban más, como que había una secreta coalición entre los padres...

*Dr. Díaz Usandivaras:* Yo hablaba de una epistemología de la familia porque creo que de todas maneras, aunque estoy totalmente de acuerdo con M. Rosa en que la madre y el padre piensan diferente, y esa es precisamente la simetría oculta que hay en esta pareja, lo que prevalece es la concepción del padre que es de alguna manera aceptada por la madre, aunque ella no la comparte, pero ella se somete a la situación del padre, es decir que la madre es pasiva ante esta situación. Con lo cual yo creo que el resultado es que tomando a la familia como una totalidad, la construcción de la realidad a cuyo cargo está el padre, es que M. L. es una chica que está muy enferma y que ellos son totalmente impotentes para solucionar este problema. La construcción que trae la madre es diferente, básicamente es una mala conducta y que por sus actitudes podría ser algo que ella podría corregir. Este elemento me parece muy importante para el manejo terapéutico. Obviamente, como dije antes, si esa enfermedad es responsabilidad de los médicos, si es malos

hábitos o mala conducta, es susceptible que intervengan los padres.

Y esto no tiene nada que ver con que realmente pensemos que es enferma o no, yo esto lo tomo como maniobra terapéutica; no tiene nada que ver el hecho que uno niegue la epistemología de la enfermedad, no quiere decir que uno no crea en ella, simplemente como una maniobra para que los padres puedan intervenir.

Yo creo que cuando se produce esta situación de tensión la terapeuta se preocupa de bajar la tensión rápidamente y para eso lo trae a Mario; lo cual está dramatizando la situación en la cual Mario está triangulado, es decir, a Mario lo usan un poco como el repuesto cada vez que se arma el lío, cuando no sirve como tal M. L.

En la segunda sesión aparece otra vez la simetría oculta a través de eso que decía M. Rosa "andamos bien, hay un problema, se sabe que hay un problema", es decir que la que denuncia los problemas es la madre, el que dice "andamos bien" es el padre. La madre dice "hay que decirle para que diga, si ella quisiera..." con lo cual da a entender que el síntoma es voluntario, que eso también podría haber sido aprovechado terapéuticamente, M. L. lloriquea, quiere limpiarse, no quiere estar sucia, M. L. grita y entonces la madre le da un caramelo. Y acá la terapeuta hace la primera intervención relacional de lo que yo encontré en este material, cuando dice que se le pide a M. L. que diga y sin embargo cuando demuestra enojo se intenta silenciarla con un caramelo. Tal vez esto hubiera sido desde mi punto de vista más efectivo, si además de decirlo ella hubiera logrado que no la silenciaran con el caramelo y que M. L. pudiera enojarse y pudiera hablar, o por lo menos que la madre pudiera exigirle a M. L. que diga.

Hay otra secuencia, la madre dice "quiero que me hable" y la terapeuta dice "M. L. la deja sola con sus preguntas" y el padre insiste en "quiero encontrar la causa" y la madre dice "yo no le hice nada". Entonces la terapeuta pregunta "se siente culpable" y la madre dice "pienso que la cosa es conmigo", "a

mí me da bronca que no me hable" y el padre contesta "lo tenés a Mario que es charlatán".

Yo creo que el padre es un especialista en doble vínculos y transacciones descalificadoras, porque ese tipo de salida es una forma de maltratar a la madre, que obviamente la madre deja o acepta maltratarse.

Finalmente hay un señalamiento interesante de los terapeutas con respecto a la cosa confusa del padre que le pega y luego acaricia. Y es la primera vez que el padre aparece poniéndole un límite a esta chica y pienso que hubiera sido interesante elogiar el hecho que cuando era chica se portó mal y tomó una medida. En cambio se critica que haya hecho la cosa confusa y obviamente es una maniobra que perturba totalmente la comunicación.

Hay un episodio que además de gracioso me parece bastante claro con respecto a cómo muestra la estructura de esta familia: Cuando el padre castiga a M. L. porque estaba viendo T.V. y la madre cuenta que estaban viendo Matrimonios y algo más que es un programa que se da después del horario de protección al menor y que tiene características en algunos casos bastante zafado y que obviamente no es para chicos de esta edad. Tampoco la hora es como para que los chicos estén viendo TV con los padres. Creo que debe interpretarse como una evidencia clara de cómo los límites intergeneracionales están absolutamente permeables en esta familia, donde M. L. y Mario están metidos entre los padres sin que exista una barrera suficiente entre los dos subsistemas.

En la sexta sesión hay un enfrentamiento entre los padres. El padre habla irónicamente, la madre se inhibe, la terapeuta señala el enfrentamiento y con esto se borra el enfrentamiento, porque la madre de aquí pasa a hablar de lo que le pasa a ella con la hermana. Yo hubiera trabajado el enfrentamiento entre marido y mujer. Creo que hay toda una situación de seducción e inducción en el sistema, en la que los terapeutas entran porque ellos le dicen que los necesitan, que se están haciendo adictos a la terapia. "Se puso nerviosa porque extrañaba la terapia."

*Dra. Pérez:* Yo quiero referirme a algunos aspectos clínicos y algunos aspectos técnicos. Si entiendo bien el material, en la primera reunión familiar por primera vez los terapeutas se congregan con la familia; es decir, no había una entrevista previa diagnóstica de la situación familiar. Da la impresión que los terapeutas trabajan con un esquema atemporal y asociativo, donde las incorrecciones de ellos están marcando en el material las vivencias transferenciales y contratransferenciales. Se las puede deducir a través de las intervenciones y daría la impresión de que están formadas de una aplicación sobre la familia de los esquemas referenciales diádicos, de las situaciones analíticas...

Yo entiendo que esta chica es una psicótica, que es una psicosis del desarrollo. No sé cómo se habrá hecho el diagnóstico, acá está rotulado Psicótica, pero con los escasos síntomas que se vertieron en el material uno entendería que se trata de una psicosis simbiótica, cuyo comportamiento interrelacional recurre a pensar en autistas como se ve bien en la terapia individual de la chica.

Lamentablemente en la hora familiar parece no haber elementos lúdicos con lo cual la chica está forzada por el ambiente terapéutico a expresarse a niveles lingüísticos, cuando seguramente su modalidad más adecuada para empezar sería la lúdica. No sé si había elementos de juego en la hora familiar, pero en todo caso no está consignado y entonces la chica no juega.

*Dr. Díaz Usandivaras:* Ellos dicen que juega mejor, así que probablemente algo hay.

*Dra. Pérez:* Y evidentemente esta chiquita está obligada a expresarse en un código que no le corresponde tanto por la edad y que además recae sobre su síntoma, lo cual permite a la familia tenerla mucho más entrampada dentro de esta dinámica familiar que se presenta. Tal como yo lo entiendo esta chiquita estaba destinada a tener un desarrollo atípico, porque entiendo que el padre cree que los hijos deben disfrutar. La teoría de la enfermedad del padre es que la chica está enferma porque no disfruta. O sea, no es que esté enferma porque tiene un desarrollo anómalo atípico...

En el momento en que viene a la familia, porque esperaban una nena, esta chiquita está signada por las dobles ligaduras alteradas de los vínculos madre-padre y madre-madre. O sea, una nena reproduce para el padre el vínculo entre él y la madre y para la madre el vínculo entre la madre y su madre. La madre de esta chica fue expulsada del seno familiar con lo cual empezó su gran duelo sobre el duelo de haber perdido a su padre que después lo reencontró en Adolfo, pero le quedó trunco todo su desarrollo con su madre, la madre muere a los 2 años de la chica, la abuela materna. La chica hasta ese momento hablaba algunas palabras y posteriormente parece que fue perdiendo el lenguaje. Esta madre emigrada de su grupo familiar primario, perdida su ligazón con su madre, tenía que reparar sobre esta chica porque así organizan los roles materno-filiales estas situaciones de carencia. Esta chica tenía que venir para restituir en la madre este vínculo que había sido mantenido a lo largo de su historia. Por lo tanto esta chica está aislada de su propia identidad porque tiene que tener una identidad reitutiva y la madre la trata desde ese abordaje. Y el padre que encuentra una madre que él perdió traumáticamente en su adolescencia (a los 16) reencuentra en esta chica la posibilidad de reinstalar, o sea, también tiene una función reitutiva para la mente del padre. Y el padre la trata desde ahí. No debe ser una hija depresiva como él fue por la pérdida de la madre y debe revivir permanentemente la imagen de la madre eternamente viva. Lo único que les importa profundamente a esta mamá y a este papá es que esta hija del sexo femenino viva, viva y sea eternamente una muda y no exprese su propia identidad, porque si expresa su propia identidad enfrenta a los padres con la situación de pérdida y de duelo por la cual iniciaron esta perturbación en la función materno-paterna para tratar a esta chiquita. Esto me permite entender que esta chica sea una psicótica simbiótica porque han fallado todas las calificaciones llevadas a permitir el desarrollo de la identidad del chico en la medida de que esta chica tenía que dar cuenta permanente de una situación mesiánica y fundamentalmente reitutiva. Yo entiendo que un chico, o en la organi-

zación de la pareja adulta uno de los miembros, debe representar forzosamente un objeto, o sea que se restituye sobre ese cuerpo una proyección para restituir un objeto perdido, está perdida la identidad del segundo y trae muchísimas perturbaciones en el desarrollo emocional. Es frecuente ver parejas que están armadas sobre esta configuración. Yo le llamo parejas que restituyen objetos perdidos y generalmente traen trastornos enormes por esta desdicha de la identidad del sujeto...

En la medida en que estos padres no hayan podido ir calificando el desarrollo de la chica, como para que la chica se hiciera alguien diferente dentro de las proyecciones que los padres pusieron en ella, está el terror de que esta chica hable, y está el terror que esta chica diga por sí misma lo que por sí misma tiene que decir. Y ahí yo coincido con vos Carlos, en el sentido de que los terapeutas hacen una alianza inconsciente y no permiten la identidad de esta chica. Es curiosísimo que en toda la primera entrevista se habla de la chica y nadie se fija en ella y nadie dice "bueno, vos qué decís". Está permanentemente metida detrás de los padres. La alianza inconsciente que yo recién decía acerca de los padres en realidad es una complicidad para ocultarse mutuamente estos duelos, que la chica no tiene nunca que hablar ni crecer, porque ellos caerían espantados con su propio dolor. Mario está fuera de esto por su sexo y está en un sitio aparte dentro de la familia donde sí se espera que de él se logre una figura armada y que funcione.

*Dr. Díaz Usandivaras:* El mito de la familia es que las mujeres son las débiles y los varones son fuertes.

*Dra. Pérez:* Además este señor Adolfo evidentemente perturbó todo su desarrollo adolescente y su genitalidad temprana, por eso se casó con esta mujer que cayó ahí y así la obtuvo, o sea, no hizo ninguna elección ni ninguna búsqueda y tomó a esta mujer que necesitaba un padre y una madre y este hombre para esta mujer, es todo el espectro de su estructura familiar. No tiene ella otra familia que Adolfo, por lo tanto él tiene que responder a los roles materno, paterno, sexual. Ella no se puede desprender de este hombre.

*Dr. Díaz Usandivaras:* Ella está sometida a él.

**Lic. Glasserman:** No hay manifestaciones ni de hostilidad ni de pena por esta cosa de incondicional agradecimiento de esta familia que él le devolvió.

**Dra. Pérez:** El le devolvió esta familia. Esta señora está confundida. Ella vive en San Juan antes del año 76 y ha recreado esto, vive en ese delirio...

**Dr. Zimmerman:** Estoy de acuerdo con eso pero quiero hacer una pregunta. Aparece en el material, en el que la chica es vista como de otro modo a partir de los dos años que coincidiría con la muerte de la madre, esto es una hipótesis que yo hago, como hay un antecedente que la madre de esta mujer perdió a un chico que antecedió a la mamá de M. L., digo si esto no es una especie de transmisión de negación de los duelos en que como pasa muchas veces en estas familias con miembros psicóticos, los duelos son taponados e inmediatamente los lugares ausentes son rellenados con otros.

**Dra. Pérez:** Claro, entonces el duelo nunca va a aparecer y no tiene que ser otro que ese objeto que se ha proyectado sobre él. La función mesiánica del hijo está exacerbada a niveles sobredimensionados totalmente, porque es el hijo el que arma la familia. Y acá esta hija por su sexo cayó justo para restituir en ambos padres aspectos de sus objetos primarios perdidos. Entonces esta chica es la madre de la familia.

**Dr. Zimmerman:** Uno podría hacer una hipótesis como etiología de psicosis con esta distorsión de la identidad que se hace de los padres, o ese llenado de identificaciones proyectivas con las cuales no se puede asumir la propia identidad.

**Dra. Pérez:** Yo acuerdo totalmente. Por ejemplo Winnicott se dedicó a escribir situaciones similares a ésta, donde los chicos reciben las impresiones nocivas de los padres y adquieren una conducta psicótica. Probablemente esta nena sea así, no sé la relación con la terapeuta individual. Me alarma un poco porque parece mucho más autista que lo señalado, pero resguarda una interioridad, resguarda un cierto self. Cuando son tomados por un cierto terapeuta que es capaz de ir calificando adecuadamente sus situaciones emocionales, o sea, ir procesando su mente, estos chicos repuntan enormemente. Esta nena apa-

rentemente tiene un delirio, evidentemente es el juego con el patito, esta chica está identificada con un objeto incompleto. Ella juega con este patito roto y con juguetes rotos, no puede armar otro tipo de configuración, es como si ella estuviera diciendo permanentemente lo que diría un delirante "me falta una pierna", si hablara y pudiera decirlo, y remite permanentemente su pensamiento a esa cuestión "a mí me falta". Si pudiera hablar, en lugar de hacerlo con juegos, nosotros nos daríamos cuenta que su mente está fijada en esa situación y eso se debe a la falta de completud que la madre y el padre normalmente tienen que otorgar como matrices extrauterinas para el desarrollo de lo mental, que es lo que a esta chica realmente le ha faltado. Otra cosa con la que acuerdo es que la capacidad de prevenir está perturbada, porque entonces el chico deja de tener el estímulo natural para hacer una creatividad del padre con el hijo y se transforma en un objeto concreto que debe responder a ese mandato, es un robot, u otra cosa como por ejemplo, la madre del padre o de la madre como tendría que ser esta chica. Las abuelas están claramente presentes porque la madre dice que ella se llama como su abuela, etc. Así que en ese sentido, yo creo que el padre, con esta situación traumática de la pérdida de su madre a los 16 años, (hecho que nosotros consideramos como un posible organizador sustituto de estructuras normales), le hace un núcleo narcisista que desvía toda su posibilidad de desarrollo heterosexual o genital. Y parece que él ha tomado características maníacas.

Dijiste que es un artista para cambiar de dial y acá no pasó nada, estamos todos bien, porque si se tiene que conectar con todo lo que le pasa y le pasó esto sería intolerable, entonces apenas surge la ansiedad, la desvía a la madre; la madre es una resentida porque su propia madre la largó y éste es otro núcleo narcisístico muy particular. Ella está resentida y tiene que dar permanentemente cuenta de ser una persona amargado o pesimista, mucho más que depresiva. Y por lo tanto que esta chica le salga mal paradójicamente alimenta este núcleo y necesitaría que la chica continuara de la misma manera.

Ese es el punto de ceguera más importante que yo veo en



estas sesiones que nosotros hemos tenido y no sé si los terapeutas están dándose cuenta de que ellos se están aliando a que esta chica no cambie, aliándose con esta parte tan enferma de la familia. Pero lo cierto es que yo también la calificaría de psicótica con estas características, lo que llamamos una psicosis del desarrollo, ella ha quedado en un ligamento simbiótico con la madre y es el que usa para su manejo con el afuera, se mete para adentro y aparece como un autista.

**Dr. Díaz Usandivaras:** Es muy claro que la chica a través del crecimiento se transformó. En un momento dado el crecer hace que deje de ser lo que la madre quiere que sea.

**Lic. Glasserman:** Lo que sin duda da la confirmación de los terapeutas en la alianza con los padres. Es una definición que la enfermedad de la que no hay ninguna referencia directa, o sea, se habla de y no con el paciente. En ningún momento hay una referencia directa con el paciente identificado, con lo cual se acepta la rotulación de la familia. Los terapeutas están totalmente centrados bajo la interacción familiar, tomándolo a Mario que es una de las personas que habla en un subsistema parental.

Estoy totalmente de acuerdo con las transferencias relacionales nominales, el tipo de relación que tiene cada miembro con la historia de alguno, en este caso acuerdo con Aurora en el vínculo que tiene la mujer con la propia madre y que lo está reproduciendo tal cual con su hija; el destino que esta chica tiene, de vínculo de repetición. No estaba segura si esta chica estaba destinada a vivir como decís vos, o a vivir de esta manera para el padre, que es como no vivir directamente. Adolfo está acostumbrado a que no haya mujeres. Irene está agradecida por la familia que él le dio y aguanta o sostiene lo que manifiesta por momentos como queja.

**Dra. Pérez:** Yo le doy importancia a que él perdió a la madre en la adolescencia, porque en la adolescencia el varón tiene que hacer una represión intensa de los aspectos bisexuales; pero cuando un padre tiene una hija siente que él es legítimo nuevamente porque su hija está prendida como algo

que le pertenece. Por eso es que le doy importancia al sexo de la nena para este padre que perdió a su mamá.

**Lic. Glasserman:** Acerca de algunos aspectos que los autores toman como las características de la familia rígida, creo que los terapeutas en ese sentido no se han metido demasiado; la centralización absoluta del paciente que ocupa el universo de la familia y la imposibilidad de atender a todas las comunicaciones con la consecuente inutilidad de los esfuerzos hechos tanto en el seno de la familia como fuera de ella para modificar su comportamiento. Me parece que los terapeutas tenían en la cabeza pensar en el doble mensaje cuando toman esto del caramelo pero creo que no terminan de desarrollarlo.

Lo culpógeno en esta familia es peligroso porque me da la impresión que esto podría prestarse a generar culpa en alguno de ellos.

**Dr. Díaz Usandivaras:** Yo lo que hubiera hecho es felicitar al padre, porque es la primera manifestación en la que el padre aparece castigando una mala conducta de M.L. (aunque fuera obviamente una mala maniobra), poniendo límites.

A mí me gustaría tener una idea desde lo familiar, con este caso, qué hubiera hecho y cómo cada uno de nosotros, porque creo que está muy claramente desarrollada la comprensión del caso, de cuál es la dinámica, pero desde lo familiar, desde la terapia familiar qué se puede hacer y cómo.

**Dra. Pérez:** Una de las cosas que me parece que está poco desarrollada es la indagación sobre situaciones triangulares y permanentemente hay vínculos diádicos, sin una indagación que llegue a acuerdos o desacuerdos con respecto a la conducta de esta nena. Me parece que estamos centrados en el subsistema parental...

**Dr. Díaz Usandivaras:** No en cuanto a fijarse objetivos de la estrategia a lograr, es decir, cuáles son los objetivos que buscaría cada uno de nosotros y cómo trataría de conseguirlos.

**Dr. Zimmerman:** Me parece que uno de los objetivos es lograr que M.L. tenga un lugar, habría que restituir o constituir esta identidad perdida que nunca tuvo y tratar que M. L. deje de ser el muñeco que han armado los padres y empiece a ser



ella, para lo cual habría que señalar cómo M. L. es una especie de muñeco ventrílocuo que hablada constantemente por los padres. Creo que ese trabajo cabalga sobre un trabajo de duelo. Creo que los dos trabajos van juntos, creo que si ha cumplido esta función sustitutiva es porque tapona toda la vertiente emocional de la cual no se puede hablar y que constituyéndose así en ese muñeco mudo impide toda la elaboración de los duelos. Esto es muy general pero creo que es a lo que apuntaría.

**Dr. Díaz Usandivaras:** ¿Cómo lo harías?

**Dr. Zimmerman:** Iría señalando, me parece, como no se la deja hablar a M. L., qué es lo que no se quiere que diga M. L., a quién sustituye este charlatán, en reemplazo de qué. Creo que es un trabajo largo, mi modo de trabajar es a la larga, sería como pasos sucesivos que iría dando hasta lograr hacerla salir de esta trampa. Ya desde el vamos es importante ver cómo es esta chica con los padres, qué lugar ocupa y ver cómo los terapeutas han entrado en esa coalición con los padres.

**Lic. Glasserman:** Yo dije que me iba a referir a algunos aspectos técnicos que de alguna manera son una censura al modo de trabajar de estos terapeutas. Yo en primer lugar no hubiera trabajado sin una entrevista familiar diagnóstica, los hubiera reunido a todos con elementos lúdicos y con una consigna de que pueden utilizar lo que quieran de lo que hay allí, de modo de ver además de los mensajes verbales, lo que los elementos lúdicos aportan. Los que trabajamos con chicos sabemos que a través del juego se complementa información que a veces hasta es negada verbalmente. También hubiera estado muy atenta a lo gestual en una familia como ésta, a las miradas, a cómo se comunican entre ellos, para tener más datos de todo lo que no tienen que esconder con la gravedad de la situación. Entonces hubiera hecho algunas correlaciones acerca de cómo estaba la pareja matrimonial, la situación matrimonial, cómo desempeñan los roles materno-paterno, para eso yo me fijo mucho cómo gesticulan, qué hacen al entrar, quién abre la sesión diagnóstica, para ver realmente quienes tienen las tareas penetrantes, quienes las receptivas referidas al orden

masculino y femenino y sobre todo cómo es el estado de los vínculos, digamos así un poco como lo manifiesto y de ahí por los gestos y por la parte lúdica trato de darme cuenta de qué es lo que pasa entre esos vínculos.

La situación transferencial, en la familia no la hago una aplicación tal cual de la situación bipersonal, espero que se plantee en algún momento y trato de ver cuál es el enlace transferencial que la familia ha hecho conmigo. Así que hubiera utilizado sobre todo lo que voy sintiendo a lo largo de la entrevista diagnóstica; me parece muy importante hacer esa entrevista aunque esté muy cantado el diagnóstico del miembro enfermo, porque sé que va a depender del estado de la red familiar lo que yo pueda ir revistiendo. Entonces si yo hubiese hecho eso acá, suponiendo que me gastara con esas observaciones, habría pensado que estos padres tienen una patología importante cruzada con la historia de cada uno de ellos, y a lo mejor hubiera pensado alternar entrevistas familiares con otras parentales. Entonces le hubiera dicho a la señora "mire la nena se sentó al lado suyo, así que parece que la nena espera que usted hable por ella, ella se esconde detrás suyo". Eso lo hubiera dicho en la diagnóstica y a lo mejor cuando trabajo con los padres trabajo más a fondo el hecho que esta señora sobreimprime a la chica y el marido la deja, hubiera ido trabajando en la gravedad del vínculo hasta que ellos tomen conciencia de lo que pasa con esto. Hubiera tratado de precisar más el rol de Mario, quien no sé muy bien cómo interviene. Probablemente tiene una competidora muy fácil dentro de la familia... entonces no hace nada. Tiene todo: familia, madre, padre. Todo para él. Este es uno de los fenómenos más corrientes en una familia, con un miembro enfermo tan grave. Hubiera trabajado con esa manía de él, que le permite pensar que puede tener los dos roles... Pero eso son construcciones. Hubiera apuntado a trabajar con la familia de esta manera: interpretando los circuitos vinculares y traduciendo los a algo comprensible para ellos.

**Dr. Díaz Usandivaras:** Cuando vos querés, por ejemplo, frenar la actuación de la madre te limitás a frenarla solamente con un señalamiento o por interpretación.

**Dra. Pérez:** No, a veces incluyo la construcción y le digo me parece que usted está haciendo esto por tal cosa.

**Dr. Díaz Usandivaras:** Por ejemplo, llegarías a evitar que lo haga.

**Dra. Pérez:** Sí.

**Dr. Díaz Usandivaras:** Decirle por ejemplo, no hable usted por ella, o déjela hablar.

**Dra. Pérez:** No es mi modalidad pero digo me parece tal cosa, trato que ellos se persigan lo menos posible, pero sí lo hago, y además puedo decir mire "usted ve que la mamá no deja hablar a la nena pero está muy tranquilo". Y después cuando puedo, inserto lo que entiendo que está pasando. No trabajo con la línea de esperar asociaciones libres y sobre el contenido manifiesto de la asociación libre.

**Lic. Glasserman:** Es interesante lo que decís porque la comprensión teórica tiene muchas pautas diferentes, sin embargo la técnica a pesar de la lectura es exactamente la misma, por ejemplo, con el ejemplo que vos diste de la madre que frena a la hija, yo le diría que me parece bien que la frene...

**Dra. Pérez:** Yo suelo utilizar las interpretaciones históricas pero con mayores explicaciones, porque a veces temo que quede muy críptico. Esta señora para mí es una pobre señora y creo que distorsiona las cosas para poder mantener un cierto mundo.

**Dr. Díaz Usandivaras:** Yo creo que más distorsiona el padre que la madre. Obviamente creo que está todo distorsionado. La lectura que hago es que la madre está en una situación inferior y el padre en una muy superior. La madre está totalmente desinflada y la chica está instigada por el padre que permanentemente alimenta la cosa. La única que ha dicho algunas cosas tendientes a buscar una solución diferente a lo que hicieron hasta ahora es la madre, lo que pasa es que no la deja y ella se somete además. Yo hubiera encarado la cosa tratando de levantar a la madre, de rescatar todos los momentos en los que ella redefine la situación como mala conducta, para tratar de poner al padre a cargo de la chica, y que se ocupe. Que trabajen y se pongan de acuerdo, que puedan llegar a un acuerdo en la

pareja, alguna crianza parental mínimamente satisfactoria porque hay una situación de conflicto muy grande entre ellos.

**Lic. Glasserman:** Yo también tomo muy en cuenta sacar a la pareja de padres porque paradójicamente se esconden en la familia, porque esta gente tiene un divorcio matrimonial.

**Dr. Díaz Usandivaras:** Vos te ocuparías de lo matrimonial.

**Lic. Glasserman:** Depende del momento de la evolución de la situación, yo no la forzaría con más terapeutas. Me parece contraindicado incluir más terapeutas.

**Dra. Pérez:** Me acuerdo que Selvini Palazzoli planteó un caso parecido, había una diferencia muy parecida de edad entre el padre y la madre, ellos lo entendían como que esta chica tenía el destino de ser psicótica porque le garantiza al padre que la madre no se va a mover de su casa.

Una de las preguntas que yo haría es si la mujer tiene proyectos propios, fuera de la familia, trabajar, salir. Porque hay dos modelos familiares muy distintos: la madre vivió un poco disgregada y el padre vivió una formación casi feudal.

**Lic. Glasserman:** Lo único que quiero acotar es que esta familia realmente necesita el tratamiento, porque es una trama muy enferma para los padres y los hijos, pero hay que tener cuidado porque esta pareja —no me refiero a pareja matrimonial sino parental— necesita una atención en forma particular.

**Dr. Díaz Usandivaras:** Una forma que pueda funcionar como pareja marital es ayudándolos a que funcionen como pareja parental. Yo intentaría que empiecen a funcionar como padres de M. L., que puedan llegar a un acuerdo, que no tengan esta lucha en la que el padre dice una cosa y la madre otra. A través de ese encuentro que salgan M. L. y Mario del medio y se pueda llegar a alguna elaboración de lo marital, que mejoraría si ellos consiguieran formar una pareja parental.

**Lic. Glasserman:** Sin duda hay una interrelación directa entre los éxitos en la crianza y el incremento libidinal de la pareja matrimonial. Eso es importante, hay un chico que fracasa, porque esta pareja que fracasa tiene un hijo fracasado. Yo haría terapia familiar y parental con el mismo terapeuta.

## ATENEO CLINICO

**Dr. Díaz Usandivaras:** Me impresiona como una técnica psicoanalítica en familia.

**Dr. Zimmerman:** Es lo que podríamos llamar la estructura inconsciente de la familia y todo lo que desde el pasado está constituyendo esta familia, por lo cual se toma el genograma.

**Lic. Glasserman:** Desde el punto de visto técnico nunca tomo ese tipo de material en una sesión.

**Dra. Pérez:** Nosotros tomamos cuatro entrevistas diagnósticas, y hacemos una ficha clínica en la que los pacientes construyen el genograma solos.

## COMENTARIOS DE LIBROS

### Psicoanálisis de las relaciones familiares

JUAN CARLOS NOCETTI

Torres Agüero Editor. Buenos Aires. 1983.

Quien ha seguido la obra de Juan Carlos Nocetti a través de sus numerosos artículos o conferencias, encontrará en este libro una culminación coherente y organizada de la línea teórica que ha venido desarrollando. Como lo dice Isidoro Berenstein en el prólogo, el libro acompaña al autor en la ruta de su pensamiento, tributario, por otra parte, del que aquél inauguró en su libro *Familia y Enfermedad Mental*.

Berenstein opina que el libro es de fácil lectura; Nocetti, por el contrario, advierte sobre sus dificultades. Nosotros pensamos que es un libro denso, reflexivo, que a través de ciertas redundancias lleva al lector a la profundización progresiva de los conceptos que se exponen. Cada capítulo tiene una introducción clínica como soporte empírico de las ideas que en ellos se van exponiendo.

La pregunta inaugural del primer capítulo se refiere a la forma de saber a partir de la cual se puede llegar a delimitar el objeto teórico de investigación de las relaciones familiares. El desarrollo de ciertos temas, tales como la crisis del paradigma newtoniano, la nueva concepción de la realidad física, el concepto de organización, la proposición de un paradigma científi-

co, su impacto en las ciencias humanas, el objeto de conocimiento de las investigaciones familiares, lleva a la conclusión de que es posible construir una doctrina científica de las relaciones familiares a partir de la definición de su objeto de conocimiento en tanto modelo ordenador de esas relaciones, pudiendo llamarse estructura inconsciente a la formalización de esa organización.

En el capítulo siguiente se intenta obtener el modelo semiótico que permita el ordenamiento de la crónica proporcionada por una pareja, a través del conocimiento de las reglas del juego semiótico en el orden de las relaciones familiares. "Se trata de determinar, desde una teoría semiótica, las formas de producción de sentido y su modo de existencia en el relato". Es decir, que al tomar al relato como objeto de análisis para el diagnóstico y pronóstico, se está tomando al lenguaje como centro de la reflexión. El mundo extralingüístico al cual hace referencia el relato, es el lugar de la manifestación de una significación; en la búsqueda del modelo constitucional de la significación, se trata de comprender el problema de la pareja. De esta manera, sus intercambios adquieren un orden, una organización, que es diferente de aquella que les otorga la pareja misma, cuando intentan explicar y explicarse qué les pasa, orden teórico diferente del empírico, tal cual fue propuesto por Berenstein.

Esto se relaciona con las reglas de la organización familiar, las que no siendo pasibles de observación, determinan sin embargo las condiciones de existencia del sistema de relaciones y su modo de realización. Son ellas las que se definen como objeto de conocimiento de una teoría científica de las relaciones familiares, en la medida que tienen un carácter trasindividual y objetivo, en que su constitución es independiente de la naturaleza de los participantes, no es conocida por los mismos y por lo tanto alcanzan eficacia y se prestan a un tratamiento riguroso y formalizable.

"Pensar que las relaciones familiares constituyen un sistema, es señalar que obedecen a una organización que se manifestará a través de constricciones al libre juego de las interacciones, constricciones que serán a la vez condiciones de su perdurabili-

dad". Este tema se desarrolla en el tercer capítulo, donde se replantea la teoría del sistema de las relaciones familiares. Se puede pensar al grupo familiar en términos de los principios generales que gobiernan el funcionamiento de los sistemas, en virtud de las reiteraciones que un grupo realiza en sus configuraciones posibles, las que aluden a una organización cuya función es la de preservar la invariancia de las relaciones. La presencia de una invariancia supone una constricción y como tal, una ley. De este modo las relaciones familiares están restringidas en la variedad de sus transformaciones.

Con estos conceptos se liga el de estabilidad del sistema, que se apoya finalmente en la permanencia del sentido (el cual a su vez descansa sobre las relaciones que lo determinan) y no en sus manifestaciones pasibles de cambio. Bajo éstas hay reiteraciones de combinaciones constantes, que son la expresión de una estructura lógica que les otorga coherencia.

La supervivencia del sistema a la que todos los miembros contribuyen sin saberlo se pone en juego así en la preservación de la identidad diacrónica, con métodos de regulación concretados mediante la acción de reglas no conscientes. Dicha concepción supone una oposición a un modelo que proviene de un marco teórico evolucionista, el que por medio de conceptos tales como el de crisis vitales (casamientos, embarazos, nacimiento de los hijos, etc.) daría cuenta de cambios profundos en la estructura. Por lo contrario, no es cuestión de explicar cambios en la estructura por transformaciones manifiestas, sino diferentes configuraciones por medio de invariancias profundas.

De aquí, el análisis estructural, tema del capítulo cuarto. Siguiendo a Levi-Strauss, el autor propone que los fenómenos sociales pueden ser pensados como un lenguaje, "el único que hoy parece susceptible de un estudio verdaderamente científico que explique la manera en que se ha formado y prevea ciertas modalidades en su evolución ulterior", como dice el antropólogo francés, y reconstruir entonces las reglas que lo organizan.

De esta manera se hace posible proponer un modelo constitucional de la organización de las relaciones familiares a fin de asegurarse una mayor rigurosidad en las operaciones clínicas, si

se considera que las relaciones familiares están estructuradas como un relato, producto a su vez de un sistema de oposiciones correlacionadas. Con respecto a esto, el autor desarrolla las ideas del lógico francés Robert Blanché, quien propone que existen ciertas estructuras elementales que constituyen condiciones fundamentales del pensar, las que se organizan como familias de ideas gracias a nexos que la lógica llama operadores. Los sistemas oposicionales, organizados en pares dicotómicos de ideas, ordenan la vida afectiva tanto como la articulación de las valoraciones, como estructuras cuya importancia, por tal motivo, no puede ser subestimada. De esta manera, un relato familiar (en este caso el que se transcribe en el capítulo) puede ser pensado a partir de la consideración de estructuras semánticas oposicionales que lo ordenan, las que otorgan significación en tanto significantes en el sistema que la familia constituye, a cada uno de sus miembros, como así también a todos los términos que por éste circulan, (objetos, bienes, valores, mensajes).

Vale la pena transcribir textualmente lo que dice el autor al comienzo del capítulo, que lleva por título "La estructura elemental de las relaciones familiares":

"Suele aceptarse que el punto de partida de todo intento de comprensión psicoanalítica de las relaciones familiares está constituido por el modelo teórico denominado Complejo de Edipo. La riqueza de este modelo, la incuestionabilidad y validez de su valor explicativo, dejan fuera de toda duda su pertinencia en la tarea de dar cuenta de los fenómenos en juego.

Desde la perspectiva de una teoría de las relaciones familiares pone en evidencia, sin embargo, las limitaciones propias de todo intento de explicar un sistema por sus elementos. Conduce además, frecuentemente, a consecuencias poco fructíferas tanto teórica como técnicamente. La traspolación no crítica a conceptos a él ligados (identificación, transferencia, narcisismo, etc.), la reificación de las determinaciones y la definición lineal de las relaciones causales, son algunas de ellas.

Hay pruebas suficientes como para pensar que las relaciones

familiares se encuentran organizadas como un sistema. Ello obliga a una inversión en la dirección de nuestras investigaciones, con lo cual el complejo de Edipo aparece como una consecuencia de las leyes de organización de ese sistema. Por tal razón, en este capítulo, propongo echar una ojeada al sistema de parentesco."

A partir de aquí, se desarrollan los conceptos de Levi-Strauss acerca de las diferentes maneras de organización de los sistemas de parentesco, los que han surgido bajo el imperio del tabú del incesto, que impide uniones endogámicas, de tal manera que la unión heterosexual en las distintas culturas está regida por una serie de prescripciones y prohibiciones.

La interdicción genera el principio del intercambio entre los grupos, el que está sujeto a una reglamentación que proviene de la reciprocidad: los varones no pueden tomar mujeres de su propia familia, deben cederlas a los de otra, quienes, a su vez, cederán las suyas. Este acuerdo social genera, sin embargo, en razón del difícil renunciamento que supone, una hostilidad que debe a su vez ser objeto de reglamentación social. Nocetti encara la consideración de estas reglamentaciones desde tres perspectivas: los grupos de filiación, el régimen de residencia y la influencia de la lateralidad. Los diferentes modos en que cada grupo intenta solucionar estos problemas, dependen del régimen de residencia, el que, de acuerdo a su coincidencia con el linaje predominante (filiación paterna o materna) puede ser patrilocal o matrilocal, siendo denominado neolocal cuando no coincide con ninguno de los dos. El problema de la lateralidad aparece cuando es necesario determinar la ingerencia que tendrá cada una de las familias de origen de los cónyuges, en los diferentes acontecimientos en la vida del matrimonio.

Existen diversos modos de intercambio social, que se van complejizando hasta incluir todos los grupos de la comunidad a través de la circulación de las mujeres quienes son así las encargadas de ligar a todas las familias en nexos que, abandonando las leyes biológicas, sustentan las culturales.

En estos intercambios se pone de manifiesto la tensión existente entre las relaciones consanguíneas y las relaciones de

alianza, que incluye oposiciones tales como patria potestad y matrilocalidad, matrimonio y patrimonio, oposiciones que definen la estructura constitutiva de las relaciones familiares, donde se perfila el poder de la familia materna (la que cedió a la mujer) oponiéndose a la relación de alianza de una manera más nítida y encubierta.

Al referirse a los problemas del desprendimiento de las familias de origen, dice el autor: "Esta asimetría es concordante con la que corresponde a las vicisitudes del complejo de Edipo y su final en el varón y la mujer. También el desprendimiento de sus respectivos linajes ostenta esta marca. El de la mujer es más penoso y prolongado. (...) Ahora bien, ¿qué ofrece el marido en compensación ante tanta pérdida? En principio la oportunidad de continuar un proceso que atañe a su desarrollo psicosexual. Pero ello se equilibra con la seguridad y las gratificaciones infantiles que la ligan con sus parientes consanguíneos y a éstos con ella". Dirá en la introducción clínica en el capítulo quinto: "Lo que toda familia debe afrontar en su constitución es este antagonismo cuyos modos de resolución plantean tantas dificultades como las paradojas a los lógicos. Es que también aquí, las mismas formas de razonamiento que se han erigido para defender un orden definido como válido, engendra contradicciones, que se reducen finalmente a la oposición entre naturaleza y cultura. La estructura de las relaciones familiares debe ser pensada como la estructura de las paradojas, y de esta manera es como se expresa en las sesiones.

Este sería el modo en que deben pensarse las cuestiones acerca de la normalidad y la patología, los trastornos de desarrollo o las crisis vitales —conceptos que se rechazan como modelos para la comprensión de las relaciones familiares— es decir, desde una teoría lógica acerca de la comprensión, formulación y resolución de antinomias, teoría que permite pensar problemas sólo pasibles de definición desde un orden semiótico.

Es en el capítulo quinto donde se desarrolla con mayor detalle el concepto de estructura inconsciente, nódulo teórico de esta concepción de las relaciones familiares. Para acceder a

este tema, es necesario compartir con el autor, según éste lo reclama, la idea freudiana de que el psicoanálisis es fundamentalmente un método de investigación de procesos mentales prácticamente inaccesibles de otro modo, así también como concordar con Bateson acerca de los límites y alcances de la "localización" de lo que se denomina inconsciente. Estructura inconsciente es un concepto introducido por Berenstein en 1976, a fin de diferenciar el orden empírico, observable de las relaciones familiares, del orden teórico, no perceptible, que se ocupa del conjunto y aquello que lo considera como tal y cuyo reconocimiento puede estar obstruido por modelos conscientes o inconscientes. Esta estructura se refiere a tres modelos que ordenan los datos observables para extraer de ellos una significación: 1) un modelo sincrónico por el cual se puede poner de manifiesto aquello que no es percibido por los miembros de la familia en la configuración actual, 2) un modelo diacrónico que rescata lo históricamente significativo a través de ciertas invariancias configuracionales y 3) un modelo estructural que es el que da cuenta del sistema de oposiciones "que regula la constitución de la organización familiar como parte de un sistema de parentesco que obliga a considerar a la familia actual en su relación con la familia materna como fuente y origen de las significaciones". En estos modelos teóricos se sustentará la interpretación en la doble relación que ésta establece con ellos por una parte y con los datos empíricos por otra.

El libro finaliza con un epílogo clínico. En él se considera el problema de ordenar los elementos significativos de un relato familiar para que este adquiera coherencia y racionalidad. Se ofrecen cuatro vías de aproximación a la organización que ordena ese sistema. Ha aclarado previamente, que el relato no es los hechos mismos, que el relato del relato tampoco lo es, pero que debe existir un cierto isomorfismo entre cada uno de ellos como para poder dar cuenta del objeto de estudio.

Esas cuatro vías son: el intercambio de mensajes, el intercambio de mandatos, el intercambio de mujeres y el intercambio de significaciones.

Por último, el autor se refiere a una serie de consideracio-

nes técnicas. Tomando en cuenta las dificultades que presenta el caso clínico utilizado como ejemplo en este capítulo, señala que el problema no radica en la comprensión del material, sino en cómo encontrar la manera en que el terapeuta pueda ser escuchado y comprendido. No acuerda con las maniobras terapéuticas de los investigadores de Palo Alto, que buscarían activamente producir cambios en el sistema familiar, ya que estos resultados pueden ser espectaculares pero poco duraderos, tampoco de esta manera se impiden las deserciones, y por encima de todo, se minimiza el carácter autocorrectivo que la organización de las relaciones familiares comparte con cualquier sistema ecológico. Toda acción tendiente a modificarlo sin tener en cuenta o conocer suficientemente la compleja interrelación de las variables en juego, puede generar, como Bateson mismo lo sostiene, "curvas potenciales de cambio" que pueden ser ineficaces o, peor aún, peligrosas.

Existen familias, como las del caso clínico citado, frente a las cuales es muy difícil establecer una relación analítica si antes no se ha logrado un consenso que defina la situación de discurso en la que aquélla tiene lugar. Se propone, para que el análisis sea posible, el uso de ciertas normas técnicas, que toman en cuenta los modos de regulación familiar y el monto de información acerca del mismo que los miembros de la familia puedan procesar y compartir. Es entonces la información que el analista pueda suministrar acerca de sus fuentes de perturbación, el único medio por el cual lograrán producir las modificaciones que buscan.

Nos parece incuestionable la riqueza conceptual que el libro —del cual la reseña que antecede no puede ofrecer más que una somera idea— aporta para encarar el difícil y apasionante tema del tratamiento del grupo familiar, la ampliación de las categorías que permiten dar cuenta de los hechos observables, la búsqueda de un rigor científico en el que está implícito un respeto que se pone en evidencia en su postura "técnica". Es por eso mismo que estimula el pensamiento y propone un diálogo con el lector, ya que al responder a ciertos interrogan-

tes, no deja de suscitar otros. Nos referiremos sólo a algunos de los que se nos han planteado al respecto.

El concepto teórico de estructura inconsciente es atractivo y ciertamente puede enriquecer el acercamiento a la comprensión de la organización de las relaciones familiares, pero deja lugar a ciertas dudas. El psicoanálisis investiga la producción de hechos psíquicos que se postulan como derivados de la eficacia de un inconsciente que, en tanto tal, supone a la pulsión y al deseo. La estructura inconsciente de las relaciones familiares es un modelo teórico que se refiere básicamente al orden lógico que organiza hechos de naturaleza social, pertinentes a la constitución u origen del grupo familiar y a la articulación dentro del mismo de oposiciones que en última instancia se postulan como expresión de otra oposición constituyente, la que existe entre naturaleza y cultura. ¿Pero da suficiente cuenta de los hechos psíquicos involucrados en esta oposición?

El concepto de inconsciente constituye ciertamente un problema nodular para quien quiere comprender lo que acontece cuando varios aparatos psíquicos se encuentran en mutua relación. La noción de sistema es fructífera y da efectivamente razón de los hechos que se producen en un contexto familiar. Pero esta noción, según Nocetti, no podría ser abordada desde el modelo del complejo de Edipo, por su carácter elementalista y conducente a explicaciones basadas en una causalidad lineal.

Nos preguntamos el por qué de esta concepción, ya que desde la teoría freudiana, bien podemos entender que la noción de sistema familiar está ligada a la noción del Edipo como estructura, como por otra parte queda implícito a través de diferentes conceptos (identificaciones, formación del Superyo, elección objetal, significación del hijo para los padres en función de su deseo). Las ideas de Bateson, acerca de la imprecisión de la localización del inconsciente, no resuelven el problema que se plantea desde esa óptica.

Creemos que la utilización de un modelo semiótico es un interesante aporte y facilita un modo de organizar los datos de la experiencia "clínica". Concordamos con el autor en que es necesario postular la existencia de una estructura inconsciente



que otorgue racionalidad al sistema familiar en sus manifestaciones empíricas. Pero dejaríamos planteada la idea de que el psicoanálisis como método de investigación dispone de una teoría riquísima para entender esa estructura, la que a su vez puede enriquecerse aún más aplicada al campo de las relaciones familiares. En efecto, es en el contexto de las sesiones de grupo familiar donde pueden investigarse por ejemplo, cuáles son los mecanismos de producción de significados, en aquello que atañe a las leyes que rigen la intersubjetividad; a través de qué vías se relacionan los inconscientes de cada uno de los integrantes y los efectos que la estructura deseante de cada uno, con sus defensas específicas, produce en los otros; cómo y por qué se constituyen formaciones de compromiso, tales como un síntoma o una elección objetal, como efecto de los intercambios que se producen en la familia. Recordemos, por ejemplo, que Freud dejó asentado el hecho de la comunicación de inconsciente a inconsciente como una de las leyes que rigen la relación entre dos individuos, como en el caso de una pareja. ¿Puede estar ligado a ello el hecho de que todos los miembros de una familia contribuyen, sin saberlo, a perpetuar el sistema?

A nuestro juicio y desde este punto de vista, el concepto de estructura inconsciente tal cual es definido en el libro, podría completarse con una construcción de naturaleza intermedia, tal vez más ligada a la clínica; una estructura que diera cuenta de la articulación mutua de las configuraciones "deseantes" de cada integrante de la familia, otorgando, en función de ello, lugares definidos y recíprocos para cada uno y por eso, intrínsecamente relacionados entre sí. (Esto se vincula con otras cuestiones concernientes a la clínica. Cuando, desde el punto de vista estructural, se propone escuchar el relato del conjunto, sin importar quién dice qué, parecería quedar salteado el problema concerniente a determinar cómo y en virtud de qué, cada uno contribuye a mantener la estructura vigente y es a su vez influido por ésta. ¿Es lo mismo, la posición de un niño con su particular estructura psíquica, que la de la madre o un abuelo? ¿Las interpretaciones serán escuchadas o decodificadas

del mismo modo si se formulan invariablemente desde un "Uds." que los unifican?

En este contexto, conceptos tales como narcisismo, identificaciones o repetición, adquieren en efecto nuevo sentido, sin tener por ello que ser abandonados. El concepto de repetición, particularmente, se complejiza, pero no queda desvinculado de su legalidad inaugural, la del deseo. En todo caso, se abren las vías para profundizar en su comprensión, en una causalidad que, sin abandonar la teoría psicoanalítica, y justamente por eso, nos parece estructural y no lineal.

Con esto, no estamos negando el papel de la familia materna y el hecho de su frecuente aparición en los grupos familiares que tratamos, en un vínculo conflictivo con la relación de alianza. Muy por el contrario, lo que nos interesa es entender esta relación desde un punto de vista psicoanalítico.

Respecto a esta cuestión, nos formulamos otro interrogante: ¿puede considerarse que, en los vínculos correlacionados que establece con el padre y la familia materna, la posición del hijo varón es similar a la de la mujer? Nocetti se ha referido explícitamente a las diferencias del complejo de Edipo femenino y masculino, ligándolo, de alguna manera, con las reglamentaciones sociales de la relación de alianza. ¿Cómo se explicaría, desde la estructura propuesta, la difícil relación que la mujer tiene con su suegra, que implica la relación de la mujer con otra mujer, como un término escindido de su relación con el varón? Hecho que alude a la circulación de los hombres en el universo de las mujeres, es decir, a la rivalidad de éstas entre sí, y al lugar que ocupa la madre para la hija como interdictora de la sexualidad. Lo que, por otra parte, remite nuevamente al complejo de Edipo y al de castración con el que está íntimamente ligado.

Uno de los ejemplos clínicos del libro es el de la familia King (material tomado de *Cordura, locura y familia*, de R. Laing). El predominio de la familia materna, en este caso, es incuestionable. Pero hay otro hecho, incuestionable también: el poder predominante de las mujeres. Dentro de la familia materna, el padre de la señora King, ocupaba el mismo lugar que el



## LIBROS

de su esposo: un apéndice del universo netamente femenino (si así se lo puede llamar). Es decir, que junto a la oposición familia materna - relación de alianza, encontramos otra que es mujeres - hombres. Caso, por otra parte, muy frecuente en nuestra experiencia clínica, donde el representante poderoso de la familia materna suele ser la abuela y la función del padre, en ambos grupos, el de origen y el de alianza, como en los King, se encuentra notoriamente desdibujada. Así, lo que desde el punto de vista social se denomina el operador matrilineal, parecería estar vinculado a lo que desde el punto de vista psicoanalítico podríamos denominar el operador castración. Proponemos la idea de que ambos pueden estar, efectivamente, ligados. En todo caso, tal vez es ésta una de las muchas direcciones que quedan abiertas para continuar investigando.

Hechas estas apreciaciones, diremos que a nosotros mismos nos sorprende que hayan surgido en lo que debiera ser, tal vez, una más escueta reseña. Creemos que se han generado gracias a lo que consideramos la originalidad y la fuerza del conjunto de hipótesis que la obra plantea; una de sus virtudes es, precisamente, poder suscitar una reflexión que pretende ser constructiva, en el marco siempre abierto del pensamiento científico.

*Gisela Ahlin*

---

### Análisis de la relación de pareja

---

ALBERTO C. GONZALEZ

---

*Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1979.*

---

No abundan en nuestro medio los textos originales dedicados al estudio de la relación de pareja, su patología y su tratamiento psicoterapéutico. En un campo donde hasta hace muy pocos años la bibliografía era predominantemente de origen anglosajón, el libro del licenciado Alberto C. González "Análisis de la relación de pareja" significa una valiosa contribución de un autor nacional al tema. Sus destinatarios son no sólo los principiantes en este terreno sino también los profesionales con experiencia para quienes —según las palabras liminares— "puede permitir una confrontación dentro del marco de experiencias comunes y quizá constituirse en un estímulo para reflexiones y nuevos planteos que esclarezcan este complejo y sin duda apasionante tema."

Después de definir brevemente el campo de estudio y los problemas teóricos y técnicos que éste despierta, González explicita y conceptualiza los esquemas referenciales con los cuales se propone abordarlo, el psicoanalítico y el comunicacional. Del primero destaca las nociones de relación de objeto,

## LIBROS

identificación proyectiva, complejo de Edipo, Superyó e Ideal del Yo y elección de objeto (narcisista y por apuntalamiento). El repertorio proveniente de la aproximación comunicacional es mucho más vasto aunque algo impreciso en la definición de algunos conceptos y en la inclusión de otros —el de mito por ejemplo— que poco o nada tienen que ver con el enfoque comunicacional. Además de la de mito se incluyen aquí las nociones de sistema interaccional, retroalimentación, red, definición de la relación (reglas y puntuación), confirmación, desconfirmación y rechazo, colusión, complementariedad, cisma y sesgo.

Con este instrumental ecléctico —no muy distinto por otra parte del que manejamos la mayor parte de los familiólogos— González nos muestra de qué modo trata de desentrañar e interpretar las vicisitudes de las relaciones de pareja. Pero a la “hora de la verdad” —la del trabajo con los pacientes— los esquemas no siempre se adaptan con facilidad a los hechos clínicos y los engranajes mal lubricados chirrían al cambiar de uno a otro. Así sucede por ejemplo, con los conceptos de transferencia y contratransferencia que González utiliza sabia y provechosamente desde su formación psicoanalítica (los reconocimientos prologales van dirigidos a Carmen y Ernesto Liendo y a su propio psicoanalista individual, el Dr. Abraham Benchetrit) pero que se armonizan mal con las definiciones de Haley o Minuchin y peor aún con el papel de “terapeuta que conduce la entrevista de manera que se precisen aquellas conductas que (los miembros de la pareja) quieren cambiar y por cuáles.” Dicho de otro modo: me parece que González funciona *at his best* cuando se deja guiar por su fino olfato psicoanalítico y por una delicada y precisa lectura de sus vivencias contratransferenciales. Menos satisfactorias me resultan sus reflexiones *a posteriori* sobre lo acontecido en la sesión que suenan algo esquemáticas o la planificación *a priori* —que me resulta artificial— de sus intervenciones terapéuticas.

Una reflexión final. El libro lleva pie de imprenta del año 1979 y hasta donde yo sé no ha sido reeditado en estos cinco años. En el interín su autor se ha alistado de pleno en las filas

## LIBROS

de la terapia sistémica y sospecho que no debe resultarle demasiado grato evocar este juvenil pecado psicoanalítico (o cuasi). Mi deseo personal sería que González lo retomase, y con la distancia que dan los años y la adquisición de conocimientos, nos ofreciese un nuevo volumen que reelaborase críticamente sus experiencias clínicas a la luz de los sucesivos esquemas referenciales que ha ido transitando. Sus lectores —y yo el primero entre ellos— le quedaríamos sumamente agradecidos.

*Edmundo Zimmerman*

---

INFORMACIONES

---

**ELECCION DE AUTORIDADES**

El 30 de noviembre de 1983 fue realizada la elección de autoridades de la Comisión Directiva de la Sociedad por el período 1983-85. La lista ganadora estuvo compuesta por: Presidente, Psic. Alberto González. Vicepresidente I, Lic. Zulma S. de Orlando. Vicepresidente II, Dra. Susana F. de Bullrich. Secretario, Dr. Saúl Karol. Tesorero, Dr. David Libedinsky. Vocales Titulares: Lic. Susana Barilari, Lic. Martha Schejtman, Dra. Luciana Sartoris, Lic. Silvia Stuhlman, Lic. Aída Tarrab. Vocales Suplentes: Lic. Raquel Guilligan, Lic. Norma Iurcovich. Revisores de Cuentas Titulares: Dr. Marcos Berstein, Lic. Julia Korembli. Revisores de Cuentas Suplentes: Dra. Rosalinda Gusberti, Dr. Rafael Skiadaressis.

**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 1984**

Además de las actividades ya realizadas que han incluido cursos, conferencias y debates, se proyecta entre otras cosas:

27 y 28 de julio: Jornadas sobre formación de terapeutas, que reunirá a terapeutas experimentados en capacitación de Buenos Aires y del interior del país.

5 y 6 de octubre: Jornadas epistemológicas, que contarán con la presencia del Dr. Humberto Maturana (Universidad de Chile) y Dr. Gregorio Klimovsky (U.B.A.).

**CREACION DE AREAS**

**Area del Discapacitado** (físico, mental, sensorial, múltiple) y su familia.

Estas familias que nos ocupan tienen la sobrecarga de compensar la deficiencia de alguno de sus miembros a través de una tarea de estimulación especial y es en este campo en que el profesional especializado tiene que funcionar como docente, enseñándole no sólo qué hacer, sino cómo, cuándo, dónde, para

## INFORMACIONES

qué y por qué hacerlo. Es por esto que la Sociedad Argentina de Terapia Familiar ha decidido la apertura de esta área de trabajo permanente a partir de junio de 1984, donde se brindará asesoramiento, orientación, grupos de formación y tareas de investigación sobre la problemática. Nuestro objetivo es poner énfasis en la idea de rehabilitación y recuperación como miembros activos de la sociedad, lo que está vinculado a la ideología con que se los acepta.

Esta área está bajo la coordinación de la Lic. Martha Schejtman

### Area de "Alcoholismo y familia"

La creación de esta área responde a la necesidad de sistematizar una acción de trabajo que se refiera específicamente a dicha enfermedad, que afecta al hombre en su integridad, a su familia e implica al sistema social más amplio, constituyendo así un problema de gran envergadura dentro del campo de la Salud Mental.

Los objetivos de esta área son: a) Brindar a instituciones oficiales y privadas, profesionales de distintas especialidades y estudiantes avanzados, información acerca de todo lo referente al tema. B) Implementar programas de prevención primaria enfocada en el grupo familiar a través de equipos multidisciplinarios integrados por profesionales, otras instituciones y diferentes organizaciones comunitarias. c) Ofrecer un lugar de encuentro a todos aquellos que hayan investigado sobre el tema o proyecten hacerlo, promoviendo el intercambio de experiencias en un área donde la investigación es reciente. d) Organizar regularmente eventos científicos que incluyan disertaciones, jornadas, encuentros, en Capital Federal o ciudades del interior del país.

Esta área está abajo la coordinación de la Lic. Raquel Guilligan.

### Area de "Familia y enfermedad orgánica"

Esta área investiga y estudia desde una ideología científica unicista y abarcativa, tres etapas del acontecer del ser y su

## INFORMACIONES

familia en el enfermar: 1) La primera es la de las formas en que una familia podría enfermar orgánicamente a uno de sus miembros. 2) En el período de estado estudia las relaciones de los miembros de la familia con la enfermedad, con el miembro enfermo y con el equipo de salud. 3) En el período final de resolución, rehabilitación o muerte, trabaja sobre los procesos grupales de duelo y reparación.

Se estudian las técnicas de terapia familiar o de instrumentos técnicos parciales que se consideran más adecuados para los distintos tipos de patología y para cada momento de la enfermedad.

Las tareas son de a) investigación y b) de aprendizaje mediante grupos Balint y de reflexión sobre la tarea.

Están destinadas las actividades a médicos generales y especialistas, psicoterapeutas y demás profesionales del arte de curar.

Esta área está bajo la coordinación del Dr. Saúl Karol.

## FAMILIAJE

La Sociedad Argentina de Terapia Familiar, de acuerdo a sus objetivos, ofrece sus servicios a la comunidad. Como consecuencia la Directora del Menor, Adulto y Familia de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. Clarisa Voloschin, que tiene a su cargo el proyecto "Familiaje", solicitó nuestra colaboración.

Familiaje es la implementación de hogares albergantes para niños de 45 días a tres años y medio, durante las horas diurnas en que sus padres salen a trabajar.

Este es un intento de suplir las necesidades que no alcanzan a cubrir los actuales jardines maternos de la Capital Federal.

Este plan instrumentado en otros países, además de ser económicamente posible, permite soluciones alternativas a las familias que deben delegar sus niños.

La Sociedad Argentina de Terapia Familiar será pues la encargada de colaborar en la acomodación y seguimiento de estas familias.

A este fin se han programado cursos para profesionales.

## INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

La Revista de Terapia Familiar publica dos números por año, es multidisciplinaria en el área de la familia con especial énfasis en la salud mental. Tiene como objetivo incrementar el conocimiento profesional de la problemática de la familia para mejorar la calidad de ayuda que la familia requiere.

Los trabajos son seleccionados sobre las bases de objetivos, claridad y contribución al área de la familia.

### *Artículos*

— Los originales, por triplicado, deberán ser enviados al Director de la Revista, Dr. Alfredo Canevaro, Echeverría 1945, P. Baja, 1428 Capital Federal, República Argentina.

— La responsabilidad del contenido de los trabajos es del autor.

— No se paga honorarios por los trabajos aceptados.

— El editor se reserva el derecho de rechazar trabajos, devolverlos al autor para alguna modificación de forma o de someterlos a corrección de estilo.

— Los trabajos deben estar escritos a máquina y a doble espacio. Se debe presentar original y dos copias, también deben incluir un resumen lo más conciso posible, así como su traducción en inglés para su envío a revistas internacionales. Las tablas y gráficos que acompañen el trabajo deben ser claros a fin de permitir la máxima calidad de la reproducción fotomecánica.

— Incluir nombre completo del (los) autor (es), título profesional, dirección e Institución a la que pertenece.

— Bibliografía: Las referencias bibliográficas deben ceñirse a

las normas internacionales: 1 - Ordenadas alfabéticamente y numeradas correlativamente según su orden de aparición. 2 - Nombre completo del autor o de todos los autores, en caso de ser varios. 3 - Título completo del trabajo citado. 4 - Nombre abreviado de la Revista según Index Medicus (si el tema es médico). Número de Volumen o Volúmenes; referencia de primera y última página (en este orden), ciudad, editorial, año de publicación.

— Los autores de los trabajos publicados recibirán un ejemplar de la Revista.

— Los artículos deberán ser inéditos en lengua española.

**FICHA DE SUSCRIPCION**

Sres. de Terapia Familiar:

Solicito ser suscripto por el término de un año a vuestra revista para lo que acompaño los siguientes datos:

Nombre y Apellido .....

Dirección .....

Código Postal ..... Localidad .....

Profesión .....

Adjunto Cheque o Giro a nombre de: Terapia Familiar, No a la orden, por pesos .....

Gorostiaga 1731, Capital Federal (1426), R. Argentina

PRECIO DE LA SUSCRIPCION ANUAL

**Argentina**

Consultar por carta o a  
los tel. 38-8502/37-3587

**Exterior u\$s 26.—**

Impreso en Edigraf S.A.  
Delgado 834  
Diciembre 1983